



Provas Gratuitas Anteriores para Residência Médica

1 ENARE

Documento última vez atualizado em 20/02/2024 às 15:39.



Índice

1.1)	ENARE - 2023	3
1.2)	ENARE - 2024	153

1.1 ENARE - 2023

Questão | | 2023 | 4000181580

Uma paciente de 32 anos teve, recentemente, diagnóstico de PAF (Polipose Adenomatosa Familiar) e possui aversão a cirurgias. Qual é a orientação correta a ser feita nesse caso?

- A)** Orientar que a paciente possui uma síndrome genética de herança autossômica recessiva, que dificilmente será transmitida a outras gerações.
- B)** Orientar que a paciente provavelmente precisará de intervenção cirúrgica, já que tem grandes chances de desenvolver um câncer colorretal em algum momento de sua vida.
- Orientar a paciente que o manejo da Polipose geralmente é feito por meio de
- C)** acompanhamento clínico, com colonoscopia a cada 5 anos até os 80 anos, deixando para comentar, quando preciso, sobre a possível necessidade de cirurgia.
- Orientar que essa patologia é caracterizada pela existência de alguns pólipos na região do
- D)** reto, que podem ser acompanhados e ressecados por colonoscopia, já que a paciente possui aversão a cirurgias.
- E)** Orientar que essa patologia ocorre por uma mutação no gene BRCA1 e, portanto, deve ser indicada também adenomastectomia profilática pelo alto risco de câncer de mama.

Solução

Orientar que a paciente provavelmente precisará de intervenção cirúrgica, já que

Gabarito: B) tem grandes chances de desenvolver um câncer colorretal em algum momento de sua vida.

GABARITO: ALTERNATIVA B

Paciente de 32 anos com polipose adenomatosa familiar (PAF) que tem aversão à cirurgia. Que orientação devemos dar?

A PAF é uma síndrome hereditária que predispõe ao câncer colorretal cursando com polipose, que ocorre devido a mutação do gene APC. Tal condição cursa com um risco altíssimo de câncer colorretal, de cerca de 100% ao longo da vida.

A letra A está incorreta. INCORRETA. A polipose adenomatosa familiar é de herança autossômica dominante.

A letra B está correta. CORRETA. Um paciente com PAF clássica tem praticamente 100% de chance de evoluir com um câncer colorretal. Isso mesmo, eu disse 100%! Por esse motivo, a realização de colectomia, ou seja, remoção cirúrgica do cólon, está indicada para esses pacientes.

A letra C está incorreta. INCORRETA. Um paciente com PAF clássica tem praticamente 100% de chance de evoluir com um câncer colorretal. Isso mesmo, eu disse

100%! Por esse motivo, a realização de colectomia, ou seja, remoção cirúrgica do cólon, está indicada para esses pacientes. A técnica cirúrgica de ESCOLHA para os portadores de PAF clássica é a proctocolectomia com anastomose ileoanal.

A letra D está incorreta. INCORRETA. Quais são as manifestações clássicas da Polipose Adenomatosa Familiar (PAF)?

- Centenas a milhares de pólipos colorretais (adenomas), duodenais (adenomas) e gástricos (maioria dos pólipos gástricos são hiperplásicos);
- Presença de osteomas, tumores desmoides, cistos epidérmicos, lipomas, angiofibromas e dentes supranumerários:
- Osteomas: tumores benignos em sua maioria, representados por proeminências palpáveis no crânio, mandíbula, tíbia; e
- Tumores desmoides: presentes no retroperitônio ou parede abdominal, costumam ser localmente invasivos (mesentério, ureter, intestino delgado).
- Hipertrofia congênita do epitélio retiniano.

A letra E está incorreta. INCORRETA. O gene mutado na PAF é o APC.

Questão | | 2023 | 4000181581

Um paciente será submetido a uma cirurgia cardíaca eletiva. Qual antibiótico deve ser preferencialmente utilizado para a profilaxia antimicrobiana cirúrgica?

- A)** Cefazolina.
- B)** Metronidazol.
- C)** Ceftriaxona.
- D)** Cefepima.
- E)** Ciprofloxacino.

Solução

Gabarito: A) Cefazolina.

GABARITO: ALTERNATIVA A

O principal antibiótico usado para profilaxia cirúrgica é a cefazolina, um beta-lactâmico da classe das cefalosporinas de primeira geração.

Ela é uma boa escolha porque cobre bactérias gram-positivas que colonizam a pele do paciente e que mais podem causar infecção de sítio cirúrgico (ISC).

A dose recomendada é de 2 gramas, em até 60 minutos antes da incisão ou durante a indução anestésica, devendo ser repetida a cada 4 horas.

A letra A está correta. Alternativa A correta. Como vimos, a cefazolina é o antibiótico de escolha para profilaxia cirúrgica.

A letra B está incorreta. Alternativa B incorreta. Metronidazol cobre principalmente bactérias gram negativas anaeróbias, que não estão associadas a infecção de sítio cirúrgico em cirurgia cardíaca.

A letra C está incorreta.

Alternativa C incorreta. Ceftriaxone não tem boa cobertura para bactérias gram positivas que podem causar ISC.

A letra D está incorreta. Alternativa D incorreta. Cefepime tem um espectro amplo cobrindo bactérias gram-negativas e pseudomonas, sendo desnecessário nesse caso.

A letra E está incorreta. Alternativa E incorreta. Ciprofloxacino não tem boa cobertura para bactérias gram positivas que podem causar ISC.

Questão | | 2023 | 4000181582

Assinale a alternativa correta quanto às características das doenças inflamatórias intestinais – doença de Crohn e retocolite ulcerativa.

- A)** A retocolite ulcerativa tem sua maior incidência em pacientes de 50 anos.
- B)** A retocolite ulcerativa é uma doença que geralmente acomete mucosa, submucosa e muscular do cólon.
- C)** A retocolite ulcerativa pode estar associada a manifestações extraintestinais, como a colangite esclerosante, e geralmente é agravada pelo tabagismo.
- D)** Tanto a retocolite ulcerativa como a doença de Crohn são mais comuns entre mulheres que usam contraceptivos orais em comparação com aquelas que não usam.
- E)** O tabagismo atua como efeito protetor na doença de Crohn.

Solução

Tanto a retocolite ulcerativa como a doença de Crohn são mais comuns entre
Gabarito: D) mulheres que usam contraceptivos orais em comparação com aquelas que não usam.

GABARITO: ALTERNATIVA D

Questão abordando a temática das doenças inflamatórias intestinais: retocolite ulcerativa (RCU) e doença de Crohn (DC). Com relação aos seus fatores de risco e proteção.

Nós elaboramos uma tabela, disponível no nosso e-book, bastante ilustrativa em relação a tais fatores. Confira abaixo:

Aspectos Epidemiológicos das Doenças Inflamatórias Intestinais		
Variáveis	Retocolite Ulcerativa	Doença de Crohn
Faixa etária	Distribuição Bimodal: 15-30 anos (PRINCIPAL) e 55-80 anos	
Gênero	H=M (alguns estudos mostram leve predomínio em HOMENS)	H=M (alguns estudos mostram leve predomínio em MULHERES)
Tabagismo	Fator protetor	Fator de risco
Apendicectomia	Fator protetor	Fator de risco
ACO	Fator de risco ou Indiferente	Fator de risco
Gastroenterite infecciosa	Fator de risco	
Genética	DR1501 (doença leve) DR1502 (doença grave)	Mutação NOD2/CARD15 (20-30%)

A letra A está incorreta. INCORRETA. As doenças inflamatórias intestinais têm dois picos de incidência, sendo o principal dos 15 aos 30 anos.

A letra B está incorreta. INCORRETA. A RCU tem inflamação que é restrita à mucosa, no máximo chegando até a submucosa. Quem cursa com envolvimento transmural é a doença de Crohn.

A letra C está incorreta. INCORRETA. Embora a RCU se associe à colangite esclerosante, o tabagismo é um fator protetor na RCU e um fator de risco para a DC.

A letra D está correta. CORRETA. Ambas as doenças inflamatórias intestinais, a depender do estudo, parecem ter associação positiva com o uso de anticoncepcionais orais.

A letra E está incorreta. INCORRETA. O tabagismo atua como fator de risco para DC e fator protetor na RCU.

Questão | | 2023 | 4000181583

Um paciente será submetido a uma tireoidectomia total. Qual das alternativas a seguir apresenta uma complicação que pode ocorrer em consequência desse tipo de cirurgia e sua justificativa?

- A)** Hiperparatireoidismo por lesão das paratireoides.
- B)** Paralisia de prega vocal por lesão do nervo laríngeo recorrente.
- C)** Hipertireoidismo por liberação de grande quantidade de hormônios tireoideanos.

D) Rouquidão por lesão do nervo glossofaríngeo.

E) Hipercalcemia por paratireoidectomia acidental.

Solução

Gabarito: B) Paralisia de prega vocal por lesão do nervo laríngeo recorrente.

GABARITO: ALTERNATIVA B

A letra A está incorreta. O que pode decorrer da lesão das paratireoides é uma HIPOcalcemia e não uma HIPERcalcemia.

Esta alteração é decorrente da queda dos níveis de PTH.

A letra B está correta. O conhecimento da tireoidectomia para as provas de residência é importante pois já foram cobrados detalhes sobre anatomia cirúrgica da tireoide, técnica operatória básica, indicações e complicações. Este último é o tópico mais importante sobre este assunto, sendo este o conhecimento avaliado nesta questão do ENARE.

As principais complicações decorrentes da tireoidectomia, abordadas nas provas anteriores, são: as lesões nervosas, vasculares e das paratireoides.

a) Nervosas

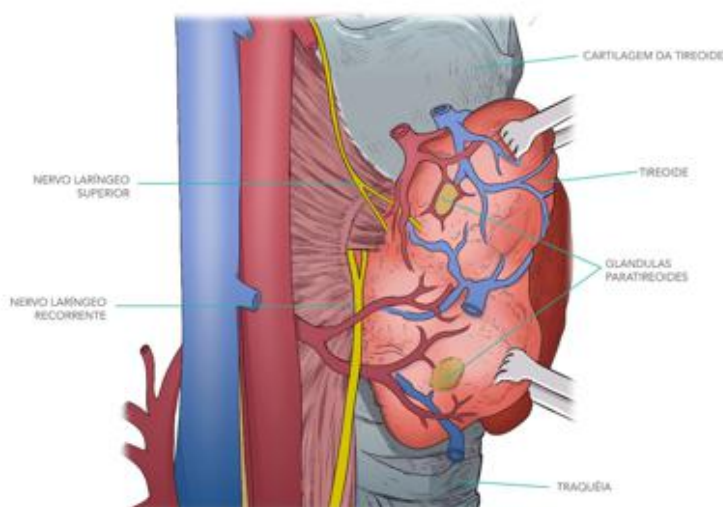
O principal nervo lesado na tireoidectomia é o nervo laríngeo recorrente (apresentado pela pinça na figura ao lado), sendo também o mais lembrado em questões de prova.

Este faz a inervação de quase toda a musculatura intrínseca da laringe ipsilateral e, nos casos em que houve lesão cirúrgica iatrogênica, o paciente pode apresentar disfonia e/ou dispneia nas lesões unilaterais, causadas por uma paresia ou paralisia da prega vocal ipsilateral.

Em casos de lesão bilaterais, pode ocorrer uma paralisia mediana de ambas as pregas vocais, não permitindo a passagem do ar para a traqueia, levando ao desenvolvimento de dispneia intensa, cornagem e estridor após a remoção do tubo ao término da cirurgia.

O outro nervo susceptível a lesão nas tireoidectomias, e cobrado nas provas mais recentes, é o nervo laríngeo superior.

ANATOMIA CIRÚRGICA DA TIREOIDE



Nos pacientes em que ocorreu lesão do ramo externo do nervo laringeo superior, verifica-se uma dificuldade na emissão de sons agudos, podendo manifestar-se nos enunciados como "dificuldade ou falha na voz" ao cantar.

b) Vasculares

Devido ao grande suprimento arterial e drenagem venosa da tireoide, são realizadas muitas ligaduras vasculares durante a cirurgia para a remoção desta glândula, e podemos ter complicações caso estas ligaduras não sejam realizadas de forma adequada.

Clinicamente, nas questões sobre hematoma pós tireoidectomia o paciente apresentou-se com aumento do volume cervical, associado a cornagem e agitação. A depender do tempo de evolução, cianose central e rebaixamento do nível de consciência também foram descritos.

C) Paratireoides

A remoção inadvertida das paratireoides ou a ligadura de seus suprimentos vasculares leva a queda do PTH que será sucedida por uma hipocalcemia sintomática, resultando em tremores, cãimbras, tetanias em casos leves, podendo levar a arritmias e convulsões em casos mais severos.

A letra C está incorreta. Esta complicação pode ocorrer mas apenas em casos específicos: pacientes com Doença de Graves.

Nestas situações os pacientes já se encontram em um estado de hipertireoidismo com uma tireoide geralmente volumosa e com um excesso de hormônios pré-fabricados já armazenados. Assim, a manipulação cirúrgica durante a cirurgia pode levar a uma eliminação destes hormônios na corrente sanguínea desencadeando a famosa tempestade tireoidiana.

Conduto, mesmo nestas situações está não é uma ocorrência comum, sendo também improvável na maioria das situações de indicação da tireoidectomia onde os pacientes encontram-se com a função tireoidiana normal ou hipofuncionante.

A letra D está incorreta. O nervo glossofaríngeo é o famoso IX par craniano, sai da base do crânio através do forame jugular e irá dar inervação sensitiva e motora para a faringe, ficando longe do campo cirúrgico da tireoidectomia e não tendo relação com a movimentação das pregas vocais.

A letra E está incorreta. A paratireoidectomia acidental leva a HIPOcalcemia e não HIPERcalcemia conforme descrito nesta alternativa e já explicado no comentário das alternativas anteriores.

Questão | | 2023 | 4000181584

Um paciente, 20 anos, teve uma fratura exposta de tíbia grau I de Gustillo-Anderson. Qual seria a forma mais correta de realizar o primeiro atendimento hospitalar desse paciente?

- A)** Profilaxia com Ceftriaxona e vacina antitetânica seguida de lavagem e desbridamento cirúrgico.

- B)** Iniciar antibiótico de forma terapêutica com Ciprofloxacino, realizar vacina antirrábica e seguir com lavagem e redução local da fratura.
- C)** Redução da fratura após analgesia, lavagem e antibioticoterapia profilática com Vancomicina durante a indução anestésica.
- D)** Profilaxia com Cefalotina e vacina antitetânica seguida de lavagem e desbridamento cirúrgico / redução da fratura.
- E)** Analgesia, profilaxia com vacina antitetânica e Ciprofloxacino e redução imediata da fratura seguidas de lavagem e desbridamento cirúrgico.

Solução

Gabarito: D) Profilaxia com Cefalotina e vacina antitetânica seguida de lavagem e desbridamento cirúrgico / redução da fratura.

GABARITO: ALTERNATIVA D

O que o examinador quer saber com esta pergunta?

Atendimento inicial ao paciente com fratura exposta.

O que você precisa saber para responder a esta pergunta?

Fratura exposta:

A fratura exposta é uma fratura (descontinuidade do tecido ósseo) em que há conexão entre o hematoma fraturário e o meio externo. Não é necessário que o osso tenha contato com o meio externo, ou esteja evidentemente exposto; muitas vezes, há um ferimento cortocotuso algo distante da fratura, mas o hematoma os conecta.

Ela é classificada conforme Gustilo e Anderson, que é uma classificação bastante simples de se compreender:

Tipo	Tamanho	Grau de contaminação	Lesão de partes moles	Lesão óssea
I	< 1cm	Limpa	Mínimo	Simples, cominuição mínima (baixa energia)
II	> 1cm	Moderada	Moderada, alguma lesão muscular	Cominuição moderada (energia moderada)
IIIA	> 10cm	Alto	Grave, com esmagamento	Cominuição grave (alta energia); há cobertura de estruturas nobres (osso)
IIIB			Importante perda de cobertura	Cominuição grave (alta energia); sem cobertura de estruturas nobres (osso), geralmente necessita de reconstrução
IIIC			Importante perda de cobertura Lesão vascular que necessita de reparo	

Deve-se sempre considerar o fator mais grave; por exemplo, um ferimento por arma de fogo, ainda que puntiforme, será considerado sempre grau III.

A fratura exposta é considerada como uma fratura contaminada. Contudo, ao contrário do que seria mais lógico, os micro-organismos que infectam a fratura exposta são de origem **hospitar**. Os mais envolvidos são: *Staphylococcus aureus*, *Pseudomonas aeruginosa* e *Escherichia coli*.

A antibioticoterapia deve ser sempre instituída no tratamento de fraturas expostas, o mais rápido possível. O esquema na maior parte dos hospitais brasileiros é: para as fraturas classificadas como Gustilo I, cefazolina; para Gustilo II e III, gentamicina ou ceftriaxona e clindamicina ou cefazolina (cefalosporina de primeira geração e aminoglicosídeo). Os protocolos internacionais indicam cefazolina para graus I e II, assim como o ATLS. Contudo, o tratamento de fraturas grau II não foi questionado até hoje, justamente para não causar celeuma.

É importante lembrar também que, em acidentes em área rural, com contaminação por terra ou esgoto, deve-se adicionar penicilina cristalina. Metronidazol também pode ser agregado.

Vamos aproveitar para comparar as indicações de antibioticoterapia, que variam nas indicações do ATLS 10ª edição e da prática clínica, adaptada do Rockwood, livro-texto de trauma ortopédico:

Tipo	Prática clínica	ATLS
I	Cefazolina	Cefazolina
II	Cefazolina ou Clindamicina + Gentamicina	Cefazolina
III	Cefazolina ou Clindamicina + Gentamicina	Cefazolina + Gentamicina
Contaminação por solo ou esgoto	+ Penicilina +/- Metronidazol	Piperacilina e Tazobactam
Alergia penicilina	Clindamicina em vez de cefazolina	Clindamicina em vez de cefazolina

Quais são os melhores métodos para evitar infecção na fratura exposta?

- Iniciar o antibiótico nas primeiras 3 horas.
- O esquema na maior parte dos hospitais brasileiros é: para as fraturas classificadas como Gustilo I, cefazolina. Gustilo II e III, gentamicina ou ceftriaxona e clindamicina ou cefazolina (cefalosporina de primeira geração e aminoglicosídeo).

- Os antibióticos só precisam ser mantidos até o fechamento de partes moles ou 72h, o que vier antes.
- Na fixação definitiva, quando houver, o antibiótico deve ser administrado em dose única, antes da indução anestésica.
- Além do antibiótico, a limpeza mecânica com soro fisiológico em abundância é essencial.

A letra A está incorreta. Incorreta a alternativa A, pois não é indicada ceftriaxona para Gustillo 1.

A letra B está incorreta. Incorreta a alternativa B, pois não é indicado ciprofloxacino, nem vacina antirrábica.

A letra C está incorreta. Incorreta a alternativa C, pois não é indicada vancomicina.

A letra D está correta. Correta a alternativa D, sem ressalvas.

A letra E está incorreta. Incorreta a alternativa E, pois não é indicado ciprofloxacino. Ademais, a redução da fratura só deve ser feita **após** a lavagem.

Questão | | 2023 | 4000181585

Assinale a alternativa que corresponde à sequência correta de marcadores mais relacionados aos seguintes tipos de câncer, nesta ordem: câncer de pâncreas / câncer de ovário / câncer colorretal / hepatocarcinoma.

- A)** Ca 125 / CEA / Ca 19-9 / alfafetoproteína.
- B)** Ca 19-9 / Ca 15-3 / CEA / LDH.
- C)** CEA / Ca 125 / CEA / LDH.
- D)** Ca 19-9 / Ca 15-3 / CEA / alfafetoproteína.
- E)** Ca 19-9 / Ca 125 / CEA / alfafetoproteína.

Solução

Gabarito: E) Ca 19-9 / Ca 125 / CEA / alfafetoproteína.

GABARITO: ALTERNATIVA E

Essa é uma questão direta.

Para que possamos respondê-la precisamos lembrar a principal função dos marcadores tumorais citados acima. Vamos lá:

CA 125: Esse marcador está tipicamente relacionado às neoplasias malignas epiteliais de ovário. A solicitação desse marcador costuma ser realizada frente à presença de massas anexiais suspeitas. De qualquer modo, vale lembrar que a sensibilidade e a especificidade desse marcador apresentam limitações (sensibilidade 78%; especificidade 78%).

CEA: Esse marcador pode estar elevado em mais de uma neoplasia maligna. Tipicamente é associado ao câncer colorretal, câncer de ovário e ao colangiocarcinoma. Vale lembrar que patologias benignas também podem elevar os níveis desse marcador. Entre elas encontram-se a úlcera péptica, diverticulite, DPOC, entre outras. Portanto, como boa parte dos marcadores tumorais, o CEA apresenta problemas relacionados à sua especificidade.

CA 19-9: O CA 19-9 é um marcador tipicamente relacionado à neoplasias de pâncreas, no entanto, esse marcador também pode estar elevado nos casos de câncer gástrico, câncer de vesícula biliar, colangiocarcinoma, tumor periampular e, até mesmo, câncer de ovário. Portanto, devido à baixa especificidade, o CA 19-9 é mais utilizado para monitorizar recidivas.

CA 15-3: Assim como o CA 19-9, o CA 15-3 é um marcador que pode ser encontrado em mais de um tipo de neoplasia, como câncer de pulmão, pâncreas e câncer colorretal. No entanto, esse marcador recebe destaque especial para as neoplasias de mama.

LDH: A desidrogenase láctica é uma enzima presente na maioria dos tecidos. Seu aumento pode estar relacionado à destruição celular, o que é visto nos tumores com alto turn over ou, ainda, com altas taxas de necrose tumoral.

Alfafetoproteína: Os níveis aumentados dessa proteína estão tipicamente relacionados às neoplasias testiculares e ao carcinoma hepatocelular.

Sendo assim, a melhor alternativa para essa questão se encontra na letra E.

Questão | | 2023 | 4000181586

Uma paciente de 24 anos, com IMC de 32kg/m^2 e sem comorbidades, procura um médico cirurgião com o desejo de realizar cirurgia bariátrica. Refere que já procurou outros cirurgiões que não quiseram realizar o procedimento. Qual seria a melhor conduta do médico diante dessa situação?

- A)** Indicar a cirurgia bariátrica, já que a paciente possui critérios para realizar o procedimento, após realização de pré-operatório completo.
- B)** Orientar a paciente que ela não possui critérios para indicação da cirurgia e que deve iniciar medidas clínicas para a perda de peso.
- C)** Orientar a paciente que ela deve realizar exames laboratoriais e que, se estes revelarem que ela é portadora de diabetes, terá indicação de realizar a cirurgia.

- D)** Orientar a paciente sobre os riscos da cirurgia e que esta deve ser indicada somente para pacientes com IMC maior que 45kg/m^2 .

Orientar a paciente que ela não possui critérios para indicação da cirurgia, porém, caso a

- E)** paciente insista em seu desejo, o médico deve realizar o procedimento, respeitando a vontade dela.

Solução

- Gabarito: B)** Orientar a paciente que ela não possui critérios para indicação da cirurgia e que deve iniciar medidas clínicas para a perda de peso.

GABARITO: ALTERNATIVA B

Para respondermos a essa questão, precisamos lembrar os critérios para indicação de cirurgia bariátrica. São eles:

INDICAÇÕES DE CIRURGIA BARIÁTRICA
1. Pacientes entre 18 e 65 anos, em acompanhamento adequado por 2 anos, sem sucesso na perda ponderal, e • IMC $\geq 40\text{kg/m}^2$; • IMC $\geq 35\text{kg/m}^2$ e $< 40\text{kg/m}^2$ na presença de comorbidades cuja perda de peso possa revertê-las ou melhorá-las.
2. Pacientes com IMC 30-34,9 kg/m^2 e diabetes mellitus não controlado com tratamento clínico otimizado. • Necessitam ter < 10 anos de diagnóstico de DM tipo 2 e idade entre 30 e 70 anos de idade. • Dois endocrinologistas devem comprovar a falha terapêutica na normalização dos níveis glicêmicos, apesar de tratamento otimizado por, pelo menos, 2 anos. • Técnicas cirúrgicas: primeira escolha é o <i>bypass gástrico</i> (derivação gastrojejunal em Y de Roux); segunda escolha é a gastrectomia vertical (sleeve).

Visto isso, vamos avaliar separadamente cada uma das alternativas.

A letra A está incorreta. Incorreta alternativa “a”: Como vimos, a paciente acima não apresenta critérios para a realização do procedimento.

A letra B está correta. Correta alternativa “b” : Essa é a conduta adequada.

A letra C está incorreta. Incorreta alternativa “c”: A cirurgia está indicada para pacientes com IMC entre 30-34,9 portadores de diabetes, sem resposta ao tratamento clínico otimizado. Ou seja, caso a paciente seja diagnosticada com diabetes, o tratamento clínico deverá ser tentado antes da cirurgia e o procedimento cirúrgico só estará indicado caso haja insucesso no tratamento medicamentoso otimizado do diabetes.

A letra D está incorreta. Incorreta alternativa “d”: Como vimos, esse não é um critério exclusivo para a realização da cirurgia.

A letra E está incorreta. Incorreta alternativa “e”: A cirurgia bariátrica apresenta uma série de riscos e, portanto, só deve ser realizada caso o paciente atenda estritamente às indicações.

Questão | | 2023 | 4000181587

Um paciente de 27 anos possui uma lesão pigmentada e assimétrica, de aproximadamente 7mm, localizada em pele do dorso. Procurou um médico que indicou biópsia. Qual é o melhor tipo de biópsia a ser indicada para esse paciente?

- A) Biópsia incisional.
- B) Biópsia excisional.
- C) Biópsia em shaving superficial.
- D) Biópsia com agulha fina.
- E) Biópsia com agulha grossa.

Solução

Gabarito: B) Biópsia excisional.

GABARITO: ALTERNATIVA B

Questão bastante direta! Sempre que estamos diante de uma lesão pigmentada devemos aplicar a regra do ABCDE para sabermos se a lesão é suspeita de melanoma. Vamos lembrar essa regra?

- A – assimetria.
- B – bordas irregulares
- C – múltiplas cores
- D – diâmetro maior que 6 mm
- E – evolução

Essa lesão pigmentada é assimétrica e mede 7mm. Portanto, é suspeita de melanoma. Quando suspeitamos de melanoma devemos realizar uma biópsia excisional (retirada de toda a lesão) com margens de 1 a 3mm. Dessa forma o gabarito é a alternativa B.

A letra A está incorreta. Incorreta. Biópsia incisional consiste em retirada de apenas um pequeno fragmento da lesão. Só realizamos esse tipo de biópsia em suspeitas de melanoma quando a lesão for muito grande e a exérese não for exequível naquele momento.

A letra B está correta. Correta. Perfeita e sem ressalvas.

A letra C está incorreta. Incorreta. A biópsia tipo shaving é uma técnica que fazemos uma retirada mais superficial como se estivéssemos “barbeando” a lesão. Ela não é a mais adequada em suspeita de melanoma.

A letra D está incorreta. Incorreta. Não realizamos biópsia de lesão cutânea com agulha grossa ou fina.

A letra E está incorreta. Incorreta. Não realizamos biópsia de lesão cutânea com agulha grossa ou fina.

Questão | | 2023 | 4000181588

Levado por um vizinho, um paciente de 68 anos, previamente lúcido, foi admitido em um hospital com rebaixamento do nível de consciência. Durante a investigação, foi sugerido provável diagnóstico de sepse grave de foco abdominal devido a uma diverticulite aguda perforada. O paciente permaneceu torporoso e, após a equipe tentar entrar em contato com a família, sem sucesso, o paciente foi encaminhado à cirurgia. O médico cirurgião indicou uma retossigmoidectomia à Hartmann – com colostomia terminal. Qual é a melhor conduta diante dessa situação?

- Proceder com a cirurgia, já que se trata de cirurgia de urgência, com risco ao paciente,
- A)** necessitando que seja feita uma colostomia para melhor tratamento dele, independentemente da opinião da família.
 - B)** Aguardar a chegada da família para iniciar a cirurgia, já que eles devem decidir sobre a confecção ou não de um estoma.
 - C)** Proceder com a cirurgia sem a confecção de estoma, pelo risco de não haver aceite da família quanto a esse procedimento, mesmo que seja a melhor estratégia para o paciente.
 - D)** Orientar o acompanhante sobre o quadro e solicitar que ele decida sobre a confecção ou não do estoma para o paciente, já que está acompanhando o paciente.
 - E)** Proceder com a cirurgia e realizar a lavagem e drenagem da cavidade para realizar, posteriormente, uma nova abordagem cirúrgica, devido à ausência da família.

Solução

Proceder com a cirurgia, já que se trata de cirurgia de urgência, com risco ao

Gabarito: A) paciente, necessitando que seja feita uma colostomia para melhor tratamento dele, independentemente da opinião da família.

GABARITO: ALTERNATIVA A

Essa é uma questão que trata de um preceito ético. Estamos diante de um paciente com uma patologia benigna, com prognóstico de cura através do procedimento cirúrgico (retossigmoidectomia à Hartmann). Nesse contexto, não há o que se discutir, o procedimento deverá ser realizado a despeito da opinião da família, como dito na alternativa A. Visto isso, vamos avaliar separadamente cada uma das assertivas.

A letra A está correta. Correta alternativa “a”: Como vimos, essa é a assertiva correta.

A letra B está incorreta.

Incorreta alternativa “b” : Como estamos diante de um quadro grave de peritonite, a não realização do estoma (confecção de anastomose primária) tem uma alta chance de evoluir para fístula, que produzirá consequências graves ao paciente. O que é especialmente verdadeiro se levarmos em consideração seu estado atual. Portanto, deverá ser realizada a conduta com maior benefício ao paciente, a despeito da opinião familiar.

A letra C está incorreta. Incorreta alternativa “c”: Como vimos, a decisão de realizar ou não o estoma não cabe à família. Devemos optar pela melhor conduta sob o ponto de vista prognóstico. Portanto, está indicado o estoma.

A letra D está incorreta. Incorreta alternativa “d”: Como vimos, a decisão de realizar ou não o estoma não cabe à família. Devemos optar pela melhor conduta sob o ponto de vista prognóstico. Portanto, está indicado o estoma.

A letra E está incorreta. Incorreta alternativa “e”: A limpeza da cavidade está adequada e a drenagem do coto retal poderá ser feita em critério vigilante, ou seja, o dreno poderá ser aplicado para vigiar a sutura do coto retal frente à possibilidade de deiscência. No entanto, como vimos, a demanda de uma nova abordagem cirúrgica será definida pela evolução clínica do paciente e não tem relação com a opinião de seus familiares.

Questão | | 2023 | 4000181589

Um paciente com uma massa em ápice pulmonar direito apresenta dor e perda de força em ombro e braço direitos, além de ptose palpebral, miose e anidrose ipsilateral. A síndrome que inclui todos esses sinais e sintomas é denominada

- A)** síndrome de Claude Bernard-Horner.
- B)** síndrome da veia cava superior.
- C)** síndrome de Kaposi.
- D)** síndrome de Pancoast.
- E)** síndrome do desfiladeiro torácico.

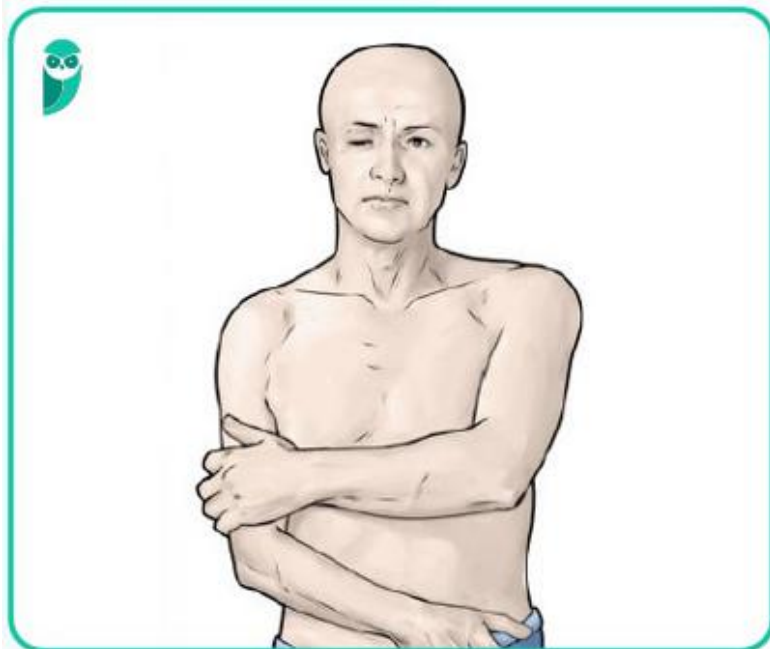
Solução

Gabarito: D) síndrome de Pancoast.

GABARITO: ALTERNATIVA D

O caso clínico apresenta um paciente com uma massa em ápice pulmonar direito, que apresenta dor e perda de força em ombro e braço direitos, além de ptose palpebral, miose e anidrose ipsilateral (síndrome de Horner). Esses sintomas são sugestivos de uma síndrome

relacionada à compressão de estruturas neurovasculares no tórax, tanto do plexo braquial, quanto da cadeia simpática, chamada síndrome de Pancoast Tobias!

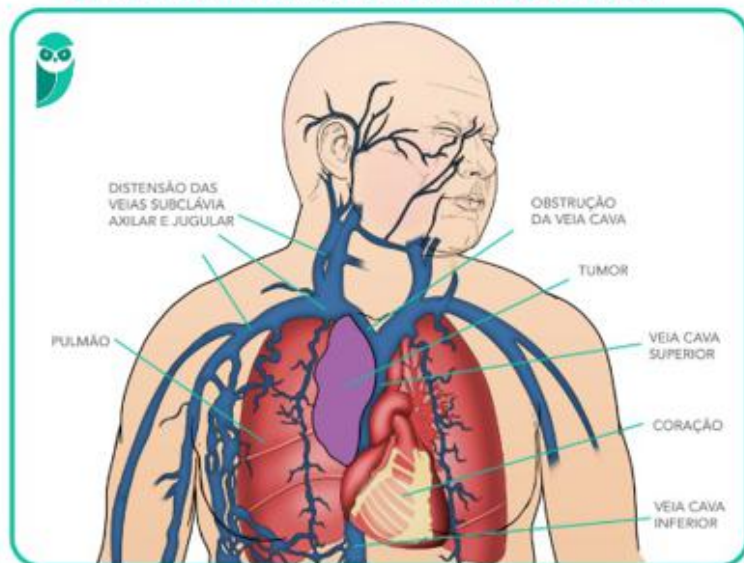


A letra A está incorreta. A. A síndrome de Claude Bernard-Horner é uma síndrome clínica que ocorre como resultado da lesão da cadeia simpática cervical. Os sintomas incluem ptose palpebral, miose e anidrose ipsilateral, mas não apresenta dor e perda de força em ombro e braço direitos. Portanto, a alternativa A está incorreta.

A letra B está incorreta.

B. A síndrome da veia cava superior é uma condição que ocorre quando a veia cava superior é comprimida por uma massa ou lesão no tórax, resultando em sintomas como edema facial, aumento da circulação venosa na porção superior do tórax, dispneia e tosse. Não apresenta ptose palpebral, miose e anidrose ipsilateral, por isso a alternativa B está incorreta.

SÍNDROME DA VEIA CAVA SUPERIOR



A letra C está incorreta. C. A síndrome de Kaposi é uma doença rara que afeta a pele e outros órgãos, relacionada ao vírus herpes humano tipo 8 (HHV-8). Não apresenta os sintomas descritos no caso clínico, por isso a alternativa C está incorreta.

A letra D está correta.

D. A síndrome de Pancoast é uma condição na qual um tumor localizado no sulco superior pode afetar o plexo braquial e os nervos simpáticos cervicais, causando sintomas como dor e perda de força em ombro e braço, além de ptose palpebral, miose e anidrose ipsilateral, que são exatamente os sintomas apresentados no caso clínico. Portanto, a alternativa D está correta.

A letra E está incorreta.

E. A síndrome do desfiladeiro torácico ocorre quando as estruturas neurovasculares são comprimidas entre as clavículas e as costelas. Os sintomas incluem dor e fraqueza em um braço, além de parestesia e alterações da cor da pele. Não apresenta ptose palpebral, miose e anidrose ipsilateral, por isso a alternativa E está incorreta.

Questão | | 2023 | 4000181590

Os pacientes submetidos à ressecção cirúrgica de lesões extensas de pele, geralmente, necessitam de retalho ou enxerto como auxílio no fechamento do defeito. Assinale a alternativa que caracteriza corretamente as técnicas empregadas nessas situações.

- A)** Enxerto que é um segmento de pele, sem o subcutâneo, com suprimento vascular próprio, rotacionado para a área doadora.
- B)** Enxerto que é um pedaço de pele retirado de uma área corpórea e transferido para outra área com um pedículo de comunicação entre as áreas.
- Retalho que é um segmento da pele e subcutâneo com suprimento vascular próprio, que
- C)** será movido de uma área (doadora) para outra (receptora), existindo uma comunicação do retalho com a área doadora por meio de um pedículo.
- Retalho que é um segmento de pele e subcutâneo sem nenhum pedículo de comunicação
- D)** entre eles. Só mais tardiamente desenvolve vascularização própria, restabelecendo, assim, um novo suprimento sanguíneo.
- E)** Geralmente o enxerto (área doadora) é retirado de pele adjacente, em continuidade com o defeito, obtendo assim melhores resultados.

Solução

Retalho que é um segmento da pele e subcutâneo com suprimento vascular

Gabarito: C) próprio, que será movido de uma área (doadora) para outra (receptora), existindo uma comunicação do retalho com a área doadora por meio de um pedículo.

GABARITO: ALTERNATIVA C

Antes de começarmos, precisamos conceitualizar o que é enxerto e o que é retalho. Vamos lá:

Enxertos: Os enxertos têm sua nutrição completamente dependente do leito receptor, afinal, não possuem suprimento vascular próprio. Ou seja, a área em que o enxerto aplicado é responsável por nutri-lo.

A consequência disso é que não podemos aplicar enxerto sobre uma área desvascularizada. Além disso, o enxerto deve manter íntimo contato com o leito receptor, para que receba vascularização. Do contrário, esse enxerto morrerá.

Justamente por isso, é essencial que o enxerto seja aplicado sobre um leito bem vascularizado, na ausência de processo infeccioso.

Retalhos: Os retalhos correspondem à transferência de tecido com pedículo vascular próprio. Ou seja, diferentemente dos enxertos, eles independem do leito receptor para sua sobrevivência. A reconstrução com retalhos está indicada quando os outros elementos da pirâmide de reconstrução não podem ser utilizados ou possuem uma contraindicação relativa. Os retalhos são elementos muito versáteis e podem ser usados com diversas finalidades, isso inclui:

- Preencher áreas de grandes perdas de tecido.
- Recriar estruturas, como a mama.
- Proporcionar uma melhor cobertura sobre áreas nobres, como articulações, vasos, nervos e tendões.

Visto isso, vamos avaliar separadamente as alternativas.

A letra A está incorreta. Incorreta alternativa “a”: Como vimos, os enxertos não possuem suprimento vascular próprio.

A letra B está incorreta. Incorreta alternativa “b”: Os enxertos não mantêm qualquer tipo de comunicação ou pedículo com sua área doadora. A presença de pedículo é característica dos retalhos.

A letra C está correta. Correta alternativa “c” : A alternativa "C" conceitua adequadamente um retalho.

A letra D está incorreta. Incorreta alternativa “d”: As características propostas pela alternativa D estão presentes nos enxertos, e não nos retalhos.

A letra E está incorreta. Incorreta alternativa “e”: Via de regra, os enxertos são retirados de áreas próximas à lesão, mas quase nunca em contiguidade a ela. Isso se justifica à medida que a retirada do enxerto em contiguidade ao ferimento produziria a extensão da área cruenta,

agravando o processo de cicatrização e favorecendo o surgimento de complicações, como a infecção.

Questão | | 2023 | 4000181591

Assinale a alternativa que NÃO corresponde a uma indicação usual de intervenção por CPRE (Colangiopancreatografia Retrógrada Endoscópica).

- A)** Coledocolitíase.
- B)** Colangite.
- C)** Estenose de colédoco distal e dilatação proximal.
- D)** Pancreatite biliar com cálculo impactado na via biliar.
- E)** Colelitíase.

Solução

Gabarito: E) Colelitíase.

GABARITO: ALTERNATIVA E

A colangiopancreatografia retrógrada endoscópica (CPRE) é um procedimento tanto diagnóstico quanto terapêutico para a coledocolitíase. Com o seu surgimento e popularização, a exploração cirúrgica da via biliar tem perdido espaço, por se tratar de procedimento mais invasivo e com risco de estenose cicatricial da via biliar.

A CPRE é capaz de tratar a coledocolitíase, mas sua aplicação não se restringe a isso. Através desse procedimento, também podemos tratar estenoses das vias biliares, através da aplicação de endopróteses e stents. Além disso, a CPRE também é capaz de realizar a drenagem interna transtumoral das vias biliares em alguns casos selecionados de neoplasia periampular.

Visto isso, vamos às alternativas.

A letra A está incorreta. Correta alternativa “a”: Atualmente, a CPRE figura como método de escolha para o tratamento de coledocolitíase na maioria dos casos.

A letra B está incorreta. Correta alternativa “b” : Considerando que a maior parte dos quadros de colangite é secundária à obstrução das vias biliares por coledocolitíase, a CPRE também se destina ao seu tratamento. Além disso, nos casos de colangite secundária à obstrução das vias biliares por estenose ou neoplasia, a CPRE também se mostra muito útil em boa parte dos casos.

A letra C está incorreta. Correta alternativa “c” : Como vimos, a CPRE é um bom método para o tratamento de estenose das vias biliares. Isso é especialmente verdadeiro quando o segmento acometido encontra-se no colédoco distal.

A letra D está incorreta. Correta alternativa “d” : Como vimos, a CPRE figura como método de escolha para o tratamento de coledocolitíase na maioria dos casos. Isso também é válido para os casos de coledocolitíase associados à pancreatite.

A letra E está correta. Incorreta alternativa “e”: A CPRE não se destina ao tratamento de cálculos no interior da vesícula biliar (coletitíase). O procedimento de escolha para esses casos é a colecistectomia.

Questão | | 2023 | 4000181592

Em um reparo cirúrgico aberto de hérnia inguinal, é importante que o cirurgião tenha conhecimento de anatomia e habilidade para preservar estruturas importantes encontradas na região do canal inguinal. No caso de pacientes homens, quais são os nervos (com suas respectivas funções) que devem ser cuidadosamente dissecados e preservados nesse procedimento?

Ramo genital do nervo genitofemoral (sensibilidade lateral do escroto); nervo ilio-hipogástrico
A) (sensibilidade da região inguinal e púbis / base do pênis); nervo ilioinguinal (sensibilidade de região medial superior da coxa).

Ramo femoral do nervo genitofemoral (sensibilidade lateral da perna); nervo ilioinguinal
B) (sensibilidade de região medial superior da coxa); nervo obturador (motricidade – adução da perna).

C) Nervo obturador (motricidade – adução da perna) e nervo cutâneo femoral lateral (sensibilidade de região lateral superior da coxa).

Nervo femoral (motricidade e sensibilidade da perna); nervo ilio-hipogástrico (sensibilidade de
D) região medial superior da coxa); nervo ilioinguinal (sensibilidade da região inguinal e púbis / base do pênis).

Ramo genital do nervo genitofemoral (sensibilidade lateral do escroto); nervo obturador
E) (motricidade – adução da perna); nervo ilioinguinal (sensibilidade da região inguinal e púbis / base do pênis).

Solução

Ramo genital do nervo genitofemoral (sensibilidade lateral do escroto); nervo ilio-
Gabarito: A) hipogástrico (sensibilidade da região inguinal e púbis / base do pênis); nervo ilioinguinal (sensibilidade de região medial superior da coxa).

GABARITO: ALTERNATIVA A

Essa é uma questão de anatomia. Para que possamos respondê-la adequadamente, precisamos nos lembrar dos nervos presentes na região inguinal e de sua respectiva função. São eles:

Nervo ilioinguinal: Inerva a pele proximal e medial da coxa e a pele sobre a raiz do pênis e a parte superior da bolsa escrotal, nos homens, e a pele do monte pubiano, grandes lábios e vulva, nas mulheres.

Nervo ílio-hipogástrico: fornece fibras motoras para os músculos oblíquo externo, oblíquo interno e transversos do abdome e fornece fibras sensoriais para a pele do monte púbico, para a pele da parte superior e lateral da coxa e para a pele que cobre o anel inguinal externo e a sínfise púbica.

Ramo genital do nervo genitofemoral: fornece inervação sensitiva para a pele da bolsa escrotal, em homens, e para grandes lábios da vulva, em mulheres.

Nervo cutâneo femoral lateral: corre abaixo ou ocasionalmente através do trato iliopúbico, lateral ao anel inguinal interno e dá a sensibilidade na pele da parte lateral da coxa.

Por fim, vale ressaltar que os nervos femoral e obturador não são tipicamente acessados durante o reparo de hérnias da região inguino-crural.

Questão | | 2023 | 4000181593

Um paciente de 57 anos possui uma lesão esofágica estenosante e não transponível ao aparelho de endoscopia em nível de esôfago médio/distal, com biópsia revelando carcinoma epidermoide escamoso. O paciente iniciará tratamento com radioterapia e quimioterapia neoadjuvantes, porém está com ingesta praticamente nula de alimentos há vários dias. Qual é a melhor estratégia cirúrgica de via alimentar a ser indicada para esse paciente?

- A) Realizar uma gastrostomia endoscópica.
- B) Realizar uma gastrostomia laparoscópica.
- C) Realizar uma jejunostomia.
- D) Realizar uma ileostomia.
- E) Realizar uma esofagostomia.

Solução

Gabarito: C) Realizar uma jejunostomia.

GABARITO: ALTERNATIVA C

Estamos diante de um paciente com neoplasia esofágica estenosante grave, que não permite sequer a passagem do aparelho de endoscopia. Nesse cenário, é esperado que o paciente não consiga alimentar-se por via oral, afinal, se há dificuldade para passagem do endoscópio, também haverá dificuldade para passagem de alimentos.

Essa estenose avançada justifica a "ingesta praticamente nula" mencionada pelo enunciado.

Frente a esse quadro, há indicação de uma via alimentar alternativa, para que o paciente possa ter seu aporte nutricional devidamente atendido.

Nesse contexto, existem, essencialmente, 4 modalidades para oferta nutricional. São elas:

- Sonda nasointestinal;**
- Gastrostomia;**
- Jejunostomia;**
- Nutrição parenteral.**

Vamos discutir cada uma delas para o caso em tela:

A presença de uma neoplasia esofágica estenosante, sem possibilidade de progressão do endoscópio, anula a possibilidade de sondagem nasointestinal. Afinal, é impossível transpor a área de estenose com a sonda, sem o auxílio de endoscopia.

A gastrostomia, por sua vez, também não pode ser considerada nos casos de tumor esofágico estenosante, seja pela via endoscópica ou pela via laparoscópica. Nesses casos, a melhor opção é a jejunostomia.

Por fim, a nutrição parenteral fica restrita aos casos em que há contraindicação ou impossibilidade de obter qualquer um dos métodos mencionados anteriormente.

Atenção, perceba que a sondagem gástrica não foi sequer mencionada. Afinal, esse método é ineficiente nos casos de neoplasias esofágicas estenosantes, e, portanto, contraindicada.

Dito isso, vamos às alternativas.

A letra A está incorreta. Incorreta alternativa "a": Como vimos, a gastrostomia não está indicada no contexto de tumor esofágico estenosante.

A letra B está incorreta. Incorreta alternativa "b": Idem à alternativa "A".

A letra C está correta. Correta alternativa "c" : Essa é a melhor conduta.

A letra D está incorreta. Incorreta alternativa "d": A ileostomia não é uma derivação destinada à nutrição.

A letra E está incorreta. Incorreta alternativa “e”: A esofagostomia não é realizada como via alternativa para administração de dieta em decorrência da dificuldade técnica e taxa de complicações. De qualquer modo, mesmo se essa fosse uma via válida, seria inútil para esse paciente. Afinal, o ponto de estenose encontra-se no próprio esôfago.

Questão | | 2023 | 4000181594

Um paciente de 74 anos recebeu o diagnóstico de HPB (Hiperplasia Prostática Benigna), e o médico indicou duas medicações para o tratamento dessa afecção e seus sintomas: a tansulosina e a finasterida. Qual é a melhor explicação que pode ser dada sobre o efeito desses compostos ao paciente?

- A) A tansulosina atua diminuindo o volume prostático, e a finasterida contribui para o relaxamento da musculatura na saída da bexiga; ambas facilitam a saída do jato urinário.
- B) A tansulosina contribui para o relaxamento da musculatura na saída da bexiga, e a finasterida atua diminuindo o volume prostático; ambas facilitam a saída do jato urinário.
- C) A tansulosina contribui para a contração do corpo da bexiga, e a finasterida age relaxando a musculatura na saída da bexiga; ambas facilitam a saída do jato urinário.
- D) A tansulosina atua na contração da musculatura da próstata, e a finasterina contribui no aumento da contração da musculatura detrusora da bexiga; ambas facilitam a saída do jato urinário.
- E) A tansulosina contribui para o relaxamento da musculatura na saída da bexiga, e a finasterida atua relaxando a musculatura prostática; ambas facilitam a saída do jato urinário.

Solução

A tansulosina contribui para o relaxamento da musculatura na saída da bexiga, e a

Gabarito: B) finasterida atua diminuindo o volume prostático; ambas facilitam a saída do jato urinário.

GABARITO: ALTERNATIVA B

Para respondermos a essa questão, precisamos relembrar as principais drogas administradas no tratamento da HPB. Para isso, trouxemos o quadro de resumo que se encontra a seguir.

CLASSE	PRINCIPAIS MEDICAÇÕES	MECANISMO DE AÇÃO	PECULIARIDADES PARA A PROVA	PRINCIPAIS EFEITOS COLATERAIS
ANTAGONISTAS ALFA-1-ADRENÉRGICOS	• DOXAZOSINA (α-1 não seletivo) • TANSULOSINA (α-1 seletivo) • ALFAZOSINA (α-1 seletivo)	Reduz o tônus da musculatura lisa prostática e do colo vesical	• Tempo de ação curto. • Terapia de escolha para monoterapia. • α-1 seletivos têm melhor perfil de efeitos colaterais.	• Hipotensão postural (principal) • Tontura • Cefaleia • Coriza • Disfunção ejaculatória
INIBIDORES DA 5-ALFA-REDUTASE	• FINASTERIDA • DUTASTERIDA	Reduz o tamanho da glândula através do bloqueio da conversão de testosterona em di-hidrotestosterona (DHT)	• Tempo para atingir efeito terapêutico – 6 meses a um ano • Reduz valores de PSA em 50% ou mais • Doses baixas também alteram o valor do PSA	• Disfunção erétil • Depressão • Distúrbios ejaculatórios • Ginecomastia
AGENTES ANTICOLINÉRGICOS	• CKBUTININA • TOLTERODINA	Diminui a hiperatividade do músculo detrusor	• Útil no tratamento dos sintomas irritativos • Perfil de efeitos colaterais geralmente limitam seu uso	• Boca seca (xerostomia) • Ciclopégia com alteração da acuidade visual para perto • Taquicardia • Constipação
INIBIDORES DA FOSFODIESTERASE-5	• TADALAFILA (único aprovado pelo FDA para tratamento de HPB)	Induz ao relaxamento e à redução da proliferação da musculatura lisa	• Útil para os pacientes com disfunção erétil em associação com HPB	• Potencializa a ação hipotensora dos antagonistas α-1

Baseando-se no quadro, vamos avaliar separadamente cada uma das alternativas.

A letra A está incorreta. Incorreta alternativa “a”: A tansulosina é um antagonista alfa adrenérgico que atua reduzindo o tônus da musculatura lisa prostática e do colo vesical. A finasterida, por sua vez, é um inibidor da 5-alfa redutase, que atua através do bloqueio da conversão de testosterona em di-hidrotestosterona (DHT), diminuindo, assim, o tamanho da glândula.

A letra B está correta. Correta alternativa “b” : Como vimos, a alternativa “B” está correta.

A letra C está incorreta. Incorreta alternativa “c”: Como vimos, as ações descritas para cada uma das drogas não está correta.

A letra D está incorreta. Incorreta alternativa “d”: Como vimos, ações descritas para cada uma das drogas não está correta.

A letra E está incorreta. Incorreta alternativa “e”: A ação descrita para a finasterida está incorreta.

Questão | | 2023 | 4000181595

Durante uma cirurgia de abordagem para ressecção da cabeça do pâncreas, qual das estruturas vasculares a seguir está presente nessa região e é de suma importância para o paciente, devendo-se, por isso, realizar o máximo de esforço para que seja preservada?

A) Artéria mesentérica inferior.

B) Artéria gastroduodenal.

- C) Artéria pancreatoduodenal posterior.
- D) Artéria mesentérica superior.
- E) Artéria pancreatoduodenal superior.

Solução

Gabarito: D) Artéria mesentérica superior.

GABARITO: ALTERNATIVA D

Essa é uma questão conceitual de anatomia.

Todas as artérias descritas nas alternativas mantém alguma relação de proximidade com o pâncreas e todas podem ser ligadas/ressecadas, à exceção da artéria mesentérica superior. Isso se justifica à medida que a obstrução completa do fluxo sanguíneo da artéria mesentérica superior é incompatível com a vida na maioria absoluta dos casos. Desse modo, essa estrutura deve ser preservada a todo custo nas abordagens cirúrgicas do pâncreas.

Questão | | 2023 | 4000181596

Um paciente chega ao hospital com febre há 2 dias e dor em região lombar direita. Ao realizar exames, recebe o diagnóstico de ureterolitíase obstrutiva à direita, com hidronefrose ipsilateral, alteração significativa da função renal e infecção associada com sinais de sepse. Qual é a melhor abordagem para esse paciente?

- A) Administração de anti-inflamatórios não esteroidais e analgésicos e realização de litotripsia ureteroscópica de urgência.
- B) Compensação clínica sintomática, administração de antibióticos e litotripsia extracorpórea – por ser o método menos invasivo para o paciente nesse momento.
- C) Analgesia, prescrição de alfa-bloqueadores, como a doxazosina, e litotripsia ureteroscópica de urgência.

Analgesia e reposição volêmica, anti-inflamatórios não esteroidais e, por cistoscopia,
D) descompressão do trato urinário superior à direita com urgência, além de inserção de cateter ureteral (duplo J) retrógrado ou por inserção de nefrostomia percutânea.

Compensação clínica sintomática, administração de antibióticos e, por cistoscopia,
E) descompressão do trato urinário superior à direita com urgência, além de inserção de cateter ureteral (duplo J) retrógrado ou por inserção de nefrostomia percutânea.

Solução

Gabarito: E)

Compensação clínica sintomática, administração de antibióticos e, por cistoscopia, descompressão do trato urinário superior à direita com urgência, além de inserção de cateter ureteral (duplo J) retrógrado ou por inserção de nefrostomia percutânea.

GABARITO: ALTERNATIVA E

A presença de sepse associada à litíase urinária obstrutiva deve nos remeter, obrigatoriamente, ao diagnóstico de pielonefrite obstrutiva.

As questões de prova sobre esse tema são extremamente comuns. Apesar disso, elas sempre recaem nos mesmos assuntos: diagnóstico da pielonefrite obstrutiva (por meio da apresentação clínica/radiológica) e conduta terapêutica.

Como na maior parte das vezes a causa da obstrução é a calculose dos ureteres, a apresentação clínica típica da pielonefrite obstrutiva é caracterizada por um quadro de cólica nefrética associada à febre.

Outros elementos clínicos relacionados à pielonefrite obstrutiva incluem:

- leucocitose ao hemograma;
- aumento de provas inflamatórias, como PCR e VHS;
- presença de leucocitúria no exame qualitativo de urina;
- identificação do fator obstrutivo ao exame de imagem.

O tratamento da pielonefrite obstrutiva tem dois pilares principais:

1. ANTIBIOTICOTERAPIA: a administração inicial de antibióticos deve ser por via parenteral e há necessidade de cobertura empírica para bactérias Gram-negativas e Gram-positivas.

2. DESOBSTRUÇÃO DA VIA URINÁRIA: em casos de pielonefrite obstrutiva, a desobstrução da via urinária é uma medida tão importante quanto a antibioticoterapia e deve ser realizada em regime de urgência.

Caso a desobstrução não seja feita, a infecção tende a progredir e se agravar mesmo com a administração adequada de antibióticos. No contexto da pielonefrite obstrutiva associada à calculose ureteral, a conduta deve ser a passagem de um stent ureteral (cateter duplo J) em caráter de urgência. O objetivo dessa medida é drenar a urina infectada.

No momento da desobstrução de urgência, o cálculo que está levando à oclusão do fluxo urinário não costuma ser abordado. Afinal, os tecidos ureterais encontram-se inflamados, edematosos e friáveis, de tal modo que a tentativa de remoção do cálculo, nesse momento, pode levar à lesão ureteral.

Visto isso, vamos às alternativas.

A letra A está incorreta. Incorreta alternativa "a": Como vimos, a conduta para desobstrução nesse momento é a passagem de cateter duplo J. Além disso, a alternativa "A" não contempla a administração de antibióticos.

A letra B está incorreta. Incorreta alternativa “b”: A alternativa "B" também não menciona a desobstrução da via urinária através da passagem de cateter duplo J.

A letra C está incorreta. Incorreta alternativa “c”: Assim como a alternativa "A", a alternativa "C" também não menciona a passagem do cateter duplo J e a antibioticoterapia.

A letra D está incorreta. Incorreta alternativa “d” : A alternativa "D" não menciona a necessidade de antibioticoterapia.

A letra E está correta. Correta alternativa “e”: A alternativa "E" é a única que contempla a desobstrução do fluxo urinário através da passagem de cateter duplo J e antibioticoterapia.

Questão | | 2023 | 4000181597

Um paciente, vítima de acidente automobilístico, chega ao hospital trazido pela equipe de atendimento pré-hospitalar já intubado, hemodinamicamente instável e anisocórico. Na admissão, foi realizada tomografia computadorizada de crânio que mostrou imagem hiperdensa no encéfalo, próximo à calota craniana, em região parietal, de aspecto côncavo-convexo e com importante desvio de linha média. Qual é o diagnóstico e o tratamento mais indicado para esse paciente?

- A)** Hematoma epidural / Abordagem cirúrgica.
- B)** Hematoma subdural / Abordagem cirúrgica.
- C)** Hematoma intraparenquimatoso / Monitorização da pressão intracraniana.
- D)** Lesão axonal difusa / Abordagem cirúrgica.
- E)** AVC isquêmico / Manitol endovenoso.

Solução

Gabarito: B) Hematoma subdural / Abordagem cirúrgica.

GABARITO: ALTERNATIVA B

Olá, estrategista. Questão com gabarito oficial incorreto! Foi interposto recurso com o objetivo de mudança de gabarito, a priori, deferido.

Trata-se de um caso de TCE em que se descreve uma complicações hemorrágica do trauma. A descrição sem imagem contempla um sangramento "côncavo-convexo", o que é motivo de MUITA confusão. Aparentemente também confundiu quem fez o gabarito. Uma lesão côncavo-convexo é uma lesão em crescente, como se fosse uma letra C, o que ocorre no hematoma SUBDURAL. Já uma lesão biconvexa, como se fosse uma letra O, é o que ocorre

no hematoma EPIDURAL. Portanto, o enunciado descreve um hematoma subdural, não um epidural. De qualquer forma, haja vista o quadro de herniação vigente, o tratamento é cirúrgico!

A letra A está incorreta. INCORRETO. Apesar de ser o gabarito oficial, o hematoma epidural é biconvexo, não côncavo-convexo

A letra B está correta. CORRETO. Esse seria o gabarito correto.

A letra C está incorreta. INCORRETO. O hematoma intraparenquimatoso ocorre dentro do parênquima, não no compartimento extra-axial.

A letra D está incorreta. INCORRETO. A LAD manifesta-se a partir de petéquias, sobretudo em regiões centrais do encéfalo. Não corresponde ao descrito no enunciado

A letra E está incorreta. INCORRETO. O enunciado descreve um sangramento, não um evento isquêmico

Questão | | 2023 | 4000181598

Um paciente foi submetido a uma cirurgia abdominal, e o anestesista introduziu um cateter peridural para analgesia. O paciente se encontra na UTI utilizando heparina de baixo peso molecular como anticoagulação profilática, e a enfermeira questiona o médico plantonista se pode retirar o cateter. Nesse caso, qual é a conduta mais adequada e a respectiva justificativa?

- A)** Retirar o cateter, já que a anticoagulação profilática não interfere no risco para hematoma epidural.
- B)** Manter o cateter e solicitar orientação ao anestesista quanto ao momento da retirada, devido ao risco de hematoma epidural.
- C)** O cateter poderá ser removido se a última dose de heparina tiver sido realizada há mais de 3h.
- D)** Manter o cateter e aguardar, pelo menos, 48h, após a última dose da heparina para remover o cateter.
- E)** Manter o cateter por, pelo menos, 24h, após a última dose de heparina devido ao risco de hematoma subdural.

Solução

Gabarito: B) Manter o cateter e solicitar orientação ao anestesista quanto ao momento da retirada, devido ao risco de hematoma epidural.

GABARITO: ALTERNATIVA B

Estamos diante de uma questão sobre a anestesia do neuroeixo. Sabemos que a presença de coagulopatias ou o uso de anticoagulantes são contraindicações a esses métodos, em decorrência do risco de hematoma epidural e subdural.

Portanto, para pacientes em uso de heparina de baixo peso molecular em regime profilático, deve-se respeitar o intervalo de 12 horas para realização de anestesia do neuroeixo, assim como passagem ou retirada de cateter peridural.

Já para os pacientes em uso de heparina de baixo peso molecular em regime terapêutico anticoagulante, deve-se respeitar o intervalo de 24 horas para realização de anestesia do neuroeixo e a manutenção do cateter está contraindicada para esses pacientes. Ou seja, o cateter deverá ser removido antes do início da anticoagulação em regime terapêutico.

Visto isso, vamos às alternativas.

A letra A está incorreta. Incorreta alternativa “a”: Como vimos, a anticoagulação profilática interfere no risco da formação de hematoma peridural.

A letra B está correta. Correta alternativa “b”: Essa é a melhor conduta frente às alternativas apresentadas.

A letra C está incorreta. Incorreta alternativa “c”: Como vimos, o cateter só poderá ser removido após 12 horas da última dose profilática de heparina de baixo peso molecular.

A letra D está incorreta. Incorreta alternativa “d”: Não há necessidade de que se passem 48 horas. Como vimos, 12 horas são suficientes.

A letra E está incorreta. Incorreta alternativa “e”: Como vimos, 12 horas são suficientes. Além disso, há risco de hematoma peridural/epidural, e não subdural.

Questão | | 2023 | 4000181599

Em relação ao risco de contaminação, podemos classificar uma cirurgia eletiva de câncer de estômago com abordagem controlada da cavidade gástrica como

- A)** limpa.
- B)** contaminada.
- C)** potencialmente contaminada.

- D)** suja.
- E)** infectada.

Solução

Gabarito: C) potencialmente contaminada.

GABARITO: ALTERNATIVA C

Vamos aprender uns conceitos. O principal fator de risco para infecção de sítio cirúrgico (ISC) é o grau de contaminação da ferida operatória. Veja aqui como podemos classifica-la:

- **Limpa.** É aquela em que não há inflamação, é realizada em tecidos estéreis e que não ocorre penetração em vísceras ocas. Exemplos: neurocirurgias, revascularização miocárdica, hernioplastias, mamoplastias etc. Nesses casos, a probabilidade de infecção é baixa, girando em torno de 1% a 5%.
- **Limpa-contaminada ou potencialmente contaminada.** É a ferida em que houve abertura do sistema digestório ou genito-urinário, ou produzidas acidentalmente com arma branca com lesão inferior a 6 horas. O risco de infecção dessas cirurgias varia de 3% a 11%.
- **Contaminadas.** São aquelas feridas que têm reação inflamatória ou entraram em contato com um material contaminado como fezes, poeira ou outra sujidade. As lesões traumáticas que passaram das 6 horas entre o trauma e o atendimento também entram nessa classificação. O risco de infecção é de 10% a 17%.
- **Infectadas.** São aquelas em que há a presença de agente infeccioso no local e lesão com evidência de intensa reação inflamatória e destruição tecidual. Pode ter a presença de pus. Por exemplo, uma apendicectomia supurada se encaixa nesta classificação. Como o nome já diz, esse tipo de ferida já está infectada.

A letra A está incorreta. Alternativa A incorreta. Como é uma cirurgia oncológica, com abertura do trato digestório, essa cirurgia não é limpa.

A letra B está incorreta. Alternativa B incorreta. Não houve contato com material contaminado para classificar a cirurgia como contaminada.

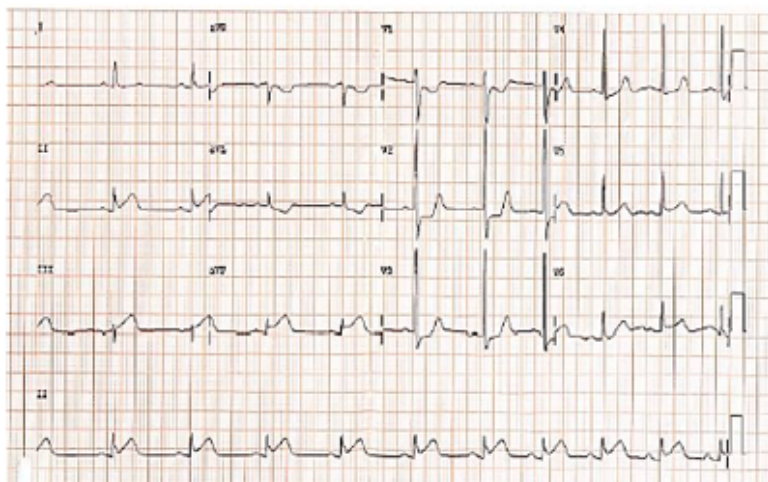
A letra C está correta. Alternativa C correta. Foi uma cirurgia eletiva com abordagem controlada da cavidade gástrica. Por isso essa cirurgia é limpa-contaminada.

A letra D está incorreta. Alternativa D incorreta. Cirurgia suja seria igual à contaminada, e que como já vimos, não se encaixa nessa classificação.

A letra E está incorreta. Alternativa E incorreta. Não há infecção no local, por isso a cirurgia é não considerada infectada.

Questão | | 2023 | 4000181600

Uma mulher de 78 anos procura atendimento médico de urgência com queixa de dor no estômago e náuseas há aproximadamente 2 horas, obtendo-se o seguinte ECG da paciente:



Nesse caso, considerando as informações apresentadas, é correto afirmar que

- A) se trata de uma colecistite aguda, e a paciente deve ser internada aos cuidados da cirurgia geral.
- B) uma opção de reperfusão coronariana deve ser indicada imediatamente.
- C) o uso de morfina e nitrato está indicado.
- D) uma endoscopia digestiva alta é prioritária.
- E) a paciente deve ser encaminhada para avaliação ambulatorial com um cardiologista.

Solução

Gabarito: B) uma opção de reperfusão coronariana deve ser indicada imediatamente.

GABARITO: ALTERNATIVA B

Estamos diante de uma **mulher idosa (78 anos)** com quadro de **dor no estômago, náuseas e supra do segmento ST localizado na parede inferior (DII, DIII e aVF)**. Apesar da dor torácica não ser típica, a principal hipótese diagnóstica é de **infarto agudo do miocárdio**. Sempre tenha em mente que determinados grupos de pacientes podem se apresentar com infarto do miocárdio e dor torácica atípica ou equivalente anginoso (dispneia, náuseas, vômitos, palidez, sudorese). São eles: **idosos, mulher, diabéticos, renais crônicos, transplantados cardíacos e pacientes com quadro demencial**.

No infarto agudo do miocárdio com supradesnívelamento do segmento ST (IAMCSST) ocorre obstrução aguda de uma artéria coronária devido ao rompimento de uma placa aterosclerótica, com consequente formação de trombo. O diagnóstico é feito pelo eletrocardiograma. **Não há necessidade de confirmação laboratorial através dos marcadores de necrose miocárdica (troponina, CKMB)!** Portanto, diante um ECG com supradesnívelamento do segmento ST e quadro clínico compatível, o diagnóstico de IAMCSST está confirmado.

O tratamento inicial consiste na administração de **antiplaquetários, anticoagulantes, analgesia e, principalmente, na reperfusão de emergência com fibrinolíticos ou**

angioplastia percutânea (padrão-ouro).

A letra A está incorreta. Incorreta a alternativa A: conforme discutido, a principal hipótese diagnóstica é de infarto agudo do miocárdio. A colecistite se apresenta com outros sinais e sintomas: dor tipo cólica em hipocôndrio direito, com defesa involuntária à palpação e sinal de Murphy (dor exacerbada na inspiração profunda durante a palpação do hipocôndrio direita, com interrupção da inspiração). Além disso, a colecistite não provoca supra de ST no ECG.

A letra B está correta. Correta a alternativa B: pois o tratamento consiste na reperfusão imediata através dos fibrinolíticos ou da angioplastia primária (padrão-ouro).

A letra C está incorreta. Incorreta a alternativa C: como o infarto ocorreu na parede inferior, devemos suspeitar de um possível acometimento do ventrículo direito. Nesse caso, a morfina e o nitrato não devem ser administrados.

A letra D está incorreta. Incorreta a alternativa D: pois o diagnóstico é de infarto com supra de ST. Não há acometimento gastrointestinal para se indicar endoscopia.

A letra E está incorreta. Incorreta a alternativa E: pois esse tipo de infarto requer tratamento imediato através da reperfusão coronariana.

Questão | | 2023 | 4000181601

Sobre o fenômeno (ou síndrome) de Eisenmenger, assinale a alternativa correta.

- A)** É muito comum nos casos de infarto agudo do miocárdio.
- B)** Uma das principais características clínicas é a cianose de extremidades.
- C)** É comum nos casos de comunicação interventricular, sendo caracterizado pelo *shunt* esquerda-direita.
- D)** Foi descrito por Frederick Eisenmenger em 1973 em estudo publicado após análise de 52 casos de cardiopatias congênitas cianóticas.
- E)** O tratamento com inibidores da enzima conversora de angiotensina (iECA) está indicado.

Solução

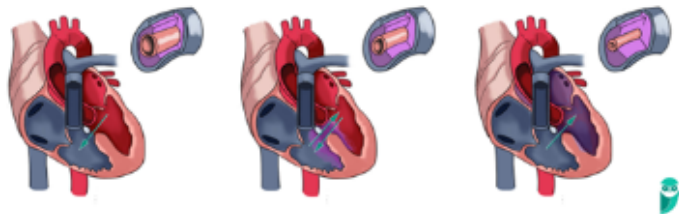
Gabarito: B) Uma das principais características clínicas é a cianose de extremidades.

GABARITO: ALTERNATIVA B

Comentário:

A síndrome de Eisenmenger é a forma mais avançada de hipertensão pulmonar ligada a defeitos cardíacos congênitos. Ela é caracterizada pelo aumento da pressão pulmonar até

níveis sistêmicos, resultante do aumento da resistência vascular pulmonar, com shunt venoso reverso (direita-esquerda) ou bidirecional através de um defeito congênito.



A letra A está incorreta. Incorreta a alternativa A: pois esse fenômeno está relacionado a cardiopatias congênitas com shunt esquerda-direita: CIA, CIV, persistência do canal arterial (PCA) e defeito do septo atrioventricular total.

A letra B está correta. Correta a alternativa B: a cianose de extremidades é marcante na síndrome de Eisenmenger, especialmente nos casos de PCA. Isto ocorre porque o sangue venoso passa através do canal e entra na aorta distal às artérias subclávias, resultando em leitos ungueais róseos à direita (mais que à esquerda) e cianose e baqueteamento em ambos os pés, constituindo a chamada “cianose diferencial”.

A letra C está incorreta. Incorreta a alternativa C: pois o shunt ocorre do lado direito em direção ao esquerdo.

A letra D está incorreta. Incorreta a alternativa D: a Sd de Eisenmenger que apresentava cianose e dispneia desde a infância e que faleceu aos 32 anos de idade com hemoptise maciça.

A letra E está incorreta. Incorreta a alternativa E: o princípio básico do tratamento clínico é de evitar quaisquer fatores que possam desestabilizar a fisiologia cardíaca. Por isso, as principais intervenções devem ser direcionadas para evitar complicações (ex. vacinas contra a gripe e pneumocócica) ou para restaurar o equilíbrio fisiológico (ex: reposição de ferro nas carências desse mineral, tratamento antiarrítmico e diuréticos para insuficiência cardíaca). Nos casos de hipoxemia grave ou insuficiência cardíaca, a principal intervenção disponível é o transplante de pulmão (além do reparo do defeito cardíaco) ou, com resultados um pouco melhores, o transplante coração-pulmão.

Questão | | 2023 | 4000181602

Em relação à classificação da insuficiência cardíaca, segundo a American Heart Association (AHA), é correto afirmar que

- A)** um homem de 56 anos, com fração de ejeção (FE) de 36% no ecocardiograma, é considerado classe A.
- B)** uma mulher caucasiana de 61 anos, com hipertensão arterial e sem alterações no ECG e/ou no ecocardiograma, é considerada classe C.

- C)** uma mulher de 42 anos, portadora de miocardiopatia puerperal, com FE de 18% e quadro clínico refratário ao tratamento clínico otimizado, é considerada classe D.
- D)** a presença de alterações cardíacas estruturais, sem sintomas de insuficiência cardíaca, é considerada classe C.
- E)** a presença de dispneia aos pequenos esforços é considerada classe III.

Solução

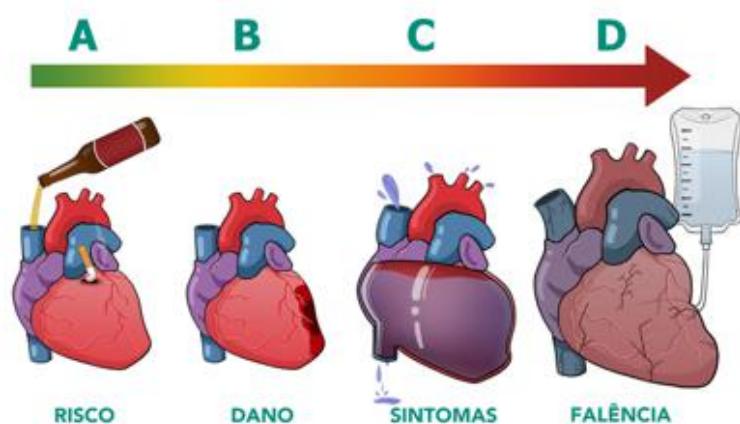
Gabarito: C) uma mulher de 42 anos, portadora de miocardiopatia puerperal, com FE de 18% e quadro clínico refratário ao tratamento clínico otimizado, é considerada classe D.

GABARITO: ALTERNATIVA C

Fala estrategista,

Temos uma questão que cobra seu conhecimento sobre os estágios da insuficiência cardíaca. Ela leva em consideração a presença de sintomas e o dano cardíaco:

Estágios da insuficiência Cardíaca



Vamos ver as alternativas:

A letra A está incorreta. Alternativa "a" incorreta: paciente já tem fração de ejeção reduzida, portanto, já teve dano ao coração. Com isso, está no estágio B (já que não há descrição de sintomas)

A letra B está incorreta. Alternativa "b" incorreta: paciente não tem dano cardíaco, mas está sob risco visto que é hipertensa. Portanto, estágio A.

A letra C está correta. Alternativa "c" correta: paciente já tem fração de ejeção reduzida e está refratário ao tratamento clínico, configurando falência, portanto, estágio D.

A letra D está incorreta. Alternativa "d" incorreta: paciente com dano cardíaco mas sem sintomas, configura estágio B.

A letra E está incorreta. Alternativa "e" incorreta: paciente com sintomas configura estágio C.

Questão | | 2023 | 4000181603

Um homem de 75 anos, portador de estenose mitral grave, procura atendimento médico com queixa de dispneia e lipotímia. Sobre o exame físico desse paciente, é correto afirmar que

- A) a presença de estalido de abertura precoce é frequente.
- B) a hipofonese de B1 é comum.
- C) sinais de insuficiência cardíaca esquerda são comuns.
- D) o exame físico costuma ser normal.
- E) a hipofonese de B2 é característica.

Solução

Gabarito: A) a presença de estalido de abertura precoce é frequente.

GABARITO: ALTERNATIVA A

Comentário:

A definição da estenose mitral (EMi). Trata-se de um transtorno da valva em que, durante a diástole, sua abertura se encontra limitada.

Quanto à etiologia, essa valvopatia, no Brasil, apresenta praticamente uma única causa. Segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia, 95% dos casos de estenose mitral têm origem reumática.

O sintoma mais comum é a **dispneia**, que pode vir associada a sintomas clássicos de **insuficiência cardíaca**, como ortopneia e dispneia paroxística noturna (sensação de afogamento à noite que melhora após se levantar). Frequentemente, por haver tanta sobrecarga atrial esquerda, os pacientes podem desenvolver também **fibrilação atrial** e reclamarem de palpitações.

No exame físico, podemos encontrar alguns sinais clássicos de insuficiência cardíaca, como **crepitações pulmonares**, **edema de membros inferiores**, **hepatomegalia**, **turgência jugular patológica**, **refluxo hepatojugular** etc. A ausculta cardíaca mostra diversos achados: a **primeira bulha (B1)** é **hiperfonética** em foco mitral. Porém, em fases tardias da doença, quando a estenose se torna mais importante e há um aumento da calcificação, a primeira bulha pode se normalizar. Além disso, a abertura da valva também produz um ruído, conhecido como **estalido de abertura da valva mitral**. O sopro da estenose mitral é **diastólico**, em ruflar, com **reforço pré-sistólico**, mais audível com a campânula, em foco mitral e em decúbito lateral esquerdo. Esse reforço acontece, já que, ao final da diástole, o átrio esquerdo se contrai e, dessa forma, acelera a passagem de sangue pela valva mitral estenosada.

Resumidamente, as palavras-chave da ausculta cardíaca na estenose mitral são: sopro diastólico, com reforço pré-sistólico, estalido de abertura e B1 hiperfonética.

A letra A está correta. Correta a alternativa A: o estalido de abertura precoce está presente na da EMI grave.

A letra B está incorreta. Incorreta a alternativa B: pois a B1 encontra-se hiperfonética.

A letra C está incorreta. Incorreta a alternativa C: a banca tornou confusa essa alternativa, o que abre margem para recurso. Como comentado, o paciente apresenta **sintomas** de insuficiência como ortopneia e dispneia paroxística noturna. Na EMI, o ventrículo esquerdo (VE) é poupado e seu tamanho é normal, pois pouco sangue chega até ele. Frequentemente, sua função está preservada (não há insuficiência do VE). Os sinais mais clássicos na EMI avançada são de insuficiência cardíaca **direita**, como **edema de membros inferiores, hepatomegalia, turgência jugular patológica, refluxo hepatojugular**.

A letra D está incorreta. Incorreta a alternativa D: pois o exame físico apresenta diversas alterações, como descrito no comentário.

A letra E está incorreta. Incorreta a alternativa E: pois a B2 encontra-se **hiperfonética**, devido ao aumento da pressão capilar pulmonar.

Questão | | 2023 | 4000181604

Um homem de 24 anos procura atendimento médico com queixa de falta de ar e boca seca. Sua glicemia capilar é aferida, 467mg/dL. Nega doenças prévias ou uso de medicações. Diante desse caso, assinale a alternativa correta.

- A)** A presença de acidose respiratória é comum nesses casos.
- B)** O uso de insulina de ação rápida pode levar ao aumento do potássio sérico.
- C)** A restrição hídrica está indicada nesse caso.
- D)** A dosagem da hemoglobina glicosilada é essencial para determinar a conduta correta.
- E)** Os títulos de anticorpos antidescarboxilase do ácido glutâmico (GADA) são importantes para o diagnóstico de LADA (*latent autoimmune diabetes of the adult*).

Solução

Gabarito: E) Os títulos de anticorpos antidescarboxilase do ácido glutâmico (GADA) são importantes para o diagnóstico de LADA (*latent autoimmune diabetes of the adult*).

GABARITO: ALTERNATIVA E

Fala, Estrategista! Tudo bem? Questão difícil sobre diabetes mellitus.

Somos apresentados em uma questão com um paciente com sinais de desidratação e hiperglicemia importante. Isso já são sinais clínicos e laboratoriais que nos devem fazer suspeitar da hipótese de diabetes mellitus.

Nas alternativas nos somos apresentados com afirmativas possíveis sobre o quadro clínico do enunciado da questão. Vamos destrinchar uma a uma para avaliar se são corretas ou incorretas.

A letra A está incorreta.

ALTERNATIVA INCORRETA

Nos quadros de diabetes mellitus devemos pensar na hipótese de acidose metabólica. Estamos diante de um paciente jovem na qual a hipótese de diabetes mellitus tipo 1 ainda é possível, mas algo improvável. A hipótese de LADA (latent autoimmune diabetes of the adult) é mais forte. De todo modo, a descompensação do diabetes gera acidose metabólica e muito comumente alcalose respiratória como tentativa de compensação.

A letra B está incorreta.

ALTERNATIVA INCORRETA

A insulina é um hormônio que acaba por gerar hipocalemia e não aumentar o potássio sérico. A insulina age na bomba $\text{Na}^+\text{K}^+\text{ATPase}$ o que acaba provocando em um shift de potássio para o meio intracelular.

A letra C está incorreta.

ALTERNATIVA INCORRETA

Estamos diante de um quadro de descompensação do diabetes, com possibilidade de cetoacidose diabética. Devemos realizar hidratação vigorosa, e não restrição hídrica.

A letra D está incorreta.

ALTERNATIVA INCORRETA

Não é necessário sabermos a dosagem de hemoglobina glicosilada para realizar a conduta correta. A HbA1C avalia a glicemia média dos últimos 3 meses e não apresenta valia em descompensações agudas.

A letra E está correta.

ALTERNATIVA CORRETA

A presença de anticorpos específicos como o anti GADA são importantes no diagnóstico de LADA. Estamos com um paciente com quadro clínico compatível com possível cetoacidose diabética o que em geral ocorre em situações de insulinopenia absoluta.

Esses cenários clínicos nos devem pensar em DM1 ou em LADA. Como temos um paciente com idade já superior a 18 anos o diagnóstico de LADA torna-se o mais provável e a investigação deve ser realizada.

A LADA ocorre em pacientes adultos com positividade para autoanticorpos contra as células beta (o mais frequente é o anti-GAD65) e que, inicialmente, não necessitam de insulinização, como acontece com os demais pacientes DM tipo 1. Além disso, apresenta genes relacionados tanto ao DM tipo 1 quanto ao DM tipo 2, levantando a hipótese de que o LADA seja um espectro de doença entre o DM tipo 1 e o tipo 2.

A apresentação clínica também é variada; pacientes com altos títulos de anti-GAD65 geralmente têm perfil mais parecido com os de DM tipo 1: magros, evoluem mais rapidamente para a insulinização e têm maior risco de cetoacidose. Já os pacientes com baixos títulos de anti-GAD65 tendem a responder melhor a antidiabéticos orais

Questão | | 2023 | 4000181605

Em relação ao hipotireoidismo, é correto afirmar que

- A)** é muito importante solicitar tireoglobulina sérica na avaliação inicial de nódulos de tireoide.
- B)** a dosagem do T3 reverso (rT3), na avaliação de função tireoideana, é essencial.
- C)** não devem ser repetidos exames de autoanticorpos [antitireoperoxidase (Anti-TPO) e/ou antitireoglobulina] no seguimento de pacientes com hipotireoidismo por tireoidite de Hashimoto com exame anterior positivo.
- D)** é essencial a dosagem de tri-iodotironina (LT3), isolada ou em associação com levotiroxina (LT4), no tratamento de hipotireoidismo.
- E)** a dosagem de marcadores moleculares, na avaliação inicial de pacientes com nódulo de tireoide, é muito importante para o plano terapêutico.

Solução

Gabarito: C) não devem ser repetidos exames de autoanticorpos [antitireoperoxidase (Anti-TPO) e/ou antitireoglobulina] no seguimento de pacientes com hipotireoidismo por tireoidite de Hashimoto com exame anterior positivo.

A letra A está incorreta.

ALTERNATIVA INCORRETA

Na avaliação de nódulos tireoidianos devemos avaliar o TSH. A tireoglobulina não nos auxilia nessa análise.

Função tireoidiana:

TSH normal ou elevado: avaliar características do nódulo para indicar PAAF ou seguimento

TSH baixo: cintilografia da tireoide para avaliar a presença de nódulo hiper funcionante

A letra B está incorreta.

ALTERNATIVA INCORRETA

O T3 reverso apresenta apenas utilidade na síndrome do eutireoideo doente, não apresentando utilidade na avaliação da função tireoidiana.

A síndrome do eutireoideo doente (SED) apresenta-se de maneira semelhante a um quadro de hipotireoidismo central. A única diferença entre ambas as situações é que na SED encontraríamos níveis de T3 reverso elevados, devido ao aumento da conversão periférica de T4 para essa forma hormonal metabolicamente inativa. Essa é a razão pela qual devemos evitar a avaliação da função tireoidiana em pacientes com doenças críticas ou doenças crônicas agudizadas.

A letra C está correta.

ALTERNATIVA CORRETA

Após uma única dosagem de autoanticorpos positivos e clínica compatível, já temos o diagnóstico firmado. Não se faz necessário repetição do exame.

A letra D está incorreta.

ALTERNATIVA INCORRETA

Para avaliação de hipotireoidismo, não se faz necessária a dosagem de T3. Ela não irá nos auxiliar no manejo.

A letra E está incorreta. ALTERNATIVA INCORRETA

Na avaliação de nódulos tireoidianos devemos avaliar o TSH. A avaliação de marcadores moleculares não nos ajudam no manejo de nódulos de tireoide.

Função tireoidiana:

TSH normal ou elevado: avaliar características do nódulo para indicar PAAF ou seguimento

TSH baixo: cintilografia da tireoide para avaliar a presença de nódulo hiper funcionante

Questão | | 2023 | 4000181606

Um homem de 27 anos é levado ao pronto atendimento após queda de nível elevado. Depois de assegurar uma via aérea pérvia, a imobilização da coluna cervical e a checagem dos sinais vitais, a resposta ao exame neurológico é a seguinte: flexão normal, sons irreconhecíveis e abertura ocular (todos após estímulos dolorosos).

Diante do exposto, assinale a alternativa correta.

- A)** A tomografia de crânio é importante para determinar a escala de coma de Glasgow desse paciente.
- B)** O homem apresenta um traumatismo crânioencefálico (TCE) leve e pode ser liberado com segurança.
- C)** A avaliação do médico neurocirurgião é essencial para a definição entre TCE leve, moderado ou grave.
- D)** O homem apresenta 8 pontos na escala de coma de Glasgow.
- E)** Uma tomografia de coluna cervical é importante para determinar a escala de coma de Glasgow desse paciente.

Solução

Gabarito: D) O homem apresenta 8 pontos na escala de coma de Glasgow.

GABARITO: ALTERNATIVA D

Estrategista, questão direta sobre TCE. Vamos aproveitar para revisar alguns aspectos relacionados à classificação do TCE e indicação de neuroimagem.

Diferentemente do que ocorre em pacientes vítimas de TCE moderado ou grave, não são todos os pacientes com TCE leve que têm indicação de tomografia de crânio. A decisão depende da presença de alguns fatores, o que pode variar de acordo com a diretriz utilizada. Antes de estudarmos as indicações de neuroimagem no paciente com TCE leve, vamos lembrar a classificação do TCE, baseada na escala de coma de Glasgow, conforme abaixo:

TCE Leve ECG 13, 14 ou 15

TCE Moderado ECG 9 a 12

TCE grave ECG 3 a 8

Vale a ressalva de que em algumas literaturas, a classificação de TCE leve engloba apenas os pacientes com ECG 14 ou 15.

O exame de tomografia de crânio sem contraste, nos pacientes com TCE leve, deverá ser realizado naqueles pacientes com maior risco de lesão estrutural cerebral. De acordo com o Canadian CT score Rule, um dos algoritmos mais usados, as principais indicações são:

- ECG < 15 após 2 horas do trauma
- Suspeita de fratura aberta do crânio
- Sinais sugestivo de fratura de base de crânio (hemotimpano, hematoma periorbitário (sinal do olho de guaxinim), hematoma retroauricular (sinal de Battle), oto ou rinorreia.
- Ao menos dois episódios de vômitos
- Idade superior a 65 anos
- Amnésia anterógrada superior a 30 minutos
- Mecanismo de alto impacto (atropelamento, acidente automobilístico com ejeção do veículo, queda de altura superior a 1 metro).

Além disso, a presença de crise epiléptica, déficit neurológico focal ou o uso de anticoagulantes também indicam a demanda de neuroimagem. Critérios como cefaleia,

intoxicação etílica e alteração comportamental são menos validados e geralmente não são, isoladamente, indicativos de necessidade de realização de neuroimagem.

Na questão apresentada, temos um paciente com escala de coma de Glasgow de 8 pontos: flexão normal (retirada inespecífica = 4 pontos + abertura ocular à dor = 2 pontos + resposta verbal com sons irreconhecíveis = 2 pontos). Vamos às alternativas para eliminarmos confusões:

A letra A está incorreta. INCORRETO. A classificação do TCE é baseada apenas na escala de coma de Glasgow, não depende da tomografia de crânio! Na verdade, a classificação do TCE é que indicará quando a TC de crânio estará indicada.

A letra B está incorreta. INCORRETO. Trata-se de um TCE grave! De forma alguma um TCE leve, tampouco o paciente pode ser liberado.

A letra C está incorreta. INCORRETO. A avaliação do Glasgow deve e pode ser feita por qualquer médico emergencista. Não há necessidade de avaliação pelo neurocirurgião para tanto.

A letra D está correta. CORRETO. Exatamente. Conforme descrito acima.

A letra E está incorreta. INCORRETO. A definição da gravidade do TCE é baseada em aspectos clínicos. Não depende de TC de crânio ou de coluna cervical.

Questão | | 2023 | 4000181607

Um homem de 63 anos, recebendo medicação para dor epigástrica na sala de observação do pronto atendimento, apresenta um colapso ao levantar-se da poltrona. Qual é a conduta imediata mais adequada nesse caso?

- A)** Realizar um eletrocardiograma de 12 derivações.
- B)** Checar a responsividade.
- C)** Aplicar 1mg de epinefrina EV.
- D)** Iniciar compressões torácicas.
- E)** Solicitar avaliação da cardiologia.

Solução

Gabarito: B) Checar a responsividade.

GABARITO: ALTERNATIVA B

Comentário:

Questão clássica de prova!

O **primeiro passo** diante de uma possível parada cardiorrespiratória (PCR) é avaliar a **segurança do local**. Veja, ao atender o paciente, se você não vai colocar sua própria vida em risco. Nesse caso clínico, o ambiente é seguro, pois o paciente está na sala de observação do pronto socorro.

Depois disso, faça uma breve análise se o **paciente está respondendo**. Pergunte “você está bem?”, toque em seus ombros e cheque se, em 10 segundos, você observa movimentos respiratórios. Caso o paciente esteja irresponsivo, certamente você precisará de **ajuda**. Juntamente com o acionamento de ajuda, solicite que tragam o DEA (desfibrilador externo automático), se houver um disponível. Só depois de todos esses passos é que você **checará o pulso** e, caso este esteja ausente, **iniciará as compressões torácicas primeiro**, intercaladas com as ventilações (30 compressões para 2 ventilações). Se o DEA chegar, pare as compressões brevemente, instale as pás do aparelho e siga as instruções.

Resumindo, a sequência de atuação diante de uma possível PCR é **C-A-B-D**, sendo que a letra C possui 5 etapas.

- **Checar segurança (1);** checar responsividade (2); chamar ajuda (3); checar pulso (4); compressões torácicas (5).
- **Abrir vias aéreas.**
- **Boas ventilações.**
- **Desfibrilação precoce (se indicada).**

A letra A está incorreta. Incorreta a alternativa A: o ECG será realizado durante o atendimento. No momento do colapso, a prioridade é a abordagem do paciente (C-A-B-D).

A letra B está correta. Correta a alternativa B: após checar a segurança do local, o próximo passo é checar a responsividade do paciente.

A letra C está incorreta. Incorreta a alternativa C: pois ainda não está caracterizada uma PCR.

A letra D está incorreta. Incorreta a alternativa D: esse é o último passo (passo 5) da letra C.

A letra E está incorreta. Incorreta a alternativa E: No momento do colapso, a prioridade é a abordagem do paciente (C-A-B-D).

Questão | | 2023 | 4000181608

Sobre a dor, assinale a alternativa correta.

- A)** Os nociceptores são responsáveis pela transdução.
- B)** A dor neuropática tem como principal característica a melhora à noite e nos meses mais frios.
- C)** A migrânea é um exemplo clássico de dor somática superficial.
- D)** A pregabalina atua nos receptores opioides do sistema nervoso central, principalmente $\mu 1$ e $\mu 2$.

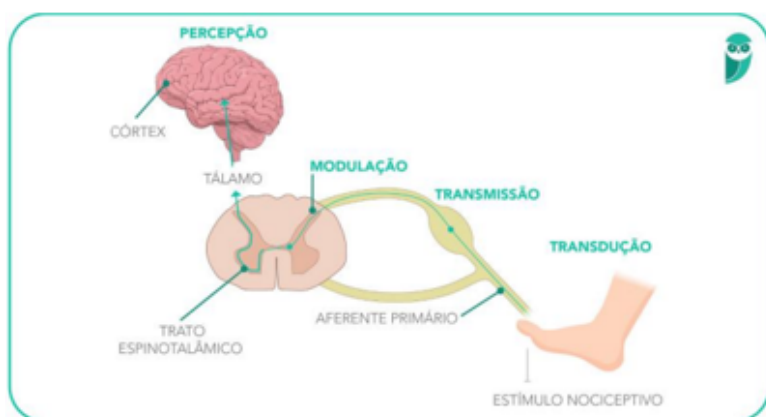
E) A presença de injúria tecidual é essencial para a explicação do fenômeno doloroso.

Solução

Gabarito: A) Os nociceptores são responsáveis pela transdução.

GABARITO: ALTERNATIVA A

A letra A está correta. Correta A: a dor nociceptiva apresenta 4 etapas: transdução, transmissão, modulação e percepção. A transdução é a primeira etapa e envolve o recebimento do estímulo doloroso pelo nociceptor e a transformação em potencial de ação. No esquema abaixo fica mais fácil compreender todo o caminho percorrido desde a formação do estímulo doloroso até sua interpretação no encéfalo.



A letra B está incorreta. Incorreta a alternativa B: a dor neuropática tem como algumas de suas características piorar à noite e piorar com o tempo frio.

A letra C está incorreta. Incorreta a alternativa C: a migrânea tem uma fisiopatologia complexa que envolve diversos mecanismos intra e extracranianos. A dor somática superficial tem origem na estimulação de nociceptores na pele e, no caso da migrânea, atualmente entende-se que sua principal origem envolve eventos neuronais no encéfalo, como hiperexcitação cortical e ativação do sistema trigeminovascular e tronco cerebral.

A letra D está incorreta. Incorreta a alternativa D: a pregabalina é um gabapentinoide que atua na modulação dos canais de cálcio e não tem relação com receptores opioides.

A letra E está incorreta. Incorreta a alternativa E: a definição mais atual de dor da IASP (Associação Internacional para o Estudo da Dor) traz “uma experiência sensitiva e emocional desagradável associada, ou semelhante àquela associada, a uma lesão tecidual real ou potencial”. Ou seja, a injúria tecidual não é necessária e a dor nociplástica, principal mecanismo fisiopatológico envolvido na fibromialgia, é exemplo disso.

Um homem de 62 anos é levado ao hospital com história de perda de força em dimídio direito, afasia e desvio de rima labial, de início há aproximadamente 40min. Após a realização de uma tomografia computadorizada de crânio (normal, com laudo oficial do radiologista), seus sinais vitais são os seguintes:

- PA: 192x124 mmHg;
- Glicemia capilar: 88 mg/dL;
- NIHSS: 18 pontos.

Nesse caso, qual é a conduta mais adequada?

- A) Chamar o neurologista de plantão.
- B) Uso de um comprimido de nifedipina 20 mg sub-lingual.
- C) Uso de 300 mg de ácido acetilssalicílico (AAS) por via oral.
- D) Uso de 20 mg de rivaroxabana por via oral.
- E) Controle da pressão arterial com medicação endovenosa – alvo abaixo de 180x100 mmHg – seguido de trombólise com alteplase 9 mg/Kg, na ausência de contraindicações.

Solução

Controle da pressão arterial com medicação endovenosa – alvo abaixo de 180x100

Gabarito: E) mmHg – seguido de trombólise com alteplase 9 mg/Kg, na ausência de contraindicações.

GABARITO: ALTERNATIVA E

Estrategista, questão que deve ser anulada pela banca. Traz um erro de grafia na dose do trombolítico. A dose do alteplase é de 0,9 mg/Kg, não de 9 mg/Kg!

Vejamos cada alternativa.

A letra A está incorreta. INCORRETO. Na verdade, não é uma afirmação, de todo, incorreta. De fato, chamar o neurologista de plantão é o que ocorreria na grande maioria dos hospitais. Fato é que não seria necessário, tampouco parece ser a melhor conduta em uma questão de prova de Residência, desenhada para avaliar os conhecimentos de um candidato. Trata-se de um AVC isquêmico em janela para trombólise EV. Antes de proceder com a trombólise, a pressão arterial deveria ser reduzida, com droga EV (nupride) e uma vez que fique abaixo de 180x100 mmHg, autorizaria o início da trombólise.

A letra B está incorreta. INCORRETO. De modo algum. A redução da PA, de fato necessária para autorizar a trombólise, deveria ser feita com drogas EV, sobretudo com nitroprussiato de sódio (nupride)

A letra C está incorreta. INCORRETO. De maneira alguma! AAS 100mg, não 300, estará indicado após 24 horas da trombólise como estratégia de profilaxia "genérica" até que se busque a causa do AVC e se defina a profilaxia secundária adequada a longo prazo.

A letra D está incorreta. INCORRETO. De maneira alguma. A anticoagulação só estará indicada, como profilaxia secundária, em casos selecionados, apenas nos pacientes com AVC de causa cardioembólica, como por exemplo ocorre nos portadores de fibrilação atrial. Ainda assim, tal estratégia só poderá ser iniciada após a espera de alguns dias, dependendo do tamanho da isquemia, para evitar o risco de transformação hemorrágica. Em outras palavras, nas primeiras 24 horas em um paciente trombolisado, NÃO fazemos nem AAS e nem anticoagulante.

A letra E está correta. INCORRETO. Está tudo correto, exceto a dose do trombolítico! A dose é de 0,9 mg/Kg, não de 9mg /Kg.

Questão | | 2023 | 4000181610

Uma mulher de 71 anos, com histórico de DPOC, procura atendimento médico com queixa de falta de ar. O resultado da gasometria arterial é o seguinte:

- pH: 7,25;
- CO₂: 62;
- BIC: 35.

Nesse caso, é correto afirmar que

- A) se trata de uma alcalose metabólica.
- B) a gasometria está normal.
- C) se trata de uma acidose metabólica.
- D) se trata de uma acidose respiratória crônica, provavelmente agudizada.
- E) está indicada reposição de bicarbonato EV.

Solução

Gabarito: D) se trata de uma acidose respiratória crônica, provavelmente agudizada.

GABARITO: ALTERNATIVA D

Caro Estrategista, temos aqui mais uma questão que aborda a interpretação da gasometria arterial. Vamos seguir o passo a passo:

Passo 1: olhar o pH. O enunciado nos forneceu um pH de 7,25. A faixa normal do pH plasmático é entre 7,35 e 7,45. Estamos diante de uma **acidemia**.

Passo 2: encontrar o distúrbio primário. Uma acidemia deve nos levar à busca de duas condições: uma redução dos níveis de bicarbonato (acidose metabólica) ou um aumento nos

níveis de pCO_2 (acidose respiratória). O que encontramos é um pCO_2 de 62 (valores normais entre 35-45mEq/L). Concluimos então, que o **distúrbio primário trata-se de uma acidose respiratória**.

Passo 3: existe compensação metabólica para o distúrbio respiratório? Perceba que, para o bicarbonato esteja alterado, certamente esse distúrbio é **antigo**, pois a compensação metabólica demora de 3 a 5 dias, no mínimo, para ocorrer. O fato da paciente ter DPOC é um forte indício de que essa alteração no bicarbonato é antiga. O interessante de se perceber é que o **pH** está em acidemia. Isso significa que a paciente deve estar com a DPOC agudizada, o que promove obstrução brônquica, retenção de pCO_2 e queda ainda mais acentuada do pH!

Vamos às alternativas.

A letra A está incorreta. Incorreta. O distúrbio primário é uma acidose respiratória!

A letra B está incorreta. Incorreta. Todos os parâmetros da gasometria estão alterados.

A letra C está incorreta. Incorreta. A acidose presente no caso é respiratória, provocada pelo aumento do pCO_2 .

A letra D está correta. Correta. A acidose é crônica pela doença pulmonar crônica e retenção continuada de CO_2 . Sabemos que a agudização da DPOC exacerba a obstrução brônquica e leva ao acúmulo ainda maior de CO_2 .

A letra E está incorreta. Incorreta. A administração de bicarbonato pode ser considerada em casos de acidose metabólica. Administrar bicarbonato em pacientes com acidose respiratória pode **piorar** a acidose, por aumentar transitoriamente a produção de CO_2 .

Questão | | 2023 | 4000181611

Sobre a neuromielite óptica, assinale a alternativa correta.

- A)** É uma forma de apresentação da Esclerose Múltipla.
- B)** Pleocitose é bastante específica para o diagnóstico.
- C)** Também é conhecida como síndrome de Devic.
- D)** A presença de paralisia espástica é frequente.
- E)** A tomografia de crânio apresenta alterações específicas.

Solução

Gabarito: C) Também é conhecida como síndrome de Devic.

GABARITO: ALTERNATIVA C

Estrategista, péssima questão. Aliás, como toda a prova da ENARE desse ano, lamentável. A questão cobra sobre neuromielite óptica.

Essa entidade, também conhecida por doença de Devic, é marcada pelo acometimento imunomediado (frequentemente associado à presença de anticorpos anti aquaporina 4) do sistema nervoso central. As regiões com maior expressão do antígeno aquaporina 4 são as mais afetadas, notadamente o nervo óptico e a medula espinal, daí o nome neuromielite óptica.

A alternativa C, gabarito oficial, diz que a condição também é conhecida como síndrome de Devic. Muito embora o termo “síndrome” seja usado de maneira intercambiável com o termo “doença”, o que não necessariamente é verdadeiro, tal referência é consagrada na literatura, por isso, a afirmação é correta. Entretanto, a alternativa D, também traz uma informação verdadeira. O termo “paralisia” descreve fraqueza muscular que quando adicionado do adjetivo “espástica” se refere a uma fraqueza cuja causa é a lesão do neurônio motor superior. Entretanto, é um termo genérico. A paralisia espástica é uma classificação de uma estrutura, o que não está descrito na alternativa. Em outras palavras: paralisia espástica de qual parte do corpo? Das pernas (paraparesia espástica)?, de um membro apenas (monoparesia espástica)?, dos quatro membros (tetraparesia espástica)?.

Fato é que a mielite, como a causada pela neuromielite óptica, é causa de “paralisia espástica” seja qual for a região. Entendo que existem pacientes com a referida doença que de forma paradoxal, não desenvolvem espasticidade, posto que há expressão de aquaporina 4 no corno anterior da medula, podendo levar a quadro de “paralisia arreflexa”. Na prática clínica, essa peculiaridade semiológica alerta o clínico para o fato de que na neuromielite óptica é possível a presença de uma fraqueza flácida, contudo, definitivamente, não invalida o fato de que a paralisia espástica não só é possível como é muito mais frequente. Sendo assim, o gabarito deveria incluir ambas as alternativas como corretas.

A letra A está incorreta. INCORRETO. No passado, a neuromielite óptica era descrita como um fenótipo da Esclerose Múltipla, contudo, a partir dos trabalhos de Devic, conclui-se que a presença do anticorpo antiaquaporina 4 caracterizava essa diferente entidade imunomediada.

A letra B está incorreta. INCORRETO. Pode ocorrer pleocitose, contudo, não é um achado específico para o diagnóstico.

A letra C está correta. CORRETO. Conforme visto acima, a doença também é conhecida como doença de Devic.

A letra D está incorreta. INCORRETA. Sim! Bastante frequente. Embora tenha sido apontada como incorreta pela banca, com certeza, essa alternativa deveria ser considerada correta.

A letra E está incorreta. INCORRETO. Assim como para outras doenças desmielinizantes do sistema nervoso central, o exame de escolha para a investigação é a ressonância magnética.

Questão | | 2023 | 4000181612

Um homem de 56 anos procura atendimento médico por crise de artrite gotosa, apresentando sinais clássicos de podagra. Sobre o tratamento para esse caso, é correto afirmar que

- A)** a colchicina está contraindicada se o paciente for portador de doença renal crônica e estiver em uso contínuo de carvedilol.
- B)** o uso de corticosteroides por via oral não é recomendado.
- C)** o alopurinol está indicado durante a crise aguda.
- D)** o uso de inibidores de interleucina-1 é considerado tratamento de primeira escolha.
- E)** a prednisona está indicada na dose de 5mg por via oral em dias alternados

Solução

Gabarito: A) a colchicina está contraindicada se o paciente for portador de doença renal crônica e estiver em uso contínuo de carvedilol.

GABARITO: ALTERNATIVA A

A letra A está correta. Correta a alternativa A: drogas que atuam inibindo a glicoproteína P, como o Carvedilol, aumentam a biodisponibilidade da Colchicina, especialmente em pacientes com redução do clearance de creatinina, elevando risco de toxicidade. Por isso, há contraindicação ao uso da Colchicina em pacientes com qualquer grau de doença renal crônica e em uso de medicações que inibam a glicoproteína P. Fique tranquilo caso você não soubesse desses detalhes porque, de fato, é algo muito específico. De qualquer forma, conseguiríamos chegar ao gabarito por exclusão das demais. Vamos em frente!

A letra B está incorreta. Incorreta a alternativa B: corticoide, assim como o anti-inflamatório não esteroide e a colchicina, são as drogas de escolha para o tratamento da crise aguda de gota. A escolha de cada um deles recairá sobre eventuais comorbidades e contraindicações que o paciente apresente.

A letra C está incorreta. Incorreta a alternativa C: o Alopurinol é uma droga uricorrredutora que atua inibindo a produção do ácido úrico. Não possui qualquer ação anti-inflamatória e, por isso, não está indicada para controle da crise aguda. Não confunda esta informação com a recomendação condicional do último guideline lançado em 2020 pelo Colégio Americano de Reumatologia (ACR). Nesta recomendação os autores pesam o custo-benefício de uma eventual piora clínica após introdução de alopurinol durante a crise e o abandono do seguimento clínico após o tratamento da crise. Existem estudos pequenos mostrando tanto piora do quadro clínico, quanto ausência de impacto significativo. Por isso, a introdução do Alopurinol na vigência de crise ou após a sua resolução deve ser avaliada individualmente.

A letra D está incorreta. Incorreta a alternativa D: o uso de inibidores da interleucina-1, como o canakinumabe, está indicado para casos refratários a todas as terapias padrão para a crise aguda de gota ou se contraindicação a todas elas. Este tipo de medicamento é de difícil acesso e possui altíssimo custo.

A letra E está incorreta. Incorreta a alternativa E: para o tratamento da crise aguda de gota ser efetivo, a posologia não deve ser a mencionada nesta alternativa. Em geral, as doses utilizadas

variam de 20 a 30 mg/dia. Doses maiores, como 40 mg/dia e, mesmo uso de glicocorticoide parenteral, podem ser necessários em casos específicos.

Questão | | 2023 | 4000181613

São considerados anticoagulantes, por bloqueio do fator Xa, EXCETO

- A)** rivaroxabana.
- B)** edoxabana.
- C)** enoxaparina.
- D)** dabigatrana.
- E)** apixabana.

Solução

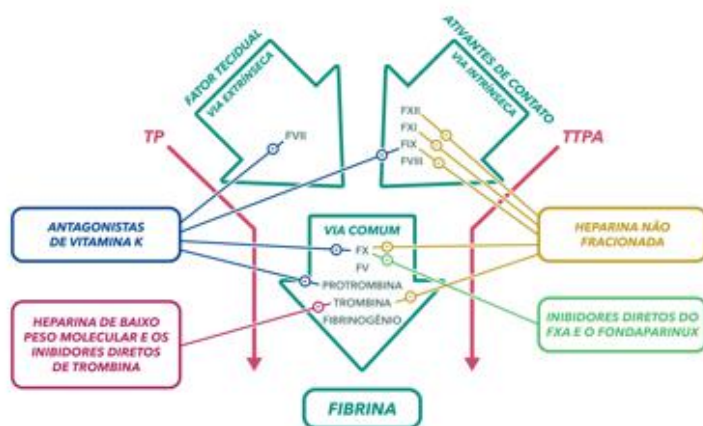
Gabarito: D) dabigatrana.

GABARITO: ALTERNATIVA D

Ótima questão para relembrar o mecanismo de ação de alguns anticoagulantes. Primeiro, vamos aprender um macete? Os **anticoagulantes orais diretos que inibem o o fator Xa trazem a sílaba xa em seu nome**, Estrategista! É o caso da **rivaroxabana**, **apixabana** e **edoxabana**. Por outro lado, temos a **dabigatrana**, um inibidor oral direto da trombina.

No entanto, nem só os anticoagulantes orais diretos agem sobre o fator Xa: as **heparinas** e o **fondaparinux** funcionam como intensificadores dos efeitos da **antitrombina**, um anticoagulante natural que age inibindo o fator Xa, dentre outros fatores da coagulação. Os antagonistas de vitamina K, por sua vez, agem inibindo os fatores II, VII, IX e X da coagulação, uma informação que as provas de residência adoram cobrar!

Os principais mecanismos de ação dos anticoagulantes estão resumidos na imagem abaixo, veja com atenção:



Com isso em mente, vamos às alternativas:

A letra A está incorreta. A rivaroxabana é um clássico anticoagulante oral direto que inibe o fator Xa.

A letra B está incorreta. A edoxabana também age inibindo o fator Xa.

A letra C está incorreta. A enoxaparina, uma heparina de baixo peso molecular, age intensificando a ação da antitrombina, um anticoagulante natural que age sobre diversos fatores da coagulação, especialmente o fator Xa.

A letra D está correta. É isso, Estrategista! A dabigatrana age inibindo a trombina, e não o fator Xa. Há até um macete para isso também: a trombina é o fator II da coagulação, por isso seu inibidor tem BI no nome e se chama dabigatrana.

A letra E está incorreta. Perfeito, a apixabana também age inibindo o fator Xa da coagulação.

Questão | | 2023 | 4000181614

Em relação à febre reumática, é correto afirmar que

- A)** a coreia de Sydenham é considerada um critério maior para o diagnóstico, sendo muito frequente na apresentação inicial (80-90%).
- B)** a dor articular (artralgia) é considerada um critério menor para o diagnóstico.
- C)** a presença de febre baixa é essencial para o diagnóstico.
- D)** a faixa etária mais acometida é de 40 – 50 anos.
- E)** o uso de corticosteroides está indicado na profilaxia da febre reumática.

Solução

Gabarito: B) a dor articular (artralgia) é considerada um critério menor para o diagnóstico.

GABARITO: ALTERNATIVA B

Olá Estrategista,

A Febre Reumática é uma doença prevalente em nosso meio e causa importante de cardiopatia adquirida em idade jovem. Ela consiste numa sequela não supurativa de uma infecção estreptocócica de orofaringe. Ocorre após algumas semanas da infecção e é mais comum entre 5 e 15 anos de vida.

Veja abaixo os critérios diagnósticos para a Febre Reumática (FR):

Países de Moderado e alto risco para FR

CRITÉRIOS MAIORES	CRITÉRIOS MENORES
Poliartrose migratória (poliartralgia ou monoartrite)	alteração de VHS (maior que 30mm primeira hora) e PCR maior ou igual a 3mg/dl
Cardite	aumento do PR no ECG corrigido para a idade (quando não houver condite)
Coreia	Febre maior ou igual a 38°C
Eritema marginado	Artralgia
Nódulos subcutâneos	

São necessários 2 critérios maiores mais a evidência de infecção estreptocócica ou 1 maior e 2 menores mais a evidência de infecção estreptocócica para o diagnóstico da FR.

A letra A está incorreta. Incorreta A, a coreia de Sydenham é um critério maior, mas não é frequente, estando presente em cerca de 10 a 15% dos casos.

A letra B está correta. Correta B a dor articular, ou monoartralgia, é considerada critério menor.

A letra C está incorreta. Incorreta C, a febre é um critério menor e não é essencial para o diagnóstico.

A letra D está incorreta. Incorreta D, a faixa etária mais acometida é entre 5 e 15 anos de vida.

A letra E está incorreta. Incorreta E, a profilaxia da febre reumática é feita com penicilina benzatina a cada 21 ou 28 dias.

Questão | | 2023 | 4000181615

Um homem de 54 anos procura atendimento médico com queixa de dor ao urinar e urgência miccional. O diagnóstico de prostatite é estabelecido e a urocultura mostra crescimento de *pseudomonas aeruginosa*. Diante do exposto, assinale a alternativa correta.

- A)** A *pseudomonas aeruginosa* é responsável pela maioria dos casos de prostatite bacteriana aguda.
- B)** O quadro clínico geralmente é pouco sintomático.

- C)** A incidência de neoplasia de próstata é comum nesses casos.
- D)** A macrodantina é o antimicrobiano de escolha nesses casos.
- E)** O uso de ertapenem está contraindicado.

Solução

Gabarito: E) O uso de ertapenem está contraindicado.

GABARITO: ALTERNATIVA E

A letra A está incorreta. Alternativa A incorreta. A E. coli é bactéria mais comum nos casos de prostatite.

A letra B está incorreta. Alternativa B incorreta. O quadro clínico geralmente envolve febre, mal estar, disúria, polaciúria e estranguria.

A letra C está incorreta. Alternativa C incorreta. A incidência de neoplasia não é comum nesses casos. O achado mais frequente é a hiperplasia prostática benigna.

A letra D está incorreta. Alternativa D incorreta. A macrodantina é um antibiótico indicado somente para cistite e não tem ação contra a pseudomonas.

A letra E está correta. Alternativa E correta. O ertapenem não está indicado neste caso porque é um antibiótico da classe dos carbapenêmicos e que não tem ação contra pseudomonas.

Questão | | 2023 | 4000181616

Qual neoplasia maligna é responsável pelo maior número de óbitos no Brasil?

- A)** Neoplasia de pulmão.
- B)** Neoplasia de intestino.
- C)** Neoplasia de mama.
- D)** Neoplasia de pele.
- E)** Neoplasia de colo de útero.

Solução

Gabarito: A) Neoplasia de pulmão.

GABARITO: ALTERNATIVA A

O câncer é uma das principais causas de morte no Brasil e no mundo, sendo que alguns tipos são responsáveis por um maior número de óbitos. Nesse contexto, a questão é apenas sobre epidemiologia e busca identificar qual neoplasia maligna é responsável pelo maior número de mortes no Brasil.

Vamos nos recordar quais os tipos de câncer mais comuns no Brasil segundo o INCA (2022):

Pele não melanoma (31,3%)

Mama feminina (10,5%);

Próstata (10,2%);

Cólon e reto (6,5%);

Pulmão (4,6%);

E estômago (3,1%).

E quanto à mortalidade? (INCA 2020)

Pulmão, traqueia e brônquios: 9,95 %

Mama: 6,46%

Estômago: 4,82%

Próstata: 4,77%

Cólon: 4,26%

A letra A está correta.

A alternativa A, neoplasia de pulmão, é a resposta correta. O câncer de pulmão é um dos tipos de câncer mais comuns em todo o mundo e o mais letal de todos, sendo responsável por cerca de 1,8 milhões de mortes por ano em todo o mundo. Esse tipo de câncer é mais comum em pessoas acima de 50 anos e é fortemente associado ao tabagismo, sendo que cerca de 85% dos casos são causados pelo consumo de cigarros.

A letra B está incorreta.

A alternativa B é incorreta, neoplasia de intestino, é um tipo de câncer que vem aumentando sua incidência nos últimos anos, mas ainda não supera o câncer de pulmão em número de mortes no Brasil. A doença é mais comum em pessoas acima de 50 anos e pode ser prevenida com a adoção de hábitos saudáveis e o rastreamento regular.

A letra C está incorreta.

A alternativa C, neoplasia de mama, é um tipo de câncer que afeta principalmente mulheres, mas também pode ocorrer em homens. Embora seja um tipo de câncer com alta incidência, a mortalidade por câncer de mama vem diminuindo nos últimos anos, devido ao diagnóstico precoce e aos avanços no tratamento.

A letra D está incorreta.

A alternativa D, neoplasia de pele, é um tipo de câncer que possui alta incidência no Brasil, mas baixa mortalidade. A maioria dos casos são do tipo não melanoma, que têm baixo potencial de disseminação e boa resposta ao tratamento.

A letra E está incorreta.

A alternativa E, neoplasia de colo de útero, é um tipo de câncer que afeta mulheres e que pode ser prevenido com o rastreamento regular e a vacinação contra o HPV. Embora seja um tipo de câncer com alta incidência, a mortalidade vem diminuindo nos últimos anos devido à prevenção e ao diagnóstico precoce.

Questão | | 2023 | 4000181617

Em relação à artrite reumatoide, é correto afirmar que

- A)** os anti-inflamatórios não esteroidais (AINE) são considerados drogas modificadoras de doença.
- B)** o diagnóstico deve ser confirmado pela dosagem do fator reumatoide.
- C)** a presença de marcadores agudos de inflamação (proteína C reativa ou velocidade de hemossedimentação) adiciona 5 pontos aos critérios mais recentes de diagnóstico.
- D)** o metotrexato é considerado droga de primeira escolha.
- E)** o uso de corticosteroides intra-articulares está indicado na maioria dos casos.

Solução

Gabarito: D) o metotrexato é considerado droga de primeira escolha.

GABARITO: ALTERNATIVA D

A letra A está incorreta. Incorreta a alternativa A: AINEs e glicocorticoides são drogas de ação sintomática e não modificam o curso da doença.

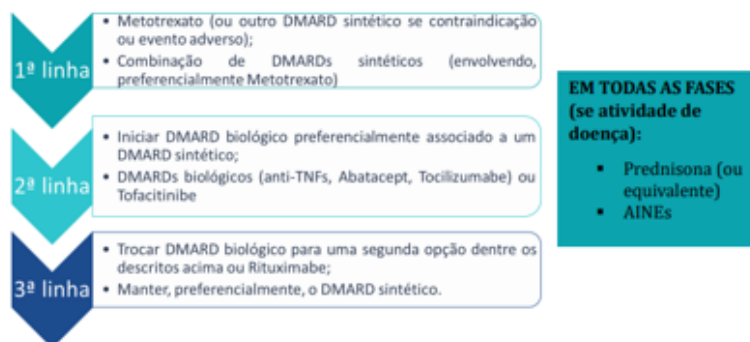
A letra B está incorreta. Incorreta a alternativa B: o fator reumatoide não é específico da artrite reumatoide ou de qualquer outra condição e está presente em pacientes com outras doenças reumáticas, infecções, neoplasias e mesmo em indivíduos hígidos, especialmente idosos. Na artrite reumatoide, está presente em 70 a 80% dos casos; por isso, sua presença, isoladamente, não confirma o diagnóstico e a sua ausência não o descarta.

A letra C está incorreta. Incorreta a alternativa C: PCR ou VHS anormais pontuam 1 nos critérios do EULAR de 2010. Decoreba – eu sei – mas, ainda que você não soubesse se essa afirmação é verdadeira ou não, a alternativa seguinte não deixa dúvidas.

A letra D está correta. Correta a alternativa D: os DMARDs sintéticos são as drogas de primeira linha no tratamento da artrite reumatoide e, dentre eles, o Metotrexato é a droga de escolha.

A letra E está incorreta. Incorreta a alternativa E: o uso de corticoide intra-articular está indicado em casos específicos, como em um paciente que apresenta bom controle de doença e mantém artrite em uma única articulação.

O esquema abaixo vai te ajudar a compreender todas as etapas no tratamento da artrite reumatoide.



Questão | 2023 | 4000181618

Sobre o carvedilol, assinale a alternativa correta.

- A)** Sua dose máxima recomendada é 100 mg duas vezes ao dia.
- B)** É considerado uma medicação de primeira escolha nos casos de hipertensão arterial sistêmica.
- C)** Está contraindicado nos pacientes com bloqueio atrioventricular avançado.
- D)** Está indicado nos casos de insuficiência cardíaca descompensada, principalmente nos pacientes com perfil frio e úmido.
- E)** Pode ser associado ao propranolol nos pacientes portadores de fibrilação atrial.

Solução

Gabarito: C) Está contraindicado nos pacientes com bloqueio atrioventricular avançado.

GABARITO: ALTERNATIVA C

Estrategista,

Antigamente, os betabloqueadores faziam parte da lista dos medicamentos de primeira linha, visto que muitos estudos demonstraram benefícios relacionados ao seu uso quando comparado ao PLACEBO. No entanto, quando comparado aos outros anti-hipertensivos (especialmente os de primeira linha), os betabloqueadores aumentam em 16% o risco de AVE e, em outros estudos, mortalidade. Por isso, esta droga saiu do time titular e foi para o banco

de reservas. Mas atenção: como os betabloqueadores são drogas de primeira linha na insuficiência cardíaca e na doença arterial coronariana, no tratamento da hipertensão diante dessas condições específicas, priorizaremos o uso desta classe.

Um detalhe final importante: os betabloqueadores com ação vasodilatadora (carvedilol e nebivolol) são os medicamentos com menor incidência desses efeitos colaterais, com ação neutra no metabolismo lipídico e benéfica no metabolismo glicídico, com redução da resistência insulínica e melhora da captação de glicose em tecidos periféricos. Além disso, a taxa de disfunção sexual é menor nos pacientes usuários do nebivolol, devido aos efeitos diretos sobre a síntese de óxido nítrico.

As principais contraindicações aos betabloqueadores são relacionadas ao broncoespasmo grave (asma ou DPOC grave), bloqueios avançados (BAV de 2º e 3º graus) e doença oclusiva periférica grave com claudicação intermitente (lembre-se do efeito vasoconstritor mediado pelo bloqueio do receptor beta-2). Esses efeitos são mais evidentes nos betabloqueadores não seletivos, mas podem limitar o uso dos cardiosseletivos, especialmente em altas doses.

Vamos analisar as alternativas:

A letra A está incorreta. Alternativa "a" incorreta: a dose máxima é 25mg, duas vezes ao dia, mas pode ser utilizada em dose maior (50mg duas vezes por dia em pacientes com peso > 85Kg).

A letra B está incorreta. Alternativa "b" incorreta: os betabloqueadores são drogas de primeira linha em doentes hipertensos somente quando tratamos a insuficiência cardíaca e a doença arterial coronariana

A letra C está correta. Alternativa "c" correta: conforme explicado acima.

A letra D está incorreta. Alternativa "d" incorreta: o betabloqueador deve ser iniciado em pacientes compensados ou em fase de resolução da congestão pulmonar.

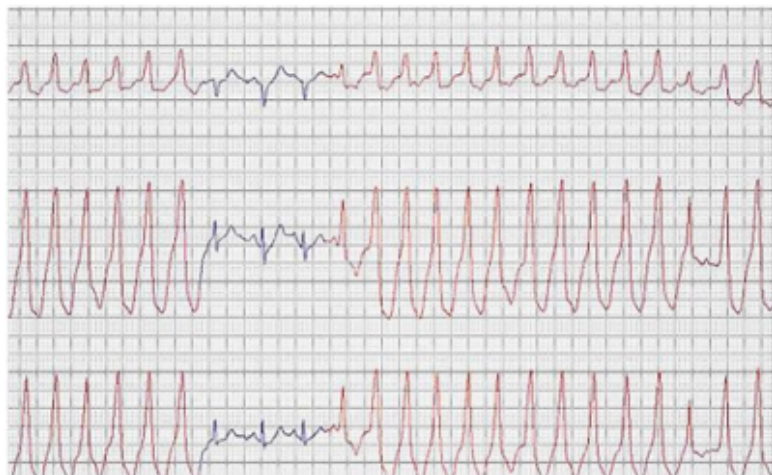
A letra E está incorreta. Alternativa "e" incorreta: não é recomendado utilização de mais de um betabloqueador concomitantemente em nenhuma situação.

Questão | | 2023 | 4000181619

Um homem de 46 anos procura atendimento médico de urgência com queixa de palpitações e dor torácica do tipo aperto, de início há aproximadamente 1 hora. Seus sinais vitais são aferidos:

- PA: 70x40mmHg (Pressão arterial);
- FC: 190bpm (Frequência cardíaca);
- SatO2: 88% (Saturação de oxigênio).

E seu eletrocardiograma (ECG) é o seguinte:



Nesse caso, conforme as informações apresentadas, é correto afirmar que

- A) se trata de uma taquicardia supraventricular, e o uso da manobra vagal modificada está indicado.
- B) a avaliação de um especialista deve ser prioritária.
- C) o uso de atropina 1mg endovenosa (EV) está indicado.
- D) a cardioversão elétrica sincronizada está indicada.
- E) um estudo eletrofisiológico deve ser realizado antes de qualquer intervenção terapêutica.

Solução

Gabarito: D) a cardioversão elétrica sincronizada está indicada.

GABARITO: ALTERNATIVA D

Estrategista,

Toda vez que estamos diante de uma taquiarritmia, a primeira pergunta que devemos responder é: o paciente está instável? Caso afirmativo, a conduta será, na maioria das vezes, cardioversão elétrica sincronizada. A carga recomendada no desfibrilador bifásico deverá ser: QRS estreito e regular (50-100J); QRS estreito e irregular (120-200J); QRS largo e regular (100J); QRS largo e irregular (desfibrilação conforme ACLS). São critérios de instabilidade: rebaixamento de nível de consciência, hipotensão com choque, dor torácica ou dispnéia. Importante lembrar da sedação antes da cardioversão.

INSTABILIDADE HEMODINÂMICA

Procure os 4 D's



DISPNEIA



DIMINUIÇÃO DA CONSCIÊNCIA



DOR TORÁCICA ANGINOSA



DIMINUIÇÃO DA PRESSÃO (CHOQUE)

A letra A está incorreta. Alternativa "a" incorreta: paciente está instável e deve receber cardioversão elétrica sincronizada. Como se trata de uma arritmia de QRS largo, a principal hipótese é taquicardia de origem ventricular.

A letra B está incorreta. Alternativa "b" incorreta: paciente está instável e deve receber cardioversão elétrica sincronizada imediatamente. A avaliação do especialista irá ajudar após estabilização do doente.

A letra C está incorreta. Alternativa "c" incorreta: atropina é utilizada no protocolo de bradiarritmias instáveis, visto que aumenta a frequência cardíaca.

A letra D está correta. Alternativa "d" correta: paciente está instável e deve receber cardioversão elétrica sincronizada.

A letra E está incorreta. Alternativa "e" incorreta: paciente está instável e deve receber cardioversão elétrica sincronizada imediatamente. O estudo eletrofisiológico pode ser considerado em algum momento após estabilização clínica.

Questão | | 2023 | 4000181620

Na fase mais inicial da apendicite aguda, qual é a tríade sintomática mais característica entre as seguintes?

- A)** Dor em fossa ilíaca direita, febre alta e prostração.
- B)** Dor epigástrica intensa, febre moderada e vômitos.

- C)** Dor abdominal difusa, febre alta e anorexia.
- D)** Dor periumbilical, febre alta e vômitos.
- E)** Dor periumbilical, febre moderada e anorexia.

Solução

Gabarito: E) Dor periumbilical, febre moderada e anorexia.

GABARITO: ALTERNATIVA E

A apresentação clássica da apendicite aguda é caracterizada por uma dor abdominal vaga e imprecisa, localizada na região mesogástrica ou periumbilical, com duração aproximada de 4 a 6 horas e posterior migração para a fossa ilíaca direita. Geralmente, vem associada a náuseas, vômitos e anorexia. Além disso, FEBRE BAIXA ($< 38,5^{\circ}\text{C}$) faz parte da maioria dos quadros clínicos iniciais, aumentando à medida que a inflamação progride, assim como taquicardia e desidratação leve.

Os vômitos, quando presentes, vêm após a dor abdominal e ocorrem pelo íleo metabólico causado pela inflamação, ou pela distensão que ativa os receptores viscerais (sistema simpático), com consequente diminuição do peristaltismo. Constipação ou diarreia também podem estar presentes.

Portanto, a melhor alternativa se encontra na letra "E".

Questão | | 2023 | 4000181621

Você está atendendo uma criança de 6 anos com queixa de lesões de pele, com prurido intenso, que ocorre principalmente à noite, há alguns dias. O paciente não apresentou febre ou qualquer outro sintoma. As lesões são papulovesiculares eritematosas, localizadas em espaços interdigitais, axilas, punhos, regiões glútea e genital. Os pais estão presentes na consulta, e a mãe refere os mesmos sintomas, com lesões semelhantes, mas com presença de lesões em túnel. O pai está assintomático e sem lesões. Qual é a conduta adequada em relação ao paciente e aos seus pais?

- A)** Prescrever tratamento para a criança e para os familiares, independentemente da presença de sintomas.
- B)** Prescrever o tratamento para a criança e para os familiares sintomáticos.
- C)** Prescrever o tratamento apenas para a criança, que é sua paciente.
- D)** Prescrever o tratamento para a criança e para a mãe.
- E)** Prescrever o tratamento para a criança e indicar avaliação com dermatologista para a mãe.

Solução

Gabarito: A) Prescrever tratamento para a criança e para os familiares, independentemente da presença de sintomas.

GABARITO: ALTERNATIVA A

Estrategista, essa criança apresenta uma dermatose generalizada aguda que é extremamente pruriginosa principalmente no período noturno. Sempre que você estiver diante dessa informação deve pensar na possibilidade de escabiose. A mãe da criança apresenta um quadro clínico semelhante o que aumenta a possibilidade de estarmos diante de uma doença infecciosa. A escabiose é uma dermatose parasitária causada pelo ácaro *Sarcoptes scabiei*. Clinicamente surgem pápulas e túneis localizadas nas axilas, região interdigital, genital e glúteas. O prurido é intenso e predomina durante a noite.

Feito o diagnóstico de escabiose, precisamos realizar o tratamento. O ponto chave da questão é lembrar que não devemos tratar apenas o nosso paciente. É imperativo tratar o paciente e todos os contatos ainda que estejam assintomáticos. Isso ocorre, pois algumas pessoas são carregadoras assintomáticas! Logo, precisamos tratar a criança e os pais. Dessa forma, o gabarito é a alternativa A.

Questão | | 2023 | 4000181622

Em relação à vacina tríplice viral, oferecida pelo Programa Nacional de Imunizações, assinale a alternativa correta.

- A)** A dose zero, dada em situação epidemiológica de risco para sarampo ou rubéola, não é considerada válida para a cobertura vacinal de rotina.
- B)** É contraindicada para gestantes, exceto em situações de surto de sarampo, caxumba ou rubéola.
- C)** É contraindicada para crianças abaixo dos 12 meses de idade, mesmo em situações de surto de sarampo, caxumba ou rubéola.
- D)** Mulheres em idade fértil devem evitar a gravidez até pelo menos 1 ano após a vacinação.
- E)** Pessoas comprovadamente portadoras de alergia à proteína do leite de vaca não podem receber vacina tríplice viral.

Solução

Gabarito: A) A dose zero, dada em situação epidemiológica de risco para sarampo ou rubéola, não é considerada válida para a cobertura vacinal de rotina.

GABARITO: ALTERNATIVA A

Olá, querido Estrategista.

O sarampo é uma doença exantemática viral potencialmente letal. Sua prevenção é realizada aos 12 meses na vacina tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola) e aos 15 meses na tetra viral (sarampo, caxumba, rubéola e varicela). O esquema vacinal para sarampo é considerado completo com:

- 2 doses para crianças, adolescentes e adultos até 29 anos.
- 1 dose para adultos dos 30 aos 59 anos.
- Duas doses para profissionais de saúde, independente da idade.

A profilaxia pós-exposição deve ser realizada com a tríplice viral em todos contactantes suscetíveis (não vacinados), através da vacina ou da imunoglobulina. A vacina é indicada para suscetíveis imunocompetentes a partir dos 6 meses de idade. Já a imunoglobulina deve ser feita para menores de 6 meses, imunodeprimidos e gestantes. Esses dois últimos tem contraindicação à vacina por ela ser viva atenuada.

Agora, preste atenção, quando a criança aplica uma dose extra de vacina, no caso de profilaxia pós-exposição em menores de 12 meses ou em situações de controle de surtos, a dose é chamada de "zero" (dose extra de 6 a 12 meses). Nesses casos, o esquema vacinal deve correr normalmente, aplicando as vacinas dos 12 e 15 meses.

A letra A está correta. Correta, a dose zero é uma dose extra.

A letra B está incorreta. Ela é contraindicada para gestantes em qualquer situação, por ser vacina viva atenuada.

A letra C está incorreta. Em situações de surto de sarampo, caxumba ou rubéola, a dose extra é feita para crianças de seis a doze meses.

A letra D está incorreta. Não há consenso no tempo de espera, mas a maioria das literaturas indica um a três meses de espera e não um ano.

A letra E está incorreta. Crianças com alergia à proteína do leite de vaca devem evitar a vacina da tríplice viral de um laboratório específico, o Serum Institute of India. As vacinas dos demais laboratórios podem ser aplicadas.

Questão | | 2023 | 4000181623

Uma criança em idade escolar está em antibioticoterapia, há 48 horas, por pneumonia bacteriana. Ela é levada ao hospital para reavaliação, pois não teve melhora da curva térmica, está prostrada e com perda de apetite. Ao exame físico, apresenta diminuição do murmúrio vesicular em base esquerda e tem bom padrão respiratório, apesar de manter uma posição antálgica em escoliose. Qual, entre as seguintes, é a conduta mais indicada no momento?

A) Realizar radiografia de tórax.

- B)** Trocar antibiótico e reavaliar em 48 a 72 horas.
- C)** Manter antibiótico e aguardar completar 72 horas de tratamento para uma reavaliação mais adequada.
- D)** Realizar tomografia de tórax com contraste.
- E)** Associar um segundo antibiótico ao esquema inicial, para cobertura de germes atípicos, e reavaliar em 48 horas.

Solução

Gabarito: A) Realizar radiografia de tórax.

GABARITO: ALTERNATIVA A

Olá Estrategista,

Temos aqui uma criança com diagnóstico de pneumonia bacteriana, que não apresentou melhora após 48 horas de antibioticoterapia. A ausculta pulmonar com redução do murmúrio vesicular, sugere a presença de derrame pleural, e essa hipótese é corroborada pela presença de escoliose e posição antálgica.

O derrame pleural é a principal complicação das pneumonias bacterianas e a principal causa de manutenção da febre.

Assim, nessa situação, a primeira coisa que devemos fazer é solicitar uma radiografia de tórax para detectar essa complicação, lembre-se disso !!

Se detectarmos a presença de derrame pleural, caracterizamos a pneumonia como complicada e a internação é necessária para antibioticoterapia endovenosa e toracocentese. O intuito da toracocentese é identificar a presença de um derrame complicado, ou seja, com presença de bactérias. Nesse caso, está indicada a drenagem torácica com selo d'água.

Vamos analisar as alternativas:

A letra A está correta. Correta A, a radiografia de tórax é o método de imagem que pode diagnosticar a presença do derrame pleural, que é nossa principal suspeita nesse momento.

A letra B está incorreta. Incorreta B, a troca de antibiótico é apropriada quando não encontramos complicações que justifiquem a persistência da febre.

A letra C está incorreta. Incorreta C, se essa criança tiver um derrame pleural, a conduta não será expectante, devemos fazer a toracocentese.

A letra D está incorreta. Incorreta D, a tomografia expõe a criança a uma radiação desnecessária, a radiografia de tórax é um bom método para detecção do derrame pleural.

A letra E está incorreta. Incorreta E, antes de modificar a antibioticoterapia, precisamos nos certificar de que não estamos diante de alguma complicação.

As infecções sexualmente transmissíveis são um grave problema de saúde pública no Brasil, devendo-se ter especial atenção à população adolescente. Considerando somente as infecções adquiridas, qual, das seguintes, pode ser transmitida de outras formas além da sexual?

- A) Sífilis.
- B) Hepatite B.
- C) Gonorreia.
- D) Linfogranuloma venéreo.
- E) Cancro mole.

Solução

Gabarito: B) Hepatite B.

GABARITO: ALTERNATIVA B

A questão aborda infecções sexualmente transmissíveis (ISTs) e sua transmissão. Preste atenção aos comentários, pois há duas alternativas corretas.

A letra A está incorreta. Correta a alternativa A. A sífilis pode ser transmitida não apenas por meio do contato sexual, mas também por via vertical, da mãe para o feto durante a gravidez, e por contato com sangue contaminado.

A letra B está correta. Correta a alternativa B. A hepatite B pode ser transmitida por contato sexual, exposição a sangue contaminado e da mãe para o feto durante a gestação ou o parto.

A letra C está incorreta. Incorreta a alternativa C. Gonorreia é principalmente transmitida por meio do contato sexual. Não é comumente transmitida por outras vias.

A letra D está incorreta. Incorreta a alternativa D. O linfogranuloma venéreo é uma IST que também é transmitida principalmente por meio do contato sexual. Não é comumente transmitido por outras vias.

A letra E está incorreta. Incorreta a alternativa E. O cancro mole, ou cancroide, é uma IST que se espalha principalmente por contato sexual direto com uma ferida ou úlcera genital. Não é comumente transmitido por outras vias.

Questão | | 2023 | 4000181625

Um menino de 3 anos apresenta quadro febril há 6 dias e é levado para avaliação. Durante a consulta, são identificadas outras alterações: exantema polimorfo difuso, conjuntivite sem exsudato, mucosite oral, edema distal dos membros e adenomegalia cervical unilateral. Suspeitando-se de Doença de Kawasaki, qual dos sinais ou sintomas apresentados pelo paciente é considerado o critério mandatório para o diagnóstico?

- A) Febre.
- B) Exantema.
- C) Conjuntivite.
- D) Mucosite.
- E) Edema distal.

Solução

Gabarito: A) Febre.

GABARITO: ALTERNATIVA A

Olá Estrategista,

A doença de Kawasaki é uma vasculite que acomete crianças causando um processo inflamatório sistêmico.

Suas principais manifestações são:

- Febre;
- Conjuntivite não purulenta;
- Exantema polimorfo;
- Linfadenopatia cervical;
- Alterações de mucosa oral;
- Alterações de extremidades.

Para o diagnóstico da doença de Kawasaki é necessário observar a febre por cinco dias ou mais , associada a quatro dos outros cinco critérios, observe:



O tratamento precoce (até o décimo dia da febre) com imunoglobulina e AAS, visa evitar a formação dos aneurismas de coronária, que são a principal complicação da doença de

Kawasaki.

Questão | | 2023 | 4000181626

Um paciente de 5 anos, assintomático, está em consulta de puericultura. Ao exame físico, é identificado um linfonodo supraclavicular palpável. Nesse caso, está indicada a biópsia desse linfonodo?

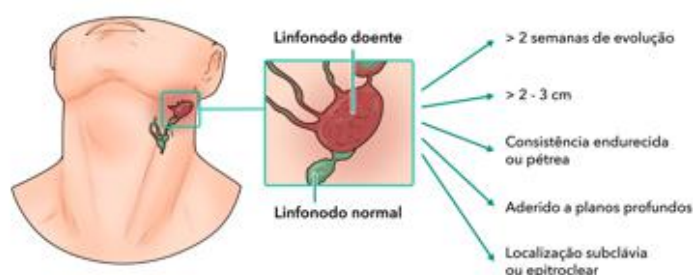
- A) Não, pois o paciente deve ser revisado em duas semanas para avaliar se houve regressão.
- B) Não, pois o paciente é assintomático.
- C) Sim, independentemente das características do linfonodo.
- D) Sim, se o linfonodo for firmemente aderido e maior que 2 cm.
- E) Sim, se o linfonodo for maior que 1 cm.

Solução

Gabarito: C) Sim, independentemente das características do linfonodo.

GABARITO: ALTERNATIVA C

Estrategista, identificar um linfonodo suspeito é uma habilidade essencial para todo médico. Isso porque muitos casos de linfadenomegalias são reacionais a quadros infecciosos e não exigem conduta específica. Vamos lembrar das características de linfadenomegalias suspeitas na imagem abaixo?



No caso em questão, temos que lembrar que localização supraclavicular é altamente suspeita de neoplasia e, por isso, sempre deve ser biopsiada. Com isso em mente, vamos às alternativas:

A letra A está incorreta. Incorreto. Linfadenomegalias supraclaviculares sempre são suspeitas e devem ser biopsiadas.

A letra B está incorreta. Incorreto. Mesmo sem outros sintomas associados, a localização supraclavicular já é suspeita e a biópsia está indicada.

A letra C está correta. Perfeito! A localização supraclavicular já é suspeita suficiente para indicar a realização da biópsia.

A letra D está incorreta. Incorreto. Independente das demais características, a biópsia já está indicada pela localização do linfonodo.

A letra E está incorreta. Incorreto. Linfadenomegalias supraclaviculares sempre devem ser biopsiadas.

Questão | | 2023 | 4000181627

Sobre a rubéola congênita, assinale a alternativa correta.

- A)** Perda auditiva é a manifestação mais comum e usualmente é condutiva bilateral, e a severidade varia de moderada a grave, com progressão ao longo do tempo.
- B)** Cerca de 50% apresentam algum tipo de defeito cardíaco estrutural, sendo mais comuns os defeitos de septo cardíaco.
- C)** O risco de transmissão materno-fetal é maior nas primeiras 10 semanas de gestação, e o risco de ocorrer malformações prolonga-se até a 18ª e a 20ª semana.
- D)** As manifestações tardias de diabetes melito e das patologias da tireoide são bastante comuns, afetando mais de 1/3 dos casos até a adolescência.
- E)** O uso de imunoglobulina para tratamento da rubéola materna garante proteção contra a infecção do feto.

Solução

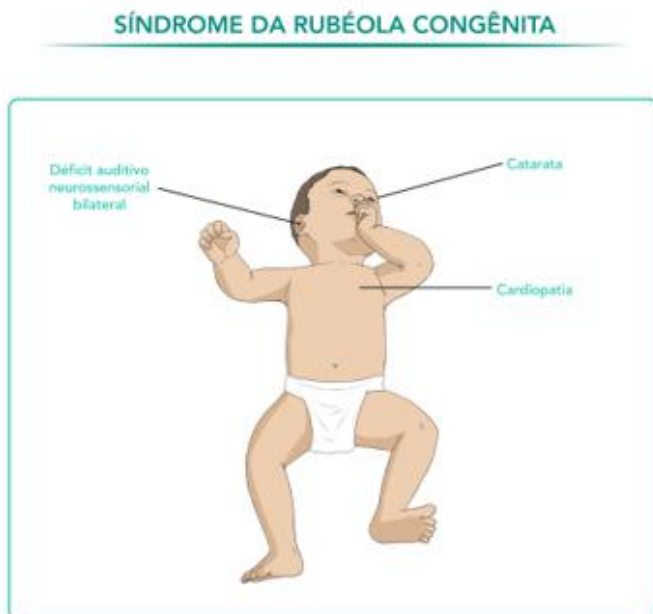
O risco de transmissão materno-fetal é maior nas primeiras 10 semanas de

Gabarito: C) gestação, e o risco de ocorrer malformações prolonga-se até a 18ª e a 20ª semana.

GABARITO: ALTERNATIVA C

A rubéola é uma doença exantemática aguda de alta contagiosidade que acomete principalmente crianças e adolescente. A importância da rubéola se dá, sobretudo, pela ocorrência da síndrome da rubéola congênita (SRC) que atinge o feto e o recém-nascido de mães infectadas durante a gestação e por isso é uma doença de notificação compulsória nacional. Devido a exaustiva vacinação de toda a população, essa doença está erradicada no Brasil desde 2008, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS) e não faz mais parte do rastreamento obrigatório durante o pré-natal. A infecção pelo vírus da rubéola causa os danos mais graves quando a mãe é infectada no início da gravidez, especialmente no primeiro trimestre. Depois de 18 semanas da gestação, o risco de SRC é muito baixo pois o bebê já está bem desenvolvido.

As manifestações mais comuns da Síndrome da Rubéola Congênita é a associação de cardiopatia congênita, catarata e déficit auditivo neurossensorial bilateral.



Para diagnóstico, a presença de anticorpos IgM confirmam a infecção, mas, a ausência não descarta. Também podemos isolar o vírus em secreção nasofaríngea, líquido e urina, ele está presente em 80% das crianças infectadas no primeiro ano de vida. Não há tratamento específico, deve-se tratar as complicações.

Vamos analisar as alternativas.

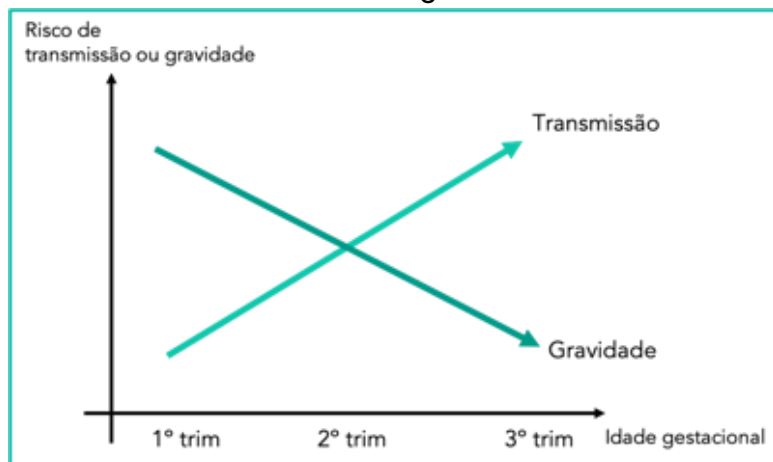
A letra A está incorreta.

Perda auditiva é a manifestação mais comum, porém ela é neurossensorial bilateral e não condutiva.

A letra B está incorreta. Os defeitos cardíacos estruturais mais comuns são a estenose pulmonar e a persistência do canal arterial.

A letra C está correta. Incorreto. Inicialmente, esse foi o gabarito oficial, porém, depois a questão foi anulada. Veja bem, as infecções congênitas transmitidas via transplacentária dependem do bom desenvolvimento da placenta, então, a transmissão é máxima no 3º trimestre. Já a gravidade é maior no primeiro trimestre, pois é quando o feto está em

desenvolvimento. Observe o gráfico.



Sendo assim, é incorreto dizer que o risco de transmissão materno-fetal é maior nas primeiras 10 semanas de gestação.

O risco de malformações ser maior no primeiro trimestre é correto, na literatura, a síndrome clássica da rubéola congênita só foi identificado em infecções que ocorreram até as primeiras 20 semanas.

Portanto, a questão foi anulada.

A letra D está incorreta. A diabetes afeta 1% dos pacientes e as patologias da tireoide, 5%.

A letra E está incorreta. Não há tratamento para rubéola materna.

Questão | | 2023 | 4000181628

A glomerulonefrite difusa aguda pós-estreptocócica é a mais comum das glomerulopatias da infância. Sobre essa glomerulonefrite, assinale a alternativa correta.

A dosagem do complemento sérico é obrigatória, tendo seus valores diminuídos em 95 a **A) 98%** dos casos, sendo que sua normalização em 4 a 8 semanas é um marcador importante de prognóstico e diagnóstico diferencial.

Nas alterações urinárias, observa-se hematúria, macroscópica ou microscópica, em cerca de **B) 95%** dos casos e proteinúria, raramente em níveis nefróticos, o que, na fase aguda, é um importante indicador de gravidade da nefropatia.

A insuficiência renal aguda é uma das complicações mais comuns, apresentando oligoanúria **C) intensa**, retenção de escórias proteicas no plasma e distúrbios hidreletrolíticos graves, com tendência à hiperpotassemia.

A encefalopatia hipertensiva é uma complicação que se deve essencialmente à hipertensão e pode cursar com cefaleia, vômitos, alterações visuais, agitação, sonolência, crise convulsiva **D)**

ou coma e, ao exame de fundo de olho, observam-se as alterações características de hipertensão arterial, na maioria dos casos.

Congestão circulatória é a complicação mais frequente, caracterizada por sinais clínicos de **E) hipervolemia** e que pode ser agravada por hipertensão, levando a insuficiência cardíaca congestiva e edema agudo de pulmão, com evidência de dano miocárdico intrínseco.

Solução

A dosagem do complemento sérico é obrigatória, tendo seus valores diminuídos

Gabarito: A) em 95 a 98% dos casos, sendo que sua normalização em 4 a 8 semanas é um marcador importante de prognóstico e diagnóstico diferencial.

GABARITO: ALTERNATIVA A

A glomerulonefrite pós-estreptocócica (GNPE) é a causa mais comum de síndrome nefrítica na infância. Ocorre devido a uma resposta imune a cepas denominadas nefritogênicas de estreptococos beta-hemolíticos do grupo A, com deposição de imunocomplexos no glomérulo e indução de inflamação local, sendo classicamente descrita como uma complicação não supurativa da infecção estreptocócica. O diagnóstico é confirmado pela presença de síndrome nefrítica associada a dois componentes: história de faringoamigdalite ou infecção de pele entre 1 e 3 semanas antes do quadro; alterações laboratoriais como consumo da fração C3 do complemento e positividade de anticorpos contra estreptococos, como a anti-estreptolisina O (ASO) e Anti-DNAse B. Tem bom prognóstico, sendo o tratamento de suporte com diuréticos de alça e restrição hídrica o manejo preconizado.

Vamos analisar as alternativas:

A letra A está correta. Correta. A GNPE causa uma ativação **temporária** da via alternativa do complemento, o que resulta no consumo de C3 por cerca de 4 a 8 semanas. Caso o consumo persista, está indicada a biópsia renal, pois deve tratar-se de outra glomerulopatia de pior prognóstico (glomerulonefrite membranoproliferativa ou nefrite lúpica, por exemplo).

A letra B está incorreta. Incorreta. A GNPE pode de fato ter proteinúria, habitualmente em níveis subnefróticos, mas a intensidade da proteinúria não guarda relação com o desfecho **agudo** da condição. Pacientes com proteinúrias maiores e persistentes podem, a longo prazo, ter mais chance de evoluir para doença renal crônica.

A letra C está incorreta. Incorreta. A injúria renal aguda (IRA) grave - com necessidade de diálise, por exemplo - é incomum no contexto da GNPE. As principais complicações da doença decorrem da hipervolemia (edema agudo de pulmão e encefalopatia hipertensiva).

A letra D está incorreta. Incorreta. Como tratam-se de situações **agudas**, achados de fundoscopia relativos à hipertensão arterial sistêmica não são habitualmente encontrados.

A letra E está incorreta. Incorreta. A hipervolemia pode levar a complicações como edema agudo de pulmão, mas por sobrecarga volêmica e não por dano miocárdico intrínseco.

Questão | | 2023 | 4000181629

Você está de férias, na praia, quando se depara com um afogamento. A vítima está desacordada, parece ter 16 anos, aproximadamente, e está sendo retirada da água. Ela é colocada na areia, em decúbito dorsal, e você vai prestar o atendimento inicial. Uma ambulância já foi chamada e chegará em poucos minutos. Das alternativas a seguir, qual deve ser a sua próxima atitude?

- A)** Estabilização de cervical.
- B)** Ventilação de resgate.
- C)** Posicionar o paciente em decúbito lateral.
- D)** Manobra de Heimlich.
- E)** Compressões abdominais.

Solução

Gabarito: C) Posicionar o paciente em decúbito lateral.

GABARITO: ALTERNATIVA C

Estrategista, essa questão foi anulada, pois faltava uma informação crucial para definirmos a conduta: se o afogado está ou não em parada respiratória. Veja só.

Segundo a SOBRASA (Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático), em seu manual sobre afogamentos “Manual resumido 2019 – versão Fevereiro” do Dr David Szpilman, referência nacional no manejo de vítimas de afogamento, referência inclusive para o Tratado de Pediatria da 5ª edição, a avaliação da presença ou ausência de respiração da vítima define a conduta inicial.

Nesse manual, que versa sobre a conduta inicial no atendimento dos afogados, o passo 4 diz: “Cheque se existe respiração - ver, ouvir e sentir - ouça e sinta a respiração e veja se o tórax se movimenta - Se houver respiração é um caso de resgate, ou grau 1, 2, 3, ou 4. Coloque em posição lateral de segurança e aplique o tratamento apropriado para grau. Se não houver respiração – inicie a ventilação boca-a-boca - ...”

Agora, observe que o examinador diz apenas que está desacordado, não sabemos se está inconsciente, mas respirando ou em parada respiratória.

O gabarito provisório foi “ventilação de resgate”, mas como não temos a informação sobre a respiração, podemos afirmar que “posicionar o o paciente em decúbito lateral” também seria uma possibilidade.

Sendo assim, a questão foi anulada.

Questão | | 2023 | 4000181630

Você está atendendo um paciente com quadro de púrpura palpável, dor abdominal e artralgia. Sua suspeita inicial é de Púrpura de Henoch-Schönlein. Sobre esse diagnóstico, assinale a alternativa correta.

- A) A púrpura palpável é um achado frequente nos pacientes acometidos, mas não obrigatório.
- B) Manifestações gastrointestinais são bastante incomuns e, quando presentes, são leves e autolimitadas.
- C) A doença não acomete os rins.
- D) A artrite aguda é um critério obrigatório para o diagnóstico, geralmente incapacitante, aditiva e de pequenas articulações.
- E) Pode ser primária ou desencadeada por infecções virais, bacterianas, alimentos, vacinas, medicamentos e picadas de insetos.

Solução

Gabarito: E) Pode ser primária ou desencadeada por infecções virais, bacterianas, alimentos, vacinas, medicamentos e picadas de insetos.

GABARITO: ALTERNATIVA E

Olá querido futuro residente,

A Púrpura de Henoch-Schönlein (PHS) ou vasculite por IgA, acomete crianças, sendo a principal causa de vasculite sistêmica de pequenos vasos em crianças, . Cerca de 90% dos casos ocorrem em crianças menores de 10 anos com predomínio do sexo masculino.

As principais manifestações são:

- dermatológica: púrpuras palpáveis, vinhosas, que não desaparecem à digitopressão, de caráter gravitacional
- gastrointestinal: vasculite abdominal que se manifesta com dor e eventualmente , sangramento intestinal
- articular: artrite e ou artralgia de grandes articulações
- renal: presença de nefrite que se manifesta com proteinúria e ou hematúria

O diagnóstico é clínico e é feito com os seguintes critérios:

O critério “púrpura palpável” sem plaquetopenia ou coagulopatia é obrigatório, associado a mais um dos outros itens.

- Dor abdominal (difusa de início agudo)
- Artrite ou artralgia de início agudo
- Envolvimento renal (proteinúria ou hematúria)
- Vasculite leucocitoclástica ou glomerulonefrite proliferativa com deposição predominante de IgA

Vamos analisar as afirmações:

A letra A está incorreta. Incorreta A, para o diagnóstico da PHS, a púrpura é um critério obrigatório.

A letra B está incorreta. Incorreta B, as manifestações gastrointestinais são frequentes na PHS.

A letra C está incorreta. Incorreta C, o envolvimento renal pode ser encontrado em 10-50% dos pacientes.

A letra D está incorreta. Incorreta D, a artrite acomete grandes articulações e não é considerada um critério obrigatório.

A letra E está correta. Correta E, a PHS pode ser primária ou secundária, sendo comumente associada a infecções virais de vias aéreas superiores.

Questão | | 2023 | 4000181631

Os pais de uma adolescente relatam ao seu pediatra, na ausência da paciente, que estão percebendo que ela tem mudado o comportamento alimentar. Viram, por diversas vezes, que estava comendo escondida, muito rapidamente e em grandes quantidades. Referem que ela tem vergonha quando é vista nessa situação, que demonstra tristeza após alimentar-se e que, muito frequentemente, come até se sentir desconfortável. Das seguintes condições, qual é a mais provável, baseando-se apenas no relato dos pais?

- A)** Anorexia nervosa.
- B)** Bulimia.
- C)** Transtorno alimentar restritivo evitativo.
- D)** Compulsão alimentar.
- E)** Ortorexia.

Solução

Gabarito: D) Compulsão alimentar.

GABARITO: ALTERNATIVA D

A letra A está incorreta. Incorreta. Anorexia Nervosa (AN) é um transtorno alimentar que afeta cerca de 1% das mulheres, iniciando-se normalmente na adolescência. A AN tem três características essenciais: restrição dietética; medo intenso de ganhar peso ou de engordar, e distorção da autoimagem corporal. Amenorreia ou alterações hormonais também são muito comuns neste transtorno, devido ao baixo peso, desnutrição ou desidratação. Algumas pacientes com AN podem se envolver em alguns episódios de compulsão alimentar ou uso métodos purgativos, mas, obrigatoriamente, a paciente anoréxica estará abaixo do seu peso ideal. O tratamento é realizado com psicoterapia associada a um ISRS.

A letra B está incorreta. Incorreta. Bulimia Nervosa é caracterizada por episódios recorrentes de compulsão alimentar, sensação de falta de controle sobre a ingesta e **mecanismos de “compensação”**, como atividades físicas exageradas, uso de laxantes, diuréticos ou vômitos auto-induzidos.

A letra C está incorreta. Incorreta. O transtorno alimentar restritivo e/ou evitativo (TARE), tem como característica a repulsa ou a falta de interesse nos alimentos e pouca procura por alimentação, refletindo em baixo peso e carências nutricionais.

A letra D está correta. Correta. No transtorno da compulsão alimentar, a paciente se envolve em diversos episódios de compulsão alimentar, contudo, sem a indução de vômitos ou compensações, como uso de laxantes ou diuréticos.

A letra E está incorreta. Incorreta. A ortorexia é observada quando ocorre um excesso de cuidados em relação a alimentação saudável.

Questão | | 2023 | 4000181632

Assinale a alternativa INCORRETA sobre otite média aguda (OMA).

- A)** O tabagismo passivo é um fator de risco de reconhecida importância, e o aleitamento materno é um fator de proteção.
- B)** Síndrome de Down é um fator de proteção pelas diferenças de anatomia das vias aéreas superiores.
- C)** As creches e os berçários representam um fator de risco considerável no desenvolvimento da OMA.
- D)** A ocorrência do primeiro episódio antes dos 6 meses é um fator de risco importante para a recorrência das OMAs.
- E)** A tuba auditiva ventila a orelha média, sua luz é virtual e, na criança, é mais curta e mais horizontalizada, o que facilita a progressão de microrganismos da rinofaringe para a orelha média.

Solução

Gabarito: B) Síndrome de Down é um fator de proteção pelas diferenças de anatomia das vias aéreas superiores.

Correta a alternativa "b".

A letra A está incorreta. De fato, o tabagismo passivo causa uma irritação crônica na mucosa nasal e faríngea da criança propiciando o acúmulo de secreção na orelha média, e o aleitamento materno é rico em IgA e lactoferrinas que trazem uma proteção imunológica importante para infecções de mucosa das vias aéreas superiores como a otite média aguda.

A letra B está correta. A otite média aguda é uma importante infecção na infância sendo a principal causa de prescrição de antibióticos nesta faixa etária.

Aproximadamente 35% das infecções respiratórias agudas evoluem com otite média aguda (OMA), sendo mais prevalente entre 6 e 24 meses.

Embora possa ocorrer em todas as idades, e o sexo masculino é acometido com uma maior frequência.

A maioria dos casos ocorrem até os dois anos. Além disso, nesta faixa etária ocorre um predomínio de acometimento bilateral.

Rinites e rinosinusites infecciosas são importantes fatores predisponentes. Por isso, é comum nos enunciados o relato de sintomas nasais associados ou antecedendo a OMA.

Em relação a maior prevalência desta infecção nas crianças, temos na anatomia uma das possíveis explicações. A tuba auditiva das crianças é mais curta e horizontalizada do que a dos adultos, facilitando a entrada de fluidos e secreções da oro e rinofaringe via óstio faríngeo da tuba auditiva. Estas secreções na orelha média propicia o desenvolvimento da OMA.

Importantes fatores de risco para a otite média aguda já descritos em provas anteriores, temos:

- Amamentação na posição horizontal
- Refluxo gastroesofágico
- Posição alimentar (na horizontal)
- Frequentador de creches (as com maior quantidade de alunos apresentam maior risco de contágio)
- Tabagismo passivo
- Hipertrofia de Adenoide
- Uso de chupeta

Além destes, alterações congênita crâniofaciais como ocorrem em pacientes fissurados e portadores de síndrome de Down também colaboram com uma maior prevalência por alterar ainda mais o mecanismo de proteção da orelha média através da tuba auditiva.

A letra C está incorreta. Estes são um dos principais fatores de risco, pois é lá onde as crianças irão entrar em contato tanto com os agentes virais que propiciam o desenvolvimento das OMA quanto com as próprias bactérias responsáveis por esta infecção, sendo a principal o *Streptococcus pneumoniae*.

A letra D está incorreta. A precocidade do primeiro episódio de OMA já será um indicativo que um ou vários fatores de risco presentes já foram suficientes para causar a desarmonia necessária para o desenvolvimento desta infecção.

Assim, como a presença destes fatores tende a permanecer, teremos uma maior prevalência de recorrentes da OMA nestas situações.

A letra E está incorreta. Esta alternativa trás uma explicação anatômico fisiológica perfeita do papel da tuba auditiva na proteção da orelha média e como sua disfunção pode propiciar a OMA.

Guarde este conceito!

Questão | | 2023 | 4000181633

Uma criança de 1 ano é levada para avaliação, por ter apresentado cianose, que ocorreu após período de choro prolongado, sem perda de consciência e com resolução espontânea. Após avaliação neurológica detalhada, o quadro é definido como perda de fôlego cianótica. Qual é sua postura perante os pais quanto a esse diagnóstico?

- A) Orienta que o paciente deve fazer uso de medicações anticonvulsivantes.
- B) Esclarece as dúvidas dos pais, enfatizando a alta probabilidade de o paciente ter quadros convulsivos subsequentes.
- C) Conversa sobre desenvolvimento infantil e encaminha a família para centro multidisciplinar, dado que o retardo no desenvolvimento neurológico faz parte da maioria dos casos.
- D) Tranquiliza os pais, deixando claro que o episódio é benigno e autolimitado.
- E) Explica que o paciente apresenta maior risco de parada cardiorrespiratória.

Solução

Gabarito: D) Tranquiliza os pais, deixando claro que o episódio é benigno e autolimitado.

GABARITO: ALTERNATIVA D

Questão difícil, contudo, muito direta.

A crise de perda de fôlego é um diagnóstico diferencial de uma crise epilética, contudo, diferentemente dessa condição, na perda cianótica do fôlego, o paciente não apresenta perda da consciência, além de poder ser deflagrado por episódios de choro prolongado. Essa condição é benigna, tende a melhorar com o tempo e não está associada a disfunção neurológica ou a riscos propriamente ditos. Vejamos as alternativas:

A letra A está incorreta. INCORRETO. Não há necessidade do uso de fármaco anticrise, já que tal evento não é epilético.

A letra B está incorreta. INCORRETO. Muito embora o esclarecimento de dúvidas faça parte do manejo do quadro, não há risco alto de crises epiléticas recorrentes.

A letra C está incorreta. INCORRETO. Mais uma vez. É uma condição benigna. Não demanda seguimento multidisciplinar.

A letra D está correta. CORRETO. Exatamente. É uma condição benigna, autolimitada e que não demanda propedêutica adicional, tampouco tratamento específico.

A letra E está incorreta. INCORRETO. A condição não está associada a risco elevado de parada cardiorrespiratória.

Questão | | 2023 | 4000181634

Na Hiperplasia congênita das suprarrenais por deficiência da 21-hidroxilase, ocorre

- A) aumento exagerado da produção de cortisol, sem alterar os níveis de aldosterona.
- B) deficiência de 17-hidroxiprogesterona, com aumento da produção dos androgênios suprarrenais, exceto de androstenediona e testosterona.
- C) aumento do cortisol, com retroalimentação negativa deficiente do cortisol na hipófise e no hipotálamo, seguida por grave redução de hormônio liberador de corticotrofina e hormônio adrenocorticotrófico.
- D) hiperplasia das glândulas por redução dos níveis de hormônio liberador de corticotrofina e de hormônio adrenocorticotrófico.
- E) deficiência da produção de cortisol e, em 75% dos pacientes, deficiência da produção de aldosterona.

Solução

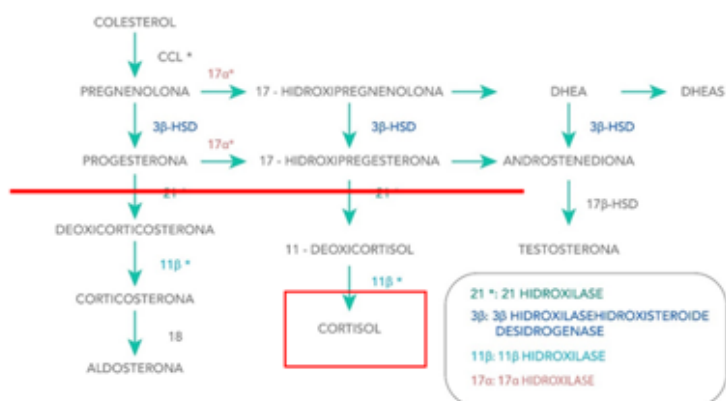
Gabarito: E) deficiência da produção de cortisol e, em 75% dos pacientes, deficiência da produção de aldosterona.

GABARITO: ALTERNATIVA E

Olá Estrategista,

Vamos agora lembrar de uma condição que pode ser detectada pelo teste de triagem neonatal: a hiperplasia adrenal congênita (HAC).

Em primeiro lugar, é importante lembrar que o principal tipo de HAC é por deficiência da enzima 21 hidroxilase. Ela causa um bloqueio na produção dos hormônios da adrenal que pode ser visto na figura abaixo:



A linha horizontal vermelha indica o bloqueio enzimático.

Com o bloqueio, a produção de aldosterona que é um mineralocorticoide e do cortisol, que é um glicocorticoide fica prejudicada, assim, o nível sérico baixo de cortisol, estimula a produção do CRH (hormônio liberador de corticotrofina) pelo hipotálamo e do ACTH (hormônio adrenocorticotrófico) pela hipófise.

A produção do ACTH e do CRH causam hiperplasia da glândula e aumentam a produção dos seus hormônios, contudo, devido ao bloqueio enzimático, ocorre acúmulo dos precursores como a 17 hidroxiprogesterona, a androstenediona e por consequência da testosterona. A falta de cortisol pode provocar hipoglicemia, a falta de produção de aldosterona faz com que ocorra perda de sódio pelos rins e acúmulo de potássio e a testosterona aumentada causa virilização do feto feminino, e no menino pode haver aumento da coloração da bolsa escrotal e aumento peniano.

Vamos analisar as afirmações:

A letra A está incorreta. Incorreta A, é o contrário, a produção de cortisol e de aldosterona estão diminuídas.

A letra B está incorreta. Incorreta B, a 17-hidroxiprogesterona está aumentada, pois fica antes do bloqueio enzimático e ocorre aumento da produção de androstenediona e testosterona.

A letra C está incorreta. Incorreta C, o cortisol encontra-se diminuído com aumento do CRH e ACTH.

A letra D está incorreta. Incorreta o ACTH está aumentado devido à baixa concentração de cortisol.

A letra E está correta. Correta E, nem todas as crianças com HAC têm a forma perdedora de sal, assim a deficiência de cortisol é mais frequente do que a de aldosterona.

Questão | | 2023 | 4000181635

Das opções a seguir, qual cita uma das causas metabólicas mais frequentes de catarata na população pediátrica?

- A)** Hipercalcemia.
- B)** Hipoandrogenismo.
- C)** Hipertireoidismo.
- D)** Hiponatremia.
- E)** Hipoglicemia.

Solução

Gabarito: E) Hipoglicemia.

GABARITO: ALTERNATIVA E

Olá, Estrategista. Questão bem decoreba e específica demais para uma prova de acesso direto, não é mesmo?

A catarata é uma patologia caracterizada pela perda da transparência do cristalino.

Ela pode ser:

1) SENIL

Ocorre em maiores de 50 anos, pelo envelhecimento das fibras do cristalino, que não se renovam. É a forma mais comum.

2) SECUNDÁRIAS a doenças sistêmicas ou oculares.

Doenças sistêmicas: DM, dermatite atópica, distrofia miotônica, neurofibromatose tipo 2

Doenças oculares: alta miopia, uveíte anterior crônica, crise aguda de glaucoma, distrofias hereditárias de fundo.

3) CONGÊNITA

É a principal causa de deficiência visual tratável ou prevenível na infância.

Pode ser idiopática (mais comum).

Hereditária (normalmente autossômica dominante).

Associada a alterações metabólicas sistêmicas: hipoglicemia refratária, galactosemia, síndrome de Lowe e doença de Fabry.

Associada a infecções intrauterinas: rubéola congênita, toxoplasmose, infecção por citomegalovírus e varicela.

Outros: distúrbios cromossômicos, síndromes sistêmicas, trauma, fármacos.

Nesse caso, o diagnóstico precoce é feito através do teste do reflexo vermelho e o tratamento é cirúrgico, com retirada do cristalino opacificado.

Questão | | 2023 | 4000181636

A fibrose cística está presente em 99% dos pacientes com diagnóstico de íleo meconial. Na ausência de fibrose cística, qual é um dos grupos de recém-nascidos (RN) mais acometidos?

- A)** RN com icterícia.
- B)** RN com asfixia perinatal.
- C)** RN com doença hemolítica.
- D)** RN com hipotireoidismo congênito.
- E)** RN prematuro com peso muito baixo.

Solução

Gabarito: E) RN prematuro com peso muito baixo.

GABARITO: ALTERNATIVA E

Questão extremamente do mal! O examinador cobra um detalhe muito específico e desconhecido pela maioria dos não especialistas da área.

O íleo meconial é uma forma de obstrução intestinal perinatal que ocorre quase exclusivamente em RN com fibrose cística (FC) - cerca de 80 a 90% dos pacientes com íleo meconial apresentam fibrose cística.

Ele ocorre quando há uma obstrução intestinal mecânica do íleo terminal por mecônio muito viscoso e espesso, que lembra “massa de vidraceiro” e que dificulta o trânsito intestinal normal. Consequentemente, em virtude da dificuldade de progressão do trânsito, o intestino delgado em sua porção terminal apresenta-se estreitado e sua luz torna-se ocupada por massas pétreas de mecônio.

O íleo meconial pode manifestar-se de duas formas: não complicada e complicada: No não complicada, observamos apenas o fenômeno obstrutivo mecânico. Nos casos complicados, há perfuração intestinal intraútero ou no início do período neonatal. Nesse contexto, pode haver peritonite grave, com resposta inflamatória intensa.

O RN com íleo meconial normalmente é de termo e apresenta peso normal ao nascimento. Os pacientes com essa afecção apresentam três sinais cardinais nas primeiras 24 a 48 horas de vida. São eles:

- Distensão abdominal generalizada
- Vômitos biliosos
- Ausência de eliminação do mecônio.

Além disso, a alça intestinal repleta de mecônio muitas vezes é palpável e apresenta consistência descrita como “pastosa”.

A radiografia simples de abdome é inespecífica. O achado típico corresponde a alças de delgado dilatadas, próximas à impactação (quadrante inferior direito), com aspecto de “vidro triturado” ou “bolha de sabão”.

No íleo meconial simples, o tratamento é feito pela administração retal de substâncias hipertônicas como a gastrografina, cujo mecanismo de ação consiste na absorção de água para a luz intestinal, fazendo com que o mecônio se torne mais fluido e, consequentemente, seja eliminado mais facilmente. O tratamento cirúrgico fica reservado aos casos que não responderam às medidas clínicas ou para os casos de íleo meconial complicado.

Agora, preste atenção aqui, apesar do íleo meconial estar associado na sua imensa maioria das vezes à fibrose cística, o UpToDate traz que: *"Approximately 10 percent of patients with CF* present as neonates with MI*; in most cases, these patients have CF transmembrane conductance regulator gene (CFTR) mutations associated with inadequate CFTR production or folding ("severe" genotypes). Conversely, most series suggest that 80 to 90 percent of infants with MI have CF, although a few series report higher proportions of non-CF MI, particularly in low birth weight infants ."*

*CF=Fibrose cística

MI= Íleo meconial

Ou seja, estudos demonstraram que o íleo meconial pode estar associado a neonatos de baixo peso. Lendo os artigos indicados, eles associam prematuridade+baixo peso com íleo meconial. Portanto, gabarito letra E. Uma questão extremamente infeliz.

Questão | | 2023 | 4000181637

Uma criança em idade escolar é levada para consulta de rotina. Ela fazia acompanhamento em outra cidade e vem, hoje, para a primeira consulta com você. Ao exame físico, você

detecta um sopro cardíaco. Qual das seguintes características indica se tratar de um sopro patológico?

- A) Sopro acentuado por quadro febril.
- B) Ausência de irradiação do sopro.
- C) Desaparecimento ou diminuição do sopro com a mudança de decúbito.
- D) Presença de frêmitos.
- E) Sopro localizado em área pequena e bem definida.

Solução

Gabarito: D) Presença de frêmitos.

GABARITO: ALTERNATIVA D

Os sopros são sons do sangue fluindo pelo coração, podem ser fisiológicos ou patológicos e podem ser a primeira manifestação de uma cardiopatia congênita.

Os sopros funcionais, também chamados de inocentes, ocorrem quando temos a presença de uma alteração na ausculta sem anormalidades anatômicas. Geralmente é um achado incidental em crianças de idade escolar.

Características dos sopros funcionais:

- Audíveis principalmente em estados hipercinéticos, como febre, anemia e desidratação.
- Sistólicos. Nunca diastólicos.
- De curta duração e baixa intensidade.
- Não há frêmitos, estalidos ou cliques.
- Não irradia.
- A ausculta das bulhas é normal.
- Radiografia de tórax e eletrocardiograma são normais.
- Diminui a intensidade quando em posição ereta (ortostática), sentado e com manobra de Valsalva.

Das alternativas abaixo, os frêmitos indicam um sopro patológico.

Questão | | 2023 | 4000181638

Um bebê de 6 meses é levado ao hospital por tosse, cansaço para respirar e respiração mais “rápida”. Nega ter tido febre, mas teve, logo antes do quadro atual, coriza leve e um pouco de obstrução nasal. Ao exame físico, o paciente apresenta taquipneia, retrações subcostais discretas e sibilos difusos à ausculta. Com base no diagnóstico provável de bronquiolite viral aguda (BVA), informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma a seguir e assinale a alternativa com a sequência correta.

() A ausência de febre não é compatível com o diagnóstico de BVA.

- () O aumento da frequência respiratória é um sinal importante e traduz a resposta do organismo ao acometimento pulmonar pelo agente infeccioso, em uma tentativa de compensar os mecanismos geradores de prejuízo na mecânica pulmonar e na troca gasosa.
- () Crepitações inspiratórias disseminadas por todos os campos pulmonares não ocorrem na BVA e, se presentes, indicam diagnóstico alternativo.
- () A radiografia de tórax pode ser útil nos casos graves, e os principais achados são hiperinsuflação torácica difusa, hipertransparência, retificação do diafragma e até broncograma aéreo com um infiltrado de padrão intersticial.
- () Na grande maioria dos pacientes, a evolução é benigna, e o processo evolui para a cura sem a necessidade de intervenção.
- A)** F – V – V – V – V.
- B)** V – V – V – F – V.
- C)** F – F – F – F – F.
- D)** F – V – F – V – V.
- E)** V – F – V – V – F.

Solução

Gabarito: D) F – V – F – V – V.

GABARITO: ALTERNATIVA D

Olá Estrategista,

O lactente do enunciado apresenta um quadro clássico de bronquiolite viral aguda e o próprio examinador sugere esse diagnóstico.

A bronquiolite viral aguda (BVA) se caracteriza pelo primeiro episódio de sibilância em um lactente que apresenta sinais clínicos de infecção viral do trato respiratório inferior e ausência de outra razão que explique a sibilância.

Quando falamos em bronquiolite nos lembramos do vírus sincicial respiratório (VSR) que é seu principal agente etiológico, sendo relatado em cerca de 50% dos casos.

A história clássica da BVA é a de um lactente que frequenta creche ou teve contato com algum parente que está com infecção viral. O lactente começa a apresentar um resfriado comum, caracterizado por febre baixa nos primeiros 2 dias, associada a coriza hialina, obstrução nasal, espirros e tosse seca e algum grau de irritabilidade. Por volta do 4º ao 6º dia, esses pacientes evoluem com piora respiratória, que se deve ao acometimento das vias aéreas inferiores.

Ao exame físico, podemos observar sinais de desconforto respiratório, taquipneia, roncos, sibilos expiratórios, aumento do tempo expiratório, estertores finos e grossos, estes se relacionam à presença de secreção nos alvéolos e bronquíolos terminais.

Não é necessária a realização de exames laboratoriais e de imagem para o diagnóstico da BVA. Apenas os dados clínicos são suficientes. Contudo, em situações em que se indica o tratamento hospitalar, os exames devem ser realizados com o intuito de se detectar possíveis

complicações como a atelectasia e infecção secundária. Quando a radiografia de tórax for realizada, ela costuma demonstrar os clássicos sinais de hiperinsuflação pulmonar:

- Hipertransparência do parênquima pulmonar,
- Retificação de arcos costais,
- Retificação do diafragma.

Algumas crianças podem apresentar infiltrado intersticial discreto.

O tratamento se baseia em medidas de suporte com inalação, hidratação e controle da febre.

Vamos analisar as afirmações:

A ausência de febre não é compatível com o diagnóstico de BVA: falso, pois nem todos os lactentes com bronquiolite apresentam febre.

O aumento da frequência respiratória é um sinal importante e traduz a resposta do organismo ao acometimento pulmonar pelo agente infeccioso, em uma tentativa de compensar os mecanismos geradores de prejuízo na mecânica pulmonar e na troca gasosa: verdadeiro, a taquipneia é um mecanismo compensatório que ajuda a compensar a dificuldade nas trocas gasosas.

Crepitações inspiratórias disseminadas por todos os campos pulmonares não ocorrem na BVA e, se presentes, indicam diagnóstico alternativo: falsa, as crepitações finas bilaterais são um achado frequentemente encontrado na BVA

A radiografia de tórax pode ser útil nos casos graves, e os principais achados são hiperinsuflação torácica difusa, hipertransparência, retificação do diafragma e até broncograma aéreo com um infiltrado de padrão intersticial: verdadeiro, esses achados são encontrados na BVA

Na grande maioria dos pacientes, a evolução é benigna, e o processo evolui para a cura sem a necessidade de intervenção: verdadeira, a maior parte dos lactentes com BVA não necessitam de internação..

A letra A está incorreta.

A letra B está incorreta.

A letra C está incorreta.

A letra D está correta. Correta D, porque indicou as afirmativas verdadeiras e falsas na sequência correta.

A letra E está incorreta.

Questão | | 2023 | 4000181639

Sobre a predominância das neoplasias em pediatria, de acordo com a idade e o sítio primário, assinale a alternativa correta.

- A)** Entre os linfomas, tanto o de Hodgkin quanto o de não Hodgkin, são bastante predominantes em menores de 1 ano.
- B)** Entre as leucemias, a leucemia mieloide crônica juvenil é a mais predominante na adolescência e é rara em menores de 3 anos.
- C)** Das neoplasias de sistema nervoso central, o astrocitoma cerebelar está entre as mais predominantes em maiores de 3 anos.
- D)** Das neoplasias com sítio primário em cabeça e pescoço, as mais predominantes, em todas as faixas etárias, são o sarcoma de partes moles e o linfoma.
- E)** O neuroblastoma e o tumor de Wilms são as neoplasias de sítio abdominal mais predominantes em adolescentes.

Solução

Gabarito: C) Das neoplasias de sistema nervoso central, o astrocitoma cerebelar está entre as mais predominantes em maiores de 3 anos.

GABARITO: ALTERNATIVA C

O câncer na criança é diferente do adulto, pois geralmente não dependem de exposição a fatores de risco. Os cânceres pediátricos mais frequentes são as leucemias, os tumores do sistema nervoso central e os linfomas.

Diferentemente do que ocorre no adulto, as neoplasias malignas pediátricas tendem a apresentar menores períodos de latência, crescem quase sempre rapidamente, em geral são invasivas e respondem melhor à quimioterapia.

De acordo com a Sociedade Brasileira de Pediatria, o câncer pediátrico é mais comum no sexo masculino, nas crianças menores de 5 anos de idade e no grupo de adolescentes entre 15-19 anos de idade. O câncer representa a primeira causa de óbito por doença nos países desenvolvidos, e, no Brasil, entre crianças e adolescentes, de 1-19 anos de idade.

Observe na tabela abaixo a distribuição dos cânceres mais prevalentes por local e idade.

Cânceres mais prevalentes



Neoplasias	<1 ano	1 a 3 anos	3 a 11 anos	12 a 21 anos
Leucemias	Leucemia congênita	LLA	LLA	LLA
Linfomas	Muito raro	LNH	LNH	LH
SNC	Meduloblastoma	Meduloblastoma	Astrocitoma cerebelar	Astrocitoma cerebelar
Cabeça e pescoço	Retinoblastoma	Retinoblastoma	Rabdomiossarcoma	Linfoma
Torácica	Neuroblastoma	Neuroblastoma	Linfoma	Linfoma
Abdominal	Neuroblastoma	Neuroblastoma	Neuroblastoma	Linfoma
Geniturinário	Teratoma	Rabdomiossarcoma	Rabdomiossarcoma	Teratocarcinoma
Extremidades	Fibrossarcoma	Fibrossarcoma	Rabdomiossarcoma	Osteossarcoma

Adaptado do do Tratado de Pediatria da SBP – 5ª edição

Vamos as alternativas

A letra A está incorreta. Os linfomas são raros em menores de um ano.

A letra B está incorreta. Exceto no primeiro ano de vida, a leucemia mais prevalente é a LLA.

A letra C está correta. Correto. É a neoplasia mais comum de SNC dos 3 aos 21 anos.

A letra D está incorreta. Incorreto. Até os 3 anos é o retinoblastoma, até os 11 anos o rabdomiossarcoma e apenas dos 12 aos 21 anos, o linfoma.

A letra E está incorreta. Acima de 12 anos, a neoplasia mais comum abdominal é o linfoma.

Questão | | 2023 | 4000181640

A bexiga hiperativa é uma das causas de perda urinária na mulher e está relacionada à hiperatividade do músculo detrusor. Sobre esse assunto, é correto afirmar que

- A)** o tratamento da bexiga hiperativa é cirúrgico com sling transobturatório.
- B)** para o diagnóstico, é imprescindível a realização do estudo urodinâmico em todos os casos.
- C)** para o tratamento, é possível usar medicações anticolinérgicas e técnica de biofeedback.
- D)** a imipramina é o tratamento de primeira escolha.
- E)** a bexiga hiperativa acontece devido ao prolapso de parede vaginal anterior.

Solução

Gabarito: C) para o tratamento, é possível usar medicações anticolinérgicas e técnica de biofeedback.

GABARITO: ALTERNATIVA C

O diagnóstico da bexiga hiperativa é clínico e deve ser realizado a partir da sintomatologia da paciente. A constatação de urgência miccional é o sintoma definidor da síndrome, devendo estar presente. Nas provas de Residência, em geral, os quadros clínicos apresentam pacientes com urgência, noctúria e aumento de frequência urinária.

A letra A está incorreta. Alternativa “a” incorreta, pois os slings são empregados no tratamento da incontinência urinária aos esforços.

A letra B está incorreta. Alternativa “b” incorreta, pois o diagnóstico da bexiga hiperativa é clínico, não sendo necessária a realização de estudo urodinâmico para confirmação.

A letra C está correta. Alternativa “c” correta, pois o tratamento conservador também é a primeira linha de tratamento para a incontinência urinária de urgência, segundo a Sociedade Internacional de Continência. As opções de tratamento incluem medidas comportamentais e

fisioterapia.

A técnica de biofeedback é uma técnica que visa melhorar a incontinência através da conscientização da paciente. São utilizados métodos sonoros ou elétricos que emitem sinais quando ocorre relaxamento uretral. Baseiam-se no uso de musculatura acessória quando houver aumento da pressão abdominal. Em caso de falha no tratamento conservador, os anticolinérgicos são as medicações de primeira escolha.

A letra D está incorreta. Alternativa “d” incorreta, pois os antidepressivos tricíclicos, como a imipramina, são menos efetivos do que a oxibutinina e a tolterodina, porém, por apresentarem efeito anticolinérgico e alfa-adrenérgico, podem ser empregados na incontinência urinária mista.

A letra E está incorreta. Alternativa “e” incorreta, pois a bexiga hiperativa tem como principal fator causal, a presença de hiperatividade do detrusor.

Questão | | 2023 | 4000181641

Uma paciente de 40 anos apresenta leucorreia de odor fétido. Na citologia oncótica cervical, foi demonstrada a presença de clue-cells. Sobre esse assunto, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma a seguir e assinale a alternativa com a sequência correta.

() O teste de aminas possivelmente será positivo.

() O PH vaginal, nesse caso, será menor que 4,5.

() *Gardnerella vaginalis*, *Bacterioides*, *Mobiluncus* e *Peptococcus* fazem parte da flora normal, desde que em pequenas quantidades.

() Nesse caso, é necessário o tratamento do parceiro.

A) V – V – V – F.

B) V – F – V – F.

C) V – V – F – F.

D) F – F – F – V.

E) F – F – V – F.

Solução

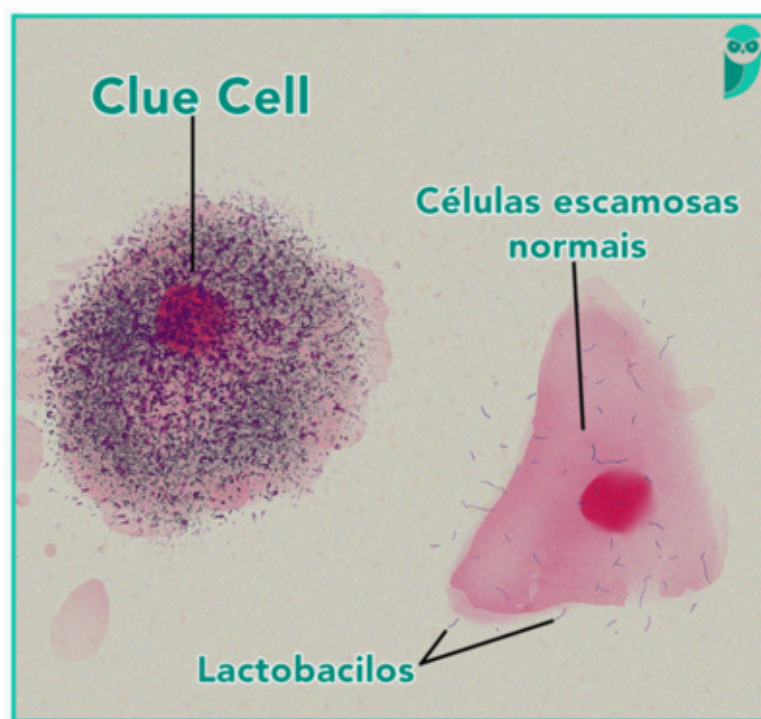
Gabarito: B) V – F – V – F.

GABARITO: ALTERNATIVA B

A vaginose bacteriana (VB) é a principal causa de corrimento vaginal de origem infecciosa, sendo responsável por aproximadamente 40% - 50% de todos os casos. O termo “vaginose” descreve a presença de leucorreia sem sinais clínicos de inflamação e nem leucócitos no esfregaço (o que o diferencia de “vaginite”).

Na VB, ocorre diminuição dos lactobacilos produtores de ácido lático e peróxido de hidrogênio. Consequentemente, há aumento de pH e aumento da concentração de anaeróbios, tais como: *Gardnerella vaginalis*, *Peptostreptococcus*, *Bacteroides* sp., *Mobiluncus* sp., *Fusobacterium*, *Atopobium vaginae* e *Mycoplasma hominis*.

A proliferação de anaeróbios é acompanhada de produção de enzimas proteolíticas que liberam aminas (putrescina, cadaverina e trimetilamina). Essas, por sua vez, atuam aumentando a transudação de fluidos vaginais e esfoliação de células epiteliais, resultando no corrimento característico da patologia. As células epiteliais, quando descamam, são chamadas de clue cells ou “células-guia” e são vistas no exame a fresco ou na bacterioscopia corada pelo Gram como células epiteliais de contorno pouco nítido, rodeadas por anaeróbios.



(V) O teste de aminas possivelmente será positivo.

Verdadeiro, pois as bactéria envolvidas com a vaginose liberam aminas voláteis em contato com o KOH.

(F) O PH vaginal, nesse caso, será menor que 4,5.

Falsa, pois o pH vaginal na vaginose é superior a 4,5

(V) Gardnerella vaginalis, Bacterioides, Mobiluncus e Peptococcus fazem parte da flora normal, desde que em pequenas quantidades.

Verdadeiro, pois todos esses são agentes anaeróbios envolvidos com a vaginose bacteriana.

(F) Nesse caso, é necessário o tratamento do parceiro.

Falsa, pois a vaginose bacteriana não é uma IST.

Diante do exposto, a alternativa correta é a letra “b”.

Questão | | 2023 | 4000181642

Pacientes que apresentam vaginose citolítica podem ter alguns sintomas semelhantes a outros tipos de vaginites, como prurido e corrimento esbranquiçado antes do período menstrual; ardor; queimação; disúria e dispareunia. Essa semelhança de sintomas com outras patologias do trato genital inferior pode atrasar o seu diagnóstico. Em relação à vaginose citolítica, é correto afirmar que

- A) é causada pela proliferação excessiva de *Lactobacillus* e pela redução do PH vaginal, que se encontra menor ou igual a quatro.
- B) o processo inflamatório intenso é causado por *Streptococcus* do grupo B e *Escherichia Coli*.
- C) tem como agente etiológico o parasita flagelado *Trichomonas vaginalis*.
- D) é o processo inflamatório vaginal causado pela proliferação de fungos como o *Candida tropicalis*.
- E) é causada pela substituição da flora microbiana vaginal denominada *Lactobacillus* por bactérias anaeróbias e facultativas.

Solução

Gabarito: A) é causada pela proliferação excessiva de *Lactobacillus* e pela redução do PH vaginal, que se encontra menor ou igual a quatro.

GABARITO: ALTERNATIVA A

A vaginose citolítica é uma condição pouco diagnosticada, devido tanto à falta do conhecimento da sua existência por parte dos profissionais de saúde quanto ao seu quadro clínico, que é muito semelhante ao da candidíase vulvovaginal. A prevalência dessa doença varia de 1,8% a 7,1% e é causa de vulvovaginite cíclica em mulheres em idade reprodutiva.

As pacientes com essa vulvovaginite apresentam proliferação excessiva de lactobacilos, que diminuem o pH vaginal. Esses, isoladamente ou em conjunto com outros microrganismos, danificam as células da camada intermediária vaginal, causando citólise. A acidez vaginal excessiva junto com os produtos da citólise levam aos sintomas da doença.

Os sintomas da vaginose citolítica são semelhantes aos da candidíase: corrimento vaginal esbranquiçado com prurido, sensação de queimação, desconforto e dispareunia, que se acentuam no período pré-menstrual. Ao exame especular, observa-se corrimento vaginal abundante, esbranquiçado, que pode ou não estar aderido às paredes vaginais. Sinais inflamatórios também podem ser encontrados, devido à acidez excessiva e à citólise.

A letra A está correta. Alternativa “a” correta, pois conforme foi explicado na introdução, essa vulvovaginite se caracteriza pela proliferação de lactobacilos com aumento da acidez vaginal.

A letra B está incorreta. Alternativa “b” incorreta, pois a vulvovaginite causada por esses agentes é a vaginite aeróbia, um diagnóstico diferencial para tricomoníase.

A letra C está incorreta. Alternativa “c” incorreta, pois o *Trichomonas vaginalis* é o agente da tricomoníase.

A letra D está incorreta. Alternativa “d” incorreta, pois a proliferação da *Candida* está associada à candidíase, que é um diagnóstico diferencial importante.

A letra E está incorreta. Alternativa “e” incorreta, pois a proliferação de anaeróbios caracteriza a vaginose bacteriana.

Questão | | 2023 | 4000181643

Dentre as alternativas a seguir, qual delas apresenta os achados que seriam mais sugestivos de câncer de mama?

- A)** Cisto único no quadrante inferior interno da mama esquerda.
- B)** Cistos múltiplos em ambas as mamas.
- C)** Nódulos difusos, simétricos, em ambas as mamas.
- D)** Consolidação na mama direita que aparece logo antes da menstruação.
- E)** Nódulo sólido único no quadrante superior externo da mama esquerda.

Solução

Gabarito: E) Nódulo sólido único no quadrante superior externo da mama esquerda.

GABARITO: ALTERNATIVA E

Estrategista, o câncer de mama pode manifestar-se clinicamente por meio de vários sinais. O sinal clássico do câncer de mama é o nódulo mamário único endurecido e indolor. Outros possíveis sinais do câncer de mama são: aumento do volume da mama com edema, eritema e outras alterações da pele, como a peau d'orange ou ulceração; descarga papilar sanguinolenta ou em água de rocha; abaulamentos ou retrações; e inversão do mamilo.

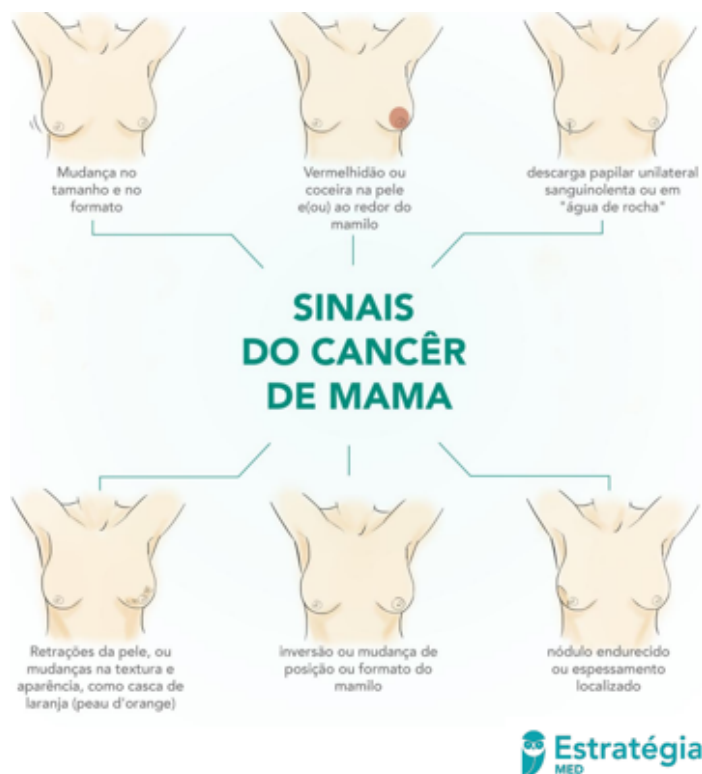
Repare que a dor não é um sintoma característico do câncer de mama. A maioria das pacientes com câncer de mama não sente dor. Esse é um dos motivos que podem retardar a procura do médico, atrasando o diagnóstico da doença. O câncer de mama costuma causar dor nos casos mais avançados, pelo comprometimento profundo dos nervos intercostais ou pelo comprometimento da pele com ulceração.

A palpação de linfonodos axilares endurecidos, aumentados e, em alguns casos, aglomerados, formando uma “massa”, são o sinal de acometimento pelo câncer. Chamamos esses casos de “doença localmente avançada”.

A presença de abaulamentos ou retrações também é sinal de câncer de mama. As retrações ocorrem pelo acometimento dos ligamentos de Cooper pelo tumor.

Alterações da pele, como eritema, edema e a pele em casca de laranja (peau d'orange), também são possíveis sinais do câncer de mama (inflamatório). As ulcerações da pele da mama e do complexo areolopapilar são outros possíveis sinais.

A descarga papilar sanguinolenta ou em água de rocha (translúcida), espontânea, uniductal e unilateral também é suspeita de malignidade.



Agora vamos analisar as alternativas:

A letra A está incorreta. Incorreta a alternativa A, porque o cisto simples (coleção líquida) é uma lesão absolutamente benigna.

A letra B está incorreta. Incorreta a alternativa B, porque os cistos simples, mesmo que múltiplos, são lesões benignas.

A letra C está incorreta. Incorreta a alternativa C, porque nódulos difusos e múltiplos em geral são fibroadenomas e são lesões benignas.

A letra D está incorreta. Incorreta a alternativa D, porque a consolidação ou espessamento das mamas antes da menstruação acontece devido ao estímulo hormonal proliferativo sobre a

glândula mamária do estrógeno e progesterona, característico deste período do ciclo menstrual, regredindo após a menstruação, quando ocorre diminuição destes hormônios. É uma alteração absolutamente benigna.

A letra E está correta. Correta a alternativa E: o sinal clássico do câncer de mama é o nódulo mamário único endurecido e indolor.

Questão | | 2023 | 4000181644

Uma mulher de 53 anos vem ao ambulatório de uroginecologia referindo perda urinária. Possui histórico de 5 partos via vaginal e apresenta menopausa há 7 anos, sem terapia de reposição hormonal. No exame físico ginecológico, apresenta prolapso de parede anterior grau 1, sem perda urinária à valsalva. Apresenta resultado de estudo urodinâmico que revelou a presença de contrações não inibidas do músculo detrusor como único achado. Nesse caso, a abordagem terapêutica inicial é

- A) correção cirúrgica do prolapso de útero e da parede vaginal anterior por via vaginal.
- B) terapia de reposição hormonal apenas com estrogênio via oral.
- C) colposacrofixação.
- D) tratamento comportamental podendo ou não associar anticolinérgicos.
- E) correção de parede vaginal anterior com tela, via vaginal.

Solução

Gabarito: D) tratamento comportamental podendo ou não associar anticolinérgicos.

GABARITO: ALTERNATIVA D

A paciente em questão apresenta incontinência urinária com um estudo urodinâmico que evidencia contrações não inibidas do detrusor, indicando que se trata de uma incontinência urinária de urgência. É importante ressaltar que a paciente não tem queixa em relação ao prolapso, sendo considerado apenas um achado do exame físico, que não guarda relação com as queixas urinárias.

O tratamento conservador é a primeira linha de tratamento para a incontinência urinária de urgência, segundo a Sociedade Internacional de Continência. As opções de tratamento incluem medidas comportamentais e fisioterapia.

A letra A está incorreta. Alternativa “a” incorreta, pois a paciente não tem indicação de tratar o prolapso da parede anterior, pois não tem sintomas. Além disso, não há referência a um prolapso uterino.

A letra B está incorreta. Alternativa “b” incorreta, pois não há referência à presença de atrofia urogenital que indicaria o uso de estrogênio vaginal. Além disso, o estrogênio tópico não é considerado um tratamento eficaz para incontinência urinária.

A letra C está incorreta. Alternativa “c” incorreta, pois esse procedimento é empregado no tratamento de prolapso apicais e a paciente tem uma incontinência urinária.

A letra D está correta. Alternativa “d” correta, pois o tratamento comportamental é a primeira linha e caso não haja melhora podem ser empregados anticolinérgicos.

A letra E está incorreta. Alternativa “e” incorreta, pois a queixa da paciente é de incontinência e não está associada ao prolapso da parede anterior, não havendo indicação de corrigi-lo.

Questão | | 2023 | 4000181645

Uma paciente de 55 anos, com antecedente de menopausa aos 50 anos, refere que nunca usou terapia hormonal e faz tratamento de hipertensão e diabetes. Relata que, há cerca de um mês, apresentou sangramento vaginal em dois momentos diferentes, durando aproximadamente 2 dias cada episódio. Apresenta citopatológico com atrofia acentuada. Ultrassom transvaginal evidencia a presença de dois miomas intramurais de 0,7 e 1,3 cm respectivamente; volume uterino de 35 cm³; e endométrio de 11 mm. Ovários não foram visualizados. Diante desse caso, qual é a melhor conduta?

- A)** Histerectomia total abdominal mais anexectomia.
- B)** Acetato de medroxiprogesterona trimestral.
- C)** Iniciar estriol creme vaginal.
- D)** Histeroscopia diagnóstica.
- E)** Miomectomia.

Solução

Gabarito: D) Histeroscopia diagnóstica.

GABARITO: ALTERNATIVA D

Estrategista, neste caso temos uma paciente com sangramento pós menopausa e fatores de risco para o câncer de endométrio (hipertensão e diabetes). A ultrassonografia revelou uma

espessura endometrial de 11mm. Será que este endométrio está espessado? Veja o fluxograma abaixo:



Esta paciente apresenta sangramento pós menopausa e espessamento endometrial, tendo como hipótese diagnóstica a hiperplasia ou o câncer de endométrio, estando indicada a biópsia do endométrio. O exame padrão ouro para avaliação da cavidade uterina é a histeroscopia. Poderia ser tentada uma biópsia ambulatorial com cateter de Pipelle ou a curetagem uterina, mas o exame com maior acurácia para o diagnóstico do câncer de endométrio é a histeroscopia.

Agora vamos analisar as alternativas:

A letra A está incorreta. Incorreta a alternativa A, porque antes de indicar a histerectomia é necessário confirmar o diagnóstico de câncer de endométrio através de biópsia.

A letra B está incorreta. Incorreta a alternativa B, porque é necessário biópsia do endométrio para avaliar se há hiperplasia ou câncer e como a paciente já está menopausada não haveria indicação de tratamento clínico com progestágeno, estando indicada a histerectomia como tratamento.

A letra C está incorreta. Incorreta a alternativa C, porque o estriol pode estimular proliferação endometrial, podendo causar progressão da doença da paciente e piora do seu prognóstico.

A letra D está correta. Correta a alternativa D: temos como hipótese a hiperplasia ou câncer do endométrio, estando indicada a biópsia e o método padrão ouro é a histeroscopia.

A letra E está incorreta. Incorreta a alternativa E, porque a causa do sangramento pós menopausa desta paciente não é a miomatose uterina, e sim a hiperplasia ou câncer de endométrio.

Questão | | 2023 | 4000181646

A presença de células “em anel de sinete”, no exame de anatomopatológico, é um achado de qual dos seguintes tumores ovarianos?

- A)** Tumor de Brenner.
- B)** Tumor de Krukenberg.

- C)** Teratoma imaturo do ovário.
- D)** Tumor seroso.
- E)** Disgerminoma.

Solução

Gabarito: B) Tumor de Krukenberg.

GABARITO: ALTERNATIVA B

A classificação dos tumores malignos do ovário baseia-se na origem embrionária das células. Os tumores não metastáticos do ovário podem ser divididos em epiteliais, de células germinativas e do estroma dos cordões sexuais, conforme explicamos anteriormente. Cerca de 90% das neoplasias malignas ovarianas têm origem no epitélio; já as que têm origem nas células germinativas correspondem a pouco mais de 5% dos casos e as do estroma do cordão sexual apresentam uma pequena proporção dos tumores.

O único tumor metastático de ovário cobrado nas provas é o tumor de Krukenberg. É um tumor ovariano produtor de mucina e que, histologicamente, apresenta células em anel de sinete. O sítio primário desses tumores é, mais frequentemente, o estômago, porém intestino, mamas ou vias biliares podem também abrigar o tumor primário. O prognóstico, nesses casos, costuma ser ruim, pois o diagnóstico costuma ser feito pela metástase ovariana, quando o câncer já está disseminado.

A letra A está incorreta. Alternativa “a” incorreta, pois o tumor de Brenner é uma neoplasia fibroepitelial, predominantemente benigna, unilateral e de pequeno tamanho. Também pode estar associado à síndrome de Meigs.

A letra B está correta. Alternativa “b” correta, pois conforme foi explicado na introdução, o tumor de Krukenberg apresenta células em anel de sinete.

A letra C está incorreta. Alternativa “c” incorreta, pois o teratoma imaturo do ovário apresenta tecidos embrionários em sua composição.

A letra D está incorreta. Alternativa “d” incorreta, pois o tumor seroso do ovário é um tumor epitelial que não apresenta esse tipo de células.

A letra E está incorreta. Alternativa “e” incorreta, pois o disgerminoma é um tumor de células germinativas.

Questão | | 2023 | 4000181647

Quais dos seguintes sintomas podem estar associados ao aumento do hormônio prolactina no organismo?

- A) Queda de cabelo e acne.
- B) Hirsutismo e aumento do fluxo menstrual.
- C) Amenorreia e galactorreia.
- D) Irregularidade menstrual e disforia pré-menstrual.
- E) Dispareunia e dismenorreia.

Solução

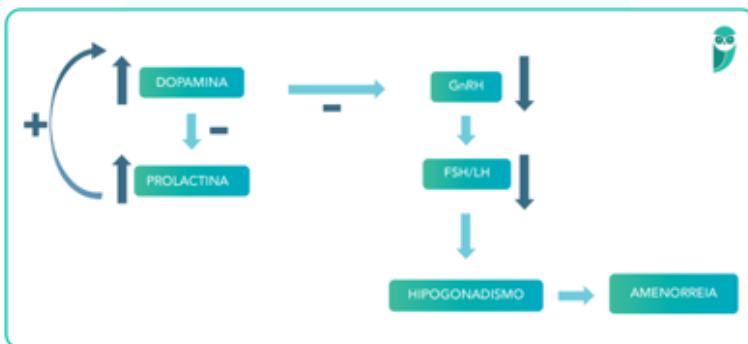
Gabarito: C) Amenorreia e galactorreia.

GABARITO: ALTERNATIVA C

A prolactina (PRL) é um hormônio sintetizado, na sua maioria, pela adeno-hipófise (existem fontes extra hipofisárias de prolactina, incluindo linfócitos, fibroblastos cutâneos, cérebro, glândula mamária, decídua e tecido adiposo) e tem como função estimular a glândula mamária a produzir leite. Entretanto, devido a seus mecanismos de regulação, esse hormônio também relaciona-se com importantes sintomas sistêmicos, como a amenorreia.

Diferentemente dos outros hormônios hipofisários, a liberação de prolactina é controlada por inibição da dopamina, um neurotransmissor hipotalâmico.

O mecanismo pelo qual a hiperprolactinemia leva à amenorreia está descrito no esquema abaixo:



A letra A está incorreta. Alternativa “a” incorreta, pois esses sintomas estão associados ao aumento dos androgênios.

A letra B está incorreta. Alternativa “b” incorreta, pois o hirsutismo ocorre por aumento de androgênios e a prolactina está associada à amenorreia.

A letra C está correta. Alternativa “c” correta, pois o aumento de prolactina tem como principais sintomas a galactorreia e a amenorreia.

A letra D está incorreta. Alternativa “d” incorreta, pois a hiperprolactinemia não se relaciona a sintoma pré-menstruais.

A letra E está incorreta. Alternativa “e” incorreta, pois nenhum desses sintomas ocorre por aumento de prolactina.

Questão | | 2023 | 4000181648

Das patologias a seguir, estão associadas à amenorreia primária, EXCETO

- A)** síndrome de Rokitansky.
- B)** síndrome de Morris.
- C)** síndrome de Kallmann.
- D)** síndrome de Asherman.
- E)** hímen imperfurado.

Solução

Gabarito: D) síndrome de Asherman.

GABARITO: ALTERNATIVA D

A amenorreia primária é definida como ausência de menstruação (menarca) aos 14 anos associada à falha no desenvolvimento de caracteres sexuais ou aos 16 anos, mesmo com desenvolvimento de caracteres sexuais (mamas e pelos). A média de idade da menarca é de 12 anos. Ela ocorre quando há o amadurecimento do eixo HHO.

A definição acima é adotada pelo Tratado de Ginecologia do Williams. Já o Tratado de Ginecologia da Febrasgo (Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia) e o livro de Berek e Novak consideram a amenorreia primária como ausência de menstruação aos 13 anos, quando não há caracteres sexuais secundários, ou aos 15 anos, mesmo na presença de caracteres sexuais secundários.

A letra A está incorreta. Alternativa “a” incorreta, pois a síndrome de Rokitansky é uma causa de amenorreia primária por uma anomalia mulleriana que leva a ausência de útero, tubas e terço superior da vagina.

A letra B está incorreta. Alternativa “b” incorreta, pois na síndrome de Morris é uma insensibilidade periférica a ação dos androgênios que leva indivíduos com cariótipo XY a desenvolverem fenótipo feminino. Nesses casos também não há útero, tubas e terço superior de vagina e por isso não há menstruação.

A letra C está incorreta. Alternativa “c” incorreta, pois a síndrome de Kallmann é uma causa de amenorreia primária hipotalâmica. Nesse caso há uma alteração na formação dos neurônios hipotalâmicos que impede a secreção de GnRH.

A letra D está correta. Alternativa “d” correta, pois a síndrome de Ashermann é uma causa de amenorreia secundária que ocorre pela formação de sinequias intrauterinas após um procedimento como a curetagem.

A letra E está incorreta. Alternativa “e” incorreta, pois o hímen imperfurado é uma causa de amenorreia primária, devido à presença de uma membrana que impede a drenagem do sangue por via vaginal.

Questão | | 2023 | 4000181649

Uma gestante de 18 anos, G1, que não realizou pré-natal, com aproximadamente 38 semanas de idade gestacional, calculada pela data da última menstruação, chega à maternidade em trabalho de parto, com 3 contrações em 10 minutos e toque vaginal colo esvaecido com 6 cm de dilatação. Nesse caso, visando reduzir os riscos de transmissão vertical do HIV, é correto afirmar que

- A)** deve ser realizado teste rápido de HIV na admissão e, caso o resultado seja positivo, iniciar infusão de AZT.
- B)** deve ser realizado teste rápido de HIV na admissão e, caso o resultado seja positivo, será uma indicação absoluta de cesárea.
- C)** deve ser realizado teste rápido de HIV na admissão e, caso o resultado seja positivo, a amniotomia precoce será indicada.

- D)** deve ser realizado teste rápido de HIV na admissão e, caso o resultado seja positivo, o parto instrumentalizado e a episiotomia estão indicados para acelerar o nascimento.
- E)** deve ser realizado teste rápido de HIV na admissão e, caso o resultado seja negativo, exclui-se completamente a possibilidade de essa paciente possuir o vírus do HIV.

Solução

Gabarito: A) deve ser realizado teste rápido de HIV na admissão e, caso o resultado seja positivo, iniciar infusão de AZT.

GABARITO: ALTERNATIVA A

O que o examinador quer saber: sobre HIV na gestação.

A indicação da via de parto nas gestantes vivendo com HIV dependerá da CV realizada na 34ª semana:

CV com 34 semanas	Conduta no parto
CV > 1000 cópias ou desconhecida	AZT EV + cesárea eletiva após 38 semanas
CV detectável < 1000 cópias	AZT EV + parto com indicação obstétrica, de preferência parto vaginal
CV indetectável	Manter TARV habitual + parto com indicação obstétrica, de preferência parto vaginal

Nos casos em que a cesárea for indicada (ou seja, CV > 1000 cópias/ml), iniciamos a infusão 3 horas antes do parto. Caso a gestante entre em trabalho de parto antes da realização da cesariana, deve-se aguardar o parto vaginal se a paciente estiver em franco trabalho de parto, com mais do que 4 cm de dilatação.

Algumas outras medidas de prevenção no intraparto são:

- Não realizar procedimentos invasivos, como amniotomia, cordocentese ou monitorização fetal invasiva.
- Evitar parto instrumentalizado: fórceps ou vácuo-extrator.
- Ligadura do cordão umbilical imediata ao parto.
- Manter membrana amniótica íntegra no parto cesárea (parto empelidado).
- Banhar o recém-nascido em água corrente.

A amamentação está contraindicada para todas as puérperas vivendo com HIV. Deve-se inibir farmacologicamente a lactação com cabergolina 1mg vo dose única, administrado antes da alta hospitalar.

A letra A está correta. Correta a alternativa A: temos uma gestante de 38 semanas em trabalho de parto ativa, com 6 cm de dilatação, sem pré-natal. Para essa gestante deve ser feito o teste rápido de HIV na admissão e se positivo ela deve receber imediatamente a Zidovudina até o clampeamento do cordão, para diminuir o risco de transmissão vertical.

A letra B está incorreta. Incorreta a alternativa B: caso o teste rápido seja positivo, a gestante teria indicação de cesariana se não estivesse em uma fase avançada do trabalho de parto. O MS preconiza a realização de cesariana eletiva com 38 semanas para gestantes com HIV e carga

viral desconhecida ou acima de 1000 cópias e a realização de Zidovudina, porém se a gestante está em trabalho de parto com mais de 4 cm de dilatação, deve-se aguardar o parto vaginal e fazer Zidovudina.

A letra C está incorreta. Incorreta a alternativa C: não deve ser realizada amniotomia precoce em gestante com HIV. O ideal é que o feto nasça empelcado.

A letra D está incorreta. Incorreta a alternativa D: em gestantes com HIV deve-se evitar a realização de parto instrumentalizado e episiotomia.

A letra E está incorreta. Incorreta a alternativa E: o resultado negativo do teste rápido de HIV não exclui completamente esse diagnóstico, pois a paciente pode estar na janela imunológica e ser um falso negativo.

Questão | | 2023 | 4000181650

Em relação à síndrome HELLP, assinale a alternativa INCORRETA.

- A)** Plaquetas abaixo de 50.000 são contraindicação à anestesia raquidiana.
- B)** A cesárea é a via de parto de melhor escolha na síndrome HELLP.
- C)** Pode ocorrer síndrome HELLP sem elevação dos níveis pressóricos.
- D)** O sulfato de magnésio é indicado quando se apresentar esse diagnóstico.
- E)** Pacientes com passado obstétrico de síndrome HELLP devem ser alertadas quanto ao maior risco de apresentar o mesmo quadro em gestação futura.

Solução

Gabarito: B) A cesárea é a via de parto de melhor escolha na síndrome HELLP.

GABARITO: ALTERNATIVA B

O que o examinador quer saber: sobre síndrome HELLP

Atenção, Estrategista! Síndrome HELLP é um tema que cai muito nas provas de residência médica! Então, resumi para você tudo que precisa saber sobre isso!

A síndrome HELLP caracteriza-se pelo quadro de hemólise, aumento das enzimas hepáticas e plaquetopenia, sendo uma das formas mais severas da pré-eclâmpsia, com altas taxas de morbimortalidade materna e fetal. Essa síndrome ocorre com mais frequência no terceiro trimestre e no puerpério. O nome “HELLP” é um mnemônico em inglês das alterações que ocorrem nessa síndrome: HE= Hemólise, EL= aumento das enzimas hepáticas (enzyme of liver) LP= plaquetopenia (low platelets).

Os principais sintomas da síndrome HELLP são: dor em hipocôndrio direito e epigástrio, mal-estar geral, náuseas e vômitos. É importante lembrar que a hipertensão e a proteinúria

podem estar ausentes ou serem apenas ligeiramente anormais, por isso recomenda-se avaliação laboratorial para todas as gestantes com alguns desses sintomas.

Os **fatores de risco** para desenvolver síndrome HELLP são: pele branca, mais de 25 anos, múltiparas, hipertensão arterial crônica, presença de quadro de pré-eclâmpsia ou eclâmpsia. A morbimortalidade materno-fetal é muito elevada nessa síndrome, chegando próximo de 30%.

O diagnóstico da síndrome HELLP é laboratorial e feito por meio dos seguintes critérios:



A síndrome HELLP é chamada de completa quando os três critérios diagnósticos laboratoriais estão presentes e parcial quando estão presentes apenas dois deles.

A trombocitopenia é a principal e mais precoce alteração encontrada. Quanto menor a quantidade de plaquetas, maior a gravidade dessa patologia.

As principais complicações relacionadas a essa síndrome são: **coagulação intravascular disseminada, hematoma/rotura hepática, descolamento prematuro de placenta, insuficiência renal, edema agudo de pulmão, hemorragia intracraniana e descolamento de retina.** O hematoma/rotura hepática é uma das complicações mais temidas na síndrome HELLP e manifesta-se por dor súbita em hipocôndrio direito, ascite, hipotensão e choque. O diagnóstico é feito por exame de imagem (ultrassom, tomografia ou ressonância de abdome).

Os principais diagnósticos diferenciais da síndrome HELLP são: **esteatose hepática aguda da gravidez, hepatites, síndrome hemolítico-urêmica e púrpura trombocitopênica trombótica.** Saber diferenciar essas patologias é importante e vem sendo cobrado nas provas de Residência Médica. Então, fique ligado!

Esteatose hepática		Icterícia, colúria, encefalopatia, CIVD e hipoglicemia grave
Síndrome hemolítico-urêmica		Hemólise microangiopática e insuficiência renal, transaminases normais
Púrpura trombocitopênica trombótica		Trombocitopenia, febre, alt. neurológicas, insuf. renal e anemia hemolítica
Hepatites virais		Icterícia e febre, sem anemia e sem insuficiência renal

Diante de uma paciente com síndrome HELLP, a **conduta inicial é semelhante ao tratamento da pré-eclâmpsia grave**, ou seja, deve-se internar e estabilizar hemodinamicamente a gestante, fazer a avaliação da vitalidade fetal, administrar sulfato de magnésio para prevenção de convulsões e anti-hipertensivo para controle da hipertensão arterial grave (PA $\geq$ 160/110 mmHg). Além disso, os **exames laboratoriais precisam ser realizados a cada 6 horas, até estabilização do quadro.**

Caso haja plaquetopenia abaixo de 50 mil, alguns serviços indicam transfusão de plaquetas e o uso de dexametasona, na dose de 10mg a cada 12h, até 36h após o parto, em mulheres que serão submetidas à cesárea.



Não está indicado o uso de corticoide de rotina para o tratamento da síndrome HELLP

A resolução da gestação é o tratamento definitivo da síndrome HELLP, por isso o parto deve ocorrer em todos os casos, após administração do sulfato de magnésio e estabilização clínica da gestante. Não é indicado manter a gestação, independentemente da idade gestacional, pois os riscos maternos são muito elevados. A administração de corticoterapia abaixo de 34 semanas pode ser realizada, mas o parto só deve ser adiado para a aplicação do ciclo completo de corticoide se houver estabilidade materna e fetal. A via de parto preferida é a vaginal para diminuir o sangramento. A cesárea está indicada nos casos de hematoma hepático.

Repare que o mapa mental a seguir é muito semelhante ao da eclâmpsia e iminência de eclâmpsia, pois as condutas são praticamente as mesmas!



Atenção, Estrategista, o examinador quer a alternativa INCORRETA!

A letra A está incorreta. Correta a alternativa A: plaquetas abaixo de 50 mil contraindicam a realização de raquianestesia e peridural, pois há risco da ocorrência de hematoma na região da punção. Nesses casos é preconizada a anestesia geral.

A letra B está correta. Incorreta a alternativa B: a via de parto de escolha nas pacientes com síndrome HELLP é o parto vaginal, com exceção para os casos de hematoma hepático.

A letra C está incorreta. Correta a alternativa C: a síndrome HELLP pode surgir sem mesmo haver alteração de pressão arterial, embora essas situações sejam extremamente raras. O que define síndrome HELLP é a presença de plaquetopenia, hemólise e aumento das enzimas hepáticas.

A letra D está incorreta. Correta a alternativa D: o sulfato de magnésio é a medicação de escolha nos casos de síndrome HELLP, para a prevenção de convulsões.

A letra E está incorreta. Correta a alternativa E: gestantes com quadro de pré-eclâmpsia, eclâmpsia ou síndrome HELLP na gestação anterior, tem um risco aumentado de apresentar o

mesmo quadro em gestação futura.

Questão | | 2023 | 4000181651

Gestantes que não consomem carne e derivados animais podem apresentar deficiência de

- A)** magnésio.
- B)** ácido fólico.
- C)** vitamina B12.
- D)** vitamina D.
- E)** zinco.

Solução

Gabarito: C) vitamina B12.

GABARITO: ALTERNATIVA C

Proteína animal é um componente importante da alimentação não só de gestantes, mas de qualquer ser humano. Ela até pode ser eliminada da dieta, mas isso desencadeará a deficiência de um nutriente que o organismo só pode absorver através desse tipo de alimentos: a **vitamina B12!**

A carência nutricional de B12 em adultos, no entanto, é rara, porque a reserva desse nutriente no organismo é muito elevada e duradoura, sendo sua deficiência mais frequentemente secundária a **distúrbios de sua absorção**, como gastrectomias ou a **anemia perniciosa** (gastrite atrófica autoimune, em que há destruição das células parietais do estômago e menor produção de fator intrínseco, substância necessária para a entrada da vitamina B12 nas células do íleo distal).

Ainda assim, indivíduos que não ingerem nenhum derivado de proteína animal (veganos) poderão evoluir com deficiência de B12, devendo receber reposição periódica do nutriente.

Com isso em mente, vamos às alternativas:

A letra A está incorreta. Incorreto. O nutriente essencial encontrado apenas na proteína animal é a vitamina B12.

A letra B está incorreta. Incorreto. O ácido fólico advém de diversos alimentos, especialmente vegetais de folhas verdes.

A letra C está correta. Perfeito. A cianocobalamina ou vitamina B12 não é produzida pelo ser humano e deve, necessariamente, ser absorvida advinda da proteína animal (carne, ovos, leite).

A letra D está incorreta. Incorreto. A vitamina D não advém da proteína animal.

A letra E está incorreta. Incorreto. O zinco não advém da proteína animal.

Questão | | 2023 | 4000181652

Gestante, 23 semanas, refere que não fez nenhum dos exames solicitados na rotina de primeiro trimestre. Nega doenças prévias; o peso pré-gestacional era 80 kg e, atualmente, está com 90 kg, sendo que a altura é de 1,60 m. Considerando a disponibilidade técnica adequada, a melhor conduta para o diagnóstico de diabetes gestacional é solicitar

- A)** hemoglobina glicada e glicemia de jejum no momento da consulta.
- B)** teste oral de tolerância à glicose com 100g em jejum e duas horas após sobrecarga.
- C)** teste oral de tolerância à glicose com 75 g em jejum de duas horas imediatamente.
- D)** apenas hemoglobina glicada.
- E)** teste oral de tolerância à glicose com 75 g em jejum, uma e duas horas após sobrecarga, entre 24 e 28 semanas.

Solução

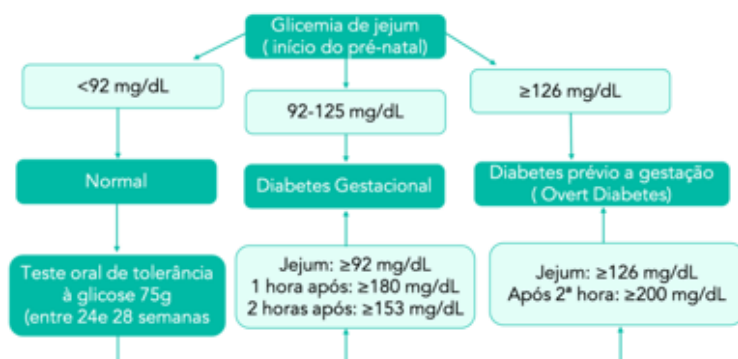
Gabarito: E) teste oral de tolerância à glicose com 75 g em jejum, uma e duas horas após sobrecarga, entre 24 e 28 semanas.

GABARITO: ALTERNATIVA E

O que o examinador quer saber: sobre diabetes na gestação.

Atenção, Estrategista! Saber como fazer o diagnóstico de Diabetes na gestação é crucial para você responder questões sobre esse tema!

O diagnóstico de Diabetes na gestação é feito conforme o organograma a seguir.



Diante de uma gestante com diagnóstico de diabetes na gestação, a primeira conduta é instituir dieta e exercício físico. Além disso, a gestante deve fazer o controle diário dos índices glicêmicos (perfil glicêmico) pela aferição da glicemia capilar diária. Essas medidas são essenciais para avaliar se a terapêutica com dieta e atividade física está sendo eficaz para o controle glicêmico.

Os valores das glicemias considerado normais são:

- Jejum < 95mg/dl
- 1 hora após as refeições < 140mg/dl
- 2 horas após as refeições < 120mg/dl.

A insulinoterapia é indicada quando não se alcança adequado controle glicêmico, isto é, na presença de duas ou mais medidas de glicemia acima da meta, avaliadas após 7 a 14 dias de terapia não farmacológica Ou se circunferência abdominal fetal $\geq$ percentil 75º na ultrassonografia de 3º trimestre (29 e 33 semanas de gestação), independente dos valores glicêmicos.

A letra A está incorreta. Incorreta a alternativa A: a hemoglobina glicada não é um exame utilizado no diagnóstico de diabetes na gestação, mas sim para acompanhamento de gestantes com diabetes prévio à gestação. Como a paciente já está com 23 semanas, deve-se esperar para fazer o TTOG 75g e não fazer apenas a glicemia de jejum.

A letra B está incorreta. Incorreta a alternativa B: o teste oral de tolerância à glicose utilizado é o de 75g e não o de 100g.

A letra C está incorreta. Incorreta a alternativa C: o teste oral de tolerância à glicose de 75 g deve avaliar três medidas: jejum, 1h e 2h após a sobrecarga.

A letra D está incorreta. Incorreta a alternativa D: a hemoglobina glicada não é um exame utilizado no diagnóstico de diabetes na gestação, mas sim para acompanhamento de gestantes com diabetes prévio à gestação.

A letra E está correta. Correta a alternativa E: temos uma gestante de 23 semanas, sem exames prévios. Para realizar o diagnóstico de diabetes gestacional, essa gestante deve fazer o teste oral de tolerância à glicose de 75 g entre 24 e 28 semanas, avaliando a glicemia em jejum, 1h e 2h após a sobrecarga de glicose.

Questão | | 2023 | 4000181653

Gestante de 41 semanas, G2C1, procura o hospital para resolução da gestação, sendo que sua última cesárea foi há 3 anos. Pré-natal de risco habitual e sem complicações durante a gestação. Ao exame físico, apresenta sinais vitais normais, vitalidade fetal preservada, altura uterina de 34 cm, contrações ausentes e movimentos fetais presentes. No toque vaginal, apresentação cefálica, colo posterior com 2 cm de dilatação e apagado 20%, De Lee -1 e bolsa íntegra. Nesse caso clínico, qual seria a melhor conduta?

A) Misoprostol via vaginal a cada 4 horas.

- B) Misoprostol via vaginal a cada 6 horas.
- C) Indicar cesárea.
- D) Preparo de colo com Sonda Foley.
- E) Indução do trabalho de parto com ocitocina em bomba de infusão.

Solução

Gabarito: D) Preparo de colo com Sonda Foley.

GABARITO: ALTERNATIVA D

O que o examinador quer saber: sobre indução do parto.

Caro Estrategista, indução do parto é um tema muito cobrado nas provas de residência, por isso, fiz um resumo para você nunca mais esquecer esse tema!

A condição do colo uterino é o principal fator preditor de sucesso na indução do trabalho de parto. Portanto, para avaliar a melhor estratégia para a indução é imprescindível avaliar primeiramente as condições do colo uterino.

Uma das formas de fazer essa avaliação é por meio do índice de Bishop. Esse índice leva em conta aspectos do colo uterino como a dilatação, o esvaecimento, a consistência e a posição do colo uterino, além da altura da apresentação fetal (planos de De Lee).

Se o colo uterino é desfavorável, isto é, quando o índice de Bishop é menor que 6, primeiro é preciso realizar a maturação cervical para depois induzir as contrações.

Durante a maturação cervical o colo uterino passa de uma estrutura fechada e grossa para uma estrutura aberta, amolecida e esvaecida, capaz de dilatar com as contrações uterinas.

Vários métodos podem promover a maturação cervical, sendo classificados em **métodos farmacológicos ou mecânicos**. A escolha do método depende da experiência médica, da preferência da gestante e das contraindicações inerentes a ele, uma vez que, em relação a superioridade entre os métodos, os estudos não mostraram diferença entre eles.



Quando o colo uterino se encontra maduro (Bishop ≥ 6 , de preferência > 9), utiliza-se a ocitocina para induzir as contrações uterinas e, dessa forma, a gestante iniciar o trabalho de parto. A ocitocina sintética é um análogo idêntico à ocitocina endógena. Essa é a medicação mais efetiva para causar contrações uterinas e por isso é a medicação utilizada para indução do parto.

A administração de ocitocina é feita por **via endovenosa em bomba de infusão contínua (BIC)**. O efeito da ocitocina se inicia 3 a 5 min após o início da infusão e a sua meia vida é de 5 minutos, o que implica em dizer que seu efeito é cessado rapidamente após sua suspensão.

O ideal é iniciar com baixas doses e ir aumentando progressivamente até dose máxima de 20 a 40 mUI/min para evitar os efeitos colaterais.



A letra A está incorreta. Incorreta a alternativa A: o misoprostol está contraindicado para indução do parto em gestantes com cesariana anterior, pois aumenta o risco de rotura uterina.

A letra B está incorreta. Incorreta a alternativa B: o misoprostol está contraindicado para indução do parto em gestantes com cesariana anterior, pois aumenta o risco de rotura uterina.

A letra C está incorreta. Incorreta a alternativa C: a paciente não apresenta indicação de parto cesáreo no momento - uma única cesárea anterior não contraindica um parto vaginal posterior!

A letra D está correta. Correta a alternativa D: temos uma gestante de 41 semanas com uma cesariana anterior e que necessita de resolução da gestação em decorrência da idade gestacional. Como a paciente apresenta colo uterino desfavorável (colo posterior, 2 cm, 20% apagado e plano -1 de De Lee) e tem uma cesariana anterior, a melhor maneira de iniciar a indução do parto é com o preparo mecânico do colo uterino com sonda de Foley.

A letra E está incorreta. Incorreta a alternativa E: como o colo uterino está desfavorável (colo posterior, 2 cm, 20% apagado e plano -1 de De Lee), é preciso primeiramente realizar a maturação cervical e somente quando o colo uterino estiver favorável utilizar ocitocina para iniciar as contrações.

Questão | | 2023 | 4000181654

Para bloqueio imediato da produção de leite em puérpera que tem contraindicação à amamentação, qual é a medicação e a dose de escolha?

- A) Cabergolina 0,5 mg/ 2 comprimidos em dose única.
- B) Cabergolina 0,25 mg/ de 12 em 12 horas, por 4 dias.
- C) Cabergolina 0,25 mg/ 2 comprimidos uma vez ao dia por 3 dias.
- D) Bromocriptina 2,5 mg/ em dose única.

E) Bromocriptina 2,5 mg/ 2 comprimidos por dia durante dois dias.

Solução

Gabarito: A) Cabergolina 0,5 mg/ 2 comprimidos em dose única.

GABARITO: ALTERNATIVA A

O que o examinador quer saber: sobre inibição da lactação.

Atenção, Estrategista! Algumas situações maternas e neonatais indicam a inibição da lactação e estão listadas a seguir:

- HIV
- CAncer de mama
- Usuarías de drogas
- Uso de quimioterapia, radioterapia, radiofarmacos
- HTLV

Os esquemas utilizado na interrupção da lactação atuam na inibição da síntese de prolactina. As drogas mais utilizadas são a cabergolina e a bromocriptina, sendo a primeira mais efetiva e, por isso, a medicação de escolha.

As medicações e suas respectivas doses estão listadas na tabela a seguir:

Medicações para inibir a lactação	Dosagem
Cabergolina	- 2 comp. (0,5 mg) VO dose única
(estimula os receptores dopaminérgicos)	- ½ comp. (0,25 mg) VO a cada 12 h por 2 dias
Bromocriptina	- 1 comp. (2,5 mg) por dia VO por 2 semanas
(agonista da dopamina)	- ½ comp. VO 12/12h por 2 semanas

A letra A está correta. Correta a alternativa A: a cabergolina é a medicação de escolha para inibir a lactação. A dose preconizada é 2 comprimidos de 0,5 mg dose única.

A letra B está incorreta. Incorreta a alternativa B: a cabergolina pode ser utilizada na dose de 0,25 mg de 12/12h por 2 dia e não por 4 dias.

A letra C está incorreta. Incorreta a alternativa C: a cabergolina pode ser utilizada na dose de 0,25 mg de 12/12h por 2 dia e não por 3 dias.

A letra D está incorreta. Incorreta a alternativa D: a bromocriptina deve ser utilizada por 2 semanas para inibir a lactação e não em dose única.

A letra E está incorreta. Incorreta a alternativa E: a bromocriptina deve ser utilizada por 2 semanas para inibir a lactação e não por 2 dias.

Questão | | 2023 | 4000181655

Gestante de 22 semanas comparece ao consultório referindo disúria e polaciúria há 3 dias. Nega outras queixas. Trouxe exame de urocultura realizado há 3 dias que evidenciou E. Coli.

O antibiograma mostrou que a bactéria em questão era sensível aos seguintes fármacos: nitrofurantoína, ampicilina, ciprofloxacino e norfloxacino. Refere que já é o terceiro quadro de infecção do trato urinário durante essa gestação. Nesse caso, a conduta mais adequada é prescrever

- A) ciprofloxacino 500 mg de 12/12 horas por 7 dias.
- B) norfloxacino 400 mg uma vez ao dia por 3 dias.
- C) nitrofurantoína 100 mg de 6/6 horas por 5 dias.
- D) ampicilina 500 mg de 6/6 horas por 7 dias seguido de nitrofurantoína profilática uma vez ao dia.
- E) nitrofurantoína 100 mg de 6/6 horas por 7 dias.

Solução

Gabarito: D) ampicilina 500 mg de 6/6 horas por 7 dias seguido de nitrofurantoína profilática uma vez ao dia.

GABARITO: ALTERNATIVA D

O que o examinador quer saber: sobre infecção de urina na gestação

Caro Estrategista, a infecção do trato urinário (ITU) é intercorrência comum na gestação e acomete cerca de 10-12% das gestantes. Quando não tratada pode levar a complicações graves para a gestante e para o conceito, como piora da anemia, prematuridade, baixo peso ao nascer, rotura prematura de membranas, corioamnionite, sepse materna e neonatal.

O agente etiológico mais comum na gestação é a **Escherichia coli**, além disso pode ocorrer por outros organismos da flora vulvoperineal.

As ITUs são classificadas como bacteriúria assintomática, cistite (ITU baixa) e pielonefrite (ITU alta).

Considera-se bacteriúria assintomática quando a gestante não tem sintomas, mas no exame de urina se identifica mais de 100 mil unidades formadores de colônias por ml. Na gravidez a bacteriúria assintomática tem que sempre ser tratada para não levar a complicações. O tratamento deve se basear no antibiograma, evitando os antibióticos com maior risco de teratogenicidade. Deve-se repetir a urocultura 2 semanas após o tratamento. Os antibióticos mais utilizados são: fosfomicina, nitrofurantoína e cefalexina.

Na cistite a gestante apresenta dor em baixo ventre, disúria, polaciúria, urgência miccional, hematúria, odor fétido na urina. O tratamento deve ser instituído após coleta da urocultura, mas não se deve aguardar o exame para iniciar o tratamento. Após o tratamento deve ser feita urocultura de controle para confirmar a cura. O tratamento é ambulatorial e os antibióticos de escolha são: fosfomicina, nitrofurantoína, cefalexina, amoxicilina + clavulanato ou cefuroxima.

Antibiótico	dose	duração
Fosfomicina	3g	Dose única
Nitrofurantoína	100 mg 6/6h	5 -7 dias
cefalexina	500 mg 6/6h	7 dias
Amoxicilina+ clavulanato	875/125mg 12/12h	7 dias
Cefuroxima	250 mg 12/12h	7 dias

Na pielonefrite a gestante apresenta febre, dor lombar, Giordano positivo, leucocitose com desvio à esquerda, prostração. A gestante pode evoluir rapidamente para sepse e apresentar taquicardia, hipotensão, por isso a internação hospital e o tratamento com antibioticoterapia endovenosa são cruciais para evitar complicações ao binômio mãe e feto. A preferência atual é pelo uso de ceftriaxone (2 g ao dia) durante 10 a 14 dias.

A presença de bacteriúria assintomática de repetição ou cistite de repetição (dois casos ou mais na gestação) indicam o uso de antibioticoprofilaxia até o parto. Os antibióticos utilizados para profilaxia podem ser a nitrofurantoína ou a cefalexina. Se for utilizado nitrofurantoína essa deve ser substituída pela cefalexina após 37 semanas devido ao risco de icterícia neonatal.

A letra A está incorreta. Incorreta a alternativa A: ciprofloxacino é um antibiótico da classe das quinolonas e deve ser evitado na gestação.

A letra B está incorreta. Incorreta a alternativa B: norfloxacino é um antibiótico da classe das quinolonas e deve ser evitado na gestação.

A letra C está incorreta. Incorreta a alternativa C: nitrofurantoína é um dos antibióticos mais utilizados na gestação. Essa alternativa não está correta, pois não menciona a necessidade de uso de antibioticoprofilaxia após o tratamento de infecção aguda.

A letra D está correta. Correta a alternativa D: temos uma gestante com infecção de urina atual que necessita de tratamento, conforme o antibiograma. Além disso, a gestante em questão teve 3 episódios de infecção de urina nessa gestação, o que configura infecção de urina de repetição e, por isso, deve usar antibiótico profilático após terminar o tratamento da infecção urinária atual.

A letra E está incorreta. Incorreta a alternativa E: nitrofurantoína é um dos antibióticos mais utilizados na gestação. Essa alternativa não está correta, pois não menciona a necessidade de uso de antibioticoprofilaxia após o tratamento de infecção aguda.

Questão | | 2023 | 4000181656

Referente à indução do trabalho de parto em pacientes que possuem cesárea anterior e feto com boa vitalidade, assinale a alternativa correta.

- A)** É contraindicado realizar indução do parto devido ao risco de rotura uterina.
- B)** Se o índice de Bishop for maior que 6, poderá ser usada ocitocina em bomba de infusão.

- C) Misoprostol 25 mcg é a primeira escolha nesses casos.
- D) Realizar amniotomia e aguardar início do trabalho de parto.
- E) Realizar misoprostol 25 mcg associado à ocitocina.

Solução

Gabarito: B) Se o índice de Bishop for maior que 6, poderá ser usada ocitocina em bomba de infusão.

GABARITO: ALTERNATIVA B

O que o examinador quer saber: sobre indução do parto.

Caro Estrategista, indução do parto é um tema muito cobrado nas provas de residência, por isso, fiz um resumo para você nunca mais esquecer esse tema!

A condição do colo uterino é o principal fator preditor de sucesso na indução do trabalho de parto. Portanto, para avaliar a melhor estratégia para a indução é imprescindível avaliar primeiramente as condições do colo uterino.

Uma das formas de fazer essa avaliação é por meio do índice de Bishop. Esse índice leva em conta aspectos do colo uterino como a dilatação, o esvaecimento, a consistência e a posição do colo uterino, além da altura da apresentação fetal (planos de De Lee).

Se o colo uterino é desfavorável, isto é, quando o índice de Bishop é menor que 6, primeiro é preciso realizar a maturação cervical para depois induzir as contrações.

Durante a maturação cervical o colo uterino passa de uma estrutura fechada e grossa para uma estrutura aberta, amolecida e esvaecida, capaz de dilatar com as contrações uterinas.

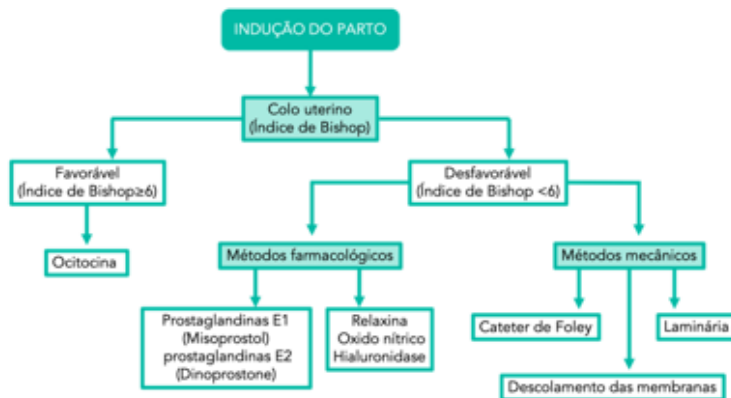
Vários métodos podem promover a maturação cervical, sendo classificados em **métodos farmacológicos ou mecânicos**. A escolha do método depende da experiência médica, da preferência da gestante e das contraindicações inerentes a ele, uma vez que, em relação a superioridade entre os métodos, os estudos não mostraram diferença entre eles.



Quando o colo uterino se encontra maduro (Bishop ≥ 6 , de preferência > 9), utiliza-se a ocitocina para induzir as contrações uterinas e, dessa forma, a gestante iniciar o trabalho de parto. A ocitocina sintética é um análogo idêntico à ocitocina endógena. Essa é a medicação mais efetiva para causar contrações uterinas e por isso é a medicação utilizada para indução do parto.

A administração de ocitocina é feita por **via endovenosa em bomba de infusão contínua (BIC)**. O efeito da ocitocina se inicia 3 a 5 min após o início da infusão e a sua meia vida é de 5 minutos, o que implica em dizer que seu efeito é cessado rapidamente após sua suspensão.

O ideal é iniciar com baixas doses e ir aumentando progressivamente até dose máxima de 20 a 40 mUI/min para evitar os efeitos colaterais.



A letra A está incorreta. Incorreta a alternativa A: a presença de cesárea anterior não contraindica a indução do parto, pois o risco de rotura uterina é pequeno. Está contraindicado apenas os métodos farmacológicos para preparo do colo uterino, como as prostaglandinas E1 (misoprostol) e E2 (Dinoprostone).

A letra B está correta. Correta a alternativa B: índice de Bishop maior do que 6 indica que o colo uterino está maduro, sendo favorável o uso de ocitocina para a indução do parto.

A letra C está incorreta. Incorreta a alternativa C: em pacientes com cesárea anterior não se pode usar misoprostol para preparar o colo uterino para indução do parto, pois essa medicação aumenta o risco de rotura uterina em pacientes com cicatriz uterina anterior.

A letra D está incorreta. Incorreta a alternativa D: a amniotomia deve ser evitada para iniciar a indução do parto, pois aumenta o risco de infecção intrauterina. Deve-se dar preferências a outros métodos de indução do parto, como o balão de foley.

A letra E está incorreta. Incorreta a alternativa E: em pacientes com cesárea anterior não se pode usar misoprostol para preparar o colo uterino para indução do parto, pois aumenta a chance de rotura uterina. A associação de ocitocina com misoprostol não deve ser utilizada em nenhuma situação, pois aumenta o risco de taquissístolia e rotura uterina.

Questão | | 2023 | 4000181657

Paciente de 39 anos, com antecedente de dois partos cesáreas pré-termo devido à pré-eclâmpsia, deseja programar nova gravidez. É hipertensa crônica com bom controle pressórico. Nesse caso, é necessário

- A)** orientar que ela deve evitar uma nova gravidez por ser hipertensa.
- B)** orientar que, considerando a idade avançada, uma nova gestação está contraindicada.

- C)** orientar que ela deve iniciar heparina de baixo peso molecular no primeiro trimestre a fim de reduzir o risco de trombose.
- D)** orientar que existe risco de pré-eclâmpsia na futura gestação e que, caso engravide, ela tem recomendação de profilaxia de pré-eclâmpsia.
- E)** prescrever AAS e heparina de baixo peso molecular no início da futura gestação.

Solução

Gabarito: D) orientar que existe risco de pré-eclâmpsia na futura gestação e que, caso engravide, ela tem recomendação de profilaxia de pré-eclâmpsia.

GABARITO: ALTERNATIVA D

O que o examinador quer saber: prevenção de pré-eclâmpsia.

A principal forma de identificar as gestantes com risco de desenvolver pré-eclâmpsia é por meio da avaliação dos fatores de risco. Considera-se gestação de alto risco para desenvolver pré-eclâmpsia quando há um único fator de risco alto ou dois fatores de risco moderados:

RISCO ALTO*	RISCO MODERADO
História pregressa de pré-eclâmpsia	Gravidez prévia com eventos adversos (descolamento prematuro de placenta, prematuridade e baixo peso ao nascer > 37 sem.)
Obesidade (IMC > 30)	História familiar de pré-eclâmpsia (mãe e irmã)
Hipertensão arterial crônica	Nuliparidade
Diabetes tipo 1 e tipo 2	Idade materna ≥ 35 anos
Doença renal	Intervalo interpartal > 10 anos
Doenças autoimunes (lúpus, SAA)	
Tratamento de reprodução assistida	
Gestação múltipla	
*Adaptada da ISSHP, FIGO, ACOG e MS	

A identificação de gestantes com alto risco para desenvolver pré-eclâmpsia e a realização de medidas para a sua prevenção ao longo do pré-natal é fundamental para se diminuir a ocorrência dessa patologia, principalmente as suas formas graves.

Todas as gestantes, independente do risco de pré-eclâmpsia, devem ser orientadas a praticar atividade física durante a gestação e ingerir pelo menos 600 mg de cálcio por dia na alimentação. Essas medidas diminuem o risco de pré-eclâmpsia na população geral. Se a gestante apresenta baixa ingestão dietética de cálcio, deve-se suplementar com pelo menos 500 mg de cálcio por dia.

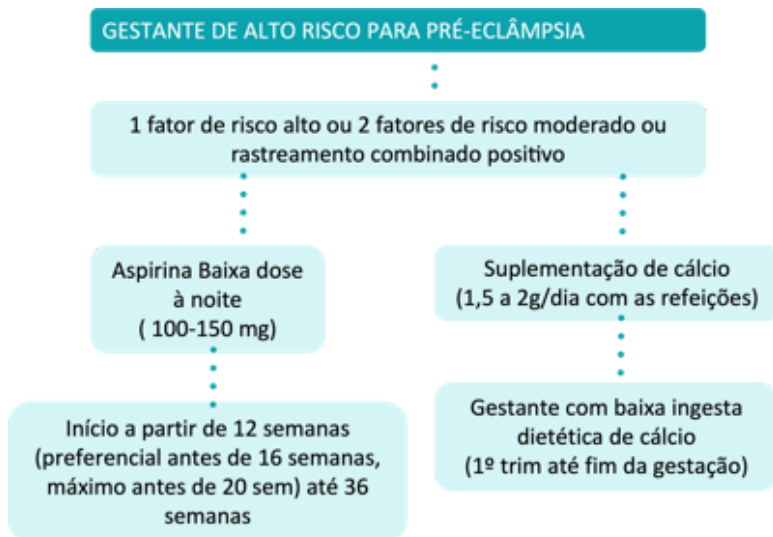
Em gestantes com alto risco de desenvolver pré-eclâmpsia, tanto pelo rastreamento combinado no primeiro trimestre, como pela avaliação dos fatores de risco maternos isolados, a prevenção primária consiste na administração de aspirina em baixa dose (100-150 mg) diariamente, com início antes de 16 semanas de gestação (preferencialmente com 12 semanas), até 36 semanas (alguns protocolos orientam até o parto). O uso de baixa dose de aspirina antes de 16 semanas de gestação diminuiu o risco de pré-eclâmpsia, principalmente a pré-eclâmpsia precoce (< 34 semanas), e de restrição de crescimento fetal em gestantes de alto risco.

A suplementação de cálcio nas gestantes de alto risco deve ser feita na dose de 1,5g a 2g/dia quando há baixa ingestão dietética de cálcio, pois essa medida reduz o risco de pré-eclâmpsia

para esse grupo de mulheres.

Não existe evidência de que a suplementação de vitamina C, D, E, óleo de peixe, ácido fólico e restrição de sal possam reduzir o risco de pré-eclâmpsia.

Além disso, o uso de heparina de baixo peso molecular não está indicado para a prevenção da pré-eclâmpsia, pois essa medida não reduz o risco dessa patologia.



Atenção, Estrategista, está é uma questão clássica sobre prevenção de pré-eclâmpsia.

A letra A está incorreta. Incorreta a alternativa A: apesar da hipertensão arterial crônica aumentar o risco gestacional, tanto para a gestante como para o conceito, uma nova gravidez não é contraindicada.

A letra B está incorreta. Incorreta a alternativa B: apesar da idade gestacional avançada aumentar o risco gestacional, uma nova gravidez não é contraindicada.

A letra C está incorreta. Incorreta a alternativa C: a heparina não está indicada para prevenção de trombose em paciente com hipertensão arterial crônica. Essa medicação é usada preventivamente em gestantes com diagnóstico de síndrome dos anticorpos antifosfolípidos (SAAF), pacientes com valva mecânica, alguns casos de trombofilias hereditárias e gestantes com histórico de tromboembolismo endovenoso.

A letra D está correta. Correta a alternativa D: temos uma gestante com hipertensão arterial crônica e histórico de pré-eclâmpsia, ambos fatores de alto risco para desenvolver pré-eclâmpsia em uma gestação futura. Por isso, para prevenção de pré-eclâmpsia deve ser feita aspirina de baixa dose (AAS) e carbonato de cálcio.

A letra E está incorreta. Incorreta a alternativa E: não há indicação de heparina para paciente com histórico de pré-eclâmpsia ou hipertensão arterial crônica.

Mulher de 24 anos refere atraso menstrual há 8 semanas e, nos últimos dias, vem apresentando sangramento intermitente. Ao exame ginecológico, apresenta pequena quantidade de sangue coletada em região de fundo de saco vaginal, ausência de sangramento ativo e colo uterino fechado. Dosagem de beta-Hcg evidenciou 40000 UI. O ultrassom demonstrou múltiplas vesículas, e o laudo veio como gestação molar completa. Nesse caso, é necessário

- A) repetir a ultrassonografia transvaginal e reavaliar dosagem de Beta-hCG em sete dias.
- B) realizar raio X de tórax e acompanhar com dosagem seriada de Beta-hCG.
- C) administrar misoprostol vaginal e seguir com realização da curetagem uterina.
- D) realizar aspiração intrauterina e acompanhar com dosagem seriada de Beta-hCG.
- E) realizar dilatação do colo com velas de Hegar e curetagem uterina.

Solução

Gabarito: D) realizar aspiração intrauterina e acompanhar com dosagem seriada de Beta-hCG.

GABARITO: ALTERNATIVA D

O que o examinador quer saber: sobre doença trofoblástica gestacional.

Caro estrategista, a doença trofoblástica gestacional (DTG) é uma entidade rara e benigna na maior parte das vezes, sendo chamada também de mola hidatiforme.

O quadro clínico depende da idade gestacional do diagnóstico. Quando o diagnóstico é feito precocemente, o quadro clínico é muito semelhante ao de um abortamento. Em idades gestacionais mais tardias encontramos útero aumentado para a idade gestacional, hiperêmese gravídica, elevação pressórica precoce (antes de 20 semanas), sinais de hipertireoidismo e saída de vesículas junto ao sangramento vaginal.

No ultrassom, o achado mais clássico é o aspecto de “flocos em neve” ou ainda em “cachos de uva” que são formações anecoicas permeando a cavidade endometrial, que representam as vesículas da gestação molar. Vamos lembrar aqui, estrategista, que a fração beta HCG mimetiza os hormônios TSH, LH e FSH, motivo pelo qual pode ocorrer o quadro de tireotoxicose (taquicardia, sudorese, insônia e tremores).

A suspeita diagnóstica se faz por meio do quadro clínico, associado à imagem ultrassonográfica e ao nível sérico de HCG, que está maior que o esperado para a idade gestacional. A confirmação diagnóstica, no entanto, se dá pela análise patológica, após o esvaziamento uterino, que, com auxílio do cariótipo, é capaz de diferenciar a mola hidatiforme em completa ou parcial, veja na tabela abaixo as diferenças de mola hidatiforme completa e parcial.

Mola hidatiforme completa	Mola hidatiforme parcial
• Diploide (46 XX) • Não há partes fetais • HCG em nível MAIOR • Mais imagens de cistos tecaluteínicos • Maligniza mais	• Triploide ou tetraploide (69, XX) • Pode conter partes fetais • HCG em nível MENOR • Menos imagens de cistos tecaluteínicos • Maligniza menos, porém diagnóstico pode ser mais tardio

O tratamento da mola hidatiforme consiste em esvaziamento uterino, de preferência com aspiração à vácuo, manual ou elétrica. Em seguida, deve haver o seguimento pós-molar com dosagem semanal de B-hCG até negativação e seguimento mensal após negativação por pelo menos 6 meses. Deve ser feito estadiamento em alguns casos, devido ao risco de transformação nas formas malignas (neoplasia trofoblástica gestacional). Das formas malignas, o coriocarcinoma e a mola invasora são as mais comuns e tem disseminação hematogênica, sendo o pulmão o principal sítio de metástase. Um ponto interessante é que mesmo a gestação normal pode evoluir para um coriocarcinoma. O seguimento pós-molar deve incluir:

- Anticoncepção por ao menos seis meses após a negativação do HCG.
- Considerar RX tórax: ver metástase pulmonar (principal sítio de metástase).
- Dosagem de beta HCG semanalmente até negativação, com seguimento mensal durante 6 a 12 meses subsequentes.

A letra A está incorreta. Incorreta a alternativa A: como temos o diagnóstico de DTG, não há indicação de repetir o ultrassom e nem a dosagem de HCG antes do esvaziamento intrauterino. A aspiração a vácuo intrauterina é a conduta preconizada.

A letra B está incorreta. Incorreta a alternativa B: o raio X pode ser solicitado diante do diagnóstico de DTG, mas a principal conduta é o esvaziamento uterino por aspiração à vácuo.

A letra C está incorreta. Incorreta a alternativa C: deve-se evitar o uso de misoprostol nos casos de DTG, pelo risco de embolização trofoblástica. A curetagem também deve ser evitada pelo risco de perfuração uterina. A conduta diante de DTG é a aspiração uterina à vácuo.

A letra D está correta. Correta a alternativa D: temos uma gestante de 8 semanas com sangramento vaginal, associado a HCG de 40000UI e ultrassom com imagem de múltiplas vesículas, com diagnóstico de gestação molar completa. Diante do diagnóstico de DTG a conduta deve ser esvaziamento uterino com aspiração intrauterina e acompanhamento seriado do HCG.

A letra E está incorreta. Incorreta a alternativa E: A curetagem deve ser evitada pelo risco de perfuração uterina. A conduta diante de DTG é a aspiração uterina à vácuo.

Paciente de 26 anos agenda consulta com ginecologista devido à dor pélvica com duração de aproximadamente 30 dias. Relata que não tem parceiro fixo e, nos últimos meses, apresentou relação desprotegida. Ao exame especular, apresenta secreção purulenta proveniente do colo do útero e, no toque vaginal, dor à mobilização do colo do útero e anexos. O ultrassom ginecológico não mostrou anormalidades. Para essa paciente, qual esquema antibiótico é o mais recomendado?

- A) Ceftriaxona e amoxicilina.
- B) Cefalexina e ciprofloxacino.
- C) Doxíciclina e azitromicina.
- D) Ceftriaxona e azitromicina.
- E) Clindamicina e metronidazol.

Solução

Gabarito: D) Ceftriaxona e azitromicina.

GABARITO: ALTERNATIVA D

O diagnóstico de DIP pode ser difícil devido à ampla variedade de sinais e sintomas. Esse fato faz com que o diagnóstico seja feito de forma tardia, podendo aumentar as chances de complicações agudas e tardias. Nem mesmo a história clínica, o exame físico e os testes laboratoriais são sensíveis ou específicos o suficiente para chegarmos ao diagnóstico.

Devido à heterogeneidade de sintomas e a fim de evitar que haja perda de diagnósticos foram desenvolvidos critérios diagnósticos bem definidos para a doença inflamatória pélvica que se encontram no quadro abaixo:

CRITÉRIOS DIAGNÓSTICOS DE DIP		
MAIORES	MENORES	ELABORADOS
- Dor abdominal ou infraumbilical. - Dor à palpação anexial. - Dor à mobilização do colo uterino.	- Temperatura axilar maior que 38,3° C. - Conteúdo cervical ou vaginal anormal. - Massa pélvica. - Leucocitose em sangue periférico. - Proteína C reativa ou velocidade de hemossedimentação aumentadas. - Mais de cinco leucócitos por campo de imersão em secreção de endocérvice. - Comprovação laboratorial de infecção por Clamídia, Gonococo ou Micoplasma.	- Evidência histopatológica de endometrite. - Presença de abscesso tubo-ovariano ou de fundo de saco de Douglas em estudo de imagem (USG pélvica ou ressonância magnética). - Videolaparoscopia com evidências de DIP.
DIAGNÓSTICO: TRÊS CRITÉRIOS MAIORES + UM CRITÉRIO MENOR OU UM CRITÉRIO ELABORADO ISOLADAMENTE		

A paciente em questão apresenta todos os critérios diagnósticos para doença inflamatória pélvica e por isso deve ser tratada com o regime de antibióticos preconizado para a doença. O quadro abaixo resume os esquemas preconizados pelo Ministério da Saúde:

TRATAMENTO DA DIP (Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para Atenção Integral às Pessoas com Infecções Sexualmente Transmissíveis - Ministério da Saúde, 2020)			
Tratamento	Primeira opção	Segunda opção	Terceira opção
Ambulatorial	- Ceftriaxona 500 mg, IM, dose única MAIS - Doxiciclina 100 mg, VO, 12/12h, por 14 dias MAIS - Metronidazol 500 mg 12/12 h, por 14 dias	- Cefotaxima 500 mg, IM, dose única MAIS - Doxiciclina 100 mg, VO, 12/12h, por 14 dias MAIS - Metronidazol 500 mg, 12/12 h, por 14 dias	
Hospitalar	- Ceftriaxona 1g IV 1x/dia, por 14 dias 14 dias MAIS - Doxiciclina 100 mg, VO, 12/12 h, por 14 dias MAIS - Metronidazol 400 mg IV 12/12h	- Clindamicina 900 mg, IV, 8/8h, por 14 dias MAIS - Gentamicina (IV ou IM): dose de ataque 2 mg/kg; dose de manutenção: 3-5 mg/kg/dia, por 14 dias	- Ampicilina/sulbactam 3g, IV, 6/6h, por 14 dias MAIS - Doxiciclina 100 mg, VO, 12/12h, por 14 dias

Como podemos visualizar, nenhuma das alternativas da questão contempla o tratamento adequado para essa paciente. A alternativa “d” considerada como resposta pela banca traz um possível tratamento para uma cervicite, porém nesse caso estamos diante de uma doença inflamatória pélvica. Por esse motivo, consideramos que não há resposta correta para essa questão.

Questão | | 2023 | 4000181660

Um grupo de pesquisadores pretende avaliar a associação entre tabagismo e episódios de pneumonia bacteriana entre adultos em certa comunidade. Para isso, decidem acompanhar toda a população adulta de uma pequena cidade e registrar todos os casos de pneumonia bacteriana ao longo de um ano. A informação sobre a exposição ao tabaco será obtida através de um questionário, o qual será enviado por correio antes do início do estudo, aos seis meses de acompanhamento e logo após o final do estudo. Com base no exposto, é correto afirmar que se trata de um estudo

- A) observacional, prospectivo de coorte.
- B) experimental, prospectivo de coorte.
- C) experimental, retrospectivo de coorte.
- D) observacional, retrospectivo de caso-controle.
- E) observacional, de coorte transversal.

Solução

Gabarito: A) observacional, prospectivo de coorte.

GABARITO: ALTERNATIVA A

Estrategista,

O primeiro ponto fundamental é identificarmos a exposição e o desfecho. Observe que, segundo o enunciado, o tabagismo é a **exposição** e os episódios de pneumonia bacteriana é o **desfecho**.

Além disso, veja que o enunciado fala que os participantes serão acompanhados ao longo de 1 ano. Opa! Se o acompanhamento acontecerá por 1 ano, então é porque estamos diante de um estudo longitudinal! Logo, esse estudo não pode ser transversal (apesar de as informações sobre a exposição serem obtidas por meio de um questionário).

Pois bem. Se é longitudinal, então existem 3 opções possíveis: **coorte**, **caso-controle** e os **estudos experimentais** (ensaio clínico, ensaio de campo e ensaio comunitário). Porém, como dito acima, as informações sobre a exposição serão obtidas por meio de um questionário. Portanto, os pesquisadores não fornecerão o tabaco (e nem poderiam, pois seria antiético, já que sabidamente é uma exposição que faz mal à saúde). Logo, estamos diante de um **estudo longitudinal e observacional** e, nesse sentido, só podemos estar diante de uma **coorte** ou **caso-controle**.

Observe, mais uma vez, o que é dito no enunciado: *"a informação sobre a exposição ao tabaco será obtida através de um questionário, o qual será enviado por correio antes do início do estudo, aos seis meses de acompanhamento e logo após o final do estudo"*. Veja que a coleta de informações ocorrerá de forma concorrente ao acompanhamento, e não de forma retrospectiva. Logo, estamos diante de um estudo prospectivo e, sob essa perspectiva, só podemos estar diante de uma **coorte prospectiva**.

Portanto:

A letra A está correta. Correta a alternativa A, sem ressalvas.

A letra B está incorreta. Incorreta a alternativa B porque os estudos de coorte não são experimentais e sim observacionais.

A letra C está incorreta. Incorreta a alternativa C pelo mesmo motivo explicado em B.

A letra D está incorreta. Incorreta a alternativa D porque estamos diante de um estudo observacional, mas de coorte.

A letra E está incorreta. Incorreta a alternativa E porque não é um estudo transversal e sim, longitudinal.

Questão | | 2023 | 4000181661

José, 55 anos, retorna à UBS para mostrar exames solicitados pelo seu médico da família após queixar-se de cansaço há alguns meses. Dentre os resultados, tem-se: ferro sérico 45 mcg/dl (VR 60-150 mcg/dl), ferritina 170 ng/ml (VR 10-150 ng/ml), TBIC 200 mcg/dl (VR 250-360 mcg/dl) e saturação de transferrina 28% (VR 30- 40%). Dessa forma, o diagnóstico mais provável é

- A) talassemia.
- B) hemocromatose.
- C) anemia ferropriva.
- D) anemia de doença crônica.
- E) anemia megaloblástica.

Solução

Gabarito: D) anemia de doença crônica.

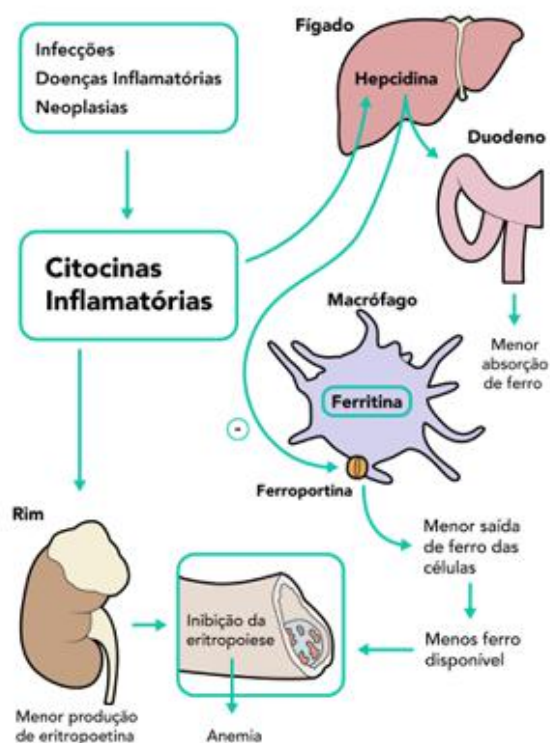
GABARITO: ALTERNATIVA D

Vamos analisar esse perfil de ferro, Estrategista? Vemos que há uma **redução do ferro presente na circulação**, uma vez que **os níveis do mineral estão baixos e a saturação da transferrina também está reduzida**, isto é, **há pouca ocupação do principal transportador sérico de ferro com o mineral**.

Baixos níveis circulantes de ferro nos fazem pensar na **anemia ferropriva**, mas olhe os demais itens do perfil de ferro. Veja que há aumento da ferritina, principal representante dos estoques do nutriente no organismo. Isso seria estranho na deficiência de ferro, uma vez que o corpo utiliza todas as reservas do mineral antes de deixar que seus níveis séricos caiam.

Assim, temos estoques de ferro repletos, mas com ferro circulante baixo. Isso é uma característica marcante da **anemia de doença crônica ou anemia inflamatória**, nossa **suspeita para esse caso!** Nessa condição, quadros inflamatórios crônicos, como doenças reumatológicas ou neoplasias, estimulam a secreção de **hepcidina**, um hormônio hepático que degrada a **ferroportina**. Esta última é o canal que permite que o ferro saia das células.

Desse modo, na anemia de doença crônica, o ferro fica aprisionado nas células de reserva sob a forma de ferritina, sendo incapaz de ganhar a circulação e chegar à medula óssea para a produção de hemoglobina, determinando anemia. Esse mecanismo está resumido na imagem abaixo, veja com atenção:

**Com isso em mente, vejamos as alternativas:**

A letra A está incorreta. Incorreto. Talassemia é uma anemia hereditária decorrente de distúrbios na síntese das cadeias de globina. Cursam com perfil de ferro normal ou até mesmo com sobrecarga de ferro.

A letra B está incorreta. Incorreto. Hemocromatose é a situação de acúmulo/sobrecarga de ferro no organismo, cursando com níveis de ferro, ferritina e saturação de transferrina elevados.

A letra C está incorreta. Incorreto. Como vimos, a anemia ferropriva cursaria com ferritina reduzida, não elevada.

A letra D está correta. Perfeito! A característica fisiopatológica da anemia de doença crônica é justamente a presença de estoques de ferro repletos ou até elevados, representados pela ferritina, mas com níveis circulantes do mineral baixo (ferro e saturação de transferrina reduzidos).

A letra E está incorreta. Incorreto. A anemia megaloblástica ocorre por carência de vitamina B12 ou folato, não cursando com alteração de perfil de ferro.

Questão | | 2023 | 4000181662

Dona Marli queixa-se de edema de membros inferiores após iniciar uso de medicamento para controlar sua pressão arterial e procura atendimento para realizar a troca do remédio, pois sente-se muito incomodada. O fármaco em questão deve ser

A) hidroclorotiazida.

- B) losartana.
C) enalapril.
D) anlodipino.
E) atenolol.

Solução

Gabarito: D) anlodipino.

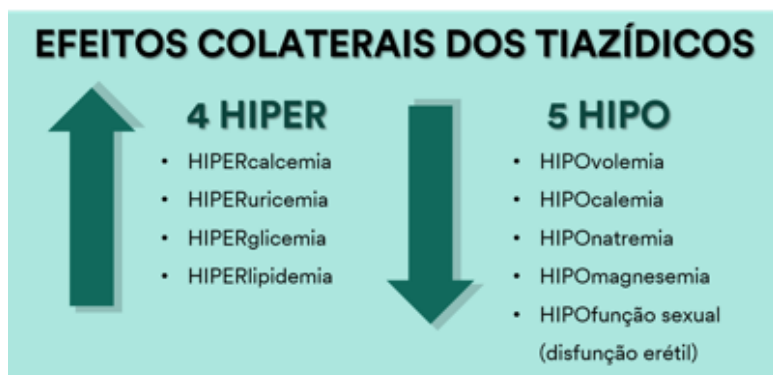
GABARITO: ALTERNATIVA D

Estrategista,

Um dos tópicos mais cobrados sobre o tratamento da hipertensão é o reconhecimento dos seus efeitos colaterais. Essa tabela resume os principais que você deve conhecer:

Drugs	Efeitos colaterais / Contraindicações
Bloqueadores dos canais de cálcio	Edema periférico (relacionado à dose e mais comum em pacientes com insuficiência cardíaca) e edema pulmonar (mais comum em pacientes com insuficiência cardíaca).
Diuréticos tiazídicos	Glicosúria, hipercalcemia, hiperuricemia , hipocalcemia, hipomagnesemia e hiponatremia. Não usar no paciente com gota.
IECA	Tosse seca (5-20% dos pacientes), hipercalcemia, angioedema e erupção cutânea. Após a introdução deste medicamento, ocorre elevação discreta e reversível de uréia e creatinina. Na elevação progressiva da creatinina, pensar em estenose de artéria renal. Seu uso é contraindicado na gravidez e na estenose bilateral da artéria renal .
Bloqueador do receptor de angiotensina	Seus principais efeitos colaterais são raros e mais frequentes nos portadores de nefropatia diabética.
Expironolactona	Hipercalcemia, ginecomastia . Não usar na disfunção renal grave.
Betabloqueadores	Broncoespasmo , bradicardia, distúrbios de condução atrioventricular, vasoconstrição periférica, inebria, pesadelos, depressão psíquica, astenia e disfunção sexual . Podem acarretar intolerância à glicose, induzir ao aparecimento de novos casos de diabetes, hipertrigliceridemia com elevação do LDL-colesterol e redução do HDL-colesterol. Atenção: o impacto sobre o metabolismo da glicose é potencializado quando em conjunto com diuréticos tiazídicos.
Vasodilatador direto	Cefaleia, flushing, taquicardia reflexa e reação lupus-like (dose-dependente). Também pode acarretar anorexia, náusea, vômito e diarreia. Um efeito colateral comum do minoxidil é o hirsutismo (80% dos pacientes). Um efeito menos comum é a expansão generalizada de volume circulante e taquicardia reflexa.
Simpaticolíticos de ação direta	Sonolência , tonturas, rash transitório, dermatite de contato, xerostomia, dor abdominal, bradicardia, palpitações, bloqueio atrioventricular, entre outros.

A letra A está incorreta. Alternativa "a" incorreta: Os efeitos colaterais mais frequentes dos tiazídicos são hipovolemia, câibras, hipocalcemia, hiponatremia, hipomagnesemia e disfunção erétil. A hipocalcemia reduz a liberação de insulina, aumentando a intolerância à glicose e, com isso, o risco de evolução para diabetes. Por esse motivo, não será a primeira opção em pacientes diabéticos e com intolerância à glicose. Outro efeito colateral muito cobrado nas provas é a hiperuricemia. Viu gota no enunciado? Fuja dos diuréticos! Essa informação está lá para isso! Não caia nessa armadilha! Um efeito colateral dos tiazídicos que pode ser benéfico é a hipercalcemia. Existem trabalhos demonstrando que os tiazídicos reduziram a incidência de fraturas em idosos com osteoporose, sendo boa opção nessa faixa etária.



A letra B está incorreta. Alternativa "b" incorreta: Esses medicamentos são muito bem tolerados e possuem poucos efeitos adversos. Assim como as outras drogas que atuam no sistema renina-angiotensina-aldosterona, IECA/BRA irão provocar hipercalemia, tornando fundamental seu acompanhamento após introdução da droga, especialmente em doentes renais crônicos. Se houver redução da função renal (superior a 30%), a medicação deve ser suspensa e devemos investigar estenose de artérias renais (mais detalhes no livro sobre HAS secundária). Além disso, IECA e BRA não devem ser utilizados em associação em nenhuma hipótese. O uso concomitante dessas drogas não trouxe benefícios, aumentando o risco de efeitos colaterais. Por fim, esses medicamentos estão contraindicados em mulheres grávidas, em qualquer fase da gravidez, pois podem gerar complicações fetais. Por isso, devemos ter cuidado em mulheres em idade fértil.

A letra C está incorreta. Alternativa "c" incorreta: Esses medicamentos são muito bem tolerados e possuem poucos efeitos adversos. O efeito colateral mais comum dos IECA é a tosse seca que acomete 5 a 20% dos usuários. Outros efeitos colaterais são bem raros: angioedema e erupção cutânea. Tanto o IECA como o BRA geralmente causam piora discreta da função renal mediada pela vasodilatação da arteríola eferente e redução da pressão de filtração glomerular. Na verdade, esse é o principal motivo dessas drogas serem benéficas em pacientes com nefropatia, pois evitam a hiperfiltração glomerular, evitando a progressão da doença renal crônica.

A letra D está correta. Alternativa "d" correta: O efeito colateral clássico dos BCC é o edema maleolar, que ocorre pela transudação capilar causada pelo maior efeito vasodilatador no leito arterial que no venoso. Em geral, os efeitos colaterais são dose-dependentes e irão demandar suspensão ou troca do BCC. Nesse caso, é recomendado a tentativa dos BCC lipofílicos (manidipino, lecanidipino e lacidipino) ou levanlodipino em baixas doses. Outros efeitos colaterais que podem surgir: cefaleia latejante, tonturas, rubor facial, dermatite ocre (hipercromia do terço distal das pernas) e hipertrofia gengival.

A letra E está incorreta. Alternativa "e" incorreta: Os principais efeitos colaterais são: broncoespasmo e vasoconstrição periférica (mais comum nos betabloqueadores não-seletivos), bradicardia, insônia, pesadelos, astenia e disfunção sexual. Para memorizar, basta lembrar que o betabloqueador gosta de reduzir as coisas: reduz o calibre do brônquio, reduz a frequência cardíaca, reduz o calibre do vaso periférico, reduz o sono, reduz a força e a libido. Além desses efeitos, esses medicamentos também afetam o metabolismo lipídico e glicídico. Os betabloqueadores podem interferir na liberação de insulina e aumentar a resistência à insulina endógena, fazendo surgir novos casos de diabetes. Atenção: o impacto sobre o metabolismo da glicose é potencializado quando em conjunto com diuréticos tiazídicos. Em diabéticos tipo I, em uso de insulina, os betabloqueadores podem mascarar os sintomas de hipoglicemia e prolongar uma crise hipoglicêmica!

Questão | | 2023 | 4000181663

Dona Elisa, 50 anos, portadora de transtorno bipolar, retornou para consulta na UBS com exames laboratoriais relacionados à tireoide alterados após iniciar uso de medicamento.

Nesse caso, o médico da família deve então reavaliar o uso de

- A) carbonato de lítio.
- B) carbamazepina.
- C) divalproato de sódio.
- D) fumarato de quetiapina.
- E) haloperidol.

Solução

Gabarito: A) carbonato de lítio.

GABARITO: ALTERNATIVA A

Estrategista, estamos diante de uma paciente bipolar, provavelmente em uso de um estabilizador do humor, com exames apontando alteração na função tireoideana. Nesses casos, é mandatório lembrar dos principais estabilizadores do humor de primeira linha: **lítio** - efeitos colaterais são alterações da tireoide, sintomas gastrointestinais e tremores, e ácido valproico - efeitos colaterais são alterações de função hepática, alteração do ciclo da ureia e eventualmente ovário policístico e reações dermatológicas.

Após esta introdução, vamos aprender um pouco mais sobre o lítio!

Um dos medicamentos mais importantes de toda a Psiquiatria, o Lítio é um remédio amplamente acessível, barato e muito eficaz. É utilizado no tratamento de transtornos psiquiátricos há mais de 70 anos, quando seus efeitos “calmantes” foram acidentalmente descobertos por um psiquiatra australiano, chamado Dr. John Frederick Joseph Cade. Desde então, esse metal é uma medicação de primeira linha para o Transtorno Bipolar, por possuir propriedades antimaníacas, antidepressivas e antissuicidas.

Seus principais possíveis efeitos colaterais a **longo prazo** são: hipotireoidismo, diabetes insípido e insuficiência renal.

Por isso, a principal suspeita é de um hipotireoidismo induzida por lítio, que pode ocorrer em até 5% dos usuários crônicos.

Questão | | 2023 | 4000181664

Dr. Antônio atende na UBS uma paciente de 34 anos com queixa de poliartralgias a qual traz resultado de exames que demonstram anemia, linfopenia e fator antinuclear positivo em títulos altos. Ao fim da consulta, o médico prescreve hidroxiclороquina para ela. Devido a essa prescrição, Dr. Antônio deve encaminhá-la para avaliação do

- A) cardiologista.
- B) nefrologista.

C) hepatologista.

D) oftalmologista.

E) hematologista.

Solução

Gabarito: D) oftalmologista.

GABARITO: ALTERNATIVA D

Paciente jovem, em idade reprodutiva, apresentando queixas poliarticulares, citopenias e FAN reagente deve ter lúpus eritematoso sistêmico (LES) como principal hipótese diagnóstica. Neste caso, provavelmente foi isso que o Dr Antônio pensou e, por esse motivo, fez a indicação de hidroxicloroquina.

A hidroxicloroquina é uma droga antimalárica com ação imunomoduladora muito utilizada no tratamento de doenças reumáticas, como o LES, artrite reumatoide e síndrome de Sjögren. Assim como qualquer outra medicação, está associada a eventos adversos e, como alguns são mais específicos, cuidados devem ser tomados no início do uso e durante o acompanhamento dos pacientes.

A letra A está incorreta. Incorreta a alternativa A: com relação ao acometimento cardíaco, são reportados casos de cardiomiopatia restritiva, distúrbios de condução e hipertensão pulmonar. São considerados fatores de risco tempo prolongado de uso, altas doses cumulativas, idade avançada, doença cardíaca pré-existente ou redução do clearance de creatinina. Assim, em pacientes jovens e sem tais fatores de risco, não há necessidade de avaliação cardíaca de rotina.

A letra B está incorreta. Incorreta a alternativa B: o clearance renal responde pela menor parte do clearance total da droga; assim, a hidroxicloroquina pode ser utilizada em pacientes com comprometimento de função renal sem necessidade de ajuste de dose, a princípio. Por isso, não há justificativa para avaliação nefrológica neste caso.

A letra C está incorreta. Incorreta a alternativa C: não há necessidade de avaliação hepática prévia, já que alteração de enzimas hepáticas não é evento adverso frequente e a hidroxicloroquina é considerada segura.

A letra D está correta. Correta a alternativa D: a retinopatia associada à hidroxicloroquina tem como alguns de seus principais fatores de risco altas doses com relação ao peso corporal do paciente, tempo de uso superior a 5 anos, baixo peso, redução do clearance de creatinina e doença macular pré-existente. Por isso, os últimos guidelines indicam a realização de exame oftalmológico basal no início do tratamento, seguido por avaliação anual após 5 anos de uso da medicação. Caso fatores de risco descritos acima estejam presentes, essa avaliação pode ser realizada em intervalos menores.

A letra E está incorreta. Incorreta a alternativa E: a hidroxicloroquina é segura do ponto de vista hematológico e, por isso, não há necessidade deste tipo de avaliação no início do tratamento.

Questão | | 2023 | 4000181665

Jovem de 22 anos apresenta quadro de dores no corpo, febre alta e astenia há 3 dias e seu exame confirma o diagnóstico de dengue. O médico da UBS, mantendo uma boa comunicação com o paciente, deve orientá-lo sobre sinais de alerta para dengue hemorrágica. Assinale a alternativa que contempla tais sinais.

- A)** Cefaleia, prostração e exantema.
- B)** Contagem de plaquetas > 150.000, cefaleia e mialgia.
- C)** Mialgia, febre alta e “rash” cutâneo.
- D)** Elevação de pressão arterial, dor retro-orbital e náuseas.
- E)** Dor abdominal, hipotensão postural e letargia.

Solução

Gabarito: E) Dor abdominal, hipotensão postural e letargia.

GABARITO: ALTERNATIVA E

dengue com sinais de alarme e dengue grave.

Dengue com sinais de alarme é aquela que demonstra algum dos seguintes sinais:

- Dor abdominal intensa (referida ou à palpação) e contínua.
- Vômitos persistentes.
- Acúmulo de líquidos (ascite, derrame pleural, derrame pericárdico).
- Hipotensão postural e/ou lipotímia.
- Hepatomegalia maior do que 2 cm abaixo do rebordo costal.
- Sangramento de mucosa.
- Letargia e/ou irritabilidade.
- Aumento progressivo do hematócrito.

A letra A está incorreta. Incorreta a alternativa A. Cefaleia, prostração e exantema não são sinais de alarme da dengue.

A letra B está incorreta. Incorreta a alternativa B. Plaquetopenia, cefaleia e mialgia não fazem parte dos sinais de alarme.

A letra C está incorreta. Incorreta a alternativa C. Não são sinais de alarme: mialgia, febre alta e “rash” cutâneo.

A letra D está incorreta. Incorreta a alternativa D. Elevação de pressão arterial, dor retro-orbital e náuseas não são sinais de alarme.

A letra E está correta. Correta a alternativa E. Dor abdominal (especialmente quando intensa e contínua), hipotensão postural e letargia são sinais de alarme da dengue.

Questão | | 2023 | 4000181666

Homem de 44 anos chega para consulta acompanhado da esposa, a qual reclama que ele ronca muito à noite. Ao final da avaliação, o médico explica que o diagnóstico provável é de apneia obstrutiva do sono. A orientação do profissional deve ser de que tal condição é fator de risco para

- A) sinusopatia.
- B) hipertensão arterial sistêmica.
- C) pneumonia.
- D) asma brônquica.
- E) doença pulmonar obstrutiva crônica.

Solução

Gabarito: B) hipertensão arterial sistêmica.

GABARITO: ALTERNATIVA B**Comentário:**

Questão direta sobre a **apneia obstrutiva do sono (AOS)**.

Muito provavelmente, ela é a principal causa de HA secundária, com prevalência de mais de 60% nos hipertensos resistentes. É caracterizada pelo colapso intermitente das vias aéreas superiores durante o sono, resultando em obstruções totais (apneias) ou parciais (hipopneias), fragmentação do sono e hipóxia. Entre os mecanismos envolvidos com a HA, estão a ativação do sistema nervoso simpático, a inflamação sistêmica, o aumento das espécies reativas de oxigênio e a disfunção endotelial.

Os principais sinais e sintomas associados são roncos altos e frequentes, sonolência excessiva diurna, sono não reparador, pausas respiratórias ou engasgos durante a noite, fadiga, noctúria, cefaleia matutina e alterações de humor. Entre os fatores de risco podemos citar o sexo masculino, obesidade, idade acima de 50 anos, uso abusivo de álcool e anormalidades estruturais das vias aéreas superiores.

A letra A está incorreta. Incorreta alternativa A: pois não há relação entre AOS e sinusopatia. Entre seus fatores de risco temos alergias, tabagismo, baixa imunidade, mudanças frequentes de pressão atmosférica e alterações anatômicas, como desvio de septo.

A letra B está correta. Correta alternativa B: conforme discutido.

A letra C está incorreta. Incorreta alternativa C: pois a AOS não é fator de risco para pneumonia. Os principais fatores de risco para pneumonia são alcoolismo, asma brônquica, DPOC, doença cardíaca, institucionalização e idade (principalmente idosos maiores de 70 anos).

A letra D está incorreta. Incorreta alternativa D: pois a AOS não é fator de risco para asma brônquica. Os principais fatores de risco para asma são poluentes químicos, ar frio, exposição a

ácaros, pêlos de animais, pólen, fumaça de cigarro, bolor, sinusite, refluxo gastroesofágico, nascimento prematuro, baixo peso ao nascimento, tabagismo

A letra E está incorreta. Incorreta alternativa E: pois o principal fator de risco para DPOC é o tabagismo.

Questão | | 2023 | 4000181667

Os pais levam Miguel de 8 anos para consulta, pois a diretora da escola disse que ele é desatento e tem dificuldade em aprender. A conduta inicial do médico da Atenção Primária nessa situação deve ser

- A) encaminhar Miguel ao neuropediatra.
- B) avaliar os ambientes familiar e escolar da criança.
- C) solicitar avaliação adicional tanto auditiva como visual.
- D) realizar testes de aptidão intelectual.
- E) solicitar eletroencefalograma.

Solução

Gabarito: B) avaliar os ambientes familiar e escolar da criança.

GABARITO: ALTERNATIVA B

O Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade (TDAH) é um transtorno do neurodesenvolvimento que atinge cerca de 5% das crianças, e 2,5% dos adultos. Seus sintomas são divididos entre desatenção, hiperatividade e impulsividade, e causam grande prejuízo acadêmico e interpessoal para a maioria dos pacientes.

Essas manifestações precisam se iniciar até os 12 anos de idade, e se manifestarem frequentemente em pelo menos 2 ambientes diferentes (como casa, escola e trabalho). Cerca de metade dos pacientes tem remissão dos sintomas até o início da vida adulta. Seu tratamento é realizado com psicoestimulantes, como metilfenidato ou lisdexanfetamina.

Vamos às alternativas!

A letra A está incorreta. Incorreto. A atenção primária é a responsável pela investigação, conduta inicial e, se necessário, tratamento. O encaminhamento ao especialista focal ocorre, normalmente, se houver grande complexidade, dúvida diagnóstica ou refratariedade ao tratamento.

A letra B está correta. Correto. Nesse primeiro momento, é fundamental coletar mais dados, conhecer melhor o paciente, família, ambientes, eventuais estressores, antes de elaborar uma hipótese diagnóstica.

A letra C está incorreta. Incorreto. Como discutido anteriormente, a **conduta inicial** ocorrerá com o aprofundamento da investigação na própria unidade. Caso haja suspeita de alteração auditiva, uma avaliação poderá ser considerada posteriormente.

A letra D está incorreta. Incorreto. Embora testagens psicométricas sejam fundamentais para uma avaliação aprofundada, não seria a primeira medida a ser tomada.

A letra E está incorreta. Incorreto, como discutimos acima.

Questão | | 2023 | 4000181668

Paulo foi encaminhado ao dermatologista pelo médico da família com suspeita de carcinoma basocelular. Nessa patologia, a forma clínica mais comum apresenta qual das seguintes características?

- A)** nódulo, com posterior ulceração recoberta por crosta.
- B)** lesão eritematodescamativa, não infiltrada, com bordas regulares.
- C)** placa acastanhada endurecida, às vezes com telangiectasia.
- D)** úlcera destrutiva, com bordas peroláceas.
- E)** pápulas claras que evoluem para vesículas.

Solução

Gabarito: A) nódulo, com posterior ulceração recoberta por crosta.

GABARITO: ALTERNATIVA A

O carcinoma basocelular é o tipo de câncer de pele mais comum. Geralmente surge em área fotoexposta. Acredita-se que o CBC seja derivado de células do folículo piloso. Isso é importante, pois em áreas em que não há folículos pilosos, como na mucosa, o desenvolvimento de um CBC é virtualmente impossível. Existem raros casos de carcinoma basocelular metastático. A grande preocupação desse tumor é seu potencial de destruição e invasão local, por vezes até com acometimento ósseo. É dividido em quatro subtipos clinicopatológicos principais: nodular, superficial, morfeiforme e fibroepitelial.

O subtipo nodular é o mais comum (50% dos casos) e o mais cobrado em provas de residência médica. A descrição clínica é muito peculiar, portanto preste bastante atenção. A lesão é uma pápula ou nódulo **PEROLADO** (brilhante) com **TELANGIECTASIAS ARBORIFORMES**. Com o crescimento do tumor, pode haver ulceração.

A letra A está correta. Correta. Essa é uma descrição de carcinoma basocelular nodular. É uma papulonódulo translúcido, perláceo, com telangiectasias. O carcinoma basocelular nodular é o subtipo mais comum.

A letra B está incorreta. Incorreta. Essa descrição assemelha-se mais ao carcinoma basocelular superficial.

A letra C está incorreta. Incorreta. Na maioria das vezes o CBC não é acastanhado. Além disso, essa característica de placa endurecida é do carcinoma basocelular esclerodermiforme.

A letra D está incorreta. Incorreta. Alguns carcinomas basocelulares podem ser muito destrutivos, porém isso não é muito comum.

A letra E está incorreta. Incorreta. Não há vesículas no carcinoma basocelular.

Questão | | 2023 | 4000181669

Relacione as colunas e assinale a alternativa com a sequência correta.

1. Endemia.
2. Epidemia.
3. Pandemia.
4. Surto epidêmico.
5. Incidência.
6. Prevalência.

() Medida de frequência dos novos casos de doença na população ao longo de um período de tempo.

() Ocorrência mais do que o esperado de número de casos de determinada doença ou uma condição crônica em uma grande área de abrangência (países ou continentes).

() Doença ou condição crônica relativamente constante em uma área geográfica, dentro dos limites esperados, por um período de tempo ilimitado.

() Frequência de casos existentes de determinada doença, em determinada população, em um dado momento.

() Concentração de casos de uma mesma doença em determinado local e época, claramente em excesso ao que seria esperado.

() Ocorrência epidêmica restrita a um espaço extremamente delimitado, como uma escola, quartel, edifício ou bairro.

A) 5 – 3 – 1 – 6 – 2 – 4.

B) 5 – 2 – 1 – 3 – 6 – 4.

C) 6 – 4 – 2 – 1 – 5 – 3.

D) 6 – 2 – 4 – 1 – 3 – 5.

E) 3 – 1 – 4 – 5 – 2 – 6.

Solução

Gabarito: A) 5 – 3 – 1 – 6 – 2 – 4.

GABARITO: ALTERNATIVA A

Estrategista, essa questão do ENARE é a prova de que, apesar do recuo da pandemia, as questões sobre os processos epidêmicos ainda estão em alta! O examinador deseja que o candidato correlacione as duas colunas. Vamos começar pela coluna 2 tentando entender qual é conceito a que ele se refere:

() Medida de frequência dos novos casos de doença na população ao longo de um período de tempo.

Opa! Observe que o examinador utilizou o termo "medidas de frequência". Isso significa que ele está se referindo à **prevalência** ou à **incidência**. A prevalência mede **todos** os casos existentes de uma doença em um determinado momento, enquanto a incidência mede apenas os casos **novos** da doença. Como a assertiva fala de casos novos, então o examinador está falando da incidência. Portanto, número 5.

() Ocorrência mais do que o esperado de número de casos de determinada doença ou uma condição crônica em uma grande área de abrangência (países ou continentes).

Se estamos diante de um número de casos acima do esperado, então estamos diante de uma epidemia ou processo epidêmico. Nesse sentido, existem 3 possibilidades:

-- Se o processo epidêmico ocorre em um ponto geograficamente delimitado, como um bairro, ou em uma população específica, como em uma creche, hospital, festa de casamento, então estamos diante de um **surto**.

-- Se o processo epidêmico ocorre em diversos países ao mesmo tempo (ou em intervalos de tempo próximos), então estamos diante de **pandemia**.

-- Se o processo epidêmico for de abrangência intermediária entre a área de um surto e de uma pandemia, então temos uma **epidemia**. Veja, portanto, que o termo epidemia pode ser utilizado para designar aquilo que não é um surto ou pandemia, ou como sinônimo de epidemia.

Veja que assertiva fala sobre a ocorrência de um processo epidêmico em países ou continentes, logo, é uma pandemia. Portanto, número 3.

() Doença ou condição crônica relativamente constante em uma área geográfica, dentro dos limites esperados, por um período de tempo ilimitado.

Veja que estamos diante de uma doença que se comporta segundo 3 características fundamentais:

- a. Ela é **constante** em uma determinada área geográfica. Isso significa que a doença "reside" naquela área com coeficiente de incidência **constante**;
- b. Seu coeficiente de incidência está **dentro dos limites esperados**, ou seja, **não** há um excesso... se não há um excesso, **não é epidêmica!**
- c. Evolui durante um período de tempo **ilimitado** - essa frase significa que o coeficiente de incidência permanece **constante**, com poucas oscilações, ao longo do tempo.

Essa é a descrição de uma endemia. Logo, número 1.

() Frequência de casos existentes de determinada doença, em determinada população, em um dado momento.

Você já sabe: se o examinador fala em medida de frequência, estamos diante da prevalência ou da incidência. Como ele diz que é a frequência de casos existentes em uma dado momento, então estamos diante da prevalência. Portanto, número 6.

() Concentração de casos de uma mesma doença em determinado local e época, claramente em excesso ao que seria esperado.

Se os casos estão em excesso, como vimos acima, isso significa que estamos diante de um processo epidêmico ou epidemia. Observe que não há a descrição da extensão geográfica. Portanto, trata-se de uma epidemia no sentido geral do termo. Número 2.

() Ocorrência epidêmica restrita a um espaço extremamente delimitado, como uma escola, quartel, edifício ou bairro.

Se é uma ocorrência epidêmica restrita, ou seja, em um espaço ou população bem delimitados, então trata-se de um surto. Número 4.

Essa é a sequência: 5 - 3 - 1 - 6 - 2 - 4.

A letra A está correta. Correta a alternativa A, sem ressalvas.

A letra B está incorreta. Incorreta a alternativa B porque essa não é a sequência correta.

A letra C está incorreta. Incorreta a alternativa C porque essa não é a sequência correta.

A letra D está incorreta. Incorreta a alternativa D porque essa não é a sequência correta.

A letra E está incorreta. Incorreta a alternativa E porque essa não é a sequência correta.

Questão | | 2023 | 4000181670

J.N.S., 37 anos, trabalhador da construção civil, sofreu queda de andaime a 2 metros de altura, resultando em fratura fechada de tíbia direita. Sobre o caso, assinale a alternativa correta.

A) Não é considerado acidente de trabalho.

- B)** Trata-se de um acidente de trabalho grave, e a CAT (Comunicação de Acidente de Trabalho) deve ser preenchida em 4 vias.
- C)** Trata-se de um acidente típico, e a CAT deve ser preenchida em 2 vias.
- D)** Trata-se de um acidente de trajeto, e não deve ser preenchida CAT.
- E)** Trata-se de um acidente de trabalho típico, e a CAT é de responsabilidade do médico assistente.

Solução

Gabarito: B) Trata-se de um acidente de trabalho grave, e a CAT (Comunicação de Acidente de Trabalho) deve ser preenchida em 4 vias.

GABARITO: ALTERNATIVA B

Referência bibliográfica:

(1) Notificação de Acidentes do Trabalho graves, fatais e com crianças e em adolescentes. Saúde do Trabalhador - Protocolos de Complexidade Diferenciada - Série A. Normas e Manuais Técnicos. Brasília – DF, 2006. Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/06_0442_M.pdf

Estrategista,

O primeiro ponto fundamental é classificarmos o acidente descrito na questão. Lembre-se de que existem 3 tipos de acidentes de trabalho:

(a) acidentes típicos, que são aqueles esperados para uma determinada profissão/ocupação. Por exemplo, um trabalhador da construção civil está sujeito à quedas de um andaime caso não utilize os equipamentos de proteção individual adequados.

(b) acidentes de trajeto, que são aqueles que acontecem enquanto o trabalhador se desloca da casa para o trabalho (ou do trabalho para casa), ou quando se desloca para outros locais a serviço da empresa. Nesse caso, é importante que ele não se desvie do caminho para pontos intermediários. Por exemplo, suponha que um trabalhador sai de casa para o trabalho, mas acaba parando em um shopping para resolver um problema rápido. Nesse caso, se sofrer um acidente automobilístico, o mesmo deixa de ser considerado acidente de trajeto porque ele "se desviou" do caminho original (ainda que o shopping seja no trajeto para o trabalho).

(c) doenças relacionadas ao trabalho, que são doenças desenvolvidas no âmbito do trabalho, como as pneumoconioses. Nesse caso, segundo a legislação brasileira, essas doenças podem ser equiparadas aos acidentes de trabalho.

Observe que estamos diante de um trabalhador da construção civil que caiu de um andaime. Portanto, é um acidente típico, conforme vimos acima.

O segundo ponto fundamental é verificarmos se estamos diante de um acidente leve ou grave. Um trabalhador que "cai" de um andaime e sofre uma fratura na tíbia, tem um acidente de trabalho grave.

-- Mas Bárbara, esse trabalhador teve uma fratura fechada. Provavelmente não evoluiu de forma grave. Ainda assim o acidente é grave?

Opa! Aqui é importante não confundirmos quadro clínico grave com acidente de trabalho grave. Uma coisa é o quadro clínico do paciente. Como ele não sofreu um politraumatismo, e como o enunciado não fala em internação, instabilidade hemodinâmica ou outros fatores que lembrem um quadro clínico grave, é provável que ele não evoluiu para um estado grave.

No entanto, por mais que ele não esteja em estado "grave", ainda assim é o acidente é considerado grave devido às repercussões que o acidente gerou. Afinal, um trabalhador que sofre uma fratura dessa natureza, provavelmente ficará afastado de suas atividades laborais por algumas semanas, ficará dependente temporariamente em algumas atividades de sua vida diária, e assim por diante...

Além disso, as condições listadas abaixo são consideradas "acidentes de trabalho graves" pelo Ministério da Saúde. Observe que as fraturas (de forma geral) classificam o acidente como grave:

- 1) *necessidade de tratamento em regime de internação hospitalar;*
- 2) *incapacidade para as ocupações habituais, por mais de 30 dias;*
- 3) *incapacidade permanente para o trabalho;*
- 4) *enfermidade incurável;*
- 5) *debilidade permanente de membro, sentido ou função;*
- 6) *perda ou inutilização do membro, sentido ou função;*
- 7) *deformidade permanente;*
- 8) *aceleração de parto;*
- 9) *aborto;*
- 10) *fraturas, amputações de tecido ósseo, luxações ou queimaduras graves;*
- 11) *desmaio (perda de consciência) provocado por asfixia, choque elétrico ou outra causa externa;*
- 12) *qualquer outra lesão: levando à hipotermia, doença induzida pelo calor ou inconsciência; requerendo ressuscitação; ou requerendo hospitalização por mais de 24 horas;*
- 13) *doenças agudas que requeiram tratamento médico em que exista razão para acreditar que resulte de exposição ao agente biológico, suas toxinas ou ao material infectado.*

O terceiro ponto fundamental é entendermos como é feita a emissão da CAT. Esse é um documento que deve ser enviado ao INSS quando ocorrer um acidente de trabalho, mesmo se o acidente não gerar afastamento. Só tem um porém: a CAT só deve ser emitida se estivermos diante de um trabalhador com **vínculo formal** (isto é, carteira assinada) ou **empregado doméstico** (pois no Brasil é obrigatório que empregados domésticos tenham carteira assinada) ou **segurado especial** (trabalhadores sem carteira assinada mas que trabalham para sua própria subsistência, como agricultores ou pescadores artesanais, marisqueiros, entre outros).

Além disso, a obrigatoriedade de emissão da CAT é da empresa, e a mesma deve emití-la até o próximo dia útil após o acidente (em caso de óbito, deve ser emitida na hora). Se a empresa não realizar a emissão, ela pagará multa. A CAT também pode ser emitida pelo médico assistente (não precisa ser especialista em medicina do trabalho), pelos familiares, pelo sindicato, pelas autoridades públicas e até mesmo pelo próprio acidentado.

Ainda, lembre-se de que o documento tem 4 vias:

- a primeira via é entregue ao INSS,
- a segunda via fica com o segurado ou seu dependente;
- a terceira via é entregue ao sindicato e
- a quarta via fica com a empresa.

Por último, a questão não menciona a notificação para o SINAN, mas é importante ressaltar que os acidentes de trabalho típicos e de trajeto também devem ser notificados para a vigilância epidemiológica (nesse caso, notificamos mesmo se o paciente NÃO possuir carteira assinada). Porém, esteja atento (a) às modificações que aconteceram em março de 2023. Até então, apenas os acidentes de trabalho graves, fatais, em crianças ou adolescentes eram notificados para a vigilância. Agora, os acidentes são notificados independentemente da gravidade do acidente (ou seja, acidentes leves também são notificados). A notificação deve ser imediata.

A lista também manteve a notificação de acidentes com exposição a material biológico (periodicidade semanal). Já a notificação das doenças relacionadas ao trabalho é feita pela lista da vigilância sentinela.

Com esses conhecimentos, vamos avaliar as alternativas:

A letra A está incorreta. **Incorreta a alternativa A** porque, como vimos, é acidente de trabalho típico.

A letra B está correta. **Correta a alternativa B.** O enunciado não menciona se o trabalhador se enquadra nas 3 condições que permitem a emissão da CAT, mas essa é a única alternativa plausível. Por isso, é o gabarito.

A letra C está incorreta. **Incorreta a alternativa C.** Trata-se de um acidente típico e a CAT deve ser preenchida em 4 vias.

A letra D está incorreta. **Incorreta a alternativa D.** Trata-se de um **acidente típico** e o preenchimento da CAT deve ser realizado se o trabalhador se enquadrar em uma das três condições já citadas acima: (a) **trabalhador com vínculo formal** (isto é, carteira assinada) ou (b) **empregado doméstico** (pois no Brasil é obrigatório que empregados domésticos tenham carteira assinada) ou (c) **segurado especial** (trabalhadores sem carteira assinada mas que trabalham para sua própria subsistência, como agricultores ou pescadores artesanais, marisqueiros, entre outros).

A letra E está incorreta. **Incorreta a alternativa E.** Trata-se de um acidente típico e a responsabilidade da emissão da CAT é da empresa, muito embora o médico assistente possa emití-la caso a empresa não o faça ou caso o médico efetue o atendimento primeiro.

Questão | | 2023 | 4000181671

M.J.F., 42 anos, procura UBS com queixa de febre, mialgia, cefaleia e dor retrorbital há 2 dias. Relata que, na sua rua, ocorreram vários casos semelhantes nesta semana. Após diagnosticar o caso de dengue e propor tratamento, cabe aos profissionais da UBS

- A)** notificar imediatamente o caso.
- B)** notificar semanalmente os casos de dengue e propor grupos de orientação para prevenção da doença.
- C)** tratar caso a caso e verificar situação vacinal dos doentes.
- D)** notificar imediatamente para fins informativos, sem interesse em prevenção e promoção de saúde.
- E)** notificar semanalmente os casos de dengue, sem interesse em prevenção ou promoção de saúde.

Solução

Gabarito: B) notificar semanalmente os casos de dengue e propor grupos de orientação para prevenção da doença.

GABARITO: ALTERNATIVA B

Referência bibliográfica:

(1) Ministério da Saúde. Portaria de Consolidação nº 04. Disponível em:

https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2017/prc0004_03_10_2017.html#ANEXO1ANEXO

Estrategista,

Segundo a Lista Nacional de Notificação Compulsória, essas são as arboviroses que devem ser notificadas no Brasil:

A. Dengue:

- casos suspeitos ou confirmados devem ser notificados com periodicidade semanal;
- óbitos suspeitos ou confirmados devem ser notificados imediatamente (isto é, em até 24 horas);

B. Chikungunya:

- casos suspeitos ou confirmados devem ser notificados semanalmente;
- casos suspeitos ou confirmados fora das áreas de transmissão, assim como óbitos suspeitos ou confirmados, devem ser notificados imediatamente.

(observação: a ficha de notificação da chikungunya é a mesma ficha da dengue).

C. Zika:

- casos suspeitos ou confirmados devem ser notificados com periodicidade semanal, exceto se em gestantes, cuja notificação deve ser imediata.
- óbitos suspeitos ou confirmados devem ser notificados imediatamente;
- Síndrome congênita do zika deve ser notificada semanalmente.

D. Febre amarela:

- casos suspeitos ou confirmados devem ser notificados com periodicidade imediata, assim como óbitos.

E. Febre do Nilo Ocidental e outras arboviroses de importância pública:

- casos suspeitos ou confirmados devem ser notificados com periodicidade imediata, assim como óbitos.

Veja que o examinador menciona que uma determinada rua apresenta um surto de dengue. Diante disso, e com as informações acerca das notificações de dengue, vamos analisar as alternativas:

A letra A está incorreta. **Incorreta a alternativa A.** De acordo com o que vimos acima, a notificação deve ser semanal e não imediate (exceto se óbito).

A letra B está correta. **Correta a alternativa B.** Diante de um surto de dengue deve-se, além de avaliar individualmente os casos, notificá-los para a vigilância epidemiológica com periodicidade semanal e propor grupos de educação em saúde, conscientizando a comunidade sobre o problema e convocando-os a executar as medidas de prevenção contra a proliferação do *Aedes aegypti*, como não deixar focos de água parada (pneus, garrafas, pratinhos de plantas, entre outros).

A letra C está incorreta. **Incorreta a alternativa C.** De fato, as equipes devem tratar caso a caso, mas na época da aplicação dessa prova (novembro de 2022), a única vacina disponível contra a dengue no Brasil era a Dengvaxia, que apresenta baixa eficácia (cerca de 60%) e restrição de público (apenas quem já teve dengue pode recebê-la), não tendo sido incorporada no SUS. Por isso, não faz sentido verificar a situação vacinal dos doentes.

No entanto, saiba que em março de 2023 a ANVISA aprovou a comercialização da QDenga no Brasil, uma vacina de origem japonesa e que é composta pelos 4 sorotipos da dengue, podendo atingir eficácia de 80%. A QDenga apresenta uma população-alvo mais ampla, uma vez pode ser

aplicada em quem ainda não teve dengue e nas seguintes faixas etárias: em crianças a partir de 4 anos, adolescentes e adultos até 60 anos. Ainda, são necessárias 2 doses para a imunização completa, com intervalo de 3 meses entre as aplicações.

A letra D está incorreta. **Incorreta a alternativa D** porque a notificação dos casos não é imediata, e sim semanal. Além disso, a notificação para a vigilância é realizada para fins de monitorização (afinal, são as notificações que trazem a compreensão se estamos caminhando para uma epidemia) e para prevenção em saúde.

A letra E está incorreta. **Incorreta a alternativa E.** A notificação semanal está correta, mas não está correto afirmar que as notificações não têm interesse na promoção e prevenção de saúde pois, como vimos acima, elas são utilizadas para prevenção.

Questão | | 2023 | 4000181672

M.F.J., 49 anos, procura atendimento por queixa de dispneia progressiva e nega tabagismo. Trabalha em vidraçaria desde os 30 anos de idade. O exame de imagem do tórax apresenta infiltrado micronodular bilateral com predomínio nas zonas pulmonares superiores, poupando os seios costofrênicos. Qual é o diagnóstico mais provável para esse caso?

- A)** DPOC.
- B)** Asbestose.
- C)** Silicose.
- D)** Asma.
- E)** Pneumopatia por berílio.

Solução

Gabarito: C) Silicose.

GABARITO: ALTERNATIVA C

Referências bibliográficas:

(1) Meirelles GSP et al. Imagem nas doenças ocupacionais pulmonares. Jornal Brasileiro de Pneumologia, Vol.32 Número (1 Suppl.2) 1 / 2006. Disponível em <https://www.jornaldepneumologia.com.br/details/3163/pt-BR/imagem-nas-doencas-ocupacionais-pulmonares>.

(2) Centers for Disease Control and Prevention. Clinical Overview: Major Occupational Lung Diseases, Granulomatous Diseases, Chronic Beryllium Disease Disponível em: <https://www.cdc.gov/niosh/learning/b-reader/clinical/lung/6.html>

Estrategista,

O ENARE se destacou em 2022 como uma banca que tem predileção pela **saúde do trabalhador**, já que 4 questões sobre o tema foram cobradas só naquele ano. Portanto, embora esse seja um assunto pouco cobrado quando levamos em consideração a média geral das bancas brasileiras, vale a pena estudá-lo para o ENARE.

Pois bem. Observe que estamos diante de uma **trabalhadora de 49 anos, com dispneia progressiva** e que **nega** tabagismo. Ora, se é trabalhadora, se a dispneia foi progredindo ao longo do tempo e se **NÃO** é tabagista, então é **MUITO PROVÁVEL** que estejamos diante de uma questão sobre pneumoconiose (afinal, as bancas não dão "ponto sem nó" e essas informações não estão no enunciado à toa).

Entre as pneumoconioses mais cobradas em provas de residência temos a silicose e a asbestose. Portanto, é muito provável que o gabarito seja uma das duas. Vamos continuar...

Veja que a paciente trabalha em uma vidraçaria desde os 30 anos, ou seja, há 19 anos! Opa! Tem uma palavra mágica aí: vidraçaria! Quais são os riscos de se trabalhar em um local assim? O principal é, sem dúvidas, estar exposto à partículas de areia ou sílica.

-- Nossa, Bárbara, mas qual é a relação entre vidraçaria e areia?

Ora, vidros utilizam areia como matéria-prima! E areia contém sílica! Portanto, essa paciente tem história ocupacional compatível com a exposição à sílica, o que nos leva a pensar em silicose.

Observe que a paciente está exposta há mais de 10 anos. Portanto, é provável que ela tenha a **silicose crônica simples**, que pode se manifestar com dispneia progressiva e cuja radiografia de tórax demonstra opacidades micronodulares (geralmente inferiores a 0.5 cm) e localizadas tipicamente nas zonas pulmonares superiores (se fosse asbestose, a paciente teria exposição ao asbesto/amianto e a imagem radiológica demonstraria opacidades irregulares tipicamente nas zonas inferiores do pulmão). Tanto a silicose como a asbestose podem ser fibrogênicas, isto é, podem cursar com fibrose pulmonar.

Observe que o enunciado traz justamente a descrição radiológica da silicose (lembre-se: a banca do ENARE não "dá ponto sem nó"). Portanto, podemos "fechar" esse diagnóstico.

A letra A está incorreta. **Incorreta a alternativa A.** O principal fator de risco ambiental para o desenvolvimento da DPOC é o tabagismo e a paciente não é tabagista. Além disso, a imagem radiológica não é compatível (para o padrão enfisematoso, por exemplo, espera-se radiografia de tórax com hipertransparência pulmonar, hiperinsuflação, retificação das hemicúpulas diafragmáticas, coração em gota, entre outros).

A letra B está incorreta. **Incorreta a alternativa B.** A exposição ao **asbesto** é causa necessária para o desenvolvimento da **asbestose**, cujo padrão radiológico típico é a presença de opacidades irregulares nos campos pulmonares inferiores. Além disso, a asbestose pode se

manifestar com acometimento pleural (placas pleurais) e associa-se até mesmo à malignidade como mesotelioma pleural.

A letra C está correta. **Correta a alternativa C**, sem ressalvas.

A letra D está incorreta. **Incorreta a alternativa D**. A paciente não apresenta clínica compatível com asma (crises de dispneia súbita, tosse, sibilância, dor torácica, além da menção de um determinado alérgeno). A imagem radiológica costuma ser normal, a menos que a paciente apresentasse uma complicação, como pneumomediastino e pneumonia, por exemplo, ou doença grave.

A letra E está incorreta. **Incorreta a alternativa E**. O primeiro ponto fundamental para pensarmos em pneumopatia por berílio seria uma história ocupacional compatível. O berílio participa de processos produtivos nas indústrias aeroespacial, nuclear, de eletrônicos, além de ser utilizado na indústria de ligas metálicas e cerâmica. Observe que nenhuma das atividades acima foi mencionada no enunciado.

Em segundo lugar, a paciente deveria ter clínica e radiologia compatíveis. Por exemplo, a beriliose crônica cursa com dispneia progressiva, mas também com tosse e perda de peso, e parece desenvolver-se apenas em indivíduos sensíveis ao metal (ou seja, nem todos os expostos necessariamente desenvolverão a doença). Do ponto de vista radiológico, a banca não colocou a pneumopatia por berílio entre as alternativas à toa. Ela também pode se manifestar com padrão micronodular difuso, ou mais acentuado em lobos superiores, e com acometimento de linfonodos hilares. Alguns autores chamam a atenção para o fato de que a beriliose crônica pode cursar com a formação de granulomas pulmonares e, por isso, tende a fazer diagnóstico diferencial com a sarcoidose.

Questão | | 2023 | 4000181673

L.B.C., 53 anos, sexo feminino, casada, trabalha há anos em fábrica de lâmpadas fluorescentes, procura UPA com queixa de fadiga, perda de peso, perda de apetite, sialorreia, afrouxamento dos dentes, irritabilidade e tremores. Diante do exposto, pode-se afirmar que se trata de intoxicação exógena por

- A)** cromo.
- B)** chumbo.
- C)** benzeno.
- D)** solventes orgânicos.
- E)** mercúrio.

Solução

Gabarito: E) mercúrio.

GABARITO: ALTERNATIVA E

(1) Buschinelli JTP. Toxicologia ocupacional. Fundacentro, São Paulo, 2020.

(2) Guerra DF e Silveira AM. Epidemia de intoxicação por chumbo em empresa de fundição secundária. Revista Médica de Minas Gerais. Volume: 20. (2 Suppl.2). Disponível em: <https://rmmg.org/artigo/detalhes/1031>.

(3) Fonseca ASA et al. Classificação clínico-laboratorial para manejo clínico de trabalhadores expostos ao benzeno em postos de revenda de combustíveis. Revista Brasileira de Saúde Ocupacional. Volume 42 - Suplemento 1 - Dossiê: Benzeno em Postos de Combustíveis: 1-10, 2017.

Estrategista,

Quero reforçar que as questões sobre saúde do trabalhador despencaram na prova do ENARE 2022: foram 4 questões sobre o tema! Portanto, fique ligado (a)!

O enunciado fala sobre uma **trabalhadora** de 53 anos que está há anos trabalhando em uma **fábrica de lâmpadas fluorescentes**! Opa! Se o enunciado cita a ocupação da paciente é porque realmente estamos diante de uma questão de saúde do trabalhador e precisaremos correlacionar essa atividade com o quadro clínico.

Pois bem. Quais são as exposições em uma fábrica de lâmpadas fluorescentes? **Tais lâmpadas levam mercúrio e chumbo**. O mercúrio era usado para intensificar o brilho da lâmpada e o chumbo está no preparo do vidro da lâmpada, auxiliando no suporte térmico (e quando digo que o mercúrio era usado é porque estamos em processo de descontinuação do uso do Mercúrio no Brasil, graças à Convenção de Minamata, um acordo internacional para eliminar o uso de mercúrio nos processos produtivos). Portanto, esses são os dois metais envolvidos na produção de lâmpadas fluorescentes.

Agora vem o voo da coruja:

Se pensarmos em uma intoxicação crônica pelo **mercúrio** (já que a paciente trabalha na fábrica há anos), pensaremos justamente em sinais e sintomas como alterações neurológicas (distúrbios da marcha, alterações cognitivas...), eretismo psíquico (irritabilidade, agitação), tremores, sialorréia, perda de peso e gengivite (aliás, o eretismo psíquico, os tremores e a gengivite são conhecidos como **tríade mercurial**) (1).

Se pensarmos em uma intoxicação crônica pelo **chumbo** (também conhecida como **plumbismo**), pensaremos no clássico saturnismo, que se manifesta com crises de dor abdominal em cólica, intensa, refratária a analgésicos comuns, simulando um abdômen agudo cirúrgico. Porém o exame físico tem blumberg negativo e a imagem radiológica abdominal não tem alterações. Além disso, o paciente pode apresentar também as linhas de Burton, que são linhas azul-violáceas que surgem no encontro da gengiva com os dentes e que representam a deposição de sulfeto de chumbo (PbS). A intoxicação pelo chumbo também

pode cursar com anemia e com alterações neurológicas, especialmente a perda do interesse por atividades sociais, tanto que os familiares relatam que o paciente "está diferente" (1,2).



Voltando para a questão, observe o quadro clínico apresentado: "*L.B.C. (...) procura UPA com queixa de fadiga, perda de peso, perda de apetite, sialorreia, afrouxamento dos dentes, irritabilidade e tremores*". Portanto, o quadro clínico é compatível com a intoxicação por mercúrio.

A letra A está incorreta. **Incorreta a alternativa A.** O primeiro ponto fundamental é entendermos que o tipo de cromo que tem importância na Toxicologia é o **cromo hexavalente** ($\text{Cr}6+$), que é muito utilizado na **galvanoplastia**, um tipo de processo que utiliza a eletrólise para colocar um revestimento metálico em cima de uma determinada peça. O objetivo de revestir a peça com uma cobertura metálica é evitar a sua corrosão. A galvanoplastia pode utilizar diversos metais, inclusive o cromo (nesse caso, o processo será chamado de cromagem) (1). Na galvanoplastia, o cromo hexavalente pode reagir com outros compostos e formar névoas que podem ser "aspirados" pelo trabalhador. O cromo hexavalente também pode ser encontrado em processos produtivos que utilizam a soldagem, onde esse cromo pode virar "fumo" e ser aspirado pelo trabalhador (1).

A exposição do trabalhador à essas névoas e fumos pode levar à clássica perfuração do septo nasal por meio da formação de uma úlcera. Há também a possibilidade de asma devido à essa inalação. Ainda, outras dermatites podem ocorrer caso haja o contato direto com as soluções de cromo, como úlcera em olho de pombo (1).

Observe que o quadro clínico descrito no enunciado não é compatível com o quadro clínico de intoxicação pelo cromo.

A letra B está incorreta. **Incorreta a alternativa B**, pois o quadro clínico apresentado pela paciente não é compatível com o chumbo, conforme vimos acima.

A letra C está incorreta. **Incorreta a alternativa C.** A ocupação clássica de um trabalhador com benzenismo é aquela em que há manipulação de combustíveis, como mecânicos de aviões, postos de gasolina, indústrias petroquímicas, e também indústrias de plásticos, borrachas e tintas. Além disso, o benzenismo se manifesta com alterações do sistema hematopoiético, levando a anemia aplásica, síndrome mielodisplásica, linfoma não-Hodgkin e leucemia mieloide aguda (LMA) e crônica (LMC) e assim por diante (3).

Observe que o quadro clínico descrito no enunciado não é compatível com o quadro clínico de benzenismo.

A letra D está incorreta. **Incorreta a alternativa D.** Veja que a banca não especificou o solvente orgânico (ou seja, ela não informa se é tolueno, benzeno, acetona...). De forma geral, existe a "síndrome do solvente orgânico", cuja existência é controversa. Porém, em teoria, acredita-se que um trabalhador intoxicado cronicamente por qualquer tipo de solvente orgânico pode evoluir com sintomas como "cefaleia, fadiga, alterações do humor e distúrbios do sono, com ou sem alterações neurológicas" (1). A síndrome também receberia outros nomes como síndrome dos pintores ou encefalopatia crônica por solventes (1).

A letra E está correta. **Correta a alternativa E.** E só para complementar seus estudos porque o mercúrio pode aparecer novamente no ENARE: é importante frisarmos que 3 tipos de mercúrio podem aparecer nas provas:

- o mercúrio metálico (HgO),
- o mercúrio inorgânico (representado pelos sais de mercúrio),
- e o mercúrio orgânica, representado pelo metilmercúrio (CH_3Hg).

A intoxicação pela forma metálica é a mais comum entre os trabalhadores, uma vez que o mercúrio é um metal líquido em temperatura ambiente, mas que volatiliza facilmente formando vapores que, por sua vez, serão inalados pelo trabalhador. Provavelmente, a trabalhadora citada nessa questão inalou esses vapores por muito tempo, principalmente porque são justamente os vapores de mercúrio que são utilizados nas lâmpadas fluorescentes. Essa intoxicação também é conhecida como **mercurialismo crônico** ou **hidrargirismo (Hg porque é o símbolo do Mercúrio)**. Ah, essa é a forma química mais comum de intoxicação entre os garimpeiros também, já que eles manipulam o mercúrio líquido para formar amálgamas com o ouro (e com essa manipulação, acabam inalando os vapores também).

A intoxicação pelo mercúrio inorgânico é menos comum e está relacionada a ingestão dos sais de mercúrio, seja por autoextermínio ou de forma acidental.

Por fim, a intoxicação pelo mercúrio orgânico está mais relacionada à exposição ambiental. Esse é um problema que infelizmente vem acontecendo na Região Norte do país. O garimpo vem avançando em toda aquela região e o mercúrio líquido utilizado acaba contaminando o solo, os rios e toda a bacia hidrográfica.

Por sua vez, esse mercúrio é absorvido por plantas, especialmente as que estão nos rios, e é biotransformado em metilmercúrio. Os peixes da base da cadeia alimentar se alimentam dessas plantas e, uma vez que o mercúrio entra na cadeia alimentar, ele vai se acumulando progressivamente ao longo dos peixes da cadeia, em um fenômeno conhecido como **magnificação trófica**.

Quando a população ribeirinha consumir os peixes que estão no topo da cadeia alimentar, acabará se contaminando com o metilmercúrio, que tem absorção rápida pelo trato gastrointestinal e se deposita diretamente no sistema nervoso central, causando alterações neurológicas importantes como alterações comportamentais, distúrbios da marcha e da fala, entre outros. Esse espectro de intoxicação pelo mercúrio é conhecido como **Doença de Minamata** e foi descrito pela primeira na década de 60 no Japão.

Questão | | 2023 | 4000181674

Marcos, 22 anos, HIV positivo, participou de um estudo sobre testes rápidos para HIV e seu resultado foi o único negativo entre as 50 pessoas soropositivas do estudo, com um total de 100 participantes. Nesse caso, qual foi a sensibilidade do teste?

- A)** 96%.
- B)** 99%.
- C)** 49%.
- D)** 98%.
- E)** 50%.

Solução

Gabarito: D) 98%.

GABARITO: ALTERNATIVA D

Estrategista,

Estamos diante de uma questão muito objetiva do ENARE que fala o seguinte: um paciente chamado Marcos, que é uma pessoa que vive com o vírus HIV, participou de um estudo sobre testes rápidos para HIV. O seu resultado foi o **único negativo** entre as 50 pessoas soropositivas participantes.

Portanto, temos 50 indivíduos doentes, sendo que 49 tiveram resultados verdadeiro-positivos (VP), enquanto apenas Marcos teve um resultado falso-negativo (FN).

Ora, a sensibilidade do teste é do que a capacidade de captar corretamente os indivíduos doentes. Do ponto de vista matemático, calculamos da seguinte forma:

$$\text{Sensibilidade} = \frac{VP}{(VP + FN)}$$

(observe que $VP + FN$ nada mais é do que o número total de doentes).

No caso proposto, temos que:

$$\text{Sensibilidade} = \frac{49}{50} = 0,98.$$

Se multiplicarmos por 100, temos 98%.

Portanto:

A letra A está incorreta. **Incorreta a alternativa A**, conforme demonstrado acima.

A letra B está incorreta. **Incorreta a alternativa B**, conforme demonstrado acima.

A letra C está incorreta. **Incorreta a alternativa C**, conforme demonstrado acima.

A letra D está correta. **Correta a alternativa D**, sem ressalvas.

A letra E está incorreta. **Incorreta a alternativa E**, conforme demonstrado acima.

Questão | | 2023 | 4000181675

Paulo, 67 anos, engenheiro civil, casado e previamente hígido, recebeu diagnóstico de adenocarcinoma de cólon e, após toda adequada explicação do médico assistente sobre o caso, opta por não realizar o tratamento. Qual princípio ético deve ser respeitado nesse caso?

- A)** Não maleficência.
- B)** Justiça.
- C)** Beneficência.
- D)** Tolerância.
- E)** Autonomia.

Solução

Gabarito: E) Autonomia.

GABARITO: ALTERNATIVA E

Estrategista,

Grave isso: o ENARE tem predileção pelas questões que envolvem os princípios da Bioética. Portanto, vamos revisá-los rapidamente:

1. Autonomia:

Autonomia significa "autogoverno" ou "dirigir a si próprio". Portanto, nada mais é do que a capacidade que o indivíduo tem de agir de **modo livre e autônomo**, tendo a sua vontade respeitada. Ao trazermos esse conceito para o âmbito da relação médico-paciente, é imprescindível que os médicos informem aos seus pacientes sobre os prós e os contras de um determinado tratamento, para que assim eles possam decidir, junto ao profissional, qual é o melhor tratamento a ser realizado.

Assim como a autonomia permite a decisão compartilhada, ela também permite a recusa terapêutica do paciente. Pois é! O paciente pode recusar um tratamento se assim desejar (salvo em situações de risco de morte, quando então o médico pode perpassar a recusa do paciente).

Cabe ressaltar que a autonomia preza e incentiva a participação dos pacientes nas decisões porque só eles sabem seus verdadeiros valores e só eles sofrerão diretamente o impacto de suas escolhas.

2. Não maleficência:

É o famoso *primum non nocere*, ou seja, “primeiro NÃO fazer mal ao indivíduo”. Por isso, não é ética a solicitação de exames ou a indicação de tratamentos em que ainda não temos certeza se existem benefícios, pois isso implicar em iatrogenia para o paciente. É por isso que dizemos que o princípio da não maleficência está associado à **prevenção quaternária**, que é justamente a não solicitação de exames ou tratamentos duvidosos, ou ainda, a desprescrição de medicamentos de benefício duvidoso.

3. Beneficência:

Os profissionais de saúde têm a obrigação moral de atuar em benefício e interesse dos pacientes. Por isso, se há alguma ação de saúde que fará bem ao paciente, ela deve ser realizada.

4. Justiça:

O conceito de justiça está atrelado ao conceito de Equidade e significa distribuição social. Portanto, é o ato de tratar o indivíduo de forma adequada, agindo de forma a fornecer justamente aquilo que ele precisa, de forma justa.

Voltando para a questão, o examinador traz a história de Paulo, um paciente de 67 anos que optou POR NÃO realizar o tratamento de adenocarcinoma de cólon. Como não estamos diante de uma emergência médica, o paciente pode exercer a **recusa terapêutica**, pois ele tem **autonomia** para isso. Portanto:

A letra A está incorreta. Incorreta a alternativa A porque, como vimos, a não maleficência fala sobre *primeiro não fazer mal*.

A letra B está incorreta. **Incorreta a alternativa B** porque, como vimos, a **justiça** tem relação com a distribuição justa de oportunidades e recursos.

A letra C está incorreta. **Incorreta a alternativa C** porque, como vimos, a **beneficência** tem relação com executar ações que farão bem ao paciente.

A letra D está incorreta. **Incorreta a alternativa D** porque **tolerância** não é um princípio bioético.

A letra E está correta. **Correta a alternativa E**, sem ressalvas.

Questão | | 2023 | 4000181676

Paciente, sexo feminino, casada, 53 anos e obesa, procura atendimento médico em UBS pela primeira vez e relata nunca ter realizado exames de rotina. Sobre o caso, qual conduta NÃO deve ser tomada?

- A)** Solicitar TC de abdome.
- B)** Solicitar hemograma, glicemia de jejum e lipidograma.
- C)** Solicitar/realizar citologia oncológica.
- D)** Solicitar mamografia.
- E)** Verificar situação vacinal e atualizar se necessário.

Solução

Gabarito: A) Solicitar TC de abdome.

GABARITO: ALTERNATIVA A

Caro Estrategista,

Questões sobre rastreamento despencam em provas de residência. Portanto, você não pode deixar de saber quais rastreamentos são indicados e para quem são indicados.

Lembre-se que rastrear significa buscar algo em alguém absolutamente assintomático. As suas chances de causar mal, incluindo sobrediagnóstico e sobretratamento, com intervenções danosas e desnecessárias, é muito maior do que sua chance de causar bem se sair pesquisando tudo a torto e a direito. Portanto, é preciso uma base científica sólida para justificar a solicitação de um exame para rastreamento. Lembre-se: *primum non nocere*.

Os principais rastreamentos dividem-se em neoplasias, metabólicos e infecciosos. Separei 4 principais em cada grupo, o que ajuda a memorizar.

4 neoplasias:

- Colon;
- Mama;
- Colo do útero;
- Pulmão.

4 metabólicos:

- Glicemia;
- Lípides;
- Densitometria;
- Aneurisma de aorta abdominal (USG).

4 infecções:

- HIV;
- Sífilis;
- Hepatites virais*;
- Clamídia/gonococo*.

***Essas indicações são menos consensuais e pouco cobradas no contexto brasileiro.**

Vamos ver nas alternativas quais são os rastreamentos apropriados para nossa paciente, lembrando que ela pede qual não está indicado.

A letra A está correta. **Correta.** TC de abdome não é indicada para rastreamento de nenhuma condição.

A letra B está incorreta. **Incorreta, com ressalvas.** Embora muito frequente, o pedido de hemograma não está indicado como rastreamento em nenhuma circunstância.

Sobre a glicemia de jejum, a Associação Americana de Diabetes (ADA) recomenda o rastreio a partir dos 35 anos, ou em pessoas com IMC ≥ 25 kg/m² (≥ 23 kg/m² em asiáticos) com um ou mais fatores de risco para DM. A repetição deve ser feita a cada 3 anos. Outros órgãos têm recomendações ligeiramente diferentes. A nossa paciente **tem indicação de dosar glicemia.**

Sobre lípides, o US Preventive Services Task Force recomenda o cálculo de risco cardiovascular para indivíduos entre 40 e 75 anos, no contexto de indicar estatina para prevenção primária de eventos cardiovasculares. Para este cálculo, é preciso dosar os lípides, então isto deve ser feito nesta faixa etária. A nossa paciente **tem indicação de dosar lípides.**

Caberia recurso, pois esta alternativa também não está totalmente correta.

A letra C está incorreta. **Incorreta.** A solicitação de colpocitologia oncótica é indicada como rastreamento de câncer de colo do útero em mulheres acima de 25 anos que iniciaram a vida sexual, devendo continuar de acordo com as orientações do Ministério da Saúde até os 64 anos, desde que haja dois resultados negativos consecutivos. Gosto sempre de ressaltar que este, de longe, é o rastreamento **mais efetivo e mais importante** de todos! A nossa paciente **tem indicação de coletar Papanicolau.**

A letra D está incorreta. **Incorreta**, pois a mamografia está indicada na nossa paciente. Segundo o Ministério da Saúde, está indicada a mamografia a cada 2 anos para mulheres entre 50-69 anos. Cabe ressaltar que outros órgãos têm indicações levemente divergentes. A nossa paciente **tem indicação de mamografia**.

A letra E está incorreta.

Questão | | 2023 | 4000181677

Paulo, 41 anos, é trabalhador rural e procura atendimento com queixa de sudorese, sialorreia e vômitos. Relata ter trabalhado aplicando Folidol na sua lavoura. Ao exame, apresenta miose e confusão mental. Qual é o provável diagnóstico e o órgão a ser notificado?

- A)** Saturnismo / SINAN.
- B)** Intoxicação por organofosforado / SINASC.
- C)** Intoxicação por organofosforado / SINAN.
- D)** Intoxicação por cromo / SINASC.
- E)** Saturnismo / SISVAN.

Solução

Gabarito: C) Intoxicação por organofosforado / SINAN.

GABARITO: ALTERNATIVA C

Referências bibliográficas:

(1) Buschinelli JTP. Toxicologia ocupacional. Fundacentro, São Paulo, 2020.

(2) Guerra DF e Silveira AM. Epidemia de intoxicação por chumbo em empresa de fundição secundária. Revista Médica de Minas Gerais. Volume: 20. (2 Suppl.2). Disponível em: <https://rmmg.org/artigo/detalhes/1031>.

Estrategista,

Fique atento (a) às questões de saúde do trabalhador no ENARE, pois esse tema despencou na edição de 2022 e é possível que apareça novamente nas próximas provas!

Veja que estamos diante de Paulo, um trabalhador rural de 41 anos que procura atendimento com sudorese, sialorreia e vômitos e exame físico demonstrando miose e confusão mental. Veja que ele trabalha com folidol. Portanto, o quadro clínico de Paulo é uma provável intoxicação exógena pelo folidol.

-- Certo, Bárbara, mas que substância é essa?

Opa, você não precisa conhecer a substância, mas precisa reconhecer o quadro clínico. Em uma boa parte dessas questões, o objetivo do examinador é saber se você sabe a diferença entre uma síndrome adrenérgica e uma síndrome colinérgica.

A **síndrome adrenérgica** se manifesta com agitação psicomotora, taquicardia, elevação da pressão arterial, sudorese excessiva, náuseas, vômitos e midríase, ou seja, com sinais e sintomas de hiperestimulação do sistema nervoso central. Esse quadro pode ocorrer nas intoxicações por anfetaminas e no uso de drogas como cocaína e crack.

Paralelamente, a **síndrome colinérgica** se manifesta com vômitos, diarreia, aumento da diurese, sudorese, sialorreia, miose e bradicardia, além de fraqueza muscular, tremores e confusão mental. Ou seja, o paciente apresentará sinais e sintomas compatíveis com o aumento do tônus colinérgico no sistema nervoso central, já que há excesso de acetilcolina por inibição da acetilcolinesterase. E quem é capaz de inibir essa enzima? Basicamente os carbamatos e os organofosforados.

Veja que as alternativas mencionam como possíveis diagnósticos o saturnismo, a intoxicação por organofosforado e a intoxicação pelo cromo. Ora, o quadro clínico apresentado é compatível com uma síndrome colinérgica. Portanto, podemos concluir que o folídol é um organofosforado.

O examinador também questiona qual é o órgão que deve ser notificado. A **Lista Nacional de Notificação Compulsória** traz o item 31, que fala sobre **Intoxicação Exógena por substâncias químicas, incluindo agrotóxicos, gases tóxicos e metais pesados**. O folídol é um agrotóxico. Por isso, a intoxicação deve ser notificada para o SINAN (*mas fique tranquilo (a), ainda que você não soubesse que o folídol é um agrotóxico, você acertaria por eliminação, já que saberia intuitivamente que o SINASC e o SISVAN não recebem notificações dessa natureza*).

Uma última observação: estamos diante de um acidente de trabalho, já que Paulo é um trabalhador que se intoxicou durante o exercício de sua função laboral. Apesar disso, por ser uma intoxicação exógena, não notificamos ao SINAN como acidente de trabalho, mas como intoxicação, conforme descrito acima.

Portanto:

A letra A está incorreta. **Incorreta a alternativa A.** A intoxicação crônica pelo chumbo é pode se manifestar por meio de um quadro clínico chamado saturnismo, que se manifesta com crises de dor abdominal em cólica, intensa, refratária a analgésicos comuns, simulando um abdômen agudo cirúrgico. Porém o exame físico tem blumberg negativo e imagem radiológica abdominal sem alterações. Além disso, o paciente pode apresentar também as linhas de Burton, que são linhas azul-violáceas que surgem no encontro da gengiva com os dentes e que representam a deposição de sulfeto de chumbo (PbS). A intoxicação pelo chumbo também pode cursar com anemia e com alterações neurológicas, especialmente a perda do interesse por atividades sociais, tanto que os familiares relatam que o paciente "está diferente" (1,2).

A letra B está incorreta. **Incorreta a alternativa B** porque o SINASC é o sistema de informações sobre nascidos vivos.

A letra C está correta. **Correta a alternativa C.** Cabe ressaltar que a notificação das intoxicações exógenas ao SINAN ocorrem com periodicidade semanal.

A letra D está incorreta. **Incorreta a alternativa D.** Primeiro porque, como vimos acima, o SINASC é o sistema de informações sobre nascidos vivos. Segundo porque a intoxicação pelo cromo acontece em ocupações que trabalham com galvanoplastia (um tipo de processo que utiliza a eletrólise para colocar um revestimento metálico em cima de uma determinada peça) e soldagem. O nosso paciente Paulo não tem nenhuma dessas ocupações. Além disso, o principal sinal da intoxicação pelo cromo é a perfuração do septo nasal justamente pelo contato da mucosa nasal com os vapores de cromo produzidos nos processos acima, assim como o desenvolvimento de dermatites e asma (1).

A letra E está incorreta. **Incorreta a alternativa E.** Como vimos, o saturnismo é um dos espectros clínicos da intoxicação pelo chumbo. Já a sigla SISVAN significa Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional, que é o sistema de informações que monitora o estado nutricional dos brasileiros e as condições de alimentação e nutrição no país.

Questão | | 2023 | 4000181678

Gestante, 27 anos, com parto prematuro de 34 semanas gestacionais. Após alta para casa, evolui com infecção uterina, sepse e tem óbito confirmado 60 dias após o parto. Diante do exposto, qual é o tipo de morte?

- A)** Morte materna direta.
- B)** Morte obstétrica direta.
- C)** Morte não materna, pois ocorreu 60 dias após o parto.
- D)** Morte materna tardia.
- E)** Morte pós-materna.

Solução

Gabarito: D) Morte materna tardia.

GABARITO: ALTERNATIVA D

Estrategista,

Chamamos de óbito materno (ou morte materna) ao óbito que cumpre os 2 requisitos fundamentais:

(1) ocorre durante o ciclo gravídico-puerperal, que inicia-se no momento da concepção e vai até 42 dias após o fim da gestação e

(2) tem como causa básica uma complicação obstétrica, seja direta (como em uma infecção uterina decorrente da gestação) ou indireta (como em um agravamento da COVID-19 por conta da gestação).

Se um dos dois requisitos faltar, o óbito não será classificado como morte materna. Por exemplo, se uma mulher no ciclo gravídico-puerperal sofrer um atropelamento e falecer em decorrência dele, o óbito não será classificado como materno, já que a causa foi externa e não uma complicação obstétrica.

Mas existem exceções. Com o avanço da medicina, é possível que uma mulher não evolua para o óbito nos 42 dias após o fim da gestação. Pode ser que, com todo o aparato tecnológico, a equipe de saúde consiga mantê-la viva por mais tempo, ao ponto de o óbito ocorrer de forma **tardia**, mais precisamente entre 43 e 365 dias após o fim da gestação.

Nesse caso, não chamaremos mais o óbito apenas de morte materna, mas de **morte materna tardia**, justamente para sinalizar que um óbito por causa materna aconteceu após o fim do ciclo gravídico-puerperal.

Voltando para a questão, observe que o enunciado fala de uma mulher que tem o óbito confirmado 60 dias após o parto, sendo a causa uma infecção uterina que evoluiu para sepse. Ora, essa paciente faleceu em decorrência de uma complicação obstétrica direta, porém o óbito aconteceu após o 42º dia. Por isso, essa morte deve ser classificada como **morte materna tardia**.

Portanto:

A letra A está incorreta. Incorreta a alternativa A, com ressalvas. O termo correto é "morte materna por complicação obstétrica direta", ou seja, faltou o "complicação obstétrica". Mesmo assim, a alternativa não está totalmente incorreta e por isso a questão era passível de anulação.

A letra B está incorreta. Incorreta a alternativa B, com ressalvas. O correto é "morte materna" por complicação obstétrica direta (veja que faltou especificar que a morte é materna), mas aqui cabem as mesmas observações feitas na alternativa A: a questão poderia ser anulada porque a alternativa não está totalmente incorreta.

A letra C está incorreta. Incorreta a alternativa C porque trata-se de morte materna, apesar de tardia.

A letra D está correta. Correta a alternativa D, sem ressalvas.

A letra E está incorreta. Incorreta a alternativa E porque esse termo não existe.

Paciente, 50 anos, procura atendimento em UBS próxima a sua residência com queixa de mal-estar e é acolhido pela equipe de enfermagem, sendo aferida pressão arterial de 160x100mmHg. Nesse caso, o médico da unidade deve

- A) realizar o atendimento, prescrever e solicitar exames e retorno para acompanhamento.
- B) solicitar que o paciente agende consulta após ter encaminhamento do pronto atendimento.
- C) realizar atendimento, encaminhá-lo ao cardiologista e orientar que o seguimento será no serviço secundário.
- D) realizar atendimento e medicar a situação atual, sem criar vínculo de seguimento.
- E) encaminhar o paciente ao serviço de urgência e emergência.

Solução

Gabarito: A) realizar o atendimento, prescrever e solicitar exames e retorno para acompanhamento.

GABARITO: ALTERNATIVA A

Estrategista,

O enunciado fala de um paciente com 50 anos que é acolhido em uma Unidade Básica de Saúde com queixa de mal-estar e pressão arterial de 160 x 100 mmHg. Observe que nada é dito sobre outros sinais e sintomas, bem como se o paciente apresenta alguma comorbidade como hipertensão arterial sistêmica (HAS). Portanto, precisamos raciocinar apenas com base no valor da pressão arterial (PA).

Nesse sentido, se levarmos em consideração apenas esse valor, precisaremos entender que o paciente **NÃO** está em uma crise hipertensiva verdadeira (isto é, urgência hipertensiva ou emergência hipertensiva), já que a PA aferida foi inferior a 180 x 120 mmHg. Corroborando isso, veja que não há qualquer descrição no enunciado que seja compatível com comprometimentos de órgão-alvo ou risco iminente de morte. Portanto, não há porque administrarmos anti-hipertensivos; e se assim o fizermos, poderemos causar alguma iatrogenia.

O segundo ponto fundamental é lembrarmos que o paciente está com "mal-estar". Portanto, essa sintomatologia pode ser a causa da PA elevada, representando uma **pseudocrise hipertensiva**. Nesse caso, a PA retornará ao normal assim que o mal-estar "passar". É o que acontece, por exemplo, quando aferimos a pressão arterial de um paciente com cefaleia ou outro quadro algico: a PA tende a estar "falsamente" elevada, normalizando assim que a dor cessa.

Por isso, o mais sensato para esse paciente é realizar o acolhimento, classificar o risco, realizar o atendimento, medicar o paciente com analgésicos ou outra medicação compatível com o mal-estar (por exemplo, se há enjoos, podem ser prescritos antieméticos), solicitar exames (se necessário) e agendar retorno. Pode-se deixar o paciente também em algum

ambiente calmo e tranquilo e aferir novamente a pressão cerca de 40 minutos ou 1 hora depois, justamente para demonstrar a diminuição da PA.

Portanto:

A letra A está correta. Correta a alternativa A, sem ressalvas.

A letra B está incorreta. Incorreta a alternativa B. A alternativa sugere que a consulta do paciente deve ser marcada apenas se ele apresentar o encaminhamento do pronto atendimento. Lembre-se de que a Atenção Primária à Saúde é a porta de entrada principal do SUS e o acesso deve ser garantido a todos os moradores da área de abrangência da UBS.

A letra C está incorreta. Incorreta a alternativa C. De fato, o paciente deve ser acompanhado até mesmo para saber se estamos diante de um hipertenso ainda não diagnosticado, mas justamente por não termos informações sobre o diagnóstico de HAS, não há porque encaminhá-lo para o cardiologista nesse momento. Lembre-se de que o diagnóstico da HAS pode ser feito na Atenção Primária à Saúde, assim como o acompanhamento quando não há complicações.

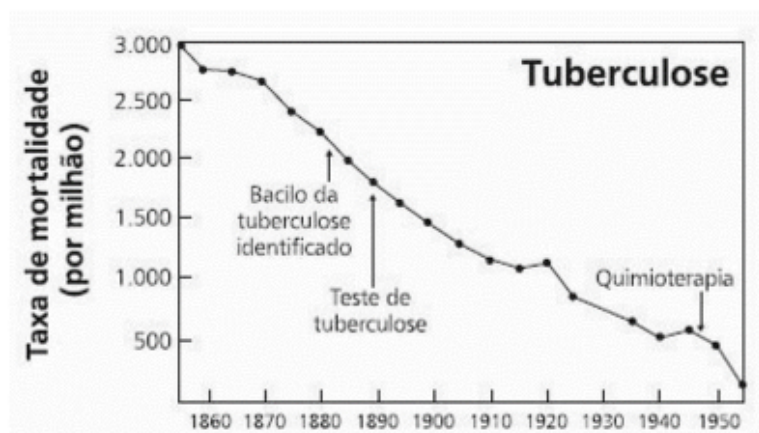
A letra D está incorreta. Incorreta a alternativa D. É justamente o oposto: deve-se criar vínculo para seguimento, justamente porque ele está na Atenção Primária à Saúde. Ainda, o acompanhamento longitudinal ajudará na compreensão se o mal-estar foi algo isolado ou se faz parte de um quadro clínico maior.

A letra E está incorreta. Incorreta a alternativa E. O enunciado não traz informações que sinalizem risco para o paciente, além de a pressão estar abaixo do ponto de corte para crises hipertensivas verdadeiras. Portanto, não há indicação de encaminhamento para uma unidade de urgência e emergência.

1.2 ENARE - 2024

Questão | | 2024 | 4000205733

O seguinte gráfico demonstra a redução da taxa de mortalidade da tuberculose ao longo do tempo, considerando estimativas traçadas desde 1860 até 1960:



Considerando esse gráfico, é correto afirmar que

- A)** A redução da mortalidade pela tuberculose se deve ao crescimento populacional, que diminuiu o número de pessoas expostas à doença.
- A redução da mortalidade pela tuberculose evidencia o impacto dos determinantes sociais da
- B)** saúde – sendo as melhorias nas condições de vida fundamentais na redução da mortalidade pela tuberculose.
- A redução da mortalidade representada nesse gráfico não é confiável, levando-se em conta a
- C)** temporalidade dos dados, visto que estes são de períodos em que não havia nenhum tipo de registro em saúde.
- A redução da mortalidade pela tuberculose se deve ao aumento do número de pessoas
- D)** globalmente expostas a micobactérias atípicas, o que diminuiu o número de pessoas expostas à doença.
- A redução da mortalidade pode ser explicada principalmente pelo surgimento da vacina BCG, que é a principal ferramenta para reduzir a mortalidade da tuberculose pulmonar.
- E)**

Solução

A redução da mortalidade pela tuberculose evidencia o impacto dos

Gabarito: B) determinantes sociais da saúde – sendo as melhorias nas condições de vida fundamentais na redução da mortalidade pela tuberculose.

GABARITO: ALTERNATIVA B

Estrategistas, questão bem interessante que envolve a história de uma das moléstias infecciosas mais prevalentes em nosso meio até os dias de hoje: a **TUBERCULOSE (TB)**.

Como sabemos, a TB é uma doença infectocontagiosa multissistêmica, que tem no *Mycobacterium tuberculosis* o seu agente etiológico. Essa condição é transmitida predominantemente pelas vias aéreas através de gotículas contendo o bacilo, eliminadas por indivíduos contaminados e capazes obviamente de exteriorizar o agente a partir de sua via respiratória (bacilíferos).

A TB possui um caráter endêmico em diversos países do mundo, incluindo o Brasil, e mostra uma importante determinação socioeconômica, já que encontramos essa endemicidade exatamente nos países mais pobres e mais populosos.

Isso ocorre porque a doença necessita de uma série de fatores para ser transmitida, se instalar e depois ser reativada. Entre esses fatores podemos incluir, as condições de acesso à saúde da população, as condições de moradia (aglomerações favorecem a transmissão da TB) e as condições nutricionais e alimentares, muito relacionadas ao estado imune dos indivíduos, o que possui ampla correlação com a manifestação dessa afecção.

Tendo por base essa linha de raciocínio, conseguimos observar de forma clara como a determinação social da saúde e os determinantes sociais da saúde influenciaram a mortalidade da tuberculose ao longo do tempo.

Se acompanharmos com atenção o gráfico trazido pela banca no enunciado da questão, veremos que muito antes da descoberta do agente etiológico da TB, bem como das formas de diagnosticar sua presença, o mundo já experimentava uma redução progressiva da mortalidade pela doença. Além disso, fica evidente que, embora tenha-se levado quase 80 anos após a descoberta do agente etiológico para que fosse desenvolvida a poliquimioterapia para tratar a condição, nesse interim a mortalidade por tuberculose continuou caindo.

O que isso nos indica?

Basicamente que todos os outros fatores não médicos envolvidos no adoecimento por tuberculose foram sendo aos poucos melhorados, reduzindo assim de forma drástica a mortalidade pela doença. Como exemplos já citados, podemos apontar a **MELHORIA NAS CONDIÇÕES DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO** como grandes responsáveis por esse declínio.

Portanto, conseguimos observar como o combate aos determinantes sociais de uma doença podem ser tão efetivos quanto um tratamento farmacológico na redução da mortalidade por ela.

Munidos desse raciocínio, vamos às alternativas.

A letra A está incorreta. **INCORRETA:** Muito pelo contrário! Quanto maior o crescimento populacional, maiores são as chances de exposição ao agente etiológico da tuberculose. Dessa maneira, não há porque crer nessa teoria: ela vai contra a história da tuberculose e contra seus mecanismos de transmissão conhecidos, que tem nas aglomerações e localidades populosas um solo fértil para a transmissão do *Mycobacterium tuberculosis*.

A letra B está correta. **CORRETA:** Perfeita a alternativa, já que ela vai de encontro exatamente ao que foi explicitado no texto do comentário introdutório. O principal responsável pela redução progressiva da mortalidade por TB foi exatamente o entendimento dos determinantes sociais dessa afecção e o seu consequente combate e melhora.

A letra C está incorreta. **INCORRETA:** Os registros médicos de doenças datam da antiguidade, vide os primórdios da medicina na Grécia Antiga. Portanto, se retornarmos alguns séculos atrás, em especial dois ou três, iremos observar que já tínhamos sistemas de registros de doenças relativamente confiáveis, não havendo porque crer que as informações apontadas no gráfico são inverídicas.

A letra D está incorreta. **INCORRETA:** As micobactérias atípicas não estão disseminadas à nível mundial e o contato com elas não confere imunidade específica ao *Mycobacterium tuberculosis*. Dessa maneira, essa correlação entre exposição à micobactérias atípicas e redução da mortalidade por tuberculose não encontra respaldo lógico.

A letra E está incorreta. **INCORRETA:** A vacina da BCG foi um marco importante no controle de ocorrência das formas graves de tuberculose e, por conseguinte, da mortalidade pela doença. Porém, não podemos atribuir o surgimento dessa vacina como principal fator incorrido na redução da mortalidade, afinal, ela não é capaz de evitar as formas pulmonares da doença, mas sim impedir casos graves, em especial a TB meningoencefálica, que representa uma pequena parcela das mortes por tuberculose. Dessa forma, temos em mente que foi a melhoria das condições socioeconômicas e dos outros determinantes sociais dessa condição os grandes responsáveis pela redução da mortalidade.

Questão | | 2024 | 4000205736

Uma das competências da Atenção Primária à Saúde (APS) é o cuidado da gestante de risco habitual de forma integral. Durante o ciclo gravídico, é natural e esperado que a mulher apresente ganho de peso. Sabe-se, no entanto, que o ganho de peso excessivo nesse período é prejudicial à saúde, aumentando o risco de diabetes mellitus gestacional. Em relação a esse tema, assinale a alternativa que apresenta o valor adequado de ganho de peso para uma mulher com IMC entre 25 e 30 durante toda a gestação.

- A) Entre 12,5 kg a 18,0 kg.
- B) Entre 5,0 kg a 9,0 kg.
- C) Entre 7,0 kg a 11,5 kg.
- D) Entre 5,0 kg a 10,0 kg.
- E) Entre 18,0 kg a 24,0 kg.

Solução

Gabarito: C) Entre 7,0 kg a 11,5 kg.

O que o examinador quer saber: sobre ganho de peso na gestação.

Estima-se o ganho de peso total para as gestantes até o fim da gestação, baseado no seu estado nutricional pré-gestacional ou no início do pré-natal. Para cada situação nutricional inicial (baixo peso, adequado, sobrepeso ou obesidade) há uma faixa de ganho de peso recomendada. Para o primeiro trimestre, o ganho foi agrupado para todo o período, enquanto no segundo e terceiro trimestre, o ganho é previsto por semana.

Observe que as gestantes deverão ter ganhos de peso distintos, de acordo com seu IMC inicial.

Gestantes de baixo peso deverão ganhar entre 12,5 e 18,0kg durante toda a gestação, sendo este ganho, em média, de 2,3kg no primeiro trimestre da gestação (até a 13ª semana) e de 0,5kg por semana no segundo e terceiro trimestres de gestação.

Gestantes com IMC adequado devem ganhar, até o fim da gestação, entre 11,5 e 16,0kg; aquelas com sobrepeso devem acumular entre 7 e 11,5kg; e as obesas devem apresentar ganho em torno de 7kg, com recomendação específica e diferente por trimestre.

IMC pré-gravídico		
IMC (kg/m ²)	Ganho de peso ideal durante a gestação	
	Semanal no 2º e 3º tri	TOTAL
< 18,5	500g/sem	12,5 a 18 kg
18,5 a 24,9	400g/sem	11,5 a 16 kg
25 a 29,9	300g/sem	7 a 11,5 kg
≥ 30	200g/sem	5 a 9 kg

A letra A está incorreta. Incorreta a alternativa A: para uma gestante com IMC entre 25 e 30, o ganho de peso durante toda a gestação deve ser entre 7 a 11,5 kg.

A letra B está incorreta. Incorreta a alternativa B: para uma gestante com IMC entre 25 e 30, o ganho de peso durante toda a gestação deve ser entre 7 a 11,5 kg.

A letra C está correta. Correta a alternativa C: para uma gestante com IMC entre 25 e 30, o ganho de peso durante toda a gestação deve ser entre 7 a 11,5 kg.

A letra D está incorreta. Incorreta a alternativa D: para uma gestante com IMC entre 25 e 30, o ganho de peso durante toda a gestação deve ser entre 7 a 11,5 kg.

A letra E está incorreta. Incorreta a alternativa E: para uma gestante com IMC entre 25 e 30, o ganho de peso durante toda a gestação deve ser entre 7 a 11,5 kg.

Questão | | 2024 | 4000205737

Um jovem de 25 anos, apresentou-se ao pronto-socorro com febre, mialgia, artralgia e rash com lesões maculopapulares. Refere que os sintomas começaram há 48h e que esteve em região de mata virgem no norte de Minas Gerais na semana que antecedeu o início dos sintomas, não tendo observado carrapatos em seu corpo nesse período de viagem. O jovem está vacinado adequadamente para febre amarela. Ao exame clínico, apresenta dados vitais normais e não apresenta sinais sugestivos de gravidade. A médica responsável pelo atendimento preocupou-se com a possibilidade de febre maculosa. Considerando essa possibilidade, qual seria a conduta mais adequada da profissional diante do aspecto clínico e considerando a notificação da febre maculosa como agravo?

- A) Solicitar sorologias, prescrever sintomáticos e notificar o município, pois trata-se de doença de notificação compulsória.
- B) Prescrever doxiciclina empírica e notificar o município, a secretaria estadual e o ministério da saúde, pois trata-se de doença de notificação compulsória.
- C) Solicitar sorologias, prescrever sintomáticos e notificar o município, a secretaria estadual e o ministério da saúde, pois trata-se de doença de notificação compulsória.

- D)** Prescrever doxiciclina empírica e notificar o município, pois trata-se de doença de notificação compulsória.
- E)** Prescrever doxiciclina empírica e notificar o município e a secretaria estadual, pois trata-se de doença de notificação compulsória.

Solução

Gabarito: B) Prescrever doxiciclina empírica e notificar o município, a secretaria estadual e o ministério da saúde, pois trata-se de doença de notificação compulsória.

GABARITO: ALTERNATIVA B

Estrategista,

O enunciado menciona um jovem de 25 anos que há 48 horas vem evoluindo com febre, mialgia, artralgia e rash com lesões maculopapulares. Em um primeiro momento, é possível pensar em um quadro clínico compatível com as arboviroses, que são endêmicas no nosso país. Mas ao prosseguirmos com a leitura, observa-se que o paciente viajou para um local de mata em Minas Gerais cerca de 1 semana antes, embora não tenha observado carrapatos em seu corpo no período da viagem. Portanto, o enunciado afirma que há a possibilidade de o quadro clínico ser compatível com febre maculosa.

Mas ele não observou carrapatos pelo corpo! Mesmo assim, devo considerar a febre maculosa como uma possibilidade?

Sim, sem dúvidas, uma vez que nem sempre o paciente “encontra” algum carrapato no corpo. Aliás, pode ser que a transmissão da doença tenha ocorrido por meio a partir dos estágios mais jovens do carrapato-estrela, como as ninfas, que são bem pequenas e podem não ser perceptíveis pelo paciente.

Nesse caso, a conduta mais adequada é iniciar a doxiciclina empiricamente (na suspeita de febre maculosa, é melhor tratar, uma vez que o atraso no tratamento pode prejudicar o paciente) e notificar de forma imediata (em até 24h) para os três entes federativos (isto é, para as vigilâncias municipal e estadual, e para o Ministério da Saúde).

- Mas é o médico quem notifica para esses três níveis?

Depende do município. Em algumas localidades, o médico notifica apenas para a Vigilância Municipal e ela se encarrega de consolidar os dados e transmiti-los para a Vigilância Estadual e Ministério da Saúde. Em outros locais, é possível que o médico tenha que comunicar aos 3 níveis.

Com essas informações em mente, vamos analisar a alternativa correta:

A letra A está incorreta. Incorretas as alternativas A e C porque é necessário iniciar a antibioticoterapia o quanto antes.

A letra B está correta. Correta a alternativa B, sem ressalvas.

A letra C está incorreta. Incorretas as alternativas A e C porque é necessário iniciar a antibioticoterapia o quanto antes.

A letra D está incorreta. Incorreta a alternativa D porque a assertiva menciona apenas a notificação municipal, quando é necessário que se notifique para os três níveis.

A letra E está incorreta. Incorreta a alternativa E porque a assertiva não menciona a notificação para o Ministério da Saúde.

Questão | | 2024 | 4000205738

A meningite é uma das doenças infectocontagiosas com maior letalidade entre crianças, sendo, portanto, questão de saúde pública. Sua incidência vem diminuindo desde os anos 2000 no Brasil, sendo que, dentro do calendário de imunização, há vacinas responsáveis pela redução da incidência da meningite em crianças. É importante salientar que, nos últimos 20 anos, um dos principais agentes etiológicos da meningite teve uma redução significativa devido aos esforços do programa nacional de imunização. Esse agente, além da meningite, provoca frequentemente infecções de vias aéreas. Nesse sentido, assinale a alternativa que apresenta a vacina que protege contra o agente etiológico citado.

- A)** Penta (DTP + Hib + HB).
- B)** Meningo C.
- C)** Meningo B.
- D)** DTPa.
- E)** BCG.

Solução

Gabarito: A) Penta (DTP + Hib + HB).

Olá, Estrategista.

A vacina contra *Haemophilus influenzae* tipo B (HiB) é inativada, constituída de cápsula polissacarídea da bactéria conjugada à proteína carreadora.

Ela previne contra infecções causadas pela bactéria, como meningite, pneumonia, amigdalite, artrite, pericardite, osteomielite entre outras. Antes da vacina, o *Haemophilus influenzae* era o principal causador dessas infecções em crianças menores de 5 anos.

Pelo PNI, é aplicada aos 2, 4 e 6 meses na vacina combinada pentavalente (DTP+ HiB + Hepatite B).

Devido à epidemiologia da doença, deve ser aplicada em todas as crianças até 5 anos, porém pacientes com risco aumentado de infecção, como imunodeprimidos, pacientes com asplenia, transplantados, em quimioterapia ou doenças crônicas e não vacinados, devem receber a vacina em qualquer idade.

O examinador quer saber de um agente etiológico que diminui a incidência de meningites após a vacinação, nos últimos 20 anos. Além disso, diz que provoca IVAS. A vacina é essa mesmo citada acima: contra H. influenzae B.

A letra A está correta. Correto. A DTP é aplicada aos 2, 4 e 6 meses e protege contra difteria, tétano, coqueluche, hepatite B e H. influenzae B.

A letra B está incorreta. Incorreto, pois, além de ter entrado no PNI mais recentemente (2010), o meningococo não causa IVAS.

A letra C está incorreta. Incorreto, pois além de não causar IVAS, não é uma vacina disponibilizada no PNI.

A letra D está incorreta. A DTPa protege contra difteria, tétano e coqueluche.

A letra E está incorreta. A BCG protege contra formas graves de tuberculose, meningoencefalite e miliar. Não é um agente causador de IVAS.

Questão | | 2024 | 4000205739

Entre os anos de 2015 a 2017, houve Emergência em Saúde Pública devido ao aumento na ocorrência de nascidos vivos com microcefalia no Brasil associada à epidemia do vírus Zika, época em que foram registrados 4.595 nascidos vivos com essa malformação congênita. A partir desse episódio, foi possível confirmar a associação entre o vírus Zika e a microcefalia. Assinale a alternativa que define corretamente a microcefalia grave.

- A)** Recém-nascidos com perímetro cefálico inferior a 3 desvios-padrão, ou seja, mais de 3 desvios-padrão abaixo da média para idade gestacional e sexo.
- B)** Recém-nascidos com perímetro cefálico inferior a 2 desvios-padrão, ou seja, mais de 2 desvios-padrão abaixo da média para idade gestacional e sexo.
- C)** Recém-nascidos com perímetro cefálico inferior a 1 desvio-padrão, ou seja, 1 desvio-padrão abaixo da média para idade gestacional e sexo.
- D)** Recém-nascidos com perímetro cefálico superior a 3 desvios-padrão, ou seja, mais de 3 desvios-padrão acima da média para idade gestacional e sexo.
- E)** Recém-nascidos com perímetro cefálico superior a 2 desvios-padrão, ou seja, mais de 2 desvios-padrão acima da média para idade gestacional e sexo.

Solução

Gabarito: A) Recém-nascidos com perímetro cefálico inferior a 3 desvios-padrão, ou seja, mais de 3 desvios-padrão abaixo da média para idade gestacional e sexo.

Olá, Estrategista, questão conceitual.

A microcefalia é uma anomalia congênita caracterizada pela redução do perímetro cefálico. A Organização Mundial da Saúde (OMS) define a microcefalia com base nos seguintes critérios: **Microcefalia: recém-nascidos com perímetro cefálico inferior a 2 desvios-padrão, ou seja, mais de 2 desvios-padrão abaixo da média para idade gestacional e sexo;** **Microcefalia grave: recém-nascidos com perímetro cefálico inferior a 3 desvios-padrão, ou seja, mais de 3 desvios-padrão abaixo da média para idade gestacional e sexo.**

A letra A está correta. Correta.

A letra B está incorreta. Esse é o conceito de microcefalia sem ser grave.

A letra C está incorreta. Aqui, o perímetro cefálico é considerado normal.

A letra D está incorreta. Aqui, temos uma macrocefalia, não há distinção de gravidade nessa classificação.

A letra E está incorreta. Aqui, temos uma macrocefalia.

Questão | | 2024 | 4000205740

Diabetes Mellitus (DM) é uma das doenças crônicas não transmissíveis mais importantes do mundo, sendo o conhecimento a seu respeito fundamental para o médico e para outros profissionais da saúde. Em relação à fisiopatologia da DM tipo 2, assinale a alternativa correta.

- A)** A DM tipo 2 tem componente genético pouco significativo, sendo uma doença exclusivamente relacionada ao estilo de vida.
- B)** As alterações metabólicas da DM tipo 2 geram inflamação sistêmica de alto grau, com frequentes alterações em marcadores laboratoriais de inflamação, como ferritina.
- C)** A resistência à ação da insulina por tecidos sensíveis a esta leva a uma redução no consumo da glicose sérica e a um aumento na produção hepática de glicose.
- D)** A perda gradual de produção de insulina secundária leva à destruição das células beta do pâncreas por processo autoimune característico da DM tipo 2.
- E)** Como resultado da resistência insulínica, há aumento da presença de ácidos graxos livres séricos levando à redução nos níveis de HDL, LDL e VLDL.

Solução

Gabarito: C) A resistência à ação da insulina por tecidos sensíveis a esta leva a uma redução no consumo da glicose sérica e a um aumento na produção hepática de glicose.

O Diabetes Mellitus tipo 2 (DM2) corresponde a 90 a 95% de todos os casos de diabetes e sua etiologia envolve fatores genéticos e ambientais. É uma doença poligênica, de forte caráter familiar, cuja prevalência aumenta a partir da quarta década de vida, a despeito de ser cada vez mais comum o diagnóstico na infância e adolescência (devido à epidemia atual de obesidade infantil). Segundo a Diretriz da Sociedade Brasileira de Diabetes, os fatores de risco para DM2 são:

- História familiar da doença
- Avançar da idade
- Obesidade
- Sedentarismo
- Diagnóstico prévio de pré-diabetes ou diabetes mellitus gestacional
- Presença de componentes da síndrome metabólica, tais como hipertensão arterial e dislipidemia.

Vamos analisar item por item:

A letra A está incorreta. Percebam que História Familiar positiva entra como fator de risco no diabetes tipo 2, e mais de 75% dos pacientes apresenta algum parente acometido. Inclusive, **o fator genético é mais importante no diabetes tipo 2 do que no diabetes tipo 1!** Fique atento à essa informação pois é uma típica pegadinha de prova.

A letra B está incorreta. A ferritina é uma proteína de fase aguda e níveis aumentados podem se correlacionar com inflamação. Porém, a presença isolada de diabetes tipo 2, sem outros fatores de risco e com bom controle glicêmico, não costuma cursar com aumento importante da ferritina. Em pacientes que além do diabetes apresentam também sobrepeso ou obesidade, aumento da circunferência abdominal, hipertensão e/ou dislipidemia (ou seja, compontes da síndrome metabólica), têm maior chance de apresentar hiperferritinemia.

A letra C está correta. Alternativa correta. A insulina atua aumentando a captação periférica de glicose e bloqueando a gliconeogênese e a glicogenólise hepática. Em estados de resistência à ação da insulina há uma diminuição da captação de glicose periférica e um aumento da produção hepática de glicose.

A letra D está incorreta. A resistência à insulina leva ao hiperestímulo de secreção de insulina, com o progressivo “esgotamento” das células beta pancreáticas. Ao diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2, estima-se que o indivíduo tenha perdido cerca de 50% da massa de células beta. A destruição das células beta não ocorre pro processo autoimune, sendo essa uma característica do diabetes tipo 1.

A letra E está incorreta. O perfil metabólico da dislipidemia da resistência à insulínica se caracteriza por: aumento dos ácidos graxos livres, aumento do VLDL e dos Triglicerídeos, Redução do HDL e LDL pequena e densa.

Questão | | 2024 | 4000205741

Um surto de casos de hepatite A foi identificado nas populações de 3 estados brasileiros em 2022. Esses casos ocorreram no período de abril a junho e um grupo de epidemiologistas foi chamado para identificar a fonte da contaminação, tendo sido observado que 52 casos ocorreram nessa janela de tempo; foi, então, selecionado um grupo controle de 104 pacientes para comparação com os pacientes que desenvolveram hepatite A. Após entrevistas e coletas de dados, observou-se que 97% dos pacientes que desenvolveram hepatite A nesse período havia consumido água engarrafada da mesma fonte, enquanto apenas 10% dos controles haviam consumido a água engarrafada dessa fonte. A metodologia de estudo realizada para a investigação desse surto foi

- A) Estudo Transversal.
- B) Estudo Coorte.
- C) Ensaio Clínico Randomizado.
- D) Estudo Ecológico.
- E) Estudo de Caso-controle.

Solução

Gabarito: E) Estudo de Caso-controle.

GABARITO: ALTERNATIVA E

Observe que um surto de hepatite A foi identificado no Brasil no período entre abril e junho de 2022. Um grupo de epidemiologistas, ao investigar o fenômeno, observou que 52 casos ocorreram nessa janela de tempo. A partir disso, foi selecionado um grupo controle de 104 pacientes para comparação com aqueles que desenvolveram hepatite A.

Ora, observe que primeiro os pesquisadores selecionaram os casos e só então parearam 2 controles para cada caso (por isso, temos 104 controles).

Quando a divisão de grupos inicia pela seleção de casos, prosseguindo para os controles (isto é, divisão entre aqueles que apresentam ou não o desfecho), temos o famoso estudo de caso-controle.

Esse tipo de desenho epidemiológico é o ideal para investigar surtos e epidemias, justamente porque o desfecho já ocorreu quando os pesquisadores chegam na comunidade e, a partir dos casos, é possível encontrar o fator comum de exposição.

Ainda, lembre-se de que os estudos de caso-controle utilizam dados individuais, são longitudinais e observacionais.

Portanto:

A letra A está incorreta. Incorreta a alternativa A. O estudo transversal é aquele em que a população é avaliada em um único momento de uma linha do tempo. Justamente por isso, há a necessidade de aferir o desfecho e a exposição naquele único momento. No estudo descrito pelo enunciado, os indivíduos com hepatite A foram identificados e a exposição foi buscada no passado. Portanto, primeiro houve a exposição e, a partir dela, desenvolveu-se o desfecho. Logo, estamos diante de um estudo longitudinal.

A letra B está incorreta. Incorreta a alternativa B. A principal diferença entre os estudos de coorte e os de caso-controle é a forma de divisão dos participantes. Os estudos de coorte dividem os participantes pela presença ou ausência da exposição (isto é, expostos e não expostos). Já os estudos de caso-controle dividem segundo a presença ou ausência do desfecho (casos e controles). Como os indivíduos foram divididos segundo o desfecho, trata-se de um caso-controle.

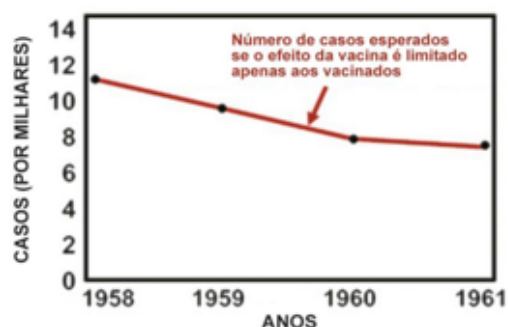
A letra C está incorreta. Incorreta a alternativa C. Os ensaios clínicos são estudos experimentais, onde o pesquisador fornece a exposição para uma parte dos participantes. Nesse caso, não seria ético fornecer água com vírus da hepatite A para os indivíduos. Ademais, é um estudo que parte do desfecho justamente para descobrir a fonte de exposição. Portanto, não é um estudo experimental e sim observacional.

A letra D está incorreta. Incorreta a alternativa D. Os estudos ecológicos são desenhos que utilizam dados agregados. Inclusive uma forma de reconhecê-los se dá pelo fato de que muitos comparam unidades territoriais entre si (por exemplo, comparação de 10 municípios de São Paulo entre si quanto à poluição atmosférica e taxas de internação hospitalar por doenças respiratórias). Observe que o estudo trazido pelo enunciado acompanhou os 52 casos. Logo, cada um deles era conhecido, o que evidencia que os dados utilizados forma individuais.

A letra E está correta. Correta a alternativa E, sem ressalvas.

Questão | | 2024 | 4000205742

A imagem a seguir foi publicada em um artigo de 1961, no jornal Americano de Saúde Pública.



A



B

Nesse estudo histórico, usando a vacina inativada da pólio foi observado um efeito protetor da vacinação além do efeito previsto. Esse efeito é conhecido como

- A) imunidade secundária.
- B) vacinação secundária.
- C) imunidade de rebanho.
- D) prevenção primária.
- E) prevenção secundária.

Solução

Gabarito: C) imunidade de rebanho.

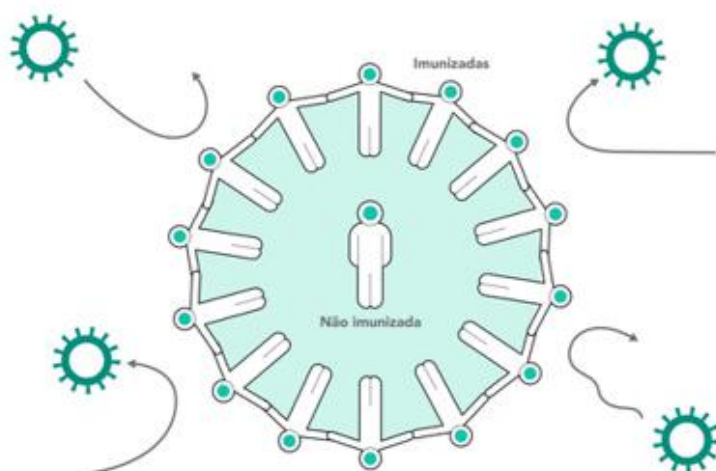
Olá, Estrategista, o que o gráfico nos mostra:

No primeiro, temos a queda esperada no número de casos após o início da vacinação contra pólio.

No segundo, que houve menos casos do que os esperados de pólio após o início da vacinação.

O examinador quer saber por que isso ocorreu, foi pela imunidade de rebanho.

A imunidade de rebanho ocorre quando pessoas não vacinadas para determinada doença são protegidas para tal. Isso ocorre pois quem está imunizado não se infecta e não propaga a doença para os não vacinados.



A letra A está incorreta. Imunidade secundária é quando a pessoa está protegida para determinada doença (por infecção prévia ou por vacina) e se expõe novamente ao agente (por vacinação de reforço ou pela própria doença).

A letra B está incorreta. Vacinação secundária são as doses de reforço aplicadas após o esquema primário de vacinação.

A letra C está correta. Correto.

A letra D está incorreta. Prevenção primária é a ação tomada para remover causas e fatores de risco de um problema de saúde individual ou populacional antes do desenvolvimento de uma condição clínica. Inclui promoção da saúde e proteção específica (ex.: imunização, orientação de atividade física para diminuir chance de desenvolvimento de obesidade).

A letra E está incorreta. b) Prevenção secundária é a ação realizada para detectar um problema de saúde em estágio inicial, muitas vezes em estágio subclínico, no indivíduo ou na população, facilitando o diagnóstico definitivo, o tratamento e reduzindo ou prevenindo sua disseminação e os efeitos de longo prazo (ex.: rastreamento, diagnóstico precoce).

Questão | | 2024 | 4000205743

Uma mulher de 35 anos, PCD (paralisia dos membros inferiores após trauma), com quadro depressivo, compulsão alimentar e insuficiência familiar, mora com a mãe, que tem 70 anos e está apresentando alguns sinais de demência em fase inicial. O médico de família está apreensivo na reunião de equipe, preocupado com a filha PCD, pois esta tem dores crônicas e responde mal às intervenções médicas propostas (analgesia e antidepressivos). Durante a reunião de equipe, estão presentes os ACSs (Agentes Comunitários de Saúde), bem como profissionais de psicologia, nutrição e fisioterapia. Diante dessas informações, assinale a alternativa que melhor apresenta uma intervenção multiprofissional e interdisciplinar.

- A)** O médico de família orienta a equipe sobre o que pode ou não ser feito dentro da realidade da filha, enquanto os outros profissionais traçam intervenções com base nessa orientação.
- O médico de família compartilha seu conhecimento do caso, buscando possíveis redes de
- B)** apoio na comunidade com os ACSs e também traçar um projeto terapêutico singular, cooperando com a nutrição e psicologia.
- O médico de família encaminha o caso durante a reunião para que atendimentos de
- C)** psicologia e nutrição sejam realizados – enfatizando a urgência do caso e orientando ao ACS para levar os encaminhamentos à casa do paciente.
- O médico de família compreende que, devido aos determinantes sociais desse caso, não há
- D)** intervenções possíveis pela equipe complementar.
- O médico de família compreende que, devido ao quadro familiar, o principal objetivo deve
- E)** ser cuidar da mãe, sugerindo sua institucionalização precoce, pois essa intervenção está alinhada com a Política Nacional de Atenção Básica (PNAB).

Solução

O médico de família compartilha seu conhecimento do caso, buscando possíveis

Gabarito: B) redes de apoio na comunidade com os ACSs e também traçar um projeto terapêutico singular, cooperando com a nutrição e psicologia.

GABARITO: ALTERNATIVA B

Estrategista,

O objetivo dessa questão foi avaliar o candidato quanto aos conceitos de intervenção multidisciplinar e intervenção interdisciplinar. Acompanhe a seguir:

- intervenção multidisciplinar – nesse tipo de intervenção, as diferentes categorias profissionais (nutrição, fisioterapia, enfermagem, medicina...) abordarão o problema sob a ótica de cada um, sem que haja integração entre elas. É aquele paciente que é acompanhado por uma equipe multidisciplinar, mas não necessariamente as condutas de cada profissional estão integradas entre si.

- intervenção interdisciplinar – já nesse tipo de intervenção, as diferentes categorias se unem em prol de um objetivo em comum, integrando as condutas. É o que acontece, por exemplo, no Projeto Terapêutico Singular, em que toda a equipe pactua os objetivos e metas do tratamento de forma conjunta com o paciente.

Diante dessas informações, vamos procurar a alternativa que melhor descreve uma intervenção multiprofissional e uma interdisciplinar, conforme as definições acima:

A letra A está incorreta. Incorreta a alternativa A. Essa assertiva demonstra apenas uma intervenção multiprofissional (já que cada profissional traça a sua própria intervenção) e ainda por cima centrada no médico (já que as intervenções são feitas conforme a orientação geral dada por ele). O processo de trabalho não deve ser centrado no médico. Esse processo de

trabalho “vertical” (onde o médico está acima dos demais profissionais) não tem razão de ser e não deve ser perpetuada. Atualmente, valoriza-se cada categoria profissional, cada um com seus saberes, em uma prática horizontal (isto é, ombro a ombro).

A letra B está correta. Correta a alternativa B. Ao buscar possíveis redes de apoio com os ACS, estamos vendo uma intervenção multiprofissional, uma vez que o médico traça sua conduta sozinho a partir do que ele conhece do caso. E ao traçar um projeto terapêutico singular cooperando com a nutrição e a psicologia, temos a integração de diversas áreas traçando uma conduta em comum. Portanto, trata-se de intervenção interdisciplinar.

A letra C está incorreta. Incorreta a alternativa C. Se o médico de família encaminha o caso para que a psicologia e a nutrição realizem atendimentos, então estamos diante de uma intervenção multiprofissional, onde cada profissional tomará as suas condutas diante do caso, sem que haja necessariamente integração entre eles.

A letra D está incorreta. Incorreta a alternativa D. A assertiva quer dizer que se a situação envolve determinantes sociais, então não há o que ser feito para melhorar a saúde da paciente. É justamente o contrário. O conhecimento desses determinantes permite uma melhor abordagem por parte da equipe.

A letra E está incorreta. Incorreta a alternativa E. A assertiva sugere que deve-se afastar a mãe do seio familiar, institucionalizando-a devido a um quadro de demência que sequer foi confirmado. Ademais, mesmo que a paciente receba esse diagnóstico, ela tem autonomia para decidir o que gostaria que fosse feito. Para finalizar, é um equívoco pensar em institucionalização para idosos por apresentarem demência ou doenças psiquiátricas, por exemplo.

Questão | | 2024 | 4000205744

Um jovem de 25 anos comparece à UBS com quadro de tosse há cerca de 3 semanas, com relato de dispneia progressiva. Ele vive com HIV (PVHIV), porém abandonou o tratamento há cerca de dois anos. Ao exame clínico, não há alterações na ausculta respiratória, porém ele apresenta uma FR de 26 irpm e uma Sat O₂ em ar ambiente de 93%, também apresenta febre de 38,2°C ao exame clínico. Considerando o agente etiológico mais provável nesse paciente, qual é o achado radiológico esperado na radiografia de tórax?

- A)** Opacidade irregular em ápice direito.
- B)** Opacidade multilobular com níveis hidroaéreos.
- C)** Infiltrado intersticial peri-hilar.
- D)** Opacidade peri-hilar em vidro fosco.
- E)** Inversão da trama vascular.

Solução

Gabarito: C) Infiltrado intersticial peri-hilar.

Gabarito oficial: alternativa D.

Gabarito Estratégia Med: alternativa C.

A pneumocistose é uma das principais infecções oportunistas que acometem o paciente portador de aids. Causada pelo fungo *Pneumocystis jirovecii*, manifesta-se geralmente quando a contagem de linfócitos T CD4+ está abaixo de 200 células/ μ L. É uma doença subaguda que causa tosse não produtiva, febre e dispneia progressiva. Portanto, os achados descritos no enunciado favorecem essa hipótese diagnóstica.

A letra A está incorreta. Incorreta a alternativa A. Opacidade irregular em ápice direito não é um achado típico de pneumocistose. Essa alteração é mais sugestiva de tuberculose pulmonar.

A letra B está incorreta. Incorreta a alternativa B. Opacidade multilobular com níveis hidroaéreos é um achado esperado em abscesso pulmonar.

A letra C está correta.

Correta a alternativa C. O gabarito informado descreve a alternativa D como correta. No entanto, o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para Manejo da Infecção pelo HIV em Adultos do Ministério da Saúde traz a seguinte informação sobre a pneumocistose, doença que apresenta as características descritas no enunciado: “o achado radiográfico mais típico de PCP é o infiltrado intersticial peri-hilar e simétrico. Pneumatocelos e pneumotórax também podem ser observados. Ressalta-se que o Rx de tórax pode ser normal em até um quarto dos casos de PCP; nessa situação, a TC pode revelar atenuação pulmonar em vidro fosco.”

Note que essa alternativa contém a descrição correta da alteração típica radiográfica na pneumocistose.

A letra D está incorreta. Incorreta a alternativa D. Apesar de apontada como correta pela banca, opacidade peri-hilar em vidro fosco seria o achado esperado em exame de tomografia computadorizada, e não em radiografia de tórax.

A letra E está incorreta. Incorreta a alternativa E. Inversão da trama vascular é um achado comum em insuficiência cardíaca.

Questão | | 2024 | 4000205751

Durante uma consulta de rotina, observa-se que um menino de 4 anos está com cartão vacinal incompleto. Ele compareceu à consulta acompanhado de sua mãe, que relata para o profissional que tem medo de vacinar o filho, pois frequentemente vê na mídia ou em grupos de mensagens que as vacinas podem causar autismo. Ela mesma não se vacina há mais de 10

anos. Diante dessa mãe – que tem um comportamento denominado hesitação vacinal – qual deve ser a postura do profissional de saúde?

- A)** O profissional de saúde deve recomendar de forma cautelosa a vacinação, para não gerar atrito na comunicação com o paciente.

Abordagens diretas, como dizer ao paciente que seus filhos estão com vacinação atrasada, ao

- B)** invés de questionar sobre os motivos do atraso, resultam em melhores resultados, principalmente entre pessoas que recusam a vacinação de forma direta.

- C)** É fundamental que os profissionais de saúde exponham aos pacientes hesitosos que a vacinação tem riscos, mas que seus benefícios os superam em muitas ordens de grandeza.

É adequado substituir o profissional de saúde que realiza o atendimento, uma vez que o

- D)** paciente tenha demonstrado recusa para vacinas diante daquele profissional, mesmo que o paciente aceite informações sobre a vacinação.

- E)** Uma comunicação padronizada para todos os pacientes apresenta melhores resultados para adesão a vacinas do que a comunicação ajustada para cada grupo de pacientes.

Solução

É fundamental que os profissionais de saúde exponham aos pacientes hesitosos

- Gabarito: C)** que a vacinação tem riscos, mas que seus benefícios os superam em muitas ordens de grandeza.

GABARITO: ALTERNATIVA C

Estrategistas, questão interessante e que cobra conhecimentos básicos de interpretação de texto, bioética e comunicação médica.

Na situação em tela, temos uma mãe que optou por não vacinar seu filho em razão de informações obtidas na mídia e em grupos de mensagens que se posicionam contra a vacinação, além de apontarem possíveis malefícios das vacinas. Isso obviamente gerou grande medo e desconfiança na mulher que, inclusive, também não se vacina há cerca de 10 anos. Todo esse contexto foi denominado de "hesitação vacinal".

Em linhas gerais, o que o profissional de saúde deverá fazer aqui é desconstruir todo o efeito gerado pela desinformação acerca das vacinas no ideário dessa mãe.

Como o profissional fará isso?

Em primeiro lugar, deve ficar claro que a exposição de evidências científicas e a explicação baseada no modelo biomédico muito provavelmente não surtirão efeito em um primeiro momento. Logo, o profissional de saúde deve "descer do salto" e aplicar os preceitos chave da medicina centrada na pessoa.

Assim, primeiramente, é necessário entender a fundo os reais motivos que afastam essa mulher das vacinas. Logo, a aplicação do método clínico centrado na pessoa, em especial de

seu primeiro e segundo componentes será de suma importância. Através deles entenderemos quais são os sentimentos, expectativas e ideias da mãe, bem como iremos compreendê-la como um todo e iniciar o processo de criação de vínculo.

A partir daí, o profissional de saúde poderá iniciar uma relação de conversa aberta com a mulher, onde tentará sempre de forma clara e com linguagem acessível, explicar os benefícios da vacinação e os potenciais riscos dela.

Após essa conversa esclarecida e tendo por base o respeito à autonomia do paciente, bem como ao compartilhamento de decisões, uma conduta poderá ser tomada.

Deve ficar claro que, nesse primeiro momento, a despeito de uma conversa bem sucedida, a mulher pode permanecer resistente e se negar a vacinar o filho. Isso não deve ser encarado pelo profissional de saúde como uma falha ou irrupção na relação, mas sim como uma negativa inicial. Logo, o profissional deve ser insistente no estabelecimento de vínculo, ofertar mais informações acessíveis para que a paciente possa ponderar em casa e agendar um retorno breve para mais conversa.

Outro ponto fundamental é tentar evitar conflitos logo nessa primeira abordagem, como ameaças de denúncia ao Conselho Tutelar, que podem afugentar mãe e filho e quebrar completamente o vínculo com a paciente, não resultando assim em uma resolução efetiva do problema.

Com esse ideário em mente, vamos às alternativas.

A letra A está incorreta. **INCORRETA:** O profissional deve deixar clara a importância da vacinação, recomendando-a como uma forma de reforçar o argumento de sua necessidade. Porém, o compartilhamento de decisão é fundamental, em respeito à autonomia do representante legal, que nesse caso é a mãe.

Deve ficar claro que recomendações muito cautelosas podem dar a impressão de que não se tem certeza sobre a necessidade da conduta, o que pode reforçar o comportamento de hesitação vacinal na situação em tela.

A letra B está incorreta. **INCORRETA:** Diante da negativa acerca da vacinação, a única forma de compreendermos o motivo disso é entendendo o indivíduo em todas as suas dimensões e descobrindo qual é o verdadeiro problema por trás das negativas em vacinar-se e vacinar seu filho. Logo, é a partir dessa compreensão mais aprofundada que o problema apresentado poderá ser efetivamente resolvido.

A letra C está correta. **CORRETA:** Conforme apontado no texto do comentário introdutório. Por meio de linguagem clara e acessível, os profissionais de saúde devem abordar os pacientes hesitosos e "colocar na mesa" todas as informações relacionadas às vacinas, incluindo seus riscos. Dessa forma, abrimos um campo para diálogo transparente e cujo conteúdo está completamente exposto ao sujeito, que passa agora a poder decidir de forma mais esclarecida.

A letra D está incorreta. **INCORRETA:** Diante de casos como esse, como bem reforçado no comentário introdutório, faz-se necessária a criação de vínculos. É através dessa vinculação a um

profissional de referência que o comportamento de hesitação vacinal pode ser superado.

A letra E está incorreta. **INCORRETA:** É exatamente o contrário! Cada caso é um caso e, tendo por base a medicina centrada na pessoa, é de suma importância que a comunicação seja ajustada de acordo com o contexto. Usar uma comunicação padronizada pode não trazer benefício algum para o caso, já que não leva em consideração as especificidades dos envolvidos.

Questão | | 2024 | 4000205752

A boa prática médica está associada à promoção da saúde, além de práticas terapêuticas e diagnósticas. A atividade física vem se tornando o centro da promoção à saúde em decorrência de seus inúmeros benefícios de curto, médio e longo prazo. Assinale a alternativa que apresenta a quantidade recomendada de atividade física para pessoas entre 6 e 17 anos.

- A)** Realização de atividade física variada, envolvendo atividades lúdicas e recreativas.
- B)** Realização de 60 minutos de atividades físicas moderadas a vigorosas por dia, sendo estas adequadas para cada idade.
- C)** Realização, no máximo, de 150 minutos por semana de atividades físicas vigorosas, devido ao risco de acidentes.
- D)** Realização de 40 minutos de atividades físicas de reforço muscular por dia, sendo estas adequadas para cada idade.
- E)** Realização de 60 minutos de atividades físicas moderadas a vigorosas, no máximo 3x por semana devido ao risco de lesões.

Solução

Gabarito: B) Realização de 60 minutos de atividades físicas moderadas a vigorosas por dia, sendo estas adequadas para cada idade.

GABARITO: ALTERNATIVA B

Referência Bibliográfica:

1. Diretrizes da OMS para atividade física e comportamento sedentário: num piscar de olhos [WHO guidelines on physical activity and sedentary behavior: at a glance].

Disponível:

https://ws.santabarbara.sp.gov.br/instar/esportes/downloads/guia_AF_OMS.pdf.

Estrategistas, aqui estamos diante de uma questão mais teórica e "decoreba" que foi solicitada na prova do ENARE.

Para acertá-la, deveríamos ter em mente algumas das recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS) acerca da prática de atividades físicas.

Vamos juntos compreender quais são essas recomendações feitas por esse órgão!

Observe que a OMS estratifica as recomendações de acordo com a faixa etária.

Crianças e adolescentes entre 5 e 17 anos: "Crianças e adolescentes devem fazer pelo menos uma média de 60 minutos por dia de atividade física de moderada a vigorosa intensidade, ao longo da semana, a maior parte dessa atividade física deve ser aeróbica (em pelo menos 3 dias da semana)".

Adultos de 18 a 64 anos: "Adultos devem realizar pelo menos 150 a 300 minutos de atividade física aeróbica de moderada intensidade ao longo da semana; ou pelo menos 75 a 150 minutos de atividade física aeróbica de vigorosa intensidade ao longo da semana; ou uma combinação equivalente de atividade física de moderada e vigorosa intensidade ao longo da semana para benefícios substanciais à saúde."

Idosos (pessoas com 65 anos ou mais): "Idosos devem realizar pelo menos 150 a 300 minutos de atividade física aeróbica de moderada intensidade ao longo da semana; ou pelo menos 75 a 150 minutos de atividade física aeróbica de vigorosa intensidade ao longo da semana; ou uma combinação equivalente de atividades físicas de moderada e vigorosa intensidade ao longo da semana para benefícios substanciais à saúde".

Mulheres grávidas e no pós-parto: "Fazer pelo menos 150 minutos de atividade física aeróbica de moderada intensidade ao longo da semana para benefícios substanciais à saúde".

Com essas recomendações em mente, vamos às alternativas, com a atenção de observar que a banca solicita a recomendação para crianças e adolescentes.

A letra A está incorreta. **INCORRETA:** Já que não é essa a recomendação da OMS para essa faixa etária. Não observamos o apontamento de "atividades físicas variadas" no documento oficial.

A letra B está correta. **CORRETA:** Conforme observado no texto do comentário introdutório da questão. Essa é a recomendação da OMS para essa faixa etária!

A letra C está incorreta. **INCORRETA:** Ao recomendar uma meta diária de 60 minutos, a OMS coloca como sendo de 420 minutos semanais de atividades físicas de moderada a vigorosa intensidade, a quantidade mínima de exercícios a serem praticadas por crianças e adolescentes.

A letra D está incorreta. **INCORRETA:** Já que a recomendação fala em 60 minutos diários. Além disso, não está apontado que essas atividades devam ser de reforço muscular.

A letra E está incorreta. **INCORRETA:** Pois a OMS recomenda esse tipo de atividade **TODOS OS DIAS** para crianças e adolescentes.

Uma criança de 4 anos é levada pelos pais à UBS após queda da própria altura enquanto brincava com os primos. Ao examiná-la, o médico observa um pequeno corte no queixo e, após limpeza da lesão e exame clínico, determina a necessidade de sutura. Sabendo que a criança pesa cerca de 15 kg, assinale a conduta adequada para a preparação desse procedimento.

- A)** Deve-se utilizar fio de náilon 5-0 e preparar lidocaína com vasoconstritor a 1% para anestesia. Deve-se, ainda, solicitar uma ou duas pessoas para auxiliar na segurança da sutura.
- B)** Deve-se utilizar fio de náilon 3-0 e preparar lidocaína com vasoconstritor a 1% para anestesia. Deve-se, ainda, solicitar uma ou duas pessoas para auxiliar na segurança da sutura.

Deve-se utilizar fio de náilon 3-0 e orientar os pais sobre o risco da anestesia,
- C)** contraindicando o uso de anestésicos injetáveis. Deve-se, ainda, solicitar uma ou duas pessoas para auxiliar na segurança da sutura.
- D)** Deve-se utilizar fio de náilon 3-0 e preparar lidocaína sem vasoconstritor a 1% para anestesia. Deve-se, ainda, solicitar uma ou duas pessoas para auxiliar na segurança da sutura.
- E)** Deve-se utilizar fio de náilon 5-0 e preparar lidocaína sem vasoconstritor a 1% para anestesia. Deve-se, ainda, solicitar uma ou duas pessoas para auxiliar na segurança da sutura.

Solução

Deve-se utilizar fio de náilon 5-0 e preparar lidocaína com vasoconstritor a 1%

Gabarito: A) para anestesia. Deve-se, ainda, solicitar uma ou duas pessoas para auxiliar na segurança da sutura.

Temos uma criança com uma ferida contusa no mento, com indicação de sutura.

Sempre que houver uma criança, principalmente as menores, com necessidade de sutura, ou algum outro procedimento à beira do leito, com anestesia local, é aconselhável ter uma ou duas pessoas para auxiliar na segurança do procedimento.

Vamos analisar as alternativas:

A letra A está correta. Esta alternativa está correta e foi o gabarito oficial liberado pela banca. O fio 5-0 é fino, indicado para suturas em face, com melhor resultado estético. A lidocaína a ser utilizada pode ser com ou sem vaso constritor.

A letra B está incorreta. O fio deve ser o de menor calibre possível para obter resultado estético adequado.

A letra C está incorreta. O fio deve ser o de menor calibre possível para obter resultado estético adequado. E não está contraindicado o uso de anestésicos locais, só se atentar ao limite da dose

a ser utilizado. Veja na tabela abaixo:

Anestésico local	pKa	Aplicação clínica	Latência	Ligação proteica (%)	Duração (h)	Dose tóxica
Lidocaína	7.9	Bloq. Perif.	Rápida	65	1 – 3	4,5 mg/kg 7 mg/kg (c/epi)
		Raqui.	Rápida		0,5 – 1	
		Peridural	Rápida		1 – 2	
Bupivacaína	8.1	Bloq. Perif.	Lenta	95	4 – 12	2,5 mg/kg 3 mg/kg (c/epi)
		Raqui.	Rápida		1 – 4	
		Peridural	Moderada		2 – 5	
Ropivacaína	8.1	Bloq. Perif.	Lenta	90 - 95	5 – 8	3 mg/kg
		Peridural	Moderada		2 – 6	

A letra D está incorreta. O fio deve ser o de menor calibre possível para obter resultado estético adequado.

A letra E está incorreta. Esta alternativa foi considerada incorreta pela banca, mas nós do EMED discordamos. A sutura pode ser realizada com anestésico sem vasoconstritor, pois é uma lesão pequena e sem sangramento ativo.

Questão | | 2024 | 4000205754

Um homem saudável de 48 anos comparece à UBS para realizar o PSA, pois viu, em um anúncio, que deve realizar tal exame para se proteger do câncer de próstata. Ele consultou-se com o médico da família e comunidade e relatou que vinha fazendo o PSA todos os anos, parou na pandemia e, agora, gostaria de fazer novamente. Considerando que o PSA é um exame que apresenta elevado risco ao paciente devido ao seu baixo valor preditivo positivo, em relação ao desejo desse paciente em realizar o PSA, assinale a conduta correta

- A) Devido ao manifesto desejo do paciente, o médico deve solicitar o exame, ainda que discorde da sua necessidade, com o objetivo de preservar a relação médico-paciente.
- B) O médico não deve solicitar o exame, explicando ao paciente, por meio de imagens, explicações verbais e visuais, que ele não é necessário.
- C) O médico deve encaminhar o paciente ao especialista, o urologista, pois só ele pode determinar a necessidade do exame.
- D) O médico deve solicitar o exame, mas deve alertar o paciente sobre a alta chance de falso positivo e o risco de uma biópsia ser necessária caso o exame venha positivo.
- E) O médico deve tomar uma decisão compartilhada, explicando ao paciente sobre os riscos do exame e sua baixa probabilidade de benefício.

Solução

Gabarito: E) O médico deve tomar uma decisão compartilhada, explicando ao paciente sobre os riscos do exame e sua baixa probabilidade de benefício.

GABARITO: ALTERNATIVA E

Estrategista,

Essa questão do ENARE 2024 foi muito polêmica, uma vez que traz um homem de 48 anos, sem fatores de risco, que solicita o rastreamento de câncer de próstata por meio do PSA.

Ora, o ponto principal aqui é observamos que ele já iniciou o rastreamento, uma vez que informa que vinha fazendo o PSA todos os anos, e apenas interrompeu durante a pandemia. Nesse sentido, o mais importante aqui não é “vetar” o exame de primeira (até porque ele já fez diversos anteriormente), e sim orientá-lo quanto à possibilidade de falso-positivo.

- Mas o Ministério da Saúde proíbe o PSA antes dos 50 anos, não?

Não. O Ministério da Saúde (MS) não recomenda instituir programas de rastreamento sistemático para a população, uma vez que não há evidências suficientes que sustentem essa tomada de decisão. Ou seja, o que o MS não recomenda que os gestores implementem um programa de rastreamento, o que consistiria em chamar ativamente os homens para a realização do PSA. Em contrapartida, o MS não proíbe que o médico avalie individualmente cada caso e solicite o exame se houver pactuação com o paciente, mesmo que isso ocorra antes dos 50 anos.

Lembre-se de que esse também é o ponto de vista do USPSTF, que coloca o rastreamento do câncer de próstata pelo PSA como nível de evidência C: não é recomendado, mas deve-se informar ao paciente os riscos e pactuar caso a caso.

Portanto:

A letra A está incorreta. Incorreta a alternativa A. O médico não é obrigado a solicitar o exame, apenas porque o paciente deseja. A decisão deve ser compartilhada. Ainda, a Resolução nº 2.232/2019 garante ao médico a objeção de consciência. Logo, como não se trata de negativa que pode prejudicar o paciente, tampouco um caso de urgência ou emergência, o médico pode conversar com o paciente sobre não concordar com o exame e encaminhá-lo a outro profissional que possa solicitá-lo.

A letra B está incorreta. Incorreta a alternativa B. O problema dessa assertiva é que ela considera apenas a decisão do médico, quando a tomada de decisão deve ser pactuada. Portanto, o médico não deve convencer o paciente, e sim orientá-lo, mas a decisão final deve ser conjunta. E como dito anteriormente, caso a solicitação do exame contrarie os ditames da consciência do médico, ele pode encaminhar o paciente a outro profissional, mas o paciente não ficaria sem a possibilidade de ter o exame de forma arbitrária como a alternativa B propõe.

A letra C está incorreta. Incorreta a alternativa C uma vez que todo o médico tem autonomia para solicitar o PSA.

A letra D está incorreta. Incorreta a alternativa D. Essa alternativa considera apenas a opinião do paciente, obrigando o médico a solicitar o exame ao dizer que o médico “deve” solicitar o exame. A decisão deve ser compartilhada.

A letra E está correta. Correta a alternativa E. Dentre todas, essa é a alternativa mais plausível, uma vez que segue a recomendação atual do INCA e do Ministério da Saúde quanto à pactuação direta com o paciente em decisão compartilhada.

Questão | | 2024 | 4000205755

Quase 55 mil pessoas morrem por ano no Brasil devido a erros médicos. Isso é o que aponta o Estudo de Saúde Suplementar, que analisou 182 hospitais nos anos anteriores à pandemia da Covid-19. Devido a esse número elevado, a preocupação com a segurança do paciente e em minimizar o número de erros é fundamental para qualquer profissional de saúde. Dentre os possíveis erros do profissional médico, está o erro do diagnóstico. Assinale a alternativa que apresenta uma atitude que melhora a segurança do paciente e a qualidade do diagnóstico médico.

- A) Aumentar o conhecimento médico dos profissionais, principalmente através da memorização de protocolos.
- B) Prescrição de tratamentos empíricos, evitando piora de quadros tratáveis.
- C) Postura ativa do profissional sobre testes e sintomas; realizar busca ativa para saber sobre sintomas e respostas aos tratamentos.
- D) Aumentar a sensibilidade para diagnósticos solicitando grandes quantidades de exames ao mesmo tempo.
- E) Encaminhamento para especialistas focais de forma precoce durante a evolução dos sintomas.

Solução

Gabarito: C) Postura ativa do profissional sobre testes e sintomas; realizar busca ativa para saber sobre sintomas e respostas aos tratamentos.

GABARITO: ALTERNATIVA C

Estrategista,

Estamos diante de mais uma questão polêmica do ENARE 2024, mas observe a seguir como devemos racionar para respondê-la corretamente.

O enunciado demonstra a preocupação com a segurança do paciente, enfatizando que entre os possíveis erros cometidos pelo profissional médico, está o erro de diagnóstico. Em seguida, o examinador solicita que o candidato marque a alternativa que melhora a segurança do paciente e a qualidade do diagnóstico médico.

Portanto, devemos analisar as assertivas verificando qual delas contribuiria, de fato, para minimizar o erro de diagnóstico, já que esse é o tipo de erro mencionado pelo examinador.

Ora, a melhor forma de minimizarmos os erros de diagnóstico é aprimorando o nosso raciocínio clínico. E esse aprimoramento passa necessariamente pelos “feedbacks”. Por exemplo, quantos de nós, após darmos um diagnóstico, vamos “atrás” do paciente para saber se ele melhorou e se o diagnóstico era aquele mesmo? Isso é difícil de acontecer, especialmente em plantões de emergência. Se o paciente internar, é mais fácil entendermos se o diagnóstico inicial estava correto, mas se for um atendimento pontual, em que o paciente comparece em uma UPA e é liberado em seguida, perde-se o contato com paciente na maioria das vezes, tornando praticamente impossível qualquer feedback se o diagnóstico inicial estava correto (e não é culpa do médico, é porque não é logisticamente viável termos o feedback de todos os pacientes que atendemos, especialmente nas condições em que a Medicina é exercida no Brasil).

Nesse sentido, caso o diagnóstico esteja errado, o médico não terá a oportunidade de reajustar o seu raciocínio clínico.

Com isso em mente, vamos procurar a alternativa correta:

A letra A está incorreta. Incorreta a alternativa A. De fato, aumentar o conhecimento dos médicos reduz a ocorrência de erros diagnósticos, mas observe que ele fala em “memorização de protocolos”. O problema está justamente aí. Os Protocolos e Guidelines devem ser utilizados com postura crítica. Nem tudo o que é recomendado por eles aplica-se a todo paciente. Portanto, a simples memorização não exclui o erro de diagnóstico, tampouco a iatrogenia, pois nem sempre “o paciente lê o livro”.

A letra B está incorreta. Incorreta a alternativa B. O empirismo muitas vezes é necessário, mas se o tratamento está sendo prescrito de forma empírica, é porque há incerteza diagnóstica.

A letra C está correta. Correta a alternativa C. Observe que a alternativa fala em postura ativa do profissional, inclusive com busca ativa para saber se o paciente de fato melhorou com o tratamento prescrito, isto é, se houve melhora nos sintomas. Isso sim é uma boa evidência de que o diagnóstico feito está correto, diminuindo a probabilidade de erro porque, ao acompanhar o paciente de forma longitudinal, é possível reajustar esse diagnóstico. Portanto, realizar busca ativa é obter aquele feedback que falamos lá em cima, fazendo com que o médico possa aprimorar o seu raciocínio clínico.

A letra D está incorreta. Incorreta a alternativa D. A solicitação de diversos exames ao mesmo tempo nada mais é do que a associação de testes em paralelo. De fato, há um aumento na sensibilidade diagnóstica, mas isso também aumenta a probabilidade de falso-positivo, contribuindo para diagnósticos incorretos e que podem resultar em iatrogenia.

A letra E está incorreta. Incorreta a alternativa E. O encaminhamento precoce ao especialista focal não contribui para a melhoria diagnóstica, pelo contrário. Muitas vezes, o paciente vai melhorar espontaneamente dos sinais e sintomas, mas ao encaminharmos para o nível secundário (ou terciário) é comum que o especialista focal demande uma resposta, já que houve o encaminhamento. Portanto, isso pode resultar em iatrogenias.

Questão | | 2024 | 4000205756

Uma jovem de 24 anos comparece à consulta na Unidade Básica de Saúde devido a atraso menstrual. Ao consultá-la, o médico solicita um teste rápido urinário que mostra resultado positivo para gravidez. Ao dar a notícia, a paciente começa a chorar copiosamente. Após um certo tempo, ela relata que a gravidez foi fruto de uma única relação com um parceiro ocasional e que não a deseja, afirmando que isso atrapalhará seu curso universitário e demonstrando preocupação em relação à reação de seus pais. Diante dessa situação, qual é a postura considerada adequada?

- A)** Diante de um paciente em sofrimento, é muito comum termos empatia e demonstrarmos esse sofrimento – muitas vezes sofrendo tanto ou mais que o paciente.
- B)** É importante manter a distância física para preservar o lugar do terapeuta e do profissional de saúde que faz o atendimento.
- C)** Enfatizar para a pessoa que ela deve sempre explicar o que está causando o sofrimento.
- D)** Quando possível, tentar ressignificar o sofrimento da pessoa – mostrando que aquele sofrimento é sem sentido.
- E)** É necessário legitimar o sofrimento dessa jovem e permitir o choro pelo tempo necessário.

Solução

Gabarito: E) É necessário legitimar o sofrimento dessa jovem e permitir o choro pelo tempo necessário.

GABARITO: ALTERNATIVA E

Estrategista,

O objetivo do examinador do ENARE foi avaliar qual seria a sua conduta como profissional diante de um caso em que há sofrimento psíquico e emocional.

Em primeiro lugar, saiba que jamais devemos minimizar o sofrimento alheio, por mais que possa parecer sem sentido para nós. O correto é acolher o paciente de forma empática, realizando uma escuta ativa e demonstrando empatia (aliás, o médico não se torna “fraco” ou “inadequado” por demonstrar sentimentos, no entanto, deve fazê-lo sob medida, sem sofrer mais que o próprio paciente).

Nessa questão, temos uma jovem que está grávida, mas cuja gestação não foi planejada e não é desejada. Por isso, ela chora copiosamente durante a consulta. A postura mais adequada é acolher a paciente, legitimando o sofrimento dela.

Portanto:

A letra A está incorreta. Incorreta a alternativa A. Como dito anteriormente, o médico não se torna inadequado por demonstrar sentimentos, mas obviamente que isso deve ser feito sob medida.

A letra B está incorreta. Incorreta a alternativa B. É importante demonstrar empatia. Portanto, é inadequado manter distância para preservar o lugar de terapeuta ou médico.

A letra C está incorreta. Incorreta a alternativa C. O sofrimento muitas vezes não é explicável em palavras. Portanto, não se deve cobrar explicações da paciente.

A letra D está incorreta. Incorreta a alternativa D. De forma alguma devemos minimizar o sofrimento dela, pois nossa perspectiva é apenas nossa. Não somos nós a vivenciar o problema. Logo, devemos ser empáticos.

A letra E está correta. Correta a alternativa E, sem ressalvas.

Questão | | 2024 | 4000205757

Um senhor de 62 anos, portador de HAS e tabagista, comparece à UBS para trazer os resultados de seus exames de rotina. Ele faz uso de losartana 50 mg BID e anlodipino 5 mg MID e apresenta bom controle de pressão arterial. A seguir estão os resultados dos exames desse paciente:

Hemoglobina: 14,3 mg/dl / Leucócitos: 7200/mm³ / Plaquetas: 230.000/mm³ / Potássio: 5,6 mEq/L / Sódio: 143 mEq/L / Ácido Úrico: 4,3 mg/dl / Glicose: 93 mg/dl / HbA1c – 5,4% / Creatinina: 0,8 mg/dl.

Sangue oculto nas fezes (imunohistoquímica): positivo / Colesterol total: 122 / Col. HDL: 46 / Col. LDL: 68 / Relação albumina-creatinina: 3,2 mg/g.

Diante desse quadro, qual é a conduta mais adequada?

- O paciente apresenta hipercalemia, sendo necessária a prescrição de diuréticos de alça para
- A)** controle do potássio. Ele deve também ser referenciado para realização de colonoscopia para rastreio de câncer de cólon.
- O paciente apresenta hipercalemia, sendo necessária a prescrição de diuréticos de alça para
- B)** controle do potássio. Ele deve também repetir o exame de sangue oculto nas fezes, uma vez que são necessárias 3 amostras positivas.
- O paciente apresenta hipercalemia, sendo necessária a suspensão da losartana para controle do potássio – devendo ser substituída por atenolol, que também é um medicamento de primeira linha para tratamento da HAS. Ele deve também ser referenciado para realização de colonoscopia para rastreio de câncer de cólon.
- C)**
- O paciente apresenta hipercalemia, sendo necessária a suspensão da losartana para controle do potássio – devendo ser substituída por indapamida, que também é um medicamento de primeira linha para tratamento da HAS. Ele deve também ser referenciado para realização de colonoscopia para rastreio de câncer de cólon.
- D)**
- O paciente apresenta hipercalemia, sendo necessária a suspensão da losartana para controle do potássio – devendo ser substituída por indapamida, que também é um medicamento de primeira linha para tratamento da HAS. Ele deve também repetir o exame de sangue oculto nas fezes, uma vez que são necessárias 3 amostras positivas.
- E)**

Solução

O paciente apresenta hipercalemia, sendo necessária a suspensão da losartana para controle do potássio – devendo ser substituída por indapamida, que também

Gabarito: D) é um medicamento de primeira linha para tratamento da HAS. Ele deve também ser referenciado para realização de colonoscopia para rastreio de câncer de cólon.

Estamos avaliando um paciente de 62 anos, portador de hipertensão arterial sistêmica (HAS) e tabagista, que apresenta hipercalemia (potássio de 5,6 mEq/L) e um teste de sangue oculto nas fezes positivo. A hipercalemia pode ser uma consequência do uso de losartana, um antagonista do receptor da angiotensina II, que pode aumentar os níveis de potássio. O manejo da hipercalemia pode incluir a revisão da medicação anti-hipertensiva, considerando a substituição por um medicamento que não afete os níveis de potássio. O teste de sangue oculto nas fezes positivo é um sinal de alerta para condições gastrointestinais, incluindo

neoplasias, especialmente em um paciente de 62 anos com histórico de tabagismo. A colonoscopia é recomendada para investigar a causa do sangramento.

Como isso em mente, vamos avaliar as alternativas, buscando a melhor conduta nesse caso:

A letra A está incorreta. INCORRETA: Embora a prescrição de diuréticos de alça possa ser uma estratégia para reduzir a hipercalcemia, essa ainda não seria a melhor escolha nesse momento. Os níveis não estão tão elevados, possivelmente sendo possível corrigir apenas com a troca do anti-hipertensivo atualmente em uso. A indicação de colonoscopia é apropriada devido ao teste de sangue oculto nas fezes positivo.

A letra B está incorreta. INCORRETA: A presença de um teste positivo em um paciente de 62 anos justifica a realização de uma colonoscopia, e não apenas a repetição do sangue oculto nas fezes. Pense bem, se o novo exame vier negativo, você deixaria de realizar uma colonoscopia? Claro que não, até porque esse paciente tem mais de 50 anos de idade, já tendo indicação para rastreamento para neoplasia colorretal, independentemente do resultado de qualquer outro exame. Além disso, já foi dito anteriormente que gestão da hipercalcemia deve incluir a revisão da medicação anti-hipertensiva.

A letra C está incorreta. INCORRETA: Suspender a losartana e substituí-la por atenolol pode ser uma opção para o manejo da hipercalcemia. No entanto, o atenolol, um beta-bloqueador, pode **não ser a melhor escolha para o tratamento da HAS desse paciente**. A indicação de colonoscopia é apropriada.

A letra D está correta. CORRETA: A decisão de substituir a losartana pela indapamida é uma abordagem terapêutica adequada neste caso. A indapamida é um diurético "tiazídico-like" que ajuda a reduzir os níveis de potássio através de sua ação diurética, promovendo uma leve excreção de potássio. Além disso, a indapamida é eficaz no controle da pressão arterial, com perfil de segurança favorável, especialmente em termos de impacto no metabolismo lipídico e glicêmico, o que é relevante considerando o histórico clínico do paciente. A indicação de colonoscopia para investigar o sangue oculto nas fezes é apropriada, dada a idade do paciente e o resultado positivo do teste.

A letra E está incorreta.

Questão | | 2024 | 4000205758

Um senhor de 58 anos comparece à consulta em unidade básica de saúde e queixa-se, para seu médico de família e comunidade, de dores nos joelhos. O paciente relata que “as dores o preocupam muito, pois o atrapalham a trabalhar diariamente”. O médico, além de fazer perguntas, realiza o exame físico e conclui que se trata de caso de artrose dos joelhos, bilateralmente. Diante da preocupação do paciente, qual é a atitude esperada desse profissional de saúde?

- A)** A atitude adequada é esclarecer ao paciente que se trata de quadro crônico e que ele deverá conviver com a dor.

- B)** A atitude adequada é demonstrar, empaticamente, que compreende a seriedade do adoecimento, apesar de se tratar de doença que não ameaça a vida.
- C)** A atitude adequada é esclarecer que se trata de quadro que não ameaça a vida, tranquilizando o paciente e orientando que esse quadro não impede seu trabalho.
- D)** A atitude adequada é encaminhar o paciente prontamente ao especialista devido à gravidade da situação.
- E)** A atitude adequada é recomendar ao paciente afastamento da sua atividade laboral, uma vez que ela é diretamente responsável pelo seu adoecimento.

Solução

Gabarito: B) A atitude adequada é demonstrar, empaticamente, que compreende a seriedade do adoecimento, apesar de se tratar de doença que não ameaça a vida.

GABARITO: ALTERNATIVA B

Estrategista,

Observe que estamos diante de um paciente que apresenta uma gonartrose bilateral e possivelmente limitante, já que as dores o atrapalham em seu trabalho.

Diante de um paciente com dor crônica, e com limitação para as atividades da vida, o médico deve acolher esse paciente, realizando sempre a escuta ativa de forma empática, e pactuar estratégias que possam aliviar a dor. O que não pode ser feito é culpabilizar o paciente pelo que ele sente, ou julgá-lo, afirmando que ele está inventando desculpas para não trabalhar, ou ainda, que ele deveria “fazer uma forcinha” para aguentar melhor a dor.

Portanto, devemos procurar justamente a alternativa que mencione termos como “acolhimento” ou “empatia” ou ainda, “alívio da dor”.

A letra A está incorreta. Incorreta a alternativa A. A assertiva parte do princípio de que o médico não pode fazer nada pelo paciente. Sempre é possível fazer algo pelo indivíduo, mesmo em doenças crônicas, como o alívio da dor. Além disso, a literatura médica informa que o médico apresenta um “efeito droga”. Isso significa que, a depender do vínculo que o profissional estabelecer com o paciente, é possível que indivíduo tenha melhor adesão as estratégias propostas e consiga melhorar apenas porque foi ouvido de forma empática.

A letra B está correta. Correta a alternativa B. Veja que essa é a alternativa que menciona um termo relacionado à empatia.

A letra C está incorreta. Incorreta a alternativa C. A condição pode não ser ameaçadora a vida, mas é limitante. Portanto, é possível sim que ela evolua a tal ponto que impeça o exercício do trabalho.

A letra D está incorreta. Incorreta a alternativa D porque a situação não é grave do ponto de vista clínica, apesar de ter alta morbidade por limitar a funcionalidade do paciente.

A letra E está incorreta. Incorreta a alternativa E. O erro da assertiva está em afirmar que a causa da gonartrose bilateral está no trabalho do paciente, quando não há nada no enunciado que estabeleça essa relação causal.

Questão | | 2024 | 4000205759

Uma menina de 8 anos é levada pela mãe à Unidade Básica de Saúde, apresentando febre, odinofagia e hiporexia. Ao exame clínico, são constatados exsudato orofaríngeo e linfadenopatia cervical palpável, e a médica responsável pelo atendimento determina que se trata de uma amigdalite bacteriana. Considerando o agente mais comum causador da amigdalite bacteriana, qual fármaco deve ser prescrito para o tratamento e qual é o principal objetivo do seu uso?

- A)** Amoxicilina / O principal objetivo é reduzir o risco de abscesso periamigdaliano.
- B)** Amoxicilina / O principal objetivo é reduzir a duração dos sintomas.
- C)** Azitromicina / O principal objetivo é evitar a febre reumática.
- D)** Amoxicilina / O principal objetivo é evitar a febre reumática.
- E)** Azitromicina / O principal objetivo é reduzir o risco de abscesso periamigdaliano.

Solução

Gabarito: D) Amoxicilina / O principal objetivo é evitar a febre reumática.

Olá, Estrategista, questão passível de recurso. Vamos lá.

Primeiro, sobre o agente etiológico. Aqui, não há controvérsias. A bactéria é a causa mais comum de faringite bacteriana, principalmente, em crianças mais velhas e adolescentes é o estreptococo beta-hemolítico do grupo A de Lancefield (SBHA), ou *Streptococcus pyogenes*.

Segundo, também não há controvérsia sobre o tratamento.

A penicilina e a amoxicilina são o tratamento de escolha para a faringite por SBHA e para a escarlatina, devido a sua eficácia, segurança, espectro estreito e baixo custo.

- Para a maioria dos adultos, pode ser utilizada a penicilina V 500 mg, via oral, de 2 a 3x/dia, por 10 dias, sendo a amoxicilina oral também uma opção razoável.
- Para crianças, podem ser utilizadas tanto a penicilina V oral como a amoxicilina.
- Em pacientes com histórico de febre reumática aguda, as opções incluem as duas citadas anteriormente, adicionadas da Penicilina Benzatina intramuscular dose única.

Agora, vem a parte com problemas.

O Tratado de Pediatria (5ª edição) salienta:

“As infecções em tonsilas palatinas e faringe são mais frequentemente de origem viral, mas podem ser causadas por bactérias, especialmente o estreptococo beta-hemolítico do grupo A (EBHGA), responsável pela única infecção bacteriana na garganta cujo tratamento com

antibióticos está definitivamente indicado, com o objetivo de prevenir sequelas supurativas e não supurativas.”

“O tratamento com antimicrobianos encurta a fase aguda da doença, diminui o potencial de transmissão e reduz o risco de sequelas supurativas e não supurativas associadas às infecções por EBHGA. O emprego correto de antibacterianos até 9 dias após o início do quadro infeccioso é capaz de impedir a febre reumática.”

O UptoDate, no artigo: Treatment and prevention of streptococcal pharyngitis in adults and children refere: *“Penicillin is the only antibiotic that has been studied and shown to reduce rates of acute rheumatic fever”*.

Dessa forma, concluímos que existe mais do que uma alternativa correta, pois as alternativas A, B e D, indicam a melhor opção de antibiótico para o tratamento, assim como os seus principais objetivos. Além disso, de acordo com o UptoDate, o antibiótico utilizado para a prevenção da febre reumática deverá ser a penicilina e não a amoxicilina.

Vamos aguardar o posicionamento da banca quanto ao recurso.

Questão | | 2024 | 4000205760

A avaliação que considera múltiplas dimensões é denominada avaliação multidimensional a qual estrutura e organiza o cuidado às pessoas idosas. Em outras palavras, a avaliação multidimensional permite a compreensão ampliada e integral do estado de saúde de um determinado indivíduo, buscando identificar e intervir nas áreas mais comprometidas e que podem afetar sua funcionalidade: doenças agudas ou crônicas, agravos como quedas e outros acidentes, questões relativas a processos psicológicos/subjetivos ou, ainda, situações sociais, econômicas e culturais que podem trazer limitações para o exercício da autonomia e/ou independência. Tal avaliação permite o direcionamento de intervenções oportunas, que respondam às reais necessidades de cada pessoa, o que possibilita prognósticos mais favoráveis em sua trajetória de envelhecimento. Referente à avaliação multidimensional do idoso, assinale a alternativa correta.

- A)** A dimensão psicossocial enfatiza critérios sociais e étnico-raciais, sendo a questão da saúde mental exclusiva da dimensão clínica.
- B)** A avaliação da capacidade de realizar atividades diárias (instrumentais e básicas) faz parte da dimensão clínica.
- C)** A avaliação psicossocial busca avaliar a funcionalidade do indivíduo diante da sua comunidade.
- D)** A dimensão clínica concentra-se em avaliar sinais de doenças passadas, ficando a cargo da dimensão funcional avaliar doenças atuais.

- E)** A dimensão funcional considera de forma objetiva se uma pessoa é capaz ou não de realizar atividades da vida diária.

Solução

Gabarito: E) A dimensão funcional considera de forma objetiva se uma pessoa é capaz ou não de realizar atividades da vida diária.

GABARITO: ALTERNATIVA E

Referência bibliografia:

Ministério da Saúde. Nota técnica 01/2019 – Esclarecimento aos gestores sobre a avaliação multidimensional do idoso. Disponível em:

<https://atencaobasica.saude.rs.gov.br/upload/arquivos/201904/25085725-nt-01-avaliacao-multi.pdf>

Estrategista,

Estamos diante de uma questão de saúde do idoso que foi cobrada no ENARE 2024. O examinador deseja saber especificamente sobre a avaliação multidimensional que, como o próprio nome evidencia, avalia diferentes dimensões do paciente idoso, como nutrição, força muscular, cognição, humor, possíveis incontinências esfincterianas, rede de apoio, realização das atividades de vida diária, e assim por diante. Logo, trata-se de uma abordagem integral.

Porém, observe que o examinador questiona especificamente sobre as dimensões psicossocial, clínica e funcional.

Nesse sentido, a Nota Técnica nº1/2019 do Ministério da Saúde afirma o seguinte (1):

- **Dimensão Clínica:** é onde avaliamos o histórico de saúde-doença do idoso, por meio da anamnese e exame físico tradicional. O objetivo é identificar a presença de agravos como quedas, hematomas, fraturas, bem como saber as doenças crônicas, a história patológica pregressa, a história da doença atual, incluindo histórico farmacológico. Portanto, é o histórico de saúde do paciente (1).
- **Dimensão Psicossocial:** é a dimensão onde a cognição, memória, humor e comportamentos que podem auxiliar na identificação precoce de demência, depressão e ansiedade serão identificados. Portanto, é a dimensão que estuda a saúde mental do idoso. Ainda, a nota técnica também afirma que é nessa dimensão que avaliamos as questões econômicas, culturais, ambientais, étnico-raciais e de gênero do idoso (1).
- **Dimensão Funcional:** como o próprio nome sugere, essa dimensão avalia a funcionalidade do indivíduo idoso. Por isso, ela tem por objetivo avaliar as atividades da vida diária, verificando se o idoso é capaz de cuidar de si (tomar banho, alimentar-se, vestir-se...), bem como se é capaz de interagir com a sua família e com o ambiente em que vive (1).

Com base nessas informações, vamos avaliar as alternativas anteriores:

A letra A está incorreta. Incorreta a alternativa A. É justamente o contrário. A saúde mental do idoso é avaliada pela dimensão psicossocial.

A letra B está incorreta. Incorreta a alternativa B. A avaliação das atividades de vida diárias, tanto as instrumentais como as básicas, faz parte da dimensão funcional.

A letra C está incorreta. Incorreta a alternativa C. A funcionalidade é avaliada pela dimensão funcional. A dimensão psicossocial avalia tanto os fatores sociais, incluindo os culturais, bem como a saúde mental do indivíduo idoso.

A letra D está incorreta. Incorreta a alternativa D porque a dimensão clínica avalia tanto a história da doença atual como a história patológica pregressa.

A letra E está correta. Correta a alternativa E, sem ressalvas.

Questão | | 2024 | 4000205761

Mulher de 55 anos já não menstruava havia dois anos, entretanto, há cerca de um mês, vem apresentando sangramentos esporádicos de moderada intensidade, associados a cólicas. Como comorbidades, apresenta diabetes e hipertensão. Nega terapia hormonal. Ao exame ginecológico, não apresenta alterações, exceto discreta atrofia da mucosa vaginal. No ultrassom transvaginal observava-se endométrio de 9 mm. Diante desse caso, assinale a alternativa que apresenta a melhor conduta.

- A)** Prescrever lubrificante à base de água, visto que o sangramento é devido à atrofia.
- B)** Realizar investigação com histeroscopia e biópsia dirigida.
- C)** A provável causa do sangramento é um mioma submucoso. Indicar miomectomia.
- D)** Indicar histerectomia total abdominal por hiperplasia endometrial com atipia.
- E)** Prescrever noretisterona 0,35 mg por 12 meses e reavaliar em 1 ano.

Solução

Gabarito: B) Realizar investigação com histeroscopia e biópsia dirigida.

Estrategista, temos neste caso uma paciente com sangramento pós menopausa e espessamento endometrial (9 mm). Temos como hipóteses para este caso a hiperplasia ou o câncer, sendo indicada a biópsia deste endométrio. Veja o fluxograma abaixo:



Agora vamos analisar as alternativas:

A letra A está incorreta. Incorreta a alternativa A, porque a causa do sangramento da paciente não é a atrofia da mucosa vaginal, e sim o espessamento endometrial.

A letra B está correta. Correta a alternativa B: trata-se de caso suspeito de hiperplasia ou câncer de endométrio, sendo indicada a biópsia através da histeroscopia, que é o método padrão ouro para avaliação da cavidade uterina.

A letra C está incorreta. Incorreta a alternativa C, porque os miomas não são causa de sangramento pós menopausa, já que costumam regredir devido ao hipoestrogenismo característico desta fase da vida da mulher e, além disso, esta paciente não apresenta mioma no exame ultrassonográfico.

A letra D está incorreta. Incorreta a alternativa D, porque antes de realizar a histerectomia é necessário confirmar o diagnóstico de hiperplasia endometrial com atipia através da biópsia guiada pela histeroscopia.

A letra E está incorreta. Incorreta a alternativa E, porque os progestágenos são indicados para o tratamento da hiperplasia endometrial sem atipia nas mulheres pós menopausa e esta paciente ainda não teve confirmação anatomopatológica deste tipo de hiperplasia através da realização de biópsia do endométrio.

Questão | | 2024 | 4000205762

O ovário, em funcionamento normal, sintetiza e secreta hormônios esteroides sexuais com padrão de controle preciso que, em parte, é determinado pelas gonadotrofinas hipofisárias, FSH e LH. São hormônios secretados pelos ovários, EXCETO

- A)** ocitocina.
- B)** estrogênios.
- C)** androgênios.
- D)** progesterona.
- E)** androstenediona.

Solução

Gabarito: A) ocitocina.

O ovário é a gônada feminina. Dentro dele, o FSH e LH ligam-se aos seus receptores e estimulam a foliculogênese e a produção ovariana de hormônios esteroides, peptídeos gonadais (inibina, ativina e folistatina) e fatores de crescimento. Os esteroides (estrogênio, progesterona e androgênios) atuam nos tecidos-alvo: mamas, aparelho reprodutor, pele, aparelho cardiovascular, ossos, sistema nervoso e metabolismo em geral.

Os hormônios esteroides sexuais são produzidos nas gônadas, nas suprarrenais, fígado, tecido adiposo e na placenta.

O colesterol é a matéria-prima para a esteroidogênese e pode ser obtido na dieta ou pela molécula endógena, produzida no fígado. O processo de produção dos hormônios esteroides envolve, no mínimo, 17 enzimas.

Pois bem, os dois compartimentos do folículo, células da teca e células da granulosa, têm a capacidade de produzir os três tipos de esteroides sexuais (estrogênio, progesterona e androgênios). Entretanto, a atividade da enzima aromatase dá-se, sobretudo, nas células da granulosa, o que faz com que a produção de esteroides fique compartimentalizada. As células da teca, por serem mais externas e vascularizadas, captam o colesterol e, sob o estímulo do LH, produzem androgênios.

Esses, por sua vez, entram nas células da granulosa por difusão e, por estímulo do FSH, convertem-se em estrogênios pela atividade da enzima aromatase. Esse mecanismo é chamado de “Teoria das duas células, duas gonadotrofinas”.

A letra A está correta. Alternativa "a" correta, pois a ocitocina é produzida pela hipófise.

A letra B está incorreta.

A letra C está incorreta.

A letra D está incorreta.

A letra E está incorreta.

Questão | | 2024 | 4000205763

Paciente nuligesta, 20 anos, comparece ao consultório de seu ginecologista referindo desejo de iniciar uso de dispositivo intrauterino com levonorgestrel. Referente a esse dispositivo, assinale a alternativa correta.

- A)** Esse DIU libera levonorgestrel a uma taxa relativamente constante de 15 mg/dia.
- B)** O exame de colpocitologia oncótica alterada não interfere na indicação desse DIU.
- C)** Na suspeita de carcinoma de mama, esse DIU não é indicado.
- D)** Pode ser inserido durante um quadro de candidíase vaginal.

- E) Aproximadamente 98% das pacientes que inserem esse tipo de DIU ficam em amenorreia após os 6 primeiros meses de uso.

Solução

Gabarito: C) Na suspeita de carcinoma de mama, esse DIU não é indicado.

Estrategista, também chamado de Sistema Intrauterino (SIU), esse dispositivo possui um reservatório contendo o progestágeno levonorgestrel. Existem dois modelos no mercado brasileiro, um contendo 52 mg de levonorgestrel (libera 20 mcg desse hormônio diariamente) e o outro contendo 19,5 mg desse hormônio (liberação diária de 12 mcg), ambos com duração de 5 anos. Há evidências sugerindo que o SIU de 52 mg tenha duração de até 7 anos. Já vimos que a estrutura do DIU provoca reação inflamatória na cavidade uterina. Além disso, a progesterona provoca o espessamento do muco cervical, tornando hostil à ascensão de espermatozoides, e atrofia o endométrio. Como já vimos, esse dispositivo bloqueia a ovulação em menos de 25% dos casos, possuindo maior efeito local.

Além de ser um método de longa duração, o SIU também tem benefícios não contraceptivos decorrentes da presença do progestágeno: redução da duração e da intensidade do sangramento, melhora da dismenorreia primária, melhora da dor relacionada a endometriose e adenomiose.

Além dos efeitos adversos relacionados à inserção do método, já descritos para o DIU de cobre (dor, perfuração, expulsão e infecção), a modificação do padrão de sangramento é a principal alteração relacionada ao SIU (comum a todos os métodos progestágenos isolados), mas tende a melhorar nos primeiros três a seis meses.

Outras queixas comuns são: acne (lembre-se que o levonorgestrel é um progestágeno androgênico), dores nas mamas, cefaleia e alterações de humor.

Para memorizar as contraindicações para o SIU de levonorgestrel, você deve lembrar que aqui estarão todas as condições que impedem a inserção do dispositivo na cavidade uterina (as mesmas do DIU de cobre) somadas às contraindicações dos progestágenos! A tabela abaixo traz as contraindicações absolutas e relativas:

CONTRAINDICAÇÕES ABSOLUTAS (CATEGORIA 4) AO DIU/SIU LIBERADOR DE LEVONORGESTREL	
	Gravidez
	Sepse puerperal
	Imediatamente após aborto séptico
	Doença trofoblástica gestacional com níveis elevados de beta HCG ou com malignidade
	Câncer de colo uterino
	Câncer de mama atual
	Câncer de endométrio
	Anormalidades que distorcem a cavidade uterina
	Sangramento transvaginal inexplicado
	Doença Inflamatória Pélvica (DIP) atual
	Cervicite purulenta ou infecção ativa por clamídia ou gonococo
	Tuberculose pélvica
CONTRAINDICAÇÕES RELATIVAS (CATEGORIA 3) AO DIU/SIU LIBERADOR DE LEVONORGESTREL	
	48 horas a 4 semanas pós-parto (pelo risco de expulsão)
	TVP/TEP aguda
	Lúpus com anticorpos antifosfolípeidos positivos ou desconhecidos
	Doença trofoblástica gestacional com níveis de beta HCG decrescentes ou indetectáveis
	Câncer de mama prévio e sem evidência da doença nos últimos 5 anos
	Câncer de ovário
	HIV avançado
	Cirrose descompensada
	Adenoma hepatocelular e tumores hepáticos malignos
	Doença cardíaca isquêmica atual ou prévia (para continuação do método)

Agora vamos analisar as alternativas:

A letra A está incorreta. Incorreta a alternativa A, porque este DIU libera levonorgestrel a uma taxa de 12 a 20 mcg por dia.

A letra B está incorreta. Incorreta a alternativa B, porque o encontro de lesões precursoras de câncer de colo na colpocitologia não é uma contraindicação para o uso de SIU de levonorgestrel.

A letra C está correta. Correta a alternativa C: o câncer de mama é uma contraindicação para o uso de qualquer método anticoncepcional hormonal, incluindo o SIU de levonorgestrel e por isso esta foi considerada a alternativa correta pela banca. Porém, a suspeita de carcinoma de mama não é uma contraindicação para o uso do DIU de levonorgestrel, e sim o carcinoma de mama confirmado através de biópsia. Por isso essa questão foi passível de recurso.

A letra D está incorreta. Incorreta a alternativa D. Esta alternativa foi considerada incorreta pela banca porém consideramos que está correta. De acordo com os critérios de elegibilidade da OMS, a candidíase vaginal não é uma contraindicação para a inserção deste DIU. Por isto esta questão foi passível de recurso.

A letra E está incorreta. Incorreta a alternativa E, porque aproximadamente 85% das pacientes que inserem o SIU de levonorgestrel ficam em amenorreia após os 6 primeiros meses de uso.

Questão | | 2024 | 4000205764

Sobre a candidíase vaginal, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma a seguir e assinale a alternativa com a sequência correta.

() O exame microscópico da leucorreia vaginal, após aplicação de KOH a 10%, permite a identificação da levedura.

() A *Candida albicans* é dimórfica, apresentando tanto leveduras quanto hifas.

() A cultura para cândida vaginal é recomendada como rotina.

() O tratamento primário para a prevenção de infecção recorrente é feito com fluconazol oral, uma vez por semana por 2 meses.

A) F – F – V – V.

B) F – V – V – F.

C) V – V – V – F.

D) V – V – F – V.

E) V – V – F – F.

Solução

Gabarito: E) V – V – F – F.

O quadro clínico da vulvovaginite fúngica caracteriza-se por prurido, de intensidade variável, acompanhado de corrimento

vaginal esbranquiçado com aspecto de “leite coalhado” ou “queijo cottage”, sem odor associado. Se houver muita inflamação, pode haver queixa de dispareunia, queimação e disúria. Os sintomas geralmente são piores na semana que antecede a menstruação.

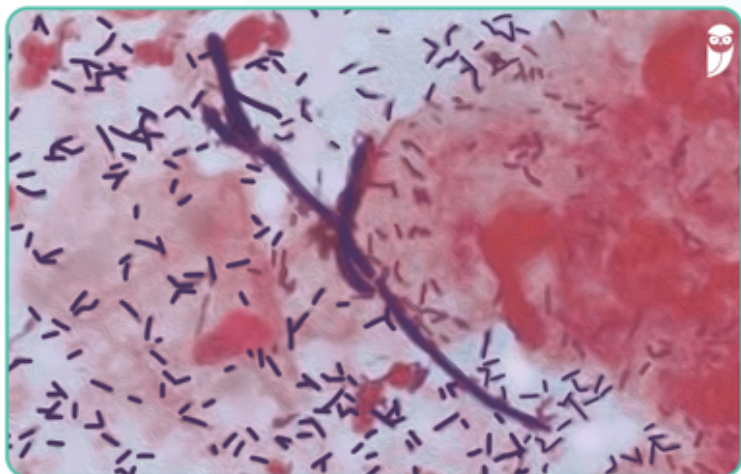
Ao exame ginecológico, pode ser observada hiperemia vulvar, edema e fissuras. O exame especular mostra mucosa vaginal hiperemiada e o corrimento vaginal aderido às paredes vaginais .

No consultório, além da anamnese e da avaliação do corrimento vaginal, também pode ser realizada a medida do pH vaginal e a microscopia.

1. Anamnese: além da queixa do corrimento vaginal e de prurido, devem ser avaliados a ciclicidade do corrimento (a candidíase tende a iniciar os sintomas na fase que antecede o período menstrual) e os fatores de risco para a doença;
2. pH vaginal: o pH vaginal da candidíase é ácido, quase sempre abaixo de 4,5;
3. KOH 10%: nesse caso, o teste das aminas é negativo;
4. Microscopia): a secreção vaginal deve ser colocada em, no mínimo, duas lâminas, uma com solução salina e outra com KOH 10%. A preparação com KOH destrói os elementos celulares e facilita o reconhecimento do fungo (leveduras, hifas e pseudo-hifas). No entanto, a microscopia é negativa em até 50% dos pacientes com candidíase vulvovaginal confirmada por cultura; as hifas parecem bambusna lâmina
5. Cultura: a secreção vaginal é inoculada no meio de ágar Sabouraud ou meio de Nickerson. A cultura é recomendada apenas nos seguintes casos:

- a. Alta suspeita de candidíase com microscopia negativa;
- b. Mulheres com sintomas persistentes ou recorrentes (para avaliar a possibilidade de espécies não albicans).

A cultura não está recomendada em pacientes sem sintomas, pois a *Candida* sp. cresce em 10% - 20% das mulheres saudáveis.



Vamos avaliar as alternativas

() O exame microscópico da leucorreia vaginal, após aplicação de KOH a 10%, permite a identificação da levedura.

Verdadeira, pois conforme descrito na introdução, com a colocação de KOH podemos remover alguns elementos celulares e facilitar a visualização de hifas e esporos.

() A *Candida albicans* é dimórfica, apresentando tanto leveduras quanto hifas.

Verdadeira, pois a *Candida* pode se manifestar com esses dois aspectos.

() A cultura para cândida vaginal é recomendada como rotina.

Falsa, pois a cultura para candida é recomendada de rotina, conforme explicado na introdução

() O tratamento primário para a prevenção de infecção recorrente é feito com fluconazol oral, uma vez por semana por 2 meses.

Falsa, pois o tratamento da candidíase recorrente deve ser realizado por pelo menos 6 meses.

Diante do exposto, a alternativa correta é a letra "e".

Questão | | 2024 | 4000205765

Paciente de 56 anos procura atendimento por um quadro de prurido vulvar crônico, com piora no período noturno. É menopausada há 5 anos e nega terapia de reposição hormonal. Durante a inspeção, apresenta vulva com área de pápulas atróficas branquicentas, simétrica, regressão dos pequenos lábios e encobrimento do clitóris. Após avaliação, o médico ginecologista indicou tratamento para líquen escleroso, sendo a melhor medicação para essa patologia

- A) nistatina por 30 dias em região vulvar.
- B) prednisona 20 mg via oral por 30 dias. Após, iniciar a redução do corticoide progressivamente.
- C) itraconazol associado à pomada de clindamicina gel por 20 dias consecutivos.
- D) propionato de clobetasol a 0,05.
- E) neomicina + bacitracina zincica associadas a anti-histamínico de primeira geração.

Solução

Gabarito: D) propionato de clobetasol a 0,05.

Estrategista, o líquen escleroso é a causa mais comum de doença crônica vulvar (1:300-1:1000). Pode acometer ambos os sexos e faixas etárias, mas é mais frequente em mulheres na pós menopausa (na quinta ou sexta década de vida) e em meninas pré-púberes.

É uma dermatose crônica, inflamatória, não neoplásica, não infecciosa, de provável origem autoimune. Em alguns casos, há associação com doenças autoimunes, como vitiligo, tireoidite auto-imune, lúpus, artrite reumatoide, doença celíaca e outros. Está associado com um risco de 4-6% de transformação maligna (carcinoma escamoso de vulva).

O principal sintoma é prurido vulvar crônico, mas pode ser assintomático em 1% dos casos. Outros sintomas associados podem ser: dor, disúria, restrição à micção e dispareunia.

Geralmente começa em torno do capuz do clitóris na forma de um eritema bem demarcado, progredindo para os pequenos lábios, vestibulo e regiões perineal e perianal. As lesões típicas são pápulas branco-nacaradas, que podem agrupar-se conferindo a característica distribuição em “figura de oito”. Devido ao ato de coçadura, podem formar-se fissuras, erosões, púrpura e equimoses. A pele adquire textura adelgada e enrugada que lembra papel de cigarro. Eventualmente, pode ocorrer distorção da arquitetura com reabsorção de estruturas anatômicas: sinéquia de pequenos lábios, encapuzamento de clitóris, perda dos pequenos lábios, e, em alguns casos, estenose do introito vaginal.

O diagnóstico pode ser apenas clínico. A biópsia só deve ser realizada quando se tem dúvida em relação ao diagnóstico, e também em casos atípicos, que há suspeita de malignidade. Os principais diagnósticos diferenciais são: líquen plano, líquen simples crônico, vitiligo e neoplasia intraepitelial vulvar.

Toda paciente com diagnóstico de líquen escleroso que não tem resposta a corticoterapia, especialmente com presença de áreas espessadas e ulcerações, deve ser feita biópsia para exclusão de câncer!

O objetivo do tratamento é reduzir o prurido, melhorar a qualidade de vida, evitar a progressão da doença e sua transformação maligna.

Devem ser feitas orientações gerais de higiene: evitar irritantes, vestir roupas íntimas de algodão, aplicar lubrificantes e emolientes na vulva e usar sabonetes sem fragrância. A base do tratamento são os corticoides tópicos de alta potência (clobetasol 0,05% ou mometasona 0,1%), inicialmente diariamente, por um mês, e a seguir, se faz a retirada progressiva da medicação. Como segunda opção de tratamento, podem ser utilizados os inibidores da calcineurina (Tacrolimus e Pimecrolimus). Mesmo em pacientes assintomáticas, o seguimento deve ser semestral ou anual para o resto da vida.

Caso não haja melhora devem ser avaliados os seguintes pontos: uso correto da medicação, infecção bacteriana ou fúngica concomitante e, principalmente, a presença de neoplasia intraepitelial vulvar ou carcinoma escamoso.

Agora vamos analisar as alternativas:

A letra A está incorreta. Incorreta a alternativa A, porque a nistatina é indicada para o tratamento da candidíase, e não do líquen escleroso.

A letra B está incorreta. Incorreta a alternativa B, porque a prednisona não é indicada para o tratamento do líquen escleroso.

A letra C está incorreta. Incorreta a alternativa C, porque o itraconazol é indicado para o tratamento de infecções fúngicas.

A letra D está correta. Correta a alternativa D: o tratamento do líquen escleroso é feito com os corticoides tópicos de alta potência (clobetasol 0,05% ou mometasona 0,1%).

A letra E está incorreta. Incorreta a alternativa E, porque o tratamento do líquen escleroso não é feito com antibióticos.

Questão | | 2024 | 4000205766

Em relação aos cistos do ducto de Gartner, assinale a alternativa correta.

- A)** É uma formação cística em parede vaginal lateral no terço superior.
- B)** Desenvolvem-se a partir dos resíduos dos ductos paramesonéfricos.
- C)** Esse cisto não gera sintomas, portanto a conduta sempre é conservadora.
- D)** Os ductos de Müller são responsáveis pela formação do cisto do ducto de Gartner.
- E)** A vulvoscopia é indicada para todos os casos.

Solução

Gabarito: A) É uma formação cística em parede vaginal lateral no terço superior.

Estrategista, a formação do cisto do ducto de Gartner ocorre devido a involução incompleta da porção vaginal do ducto mesonéfrico (ductos de Wolff). Estes cistos são geralmente pequenos e assintomáticos, mas em alguns casos podem causar dispareunia, interferir com o parto e associar-se com malformações do trato urogenital. Os cistos de Gartner ficam localizados na parede anterolateral e superior da vagina, acima da sínfise púbica.

Agora vamos analisar as alternativas:

A letra A está correta. Correta a alternativa A: os cistos de Gartner se localizam na parte superior da vagina, na parede anterolateral.

A letra B está incorreta. Incorreta a alternativa B, porque os ductos de Gartner se desenvolvem a partir dos resíduos dos ductos mesonéfricos (Wolff), e não a partir dos ductos paramesonéfricos (Muller).

A letra C está incorreta. Incorreta a alternativa C, porque este cisto pode gerar sintomas, como a dispareunia, em alguns casos.

A letra D está incorreta. Incorreta a alternativa D, porque são os ductos de Wolff (mesonéfricos) que são responsáveis pela formação do cisto de Gartner.

A letra E está incorreta. Incorreta a alternativa E, porque os cistos de Gartner podem ser diagnosticados pelo exame especular.

Questão | | 2024 | 4000205767

Um ginecologista é chamado para avaliar uma paciente de 20 anos, nuligesta, apresentando dor abdominal de início há uma semana e que foi internada na enfermaria do hospital local para investigação. A data da última menstruação foi há 15 dias. Refere não utilizar método contraceptivo de maneira regular, apenas condom esporádico. Relata dispareunia e apresenta dismenorreia que melhora com uso de AINES. PA 120x60 mmHg, FC 90 bpm, Sat. O2 99%, T. axilar 38,4 °C. Ao exame abdominal, leve dor à palpação superficial de região suprapúbica e o exame ginecológico apresenta corrimento de coloração amarelada proveniente do colo uterino associado à dor à mobilização do colo uterino. O exame ultrassonográfico revela sinal da roda dentada. Diante desse caso clínico, assinale a principal hipótese diagnóstica e a conduta adequada.

- A)** Doença inflamatória pélvica / O tratamento deve ser realizado obrigatoriamente em domicílio com antibioticoterapia via oral.
- B)** O sinal da roda dentada mostra que se trata de um quadro de apendicite associado à doença inflamatória pélvica / A indicação é cirúrgica e deve-se iniciar antibioticoterapia.
- C)** Pielonefrite complicada por uretrite / Realizar internação e antibioticoterapia endovenosa.
- D)** A principal suspeita, diante do sinal da roda dentada, é gestação ectópica / Realizar internamento e solicitar beta quantitativo a cada 48 horas.
- Doença inflamatória pélvica / Realizar internação, sendo possível iniciar ceftriaxona e
- E)** metronidazol endovenoso e, à medida que a paciente melhorar e não apresentar mais quadro febril, o esquema pode ser trocado para via oral.

Solução

Doença inflamatória pélvica / Realizar internação, sendo possível iniciar

Gabarito: E) ceftriaxona e metronidazol endovenoso e, à medida que a paciente melhorar e não apresentar mais quadro febril, o esquema pode ser trocado para via oral.

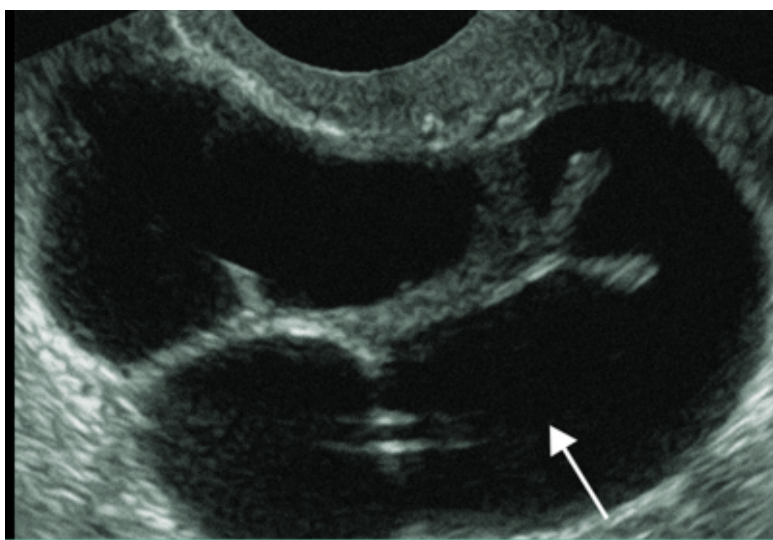
O diagnóstico de DIP pode ser difícil devido à ampla variedade de sinais e sintomas. Esse fato faz com que o diagnóstico seja feito de forma tardia, podendo aumentar as chances de complicações agudas e tardias. Nem mesmo a história clínica, o exame físico e os testes laboratoriais são sensíveis ou específicos o suficiente para chegarmos ao diagnóstico.

A laparoscopia pode ser empregada como ferramenta diagnóstica, tendo um papel importante nos casos em que o acometimento já alcançou as tubas uterinas, apresentando um valor preditivo positivo entre 65% e 90%. Porém, a videolaparoscopia não tem papel no diagnóstico quando a infecção ainda está restrita ao endométrio.

O diagnóstico da DIP é considerado clínico, apresentando sensibilidade de 87%, e especificidade de 50%. Devido à heterogeneidade de sintomas e a fim de evitar que haja perda de diagnósticos foram desenvolvidos critérios diagnósticos bem definidos para a doença inflamatória pélvica que se encontram no quadro abaixo:

CRITÉRIOS DIAGNÓSTICOS DE DIP		
MAIORES	MENORES	ELABORADOS
• Dor abdominal ou infraumbilical. • Dor à palpação anexial. • Dor à mobilização do colo uterino.	• Temperatura axilar maior que 38,3º C. • Conteúdo cervical ou vaginal anormal. • Massa pélvica. • Leucocitose em sangue periférico. • Proteína C reativa ou velocidade de hemossedimentação aumentadas. • Mais de cinco leucócitos por campo de imersão em secreção de endocérvice. • Comprovação laboratorial de infecção por Clamídia, Gonococo ou Micoplasma.	• Evidência histopatológica de endometrite. • Presença de abscesso tubo-ovariano ou de fundo de saco de Douglas em estudo de imagem (USG pélvica ou ressonância magnética). • Videolaparoscopia com evidências de DIP.
DIAGNÓSTICO: TRÊS CRITÉRIOS MAIORES + UM CRITÉRIO MENOR OU UM CRITÉRIO ELABORADO ISOLADAMENTE		

A ultrassonografia pélvica é o método de escolha para avaliação de pacientes com suspeita de DIP complicada com abscessos ou peritonite. Apesar de não ser fundamental para o diagnóstico, alguns achados são bem sugestivos para o quadro: espessamento de parede tubária (100% de sensibilidade), septos incompletos intratubários, sinal da roda denteada (imagem abaixo) em corte transversal (95% a 99% de especificidade), espessamento e líquido tubário, abscesso tubo-ovariano.



No caso da paciente do enunciado, ela apresenta sinais clínicos de DIP no exame físico, apesar de não fechar os critérios, porém a presença de abscesso tubo ovariano no exame de imagem é um critério elaborado. O sinal da roda dentada ou denteada indica a presença de uma coleção intratubária, o que pode ser considerado um abscesso tubáreo.

A letra A está incorreta. Alternativa "a" incorreta, pois a paciente tem indicação de internação hospitalar pela presença do abscesso. Além disso, o tratamento ambulatorial da DIP envolve o uso de ceftriaxone IM, que não pode ser realizado de maneira domiciliar.

A letra B está incorreta. Alternativa "b" incorreta, pois o sinal é específico para DIP.

A letra C está incorreta. Alternativa "c" incorreta, pois o quadro da paciente é sugestivo de DIP e não há menção a sintomas urinários.

A letra D está incorreta. Alternativa "d" incorreta, pois o sinal é típico de DIP.

A letra E está correta. Alternativa "e" correta, pois a paciente tem um critério de internação hospitalar que é a presença de abscesso tubo-ovariano. É importante salientar que o regime correto para o tratamento deveria incluir a Doxíciclina por via oral. Porém, essa é a alternativa mais adequada.

Questão | | 2024 | 4000205768

Diversos fatores de risco genéticos, ambientais e reprodutivos foram associados ao desenvolvimento do câncer de ovário, sendo que cerca de 5 a 10% das pacientes apresentam predisposição genética. Nas outras 90 a 95% sem qualquer conexão genética identificável para o desenvolvimento do câncer, a maioria dos fatores de risco está relacionada com o padrão de ciclos ovulatórios durante os anos reprodutivos. Sobre esse tema, assinale a alternativa INCORRETA.

- A)** Os carcinomas epiteliais ovarianos representam entre 90 e 95% dos casos, incluindo os tumores mais indolentes com baixo potencial de malignidade.
- B)** O uso em longo prazo de contraceptivos orais combinados reduz o risco de câncer de ovário. A duração de tal proteção chega a 25 anos após a última dose.
- C)** As pacientes sem filhos apresentam risco dobrado de câncer de ovário. Entre as nulíparas, aquelas com história de infertilidade apresentam risco mais baixo de desenvolver o câncer.
- D)** Em geral, o risco é reduzido a cada nascido vivo, atingindo um platô nas mulheres que tenham dado à luz cinco vezes.
- E)** A incidência geral de câncer de ovário aumenta com a idade, até em torno dos 75 anos, antes de declinar levemente entre mulheres com mais de 80 anos.

Solução

As pacientes sem filhos apresentam risco dobrado de câncer de ovário. Entre as

Gabarito: C) nulíparas, aquelas com história de infertilidade apresentam risco mais baixo de desenvolver o câncer.

Devido ao componente multifatorial da gênese do câncer de ovário, existem diversos fatores de risco associados à sua ocorrência. O principal fator de risco para essa neoplasia é o antecedente familiar de câncer de ovário e de mama, sobretudo em parentes de primeiro grau. Os demais fatores de risco estão associados à exposição a ciclos ovulatórios sem interrupção ao longo da vida, pois o estímulo ao epitélio ovariano parece estar associado à carcinogênese.

FATORES DE RISCO PARA CÂNCER DE OVÁRIO
FATORES DE RISCO BEM ESTABELECIDOS PARA CÂNCER DE OVÁRIO
- Idade - a incidência aumenta com a idade; - Menarca precoce e menopausa tardia - aumento do número de ciclos ovulatórios; - Mutação no BRCA (breast cancer gene) 1 e 2; - Síndrome de Lynch - 1% das portadoras dessa doença tem câncer de ovário; - Nuliparidade; - Endometriose - risco total baixo, mas aumento do risco para os subtipos endometrióticos e de células claras.
FATORES DE RISCO CONTROVERSOS PARA CÂNCER DE OVÁRIO
- Obesidade; - Uso de talco no trato genital; - Tabagismo - risco aumentado para câncer de ovário do tipo mucinoso; - Uso de anti-inflamatórios; - Tratamento para infertilidade; - Exposição ao asbesto.

É importante que você saiba que essa foi uma questão integralmente baseada no trecho do livro Ginecologia de Williams em que os fatores de risco para o câncer de ovário são abordados. Vou trazer os excertos nas alternativas.

A letra A está incorreta. Alternativa "a" correta, pois de fato os tumores epiteliais representam a maior parte das neoplasias malignas do ovário. Os dados foram tirados desse trecho:

"Os carcinomas epiteliais ovarianos representam entre 90 e 95% dos casos, incluindo os tumores mais indolentes com baixo potencial de malignidade (border- line) (Quirk, 2005). "

A letra B está incorreta. Alternativa "b" correta, pois a anovulação induzida pelos contraceptivos é um fator de proteção para o câncer de ovário.

"Presumivelmente por também evitar a ovulação, o uso em longo prazo de contraceptivos orais combinados (COCs) reduz em 50% o risco de câncer de ovário. A duração de tal proteção chega a 25 anos após a última dose (Riman, 2002)."

A letra C está correta. Alternativa "c" incorreta, pois apesar de ser um fator de risco controverso, estudos apontam que a infertilidade possa ser um fator de risco. A maioria das bibliografias diz que é o tratamento da infertilidade que aumentaria o risco, porém na bibliografia usada pela banca ele diz que independe da realização de tratamentos.

"A nuliparidade está associada a longos períodos com ovulações repetidas, e as pacientes sem filhos apresentam risco dobrado de câncer de ovário (Purdie, 2003). Entre as nulíparas, aquelas com história de infertilidade apresentam risco ainda mais alto."

A letra D está incorreta. Alternativa "d" correta, pois a multiparidade é um fator de proteção e o dado da alternativa foi extraído integralmente do livro Ginecologia de Williams.

"Em geral, o risco é reduzido a cada nascido vivo, atingindo um platô nas mulheres que tenham dado à luz cinco vezes (Hinkula, 2006)."

A letra E está incorreta. Alternativa "e" correta, pois o pico de incidência do câncer de ovário ocorre na sétima década de vida e o trecho da alternativa é uma reprodução íntegra do livro.

"A incidência geral de câncer de ovário aumenta com a idade até em torno dos 75 anos antes de declinar levemente entre mulheres com mais de 80 anos"

Questão | | 2024 | 4000205769

Em relação ao sistema cardiovascular fetal, assinale a alternativa correta.

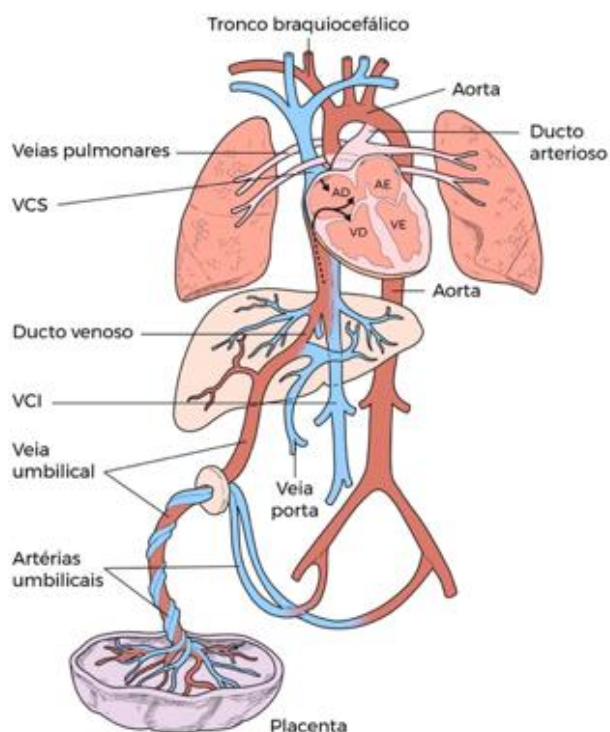
- A)** Aproximadamente 10% do retorno venoso ao coração fetal é originário da veia cava inferior, sendo que cerca de um terço desse volume é de responsabilidade do ducto venoso.
- B)** O forame oval comunica o ventrículo direito e o ventrículo esquerdo.
- C)** A maior saturação de oxigênio da circulação fetal encontra-se na veia cava inferior infra-hepática.
- D)** Medicamentos inibidores de prostaglandinas, como os anti-inflamatórios não hormonais, têm potencial para provocar o fechamento do canal arterial e causar hipertensão pulmonar antes do nascimento.
- E)** O sistema nervoso central, o miocárdio e a parte superior do corpo do feto recebem sangue ejetado pelo ventrículo direito.

Solução

Medicamentos inibidores de prostaglandinas, como os anti-inflamatórios não hormonais, têm potencial para provocar o fechamento do canal arterial e causar hipertensão pulmonar antes do nascimento.

O que o examinador quer saber: sobre a circulação fetal.

O coração fetal e seu sistema de condução desenvolvem-se entre a 3ª e a 6ª semanas de vida embrionária. O sistema cardiovascular fetal difere do extrauterino anatômica e funcionalmente, pois apresenta quatro comunicações que se fecham após o nascimento e são responsáveis por manter a adequada oxigenação no período intrauterino: vasos umbilicais, ducto venoso, forame oval e canal arterial.



Observe que o sangue oxigenado que chega pela veia umbilical vai para o ducto venoso, que é uma comunicação entre a veia umbilical e a veia cava inferior. Percorrendo a veia cava inferior, o sangue oxigenado vai ao átrio direito, mas uma parte passa para o átrio esquerdo pela comunicação entre essas duas cavidades, chamada de forame oval.

O sangue oxigenado que chega ao átrio esquerdo pelo forame oval mistura-se com o sangue pouco oxigenado vindo das veias pulmonares, uma vez que na vida intrauterina não há oxigenação sanguínea pulmonar. O sangue do átrio esquerdo vai para o ventrículo esquerdo e depois para as coronárias e a aorta ascendente, nutrindo principalmente o sistema nervoso central e a parte superior do corpo fetal.

O restante do sangue que fica no átrio direito vai para o ventrículo direito e, em seguida, para as artérias pulmonares. A maior parte do sangue que chega às artérias pulmonares passa para a aorta descendente através do canal arterial ou ducto arterial, nutrindo a parte inferior do corpo do feto, sendo que apenas uma pequena parte do sangue das artérias pulmonares vai para os pulmões.

Após o nascimento, os vasos umbilicais, o forame oval, o ducto venoso e o canal arterial fecham-se. Além disso, ocorre a vasodilatação das artérias pulmonares, com aumento do fluxo sanguíneo para os pulmões e queda da pressão das artérias pulmonares, levando a um aumento da resistência vascular periférica e queda da resistência da circulação pulmonar.



A letra A está incorreta. Incorreta a alternativa A: quase todo o retorno venoso que chega ao coração é originário da veia cava inferior e passa pelo ducto venoso.

A letra B está incorreta. Incorreta a alternativa B: o forame oval comunica o átrio direito e o ventrículo direito.

A letra C está incorreta. Incorreta a alternativa C: a maior saturação de oxigênio da circulação fetal encontra-se na veia cava inferior supra-hepática, onde chega o sangue oxigenado da veia umbilical pelo ducto venoso.

A letra D está correta. Correta a alternativa D: durante a vida intrauterina, as prostaglandinas E1 e E2 produzidas pelo feto e pela placenta são fundamentais para manter o canal arterial pérvio. Por isso, não se devem usar anti-inflamatórios que inibem a produção de prostaglandinas, pois podem levar ao fechamento do canal arterial precocemente.

A letra E está incorreta. Incorreta a alternativa E: o sistema nervoso central, o miocárdio e a parte superior do corpo do feto recebem sangue ejetado do ventrículo esquerdo.

Questão | | 2024 | 4000205770

Uma gestante G2P1, com 38 semanas, iniciou contrações de forte intensidade e apresentou um parto taquitócico por via vaginal. Após a dequitação placentária, iniciou com hemorragia puerperal. Em relação ao caso, assinale a alternativa correta.

- A)** A hemorragia apresentada é classificada como uma hemorragia pós-parto secundária.
- B)** Hemorragia pós-parto vaginal é a perda sanguínea acima de 500 ml.
- C)** A laceração de trajeto é a principal hipótese diagnóstica desse caso.

- D)** Hemorragia pós-parto vaginal é a perda sanguínea acima de 1000 ml.
- E)** Realizar o clampeamento do cordão umbilical após 30 segundos, na ausência de contraindicações, ajuda na prevenção da hemorragia.

Solução

Gabarito: B) Hemorragia pós-parto vaginal é a perda sanguínea acima de 500 ml.

O que o examinador quer saber: sobre hemorragia pós-parto.

As principais causas de HPP estão resumidas no mnemônico dos “4Ts”, conforme a tabela a seguir:

TABELA 1: CAUSAS DE HEMORRAGIA PÓS-PARTO		
4 TS	CAUSA ESPECÍFICA	FREQUÊNCIA
TÔNUS	Atonia uterina	70%
TRAUMA	Laceração, hematoma, inversão e rotura uterina	19%
TECIDO	Retenção de tecido placentário, coágulos e acretismo placentário	10%
TROMBINA	Coagulopatias e uso de anticoagulantes	1%

Como podemos ver, a atonia é a principal causa de HPP, correspondendo a mais de dois terços dos casos e, por isso, deve ser a primeira etiologia a ser investigada. O outro quase um terço engloba as causas de trauma e tecido, sendo laceração e retenção de tecido placentário a segunda e a terceira causas mais importantes, respectivamente. Por sua vez, as coagulopatias são causas muito raras e devem ser pesquisadas somente se a história for sugestiva ou se as condutas para as causas mais comuns não tiverem sido efetivas.

A letra A está incorreta. Incorreta a alternativa A: podemos classificar a HPP em primária e secundária, a depender do momento em que o sangramento ocorreu. A HPP primária ocorre nas primeiras 24 horas e é a mais comum. Já a HPP secundária pode ocorrer entre 24 horas a 6 semanas pós-parto e é mais rara.

A letra B está correta. Correta a alternativa B: a hemorragia pós-parto caracteriza-se clinicamente por sangramento maior que o esperado, que resulta em sinais e sintomas de hipovolemia e instabilidade hemodinâmica. Outra definição utilizada é a perda sanguínea estimada maior ou igual a 500ml no parto vaginal ou maior ou igual a 1.000ml na cesárea, nas primeiras 24 horas pós-parto.

A letra C está incorreta. Incorreta a alternativa C: a principal hipótese diagnóstica para esse caso é a atonia uterina. Laceração de trajeto é a segunda causa mais provável de hemorragia pós-parto, mesmo nos casos de parto taquitócico.

A letra D está incorreta. Incorreta a alternativa D: considera-se hemorragia pós-parto a perda sanguínea estimada maior ou igual a 500ml no parto vaginal ou maior ou igual a 1.000ml na cesárea, nas primeiras 24 horas pós-parto.

A letra E está incorreta. Incorreta a alternativa E: o clampeamento do cordão umbilical deve ser tardio, isto é, pelo menos após 1 minuto do nascimento do concepto.

Questão | | 2024 | 4000205771

Com as novas práticas obstétricas e o aumento das indicações de cesariana, o uso do fórceps vem reduzindo, mas este ainda é um instrumento imprescindível em algumas situações. Sobre esse assunto, é correto afirmar que

- A)** a variedade de posição occípitosacra é direta, isto é, não há necessidade de rotação.
- B)** para a variedade de posição occipitopúbica, o melhor fórceps é o de Piper.
- C)** com o fórceps de Simpson, é feito um giro como “chave na fechadura”.
- D)** nas variedades posteriores oblíquas, o fórceps de Simpson é o mais indicado, pois facilita a rotação.
- E)** a manobra de Lachapelle é o duplo movimento espiroidal: abaixamento e torção.

Solução

Gabarito: A) a variedade de posição occípitosacra é direta, isto é, não há necessidade de rotação.

O que o examinador quer saber: sobre o uso de fórcepe.

Os quatro tipos de fórcepe mais utilizados na prática obstétrica são: Simpson-Braun, Kielland, Luikart e Piper. Todos os fórcepes apresentam dois ramos, cada um deles é constituído por colher, articulação e cabo, sendo que a colher apresenta curvatura que se adapta à cabeça fetal (curvatura cefálica) e que se ajusta à pelve materna (curvatura pélvica), a articulação conecta um ramo ao outro e o cabo é o local que o obstetra segura.

O fórcepe de Simpson-Braun é o mais utilizado de todos os fórcepes, ele apresenta colher fenestrada com curvatura pélvica acentuada e articulação fixa. É usado para as variedades oblíquas e pegadas diretas (OP e OS), uma vez que não pode ser usado para rotação maior do que 45 graus.

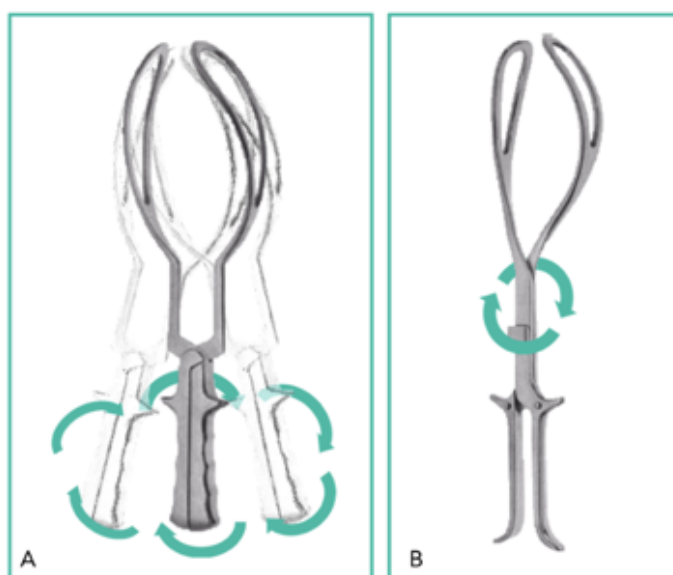
O fórcepe de Kielland apresenta colheres com curvatura pélvica menor e articulação deslizante, permitindo a correção do assinclitismo e o seu uso para rotação, por isso, pode ser usado em todas as variedades de posição, inclusive nas transversas.

Seguindo a mesma linha, o fórcepe de Luikart tem as mesmas características do Kielland, mas suas colheres não são fenestradas, o que distribui melhor a pressão exercida por ele no polo cefálico. O fórcepe de Piper, por sua vez, apresenta curvatura cefálica e pélvica pouco pronunciada e articulação por encaixe, sendo utilizado nas apresentações pélvicas quando há cabeça derradeira.

A letra A está correta. Correta a alternativa A: nas variedades de posição occiptossacra e occiptopúbica a pega é direta, não sendo necessário a rotação da cabeça fetal.

A letra B está incorreta. Incorreta a alternativa B: o fórcepe de Piper é utilizado nas apresentações pélvicas com cabeça derradeira. Nas variedades de posição occipitopúbica o melhor fórcepe é o de Simpson.

A letra C está incorreta. Incorreta a alternativa C: a rotação deve ser realizada por meio do movimento “chave em fechadura” nos fórcepes que não apresentam curvatura acentuada (Kielland e Luikart) ou por movimento amplo de circundação dos cabos naqueles com curvatura pélvica acentuada (Simpson-Braun).



A letra D está incorreta. Incorreta a alternativa D: nas variedades posteriores obliquas há necessidade de rotação de 135 graus, sendo assim, o fórcepe mais indicado é o de Kielland que permite rotações maiores do que 45 graus.

A letra E está incorreta. Incorreta a alternativa E: a manobra de Lachapelle corresponde ao triplo movimento espiroidal: abaixamento, translação e torção.

Questão | | 2024 | 4000205772

Considerando as alternativas a seguir, qual apresenta uma indicação de investigação para trombofilias adquiridas?

A) Quadro de trombose venosa profunda após trauma.

- B)** Investigação recomendada após o 1º quadro de aborto.
- C)** História familiar positiva para tromboembolismo venoso.
- D)** Se houver necrose de pele associada ao uso de antagonistas da vitamina K.
- E)** Perda fetal tardia.

Solução

Gabarito: E) Perda fetal tardia.

Trombofilias são condições em que há um aumento do risco trombótico, podendo ser **congenitas (hereditárias)** ou **adquiridas**. Nesta questão, vamos nos focar nas causas somáticas de trombofilia, ou seja, aquelas que não estão presentes ao nascimento, mas sim surgem ao longo da vida. As três principais trombofilias adquiridas que você deve se lembrar, Estrategista, são a **SAF**, as **neoplasias** e a **HPN**.

A mais cobrada nas provas, sem dúvidas, é a **SAF**, síndrome do anticorpo antifosfolípide. Trata-se como uma doença autoimune em que, de forma não totalmente esclarecida, há desenvolvimento de **anticorpos contra fosfolípidos** e o surgimento de um quadro clínico marcado por **morbidade gestacional** e **tendência à trombose venosa e arterial**. O diagnóstico desta condição é **clínico-laboratorial**, com critérios listados abaixo, e o tratamento é a **anticoagulação perene**.

Critérios diagnósticos para a SAF	
Critérios clínicos	Critérios laboratoriais
Trombose: um ou mais episódios de trombose venosa, arterial ou de pequenos vasos confirmada em qualquer tecido ou órgão	Anticoagulante lúpico detectado em duas ou mais ocasiões com pelo menos 12 semanas de intervalo
Morbidade gestacional: A) Três ou mais abortos espontâneos consecutivos, com menos de 10 semanas de gestação; B) Uma ou mais morte de feto normal com mais de 10 semanas; ou C) Um ou mais partos prematuros com menos de 34 semanas por eclâmpsia, pré-eclâmpsia grave ou insuficiência placentária.	Anticorpo anticardiolipina IgG ou IgM em título médio a alto, detectado em duas ou mais ocasiões, com pelo menos 12 semanas de intervalo Anticorpo anti-beta-2-glicoproteína-1 detectado em duas ou mais ocasiões, com pelo menos 12 semanas de intervalo
Diagnóstico de SAF: pelo menos 1 critério clínico e 1 critério laboratorial	

Neoplasias também são uma causa importante de trombose. A presença de câncer ativo, por si só, aumenta o risco trombogênico em quatro a sete vezes e aproximadamente 20% de todos os eventos tromboembólicos ocorrem em pacientes com câncer. A **HPN** (hemoglobinúria paroxística noturna), por sua vez, é uma doença hematológica de patogênese complexa, marcada por uma tríade clínico-laboratorial de **pancitopenia, anemia hemolítica intravascular e trombose em sítios incomuns**.

Outros fatores trombogênicos importantes são o tabagismo, a obesidade, a gestação, os procedimentos cirúrgicos de grande porte, como cirurgias ortopédicas, o uso de medicações, como estrogênios, e a síndrome nefrótica.

Após lembrar das principais trombofilias adquiridas, vamos às alternativas:

A letra A está incorreta. Incorreto. O trauma é, por si só, uma condição que aumenta o risco de trombose. Logo, não há necessidade de pesquisarmos trombofilias em pacientes que apresentam trombose após trauma.

A letra B está incorreta. Incorreto. Como vimos acima, o diagnóstico de SAF é feito com achado de três ou mais abortos consecutivos, devendo ser pesquisada nesta situação clínica.

A letra C está incorreta. Incorreto. Histórico familiar de trombose nos faz pensar em uma trombofilia hereditária/congênita, e não adquirida.

A letra D está incorreta. Incorreto. A necrose cutânea induzida por varfarina ocorre por uma característica intrínseca da medicação: a varfarina tem um efeito pró-coagulante nos primeiros dias, por depletar os anticoagulantes naturais proteína C e proteína S. É por isso que usamos algum anticoagulante de ponte no início do uso de varfarina.

A letra E está correta. Perfeito. Como vimos, perda fetal tardia é um dos critérios diagnósticos de SAF e, assim, indica a pesquisa desta condição.

Questão | | 2024 | 4000205773

Sobre a restrição de crescimento intrauterino, assinale a alternativa correta.

- A)** O primeiro exame a ser solicitado, após o resultado de peso inferior ao percentil 10 (ultrassonografia), é o Doppler de artéria umbilical.
- B)** Pode-se classificar a restrição de crescimento em tipo I (assimétrico) e tipo II (simétrico).
- C)** A restrição de crescimento de início precoce ocorre antes da 28ª semana.
- D)** Como critério de anormalidade para a artéria cerebral média, utiliza-se o PI abaixo do percentil 95 para a idade gestacional.
- E)** Iniciar heparina quando houver o diagnóstico de restrição fetal.

Solução

Gabarito: A) O primeiro exame a ser solicitado, após o resultado de peso inferior ao percentil 10 (ultrassonografia), é o Doppler de artéria umbilical.

O que o examinador quer saber: sobre restrição de crescimento fetal.

A restrição de crescimento fetal (RCF), também conhecida como restrição de crescimento intrauterino (RCIU) é um termo usado para descrever o feto que não está crescendo em todo seu potencial devido a algum processo patológico.

Para a definição correta de RCF, é necessário avaliar o peso fetal, a circunferência abdominal fetal e a Dopplervelocimetria obstétrica.

Quando o peso fetal está abaixo do percentil 10 para a idade gestacional, podemos estar diante de um feto pequeno para idade gestacional (PIG) constitucional ou de um feto com restrição de crescimento. Muitas vezes, é difícil diferenciar um feto que tem restrição de crescimento, daquele que é constitucionalmente pequeno e não apresenta um processo patológico, mas essa diferenciação é muito importante, visto que 70% dos fetos com peso abaixo do percentil 10 são apenas pequenos constitucionais e não apresentarão complicações.

O que ajuda nessa diferenciação é a presença de alterações do Doppler, circunferência abdominal abaixo do percentil 10 para a idade gestacional e diminuição da velocidade de crescimento fetal nos fetos com restrição de crescimento.

Contudo, quando não há possibilidade de se realizar ultrassonografia com Doppler, considera-se todo feto com percentil abaixo de 10 para a idade gestacional como restrição de crescimento.

A letra A está correta. Correta a alternativa A: diante de feto com peso abaixo do percentil 10 é importante diferenciar um feto pequeno para a idade gestacional de um feto com restrição de crescimento. Os exames que ajudam nessa diferenciação são a Dopplervelocimetria obstétrica com avaliação da artéria umbilical, a avaliação da circunferência abdominal e também a realização de ultrassonografia seriada para avaliar a velocidade de crescimento fetal.

A letra B está incorreta. Incorreta a alternativa B: a restrição de crescimento tipo I é a simétrica e a tipo II é a assimétrica.

CLASSIFICAÇÃO DA RESTRIÇÃO DE CRESCIMENTO FETAL		
TIPO I - SIMÉTRICO	TIPO II - ASSIMÉTRICO	TIPO III - MISTO
20% dos casos	75% dos casos	5-10% dos casos
Causas presentes desde o início da gestação	Agressão ocorre mais tardiamente na gravidez	Agressão nas fases de hiperplasia e hipertrofia celular
Feto com crescimento proporcional	Desproporção entre o polo cefálico e o restante do corpo fetal	Pode ser proporcional ou desproporcional
Malformações fetais	Insuficiência placentária	Desnutrição materna
Alterações cromossômicas	Hipertensão arterial	Uso de drogas
Infecção congênita	Doenças autoimunes	Tabagismo e etilismo
Sem hipóxia fetal	Pode levar à hipóxia fetal	Pode levar à hipóxia fetal

A letra C está incorreta. Incorreta a alternativa C: a restrição de crescimento é classificada em precoce ou tardia a depender da idade gestacional em que ela surge. Se a RCF aparecer antes de 32 semanas, considera-se RCF precoce; se surgir após 32 semanas, considera-se RCF tardia.

A letra D está incorreta. Incorreta a alternativa D: considera-se alterada a Dopplervelocimetria da artéria cerebral média, quando o índice de pulsatilidade está abaixo do percentil 5, isto é, quando esse vaso apresenta baixa resistência, mostrando uma centralização de fluxo fetal.

A letra E está incorreta. Incorreta a alternativa E: não há tratamento medicamentoso para restrição de crescimento fetal, sendo assim a heparina não está indicada nesses casos.

Questão | | 2024 | 4000205774

Paciente de 19 anos, G3C2 (dois filhos vivos), questiona seu médico sobre a realização de laqueadura intraparto. Dentre as seguintes recomendações, qual seria a correta de acordo com a nova lei da laqueadura?

- A)** Ela precisará do consentimento expresso do cônjuge para realizar o procedimento.
- B)** Será necessário aguardar os 21 anos para realizar a laqueadura.
- C)** Será necessário ter o termo de consentimento assinado com data de, pelo menos, 60 dias anteriores ao procedimento.
- D)** Será necessário aguardar seis meses após o parto para realizar a laqueadura.
- E)** A paciente deve ser orientada que será realizada salpingectomia bilateral.

Solução

Gabarito: C) Será necessário ter o termo de consentimento assinado com data de, pelo menos, 60 dias anteriores ao procedimento.

Estrategista, esta é uma questão sobre a lei da laqueadura. Os pontos principais dessa lei são:

1. QUEM PODE?

- Homens e mulheres;
- Idade igual ou superior a 21 anos OU dois filhos vivos;
- Risco de vida à mulher ou ao futuro conceito->assinado por 2 médicos;

2. Manifestação da vontade por escrito -> prazo de 60 dias entre a manifestação do desejo e o procedimento;

3. Permitida a esterilização cirúrgica no parto ou aborto;

4. Proibida esterilização por histerectomia ou ooforectomia;

5. Se sociedade conjugal -> não é necessária a assinatura do cônjuge;

6. PENA:

- reclusão de 2-8 anos e multa.

Agora vamos analisar as alternativas:

A letra A está incorreta. Incorreta a alternativa A, porque não é necessário o consentimento do cônjuge para realizar a laqueadura.

A letra B está incorreta. Incorreta a alternativa B, porque a paciente já tem dois filhos vivos.

A letra C está correta. Correta a alternativa C: é necessária a manifestação da mulher por escrito, pelo menos 60 dias antes da realização do procedimento.

A letra D está incorreta. Incorreta a alternativa D, porque a laqueadura pode ser realizada no momento do parto.

A letra E está incorreta. Incorreta a alternativa E, porque a lei se refere a realização de laqueadura tubária, e não a realização de salpingectomia bilateral ou ooforectomia ou histerectomia.

Questão | | 2024 | 4000205775

Durante um plantão no pronto-socorro obstétrico, o médico avalia uma paciente de 10 semanas de gestação apresentando múltiplas vesículas em região vaginal com diagnóstico clínico de herpes genital, sendo a primo-infecção. Quanto ao tratamento para esse caso, é correto indicar

- A)** aciclovir 400 mg uma vez ao dia por 6 meses.
- B)** fanciclovir 100 mg três vezes ao dia por 10 dias.
- C)** valaciclovir 1000 mg 1 vez ao dia por 5 dias.
- D)** aciclovir 400 mg três vezes ao dia por 7 dias.
- E)** fanciclovir 50 mg a cada 5 horas, pulando a dose da madrugada.

Solução

Gabarito: D) aciclovir 400 mg três vezes ao dia por 7 dias.

O que o examinador quer saber: sobre o tratamento de herpes genital na gestação.

O vírus causador da herpes simples é membro da família Herpesviridae, os principais tipos são o herpes-vírus tipo 1 e tipo 2.

A infecção intrauterina é muito rara e não há rastreio sorológico no pré-natal. A maior parte dos casos é transmitida durante o parto pelo contato do neonato com lesões no trato genital materno. Outra forma de transmissão é a pós-natal, através do contato com lesões ativas. O primeiro episódio na mulher pode ser bem doloroso e sintomático. Inicialmente aparece dor e prurido genital e posteriormente aparecem pústulas e vesículas que se transformam em múltiplas úlceras dolorosas. Os episódios recorrentes geralmente têm sintomas menos intensos.

Quando o primeiro episódio ocorre durante a gestação, no primeiro e no segundo trimestre há um aumento do risco de abortamento e perda fetal. A transmissão intraútero pode ocorrer, mas é rara. O maior risco de transmissão neonatal acontece quando a infecção se dá no terceiro trimestre e ocorre contato com o vírus no momento do parto.

O diagnóstico na maioria das vezes é clínico, mas o método diagnóstico mais fidedigno é o isolamento e a cultura ou PCR viral em tecidos e sangue. A sorologia não serve para

confirmar o diagnóstico pois demora 6-8 semanas para positivar. Exames complementares devem ser solicitados para avaliação clínica: hemograma, função hepática, função renal e coleta de líquido. Exames de imagem devem ser solicitados conforme necessário. Na gestante, o tratamento é feito com aciclovir, tentando evitar tratamento no primeiro trimestre apesar de estudos não mostrarem aumento do risco de malformações fetais. A dose para o tratamento das lesões agudas na gestante é de 400 mg 3x ao dia ou 200 mg 5x ao dia, via oral, por 7 a 10 dias. A prevenção da herpes congênita deve ser realizada em todas as gestantes que já foram infectadas. Para isso, deve-se utilizar aciclovir por volta da 36ª semana de gestação mesmo na ausência de sintomas, em gestantes com herpes genital prévia, para prevenir a recorrência no termo e evitar o parto cesáreo. Caso a gestante apresente o primeiro episódio de herpes genital no momento do parto ou até 6 semanas antes, é indicado realizar o parto cesáreo, apesar de não haver nenhum estudo randomizado que mostre a efetividade da cesárea em prevenir transmissão de herpes neonatal. Frente à infecção herpética genital recorrente no momento do parto, também está indicado o parto cesáreo. Além disso, orienta-se suspender o aleitamento se houver comprometimento das mamas da puérpera. Orientar também que pessoas com lesões ativas não devem tocar no bebê. O RN infectado deve ser mantido em isolamento de contato.

Dose profilática a partir de 36 semanas para todas as gestantes com história prévia de herpes genital : aciclovir 400 mg 3x ao dia , via oral, até o parto.

A letra A está incorreta. Incorreta a alternativa A: esta dosagem de aciclovir e duração são inadequadas para o tratamento agudo da herpes genital.

A letra B está incorreta. Incorreta a alternativa B: o tratamento de escolha para herpes genital na gestação é feito com aciclovir.

A letra C está incorreta. Incorreta a alternativa C: o tratamento de escolha para herpes genital na gestação é feito com aciclovir.

A letra D está correta. Correta a alternativa D: durante a gestação o tratamento de escolha para herpes genital aguda é feito com aciclovir na dose de 400 mg 3x ao dia ou 200 mg 5x ao dia, via oral, por 7 a 10 dias.

A letra E está incorreta. Incorreta a alternativa E: o tratamento de escolha para herpes genital na gestação é feito com aciclovir.

Questão | | 2024 | 4000205776

Primigesta de 36 semanas chega ao pronto-socorro apresentando PA de 160x100 mmHg associada à turvação visual e cefaleia. A vitalidade fetal está preservada. Diante desse caso,

qual é a melhor conduta?

- A)** Iniciar Metildopa 250 mg uma vez ao dia para controle pressórico.
- B)** Nitroprussiato de sódio é a primeira opção para esse quadro.
- C)** Realizar dipirona e aferir a pressão arterial após 4 horas da analgesia.
- D)** Indicar a cesárea de forma imediata, visto que só haverá controle pressórico após a resolução da gestação.
- E)** Realizar sulfato de magnésio a 50% e deixar aspirado gluconato de cálcio em cabeceira do leito.

Solução

Gabarito: E) Realizar sulfato de magnésio a 50% e deixar aspirado gluconato de cálcio em cabeceira do leito.

O que o examinador quer saber: sobre iminência de eclâmpsia.

A eclâmpsia é a complicação mais severa da pré-eclâmpsia, caracterizada por convulsões tônico-clônicas generalizadas na ausência de outras causas, como epilepsia, aneurisma e isquemia cerebral ou uso de drogas, podendo ser diagnosticada antes, durante ou após o parto. Essa doença é uma importante causa de morte materna e está associada à hipóxia, trauma e pneumonia aspirativa.

O diagnóstico de eclâmpsia é eminentemente clínico, com presença de convulsões tônico-clônicas generalizadas, mas raramente pode manifestar-se com convulsões focais ou síndrome HELLP. Algumas vezes, a eclâmpsia pode surgir mesmo antes do diagnóstico de pré-eclâmpsia.

Na maioria das vezes, a convulsão é precedida de sinais clínicos que chamamos de iminência de eclâmpsia: cefaleia frontal ou occipital persistente, turvação visual, escotomas, fotofobia, alteração do estado mental e hiperreflexia, epigastralgia ou dor em hipocôndrio direito.

Quadro clássico de iminência de eclâmpsia: cefaleia, turvação visual e epigastralgia.

A conduta inicial frente a uma paciente com iminência de eclâmpsia ou eclâmpsia deve ser: chamar ajuda, conter a paciente para evitar trauma, mantê-la em decúbito lateral e colocar protetor de língua para evitar aspiração, fornecer oxigenioterapia e realizar monitorização dos sinais vitais. Somente então deve-se iniciar o tratamento medicamentoso que é feito com sulfato de magnésio.

O sulfato de magnésio é a medicação de escolha na prevenção das convulsões nos casos de pré-eclâmpsia grave, iminência de eclâmpsia e durante o tratamento na eclâmpsia.

A convulsão na eclâmpsia é, geralmente, autolimitada; na maioria das vezes, cessa mesmo antes da administração de sulfato de magnésio. Contudo, o sulfato de magnésio é usado não só para controlar a convulsão, mas também para prevenção de novos episódios convulsivos.

A resolução da gestação deve ocorrer em todos os casos de iminência de eclâmpsia ou eclâmpsia depois que a gestante receber o sulfato de magnésio e apresentar estabilização do quadro clínico. Não é indicado manter a gestação, independentemente da idade gestacional, pois os riscos maternos são muito elevados. A administração de corticoterapia abaixo de 34 semanas pode ser realizada, mas não deve ser motivo para adiar o parto. Deve-se dar

preferencia ao parto vaginal, se não houver contraindicação, o trabalho de parto pode ser induzido.



A letra A está incorreta. Incorreta a alternativa A: como a paciente apresenta quadro de iminência de eclâmpsia e hipertensão arterial grave, o uso da metildopa não está indicado. A metildopa é utilizada quando a PA está < 160 x 110 mmHg.

A letra B está incorreta. Incorreta a alternativa B: a primeira medicação que deve ser administrada nesse caso é o sulfato de magnésio. Se a paciente mantiver hipertensão arterial grave após o uso do sulfato de magnésio, deve-se administrar hidralazina ou nifedipina para controle pressórico. o nitroprussiato de sódio é medicação de segunda opção nos casos de hipertensão arterial grave.

A letra C está incorreta. Incorreta a alternativa C: como a paciente tem quadro clínico compatível com iminência de eclâmpsia, ela deve ser internada e receber sulfato de magnésio o mais rápido possível.

A letra D está incorreta. Incorreta a alternativa D: diante de um quadro de iminência de eclâmpsia, deve-se primeiramente sulfatar a paciente e controlar os níveis pressóricos para depois resolver a gestação. A resolução da gestação pode ser por indução do parto, não necessita ser cesariana.

A letra E está correta. Correta a alternativa E: temos uma gestante com hipertensão arterial grave (≥ 160/110 mmHg), cefaleia e turvação visual, configurando iminência de eclâmpsia. A principal conduta diante de uma paciente com iminência de eclâmpsia é a realização de sulfato de magnésio para a prevenção de convulsões. Como há risco de intoxicação por sulfato de magnésio, deve-se manter o seu antídoto, o gluconato de cálcio 10% próximo à gestante.

Questão | | 2024 | 4000205777

Uma gestante primigesta, com idade gestacional de 6 semanas, vai à consulta de pré-natal para mostrar o resultado dos exames do primeiro trimestre que demonstraram suscetibilidade para toxoplasmose. Dentre as alternativas a seguir, assinale a que apresenta recomendações para evitar essa doença ao longo da gestação.

- A)** Não há contraindicação em utilizar a mesma faca para cortar carnes e outros vegetais ou frutas.

- B)** Toda carne deve ser cozida até atingir temperatura superior a 67° C.
- C)** Evitar qualquer tipo de carne vermelha.
- D)** Durante o primeiro trimestre, deve-se evitar ingerir verduras, pois a doença é mais grave no início da gestação.
- E)** Deve-se evitar contato direto com gatos, visto que a transmissão ocorre através do toque no felino.

Solução

Gabarito: B) Toda carne deve ser cozida até atingir temperatura superior a 67° C.

O que o examinador quer saber: sobre toxoplasmose na gestação.

Como a maioria das gestantes é assintomática, o diagnóstico da toxoplasmose é feito pela sorologia materna, com avaliação dos anticorpos IgG e IgM para toxoplasmose, solicitada no rastreamento de rotina durante o pré-natal.

Gestantes susceptíveis (podem adquirir a infecção na gestação) têm resultados negativos para os anticorpos IgG e IgM específicos para toxoplasmose e o acompanhamento deve ser feito com sorologia seriada (1-2 meses) e orientações preventivas, a depender do perfil epidemiológico da região.

As principais medidas de prevenção primária da toxoplasmose são:

- Higienização correta das mãos antes das refeições, após manusear lixo, ter contato com animais e manipular alimentos e carnes cruas.
- Manusear terra ou solo com luvas e higienizar as mãos após o término.
- Consumir apenas água filtrada ou fervida.
- Higienizar corretamente frutas e verduras (deixar de molho em solução clorada por 10 minutos).
- Congelar carnes antes do consumo.
- Não consumir carnes cruas, malcozidas ou malpassadas.
- Não consumir leite e seus derivados crus.
- Evitar contato com animais de rua.
- Alimentar gatos com ração e não deixar que façam a ingestão de carne crua ou caça.
- Evitar manipulação da caixa de areia dos gatos domésticos e o contato com as fezes dos gatos.

Se a gestante apresentar IgG positiva e IgM negativa, elas são consideradas imunes e não precisam repetir a sorologia durante o pré-natal, a não ser que sejam imunocomprometidas. Por outro lado, quando a gestante apresenta IgM positiva e IgG negativa pode ser toxoplasmose aguda ou um caso de falso positivo. Por isso, deve-se introduzir espiramicina e repetir a sorologia em 2 semanas. Se IgM mantiver positiva com IgG também positiva, trata-se de um caso de toxoplasmose aguda com soroconversão na gestação. Se o IgG não positivar, trata-se de IgM falso positivo e deve-se suspender a espiramicina.

Se a gestante apresentar IgM e IgG positivas no primeiro trimestre, deve-se introduzir espiramicina e realizar o teste de avidéz para IgG, a fim de determinar se a infecção é recente (baixa avidéz) ou tardia (alta avidéz), uma vez que os títulos de IgM podem permanecer positivos por até 1 ano e o de IgG por vários anos. Sabe-se que a capacidade de ligação e avidéz da imunoglobulina aumenta com a maturação da resposta imunológica, por

isso avidéz baixa sugere infecção recente (menos de 4 meses) e avidéz alta sugere infecção há mais de 4 m

A toxoplasmose materna aguda pode levar à transmissão vertical, causando toxoplasmose congênita. Por isso, o tratamento da toxoplasmose deve ser instituído se há suspeita ou confirmação de infecção aguda na gestação. O tratamento precoce em até 3 semanas da infecção materna diminui os riscos de infecção fetal.

Portanto, a principal conduta frente a um caso de suspeita de infecção aguda é a profilaxia para toxoplasmose congênita, com a administração materna de espiramicina na dose de 3g/dia via oral. Isso é aplicado para todas as gestantes que apresentam sorologia IgM + e IgG – ou sorologia IgM + e IgG +. A espiramicina não ultrapassa a barreira placentária, mas tem como objetivo reduzir o risco de passagem transplacentária do parasita, impedindo a infecção fetal.

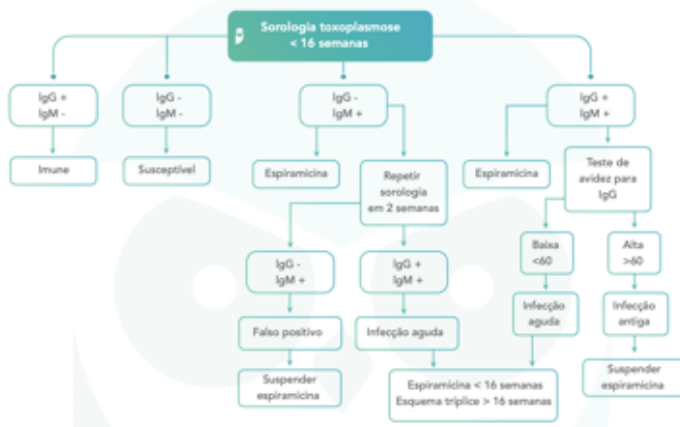
Nos casos confirmados ou prováveis de infecção aguda, isto é, se houver soroconversão, avidéz para IgG baixa ou intermediária ou ascensão dos valores de IgG em amostra seriada, deve-se fazer a pesquisa de infecção fetal a partir de 18 semanas.

Nos casos em que há dúvida se a infecção é recente ou antiga, como quando a primeira sorologia com IgG e IgM positiva é realizada após 16 semanas e o teste de avidéz já não é mais fidedigno, deve-se considerar a gestante como infecção aguda e fazer a investigar infecção fetal.

Atualmente, orienta-se utilizar espiramicina até 16 semanas e a partir de 16 semanas trocar para o esquema tríplice até realizar a pesquisa de infecção fetal.

A pesquisa de infecção fetal é realizada por meio da amniocentese, com coleta de líquido amniótico e pesquisa do DNA do *Toxoplasma gondii* por PCR. Caso a pesquisa venha positiva, estamos diante de um feto com toxoplasmose congênita (infecção fetal). Se a pesquisa de infecção fetal vier negativa, trocar por espiramicina e até o parto. Se a infecção fetal for confirmada, manter tratamento com sulfadiazina, pirimetamina e ácido folínico até o fim da gestação.

Lembre-se de não iniciar o esquema tríplice no primeiro trimestre, pelo risco de teratogenicidade dessas medicações.



A letra A está incorreta. Incorreta a alternativa A: deve-se evitar usar a mesma faca para cortar carnes e outros vegetais ou frutas para que não ocorra a contaminação destes alimentos.

A letra B está correta. Correta a alternativa B: para prevenção de toxoplasmose toda carne deve ser cozida até atingir temperatura necessária para matar os bradizoides do toxoplasma presentes nos tecidos dos hospedeiros intermediários.

A letra C está incorreta. Incorreta a alternativa C: a paciente susceptível pode ingerir carne vermelha desde que bem cozida.

A letra D está incorreta. Incorreta a alternativa D: a gestante susceptível pode ingerir verduras, desde que bem lavadas e desinfectadas.

A letra E está incorreta. Incorreta a alternativa E: a infecção pode ocorrer pelo contato com as fezes do gato contaminado e não pelo toque no felino.

Questão | | 2024 | 4000205778

Sobre os aspectos clínicos e citogenéticos da doença trofoblástica gestacional, assinale a alternativa correta

- A)** Neoplasia trofoblástica gestacional ocorre apenas após gravidez molar.
- B)** Mola hidatiforme completa é o resultado da fusão de dois óvulos por um espermatozoide.
- C)** Mola hidatiforme parcial é o resultado da fecundação de um óvulo haploide por dois espermatozoides ou duplicação de um espermatozoide, resultando em um cariótipo triploide.
- D)** Pode ocorrer pré-eclâmpsia apenas após a 20ª semana de gestação nessas pacientes.
- E)** Cerca de 80% das pacientes com neoplasia trofoblástica gestacional têm doença metastática.

Solução

Mola hidatiforme parcial é o resultado da fecundação de um óvulo haploide por dois espermatozoides ou duplicação de um espermatozoide, resultando em um cariótipo triploide.

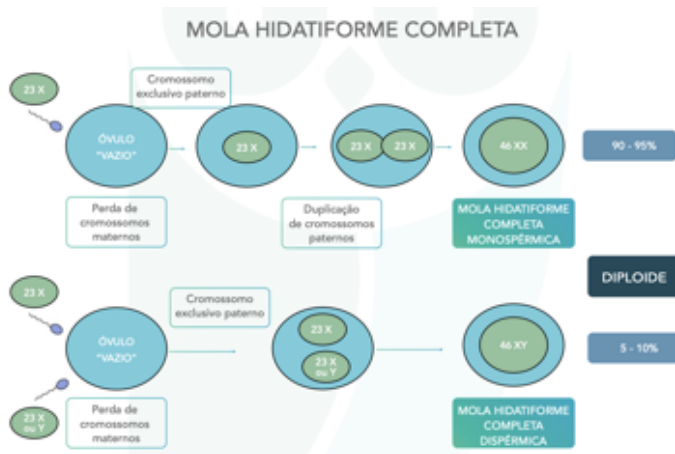
Gabarito: C)

O que o examinador quer saber: sobre doença trofoblástica gestacional.

A característica da mola completa é a proliferação exagerada e anormal do tecido trofoblástico, **NÃO** desenvolve embrião, membranas e cordão umbilical. Macroscopicamente, a placenta perde aquele aspecto de formato ovalado bem definido e a visualização dos cotilédones. O aspecto fica de um material totalmente heterogêneo com múltiplas vesículas pelas vilosidades coriônicas edemaciadas, com dilatação hidrópica e formação de cisterna central repleta de líquido. Na imagem ultrassonográfica, as múltiplas vesículas são descritas com aspecto em “cachos de uva” ou “flocos de neve”.

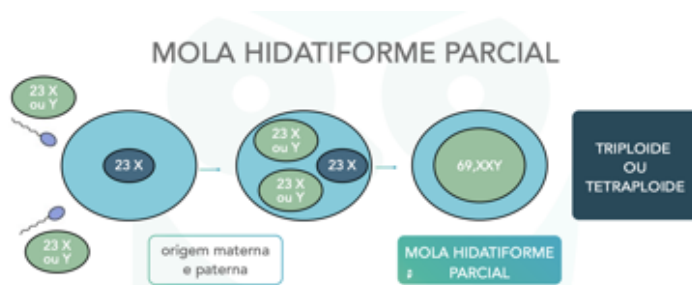
A principal característica histológica é a hiperplasia difusa do citotrofoblasto e do sinciotrofoblasto. Quando é uma mola precoce (no início do 1º trimestre), o diagnóstico é mais difícil e é possível diferenciar pelo marcador p57.

Na mola completa, o marcador p57KIP2 está ausente, porém está presente na mola hidatiforme parcial (expressão pelo alelo materno). E, por incrível que pareça, você deve saber a diferença genética da mola hidatiforme completa e parcial. Do ponto de vista genético, a mola completa origina-se por um ÓVULO “VAZIO” fecundado por espermatozoide 23X. Logo, observe que o material genético é exclusivamente PATERNO, sendo duplicado e originando uma célula 46XX (90% das vezes).



Para o raciocínio da mola parcial ou incompleta, pense em “quase” uma gestação normal. Macroscopicamente, existe a proliferação anormal difusa ou parcial do tecido trofoblástico com formação de múltiplas vesículas e pode ser encontrado embrião com múltiplas malformações e restrição do crescimento fetal. Na microscopia, existem vilosidades normais com hidrópicas e a inclusão do trofoblasto dentro do estroma.

Uma característica que pode ser cobrada nas provas e que diferencia a mola parcial da mola completa é o marcador p57. Na mola parcial, o marcador p57KIP2 está presente devido a sua expressão pelo alelo materno, e, na mola completa, está ausente por ser formada apenas pela genética paterna. Em 90% das vezes, a mola parcial origina-se por DISPERMIA, que consiste na fecundação de um ÓVULO NORMAL por 2 espermatozoides, gerando uma célula triploide (69,XXX ou 69,XXY) e 10% tetraploide.



A letra A está incorreta. Incorreta a alternativa A: a neoplasia trofoblástica gestacional pode ocorrer após gestação molar ou não molar.

A letra B está incorreta. Incorreta a alternativa B: a mola completa origina-se por um ÓVULO “VAZIO” fecundado por espermatozoide 23X. Logo, observe que o material genético é exclusivamente PATERNO, sendo duplicado e originando uma célula 46XX (90% das vezes).

A letra C está correta. Correta a alternativa C: Em 90% das vezes, a mola parcial origina-se por DISPERMIA, que consiste na fecundação de um ÓVULO NORMAL por 2 espermatozoides, gerando uma célula triploide (69,XXX ou 69,XXY).

A letra D está incorreta. Incorreta a alternativa D: na doença trofoblástica gestacional a pré-eclâmpsia pode surgir antes de 20 semanas de gestação.

A letra E está incorreta. Incorreta a alternativa E: a doença metastática na neoplasia trofoblástica gestacional é rara.

Questão | | 2024 | 4000205779

Mulher de 64 anos leva para seu médico o resultado de exames de rotina, incluindo a mamografia. No laudo, veio descrito área de assimetria focal localizada no quadrante superior medial da mama direita classificada como BIRADS 0. Diante desse caso, qual é a melhor conduta?

- A)** Indicar Core-biopsy.
- B)** Solicitar ultrassonografia mamária.
- C)** Punção por agulha fina.
- D)** Solicitar ressonância magnética das mamas.
- E)** Repetir mamografia em 3 meses.

Solução

Gabarito: B) Solicitar ultrassonografia mamária.

Estrategista, esta paciente fez uma mamografia que apresentou uma assimetria focal, considerada BI-RADS 0. Veja abaixo a classificação BI-RADS:

BI-RADS (Breast Imaging-Reporting and Data System)		
Categoria	Chance de câncer (VPP)	Interpretação / Conduta
BI-RADS 0	N/A	Exame inconclusivo / Necessita exame complementar para conclusão diagnóstica
BI-RADS 1	0	Exame normal / Rotina de rastreamento
BI-RADS 2	0	Alterações benignas / Rotina de rastreamento
BI-RADS 3	≤ 2%	Alterações provavelmente benignas / Repetir exame em 6 meses
BI-RADS 4	>2% a < 95%	Alterações suspeitas / Indicar biópsia
BI-RADS 5	≥ 95%	Alterações provavelmente malignas / Biópsia
BI-RADS 6	100%	Malignidade comprovada / Acompanhamento durante o tratamento

Repare que o BI-RADS 0 quer dizer que o achado de assimetria focal foi inconclusivo, sendo indicada a realização de um outro tipo de exame de imagem para chegar a uma conclusão diagnóstica.

O exame mais comumente indicado para avaliar melhor as assimetrias focais é a compressão localizada. Um outro tipo de mamografia que comprime somente a região do achado, para avaliar se aquela assimetria é glandular ou se existe uma lesão naquela região. Entretanto, nenhuma das alternativas apresenta esta opção e, por isto, a melhor opção para complementar a investigação neste caso seria a ultrassonografia.

Vamos analisar as alternativas:

A letra A está incorreta. Incorreta a alternativa A, porque a core biopsy é indicada para os casos suspeitos de malignidade (BI-RADS 4) ou provavelmente malignos (BI-RADS 5).

A letra B está correta. Correta a alternativa B: a melhor opção entre as alternativas é a ultrassonografia que irá analisar melhor a área de assimetria focal vista na mamografia, procurando encontrar algum nódulo ou distorção arquitetural na região. Caso se encontre alguma lesão suspeita, BI-RADS 4 ou 5, será indicada a realização de biópsia. Caso não se encontre lesão, será considerada como BI-RADS 3 (provavelmente benigno) e indicado o seguimento com novo exame de imagem em 6 meses.

A letra C está incorreta. Incorreta a alternativa C, porque não há indicação de qualquer tipo de biópsia nos achados inconclusivos, BI-RADS 0. A conduta frente ao BI-RADS 0 é realizar outro exame de imagem para se chegar a uma conclusão diagnóstica e aí sim indicar uma biópsia se existir uma lesão suspeita de malignidade.

A letra D está incorreta. Incorreta a alternativa D, porque a ultrassonografia é o exame mais indicado (além da compressão localizada) para complementar a avaliação diagnóstica das assimetrias focais.

A letra E está incorreta. Incorreta a alternativa E, porque a conduta de repetir a mamografia em 3 meses não é compatível com nenhuma categoria BI-RADS.

Questão | | 2024 | 4000205780

Como manifestação da sífilis secundária, é possível encontrar

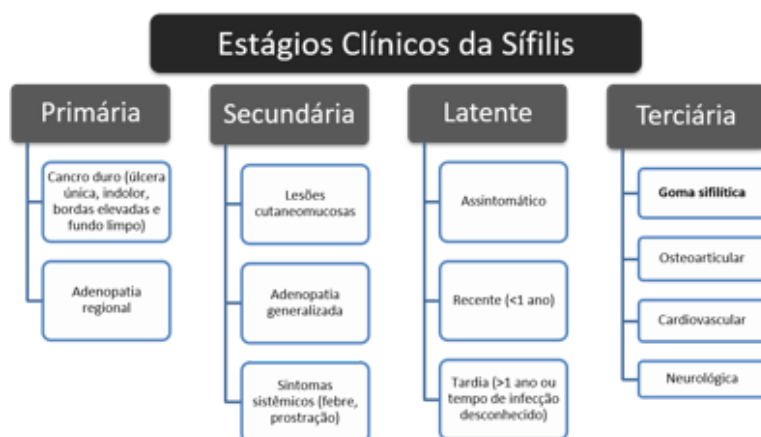
- A)** cancro mole.
- B)** múltiplas vesículas em vulva.
- C)** leucorreia purulenta proveniente do colo uterino.
- D)** condiloma plano.
- E)** úlcera única em vagina.

Solução

Gabarito: D) condiloma plano.

Gabarito: alternativa D.

Sífilis é uma infecção sexualmente transmissível causada pela espiroqueta *Treponema pallidum*. Veja abaixo os estágios clínicos da doença:



A sífilis secundária ocorre semanas a meses após a manifestação inicial. Seu quadro clínico é heterogêneo, caracterizando-se classicamente por quadro sistêmico de febre, lesões cutaneomucosas disseminadas (incluindo exantema - roséola sífilítica) e linfadenopatia.

A letra A está incorreta. Incorreta a alternativa A. O cancro mole é causado por *Haemophilus ducreyi*, não sendo uma manifestação da sífilis secundária.

A letra B está incorreta. Incorreta a alternativa B. Múltiplas vesículas em vulva é a descrição típica da infecção por herpes simplex.

A letra C está incorreta. Incorreta a alternativa C. A leucorreia purulenta não é uma característica típica da sífilis secundária. É um achado sugestivo de cervicite.

A letra D está correta. Correta a alternativa D. O condiloma plano é uma lesão típica da sífilis secundária. Refere-se a lesões mucocutâneas elevadas, de superfície plana, com predileção por áreas úmidas, como região genital e perianal.

A letra E está incorreta. Incorreta a alternativa E. Úlceras únicas são mais características da fase primária (cancro duro) da sífilis.

Questão | | 2024 | 4000205781

Os quadros de insuficiência respiratória em crianças podem ter características próprias, dependendo da faixa etária e dos fatores de risco. Sobre o tema, assinale a alternativa correta.

- A)** Nos casos de insuficiência respiratória com aumento de CO₂, o uso de oxigênio inalatório pode lavar à piora do quadro.
- B)** A insuficiência respiratória causada por uma doença cística pulmonar acomete principalmente o pulmão esquerdo dos recém-nascidos.
- C)** A insuficiência respiratória é mais comum em crianças maiores do que em lactentes, devido ao maior consumo de oxigênio.
- D)** A incapacidade do sistema respiratório de manter a oxigenação e/ou a ventilação adequadas caracteriza a insuficiência respiratória em lactentes e crianças.
- E)** A presença de cianose com maior frequência é o início do quadro de insuficiência respiratória em pediatria.

Solução

Gabarito: D) A incapacidade do sistema respiratório de manter a oxigenação e/ou a ventilação adequadas caracteriza a insuficiência respiratória em lactentes e crianças.

Olá coruja,

Essa questão cobra conhecimentos a respeito da insuficiência respiratória em crianças. Na faixa etária de até 1 ano de idade, as emergências respiratórias são as principais responsáveis pelas internações.

A insuficiência respiratória é decorrente da incapacidade do sistema respiratório em prover a oxigenação e ou ventilação, acarretando falha na oferta de oxigênio para as células. baseado em valores de gasometria, temos: PaO₂ < 60mmHg, PaCO₂ >55mmHg e SatO₂ <90%, são parâmetros para a insuficiência respiratória.

Podemos classificá-la de várias formas:

1) Parâmetros gasométricos:

-hipoxêmica

-hipercápica

2) Localização:

-alta

-baixa

3) Tempo:

-aguda

-crônica

4) Tipo de hipóxia:

-hipóxia hipoxêmica

-hipóxia anêmica

-hipóxia circulatória

-hipóxia histotóxica (intoxicações)

As causas de insuficiência respiratórias não se restringem ao sistema respiratório, elas podem ser: neurológicas, pulmonares, alterações da ventilação (esquelética, torácica, abdominal), alterações no transporte de gases, distúrbios metabólicos.

Vamos analisar cada uma das alternativas:

A letra A está incorreta. Incorreta A, o que ocorre é que crianças com hipercapnia crônica, perdem o estímulo hipercapnico do centro respiratório. Portanto, são dependentes do estímulo hipóxico e precisam de titulação da oxigenoterapia, não se recomenda utilizar dispositivos de alto fluxo. Mas, não é verdade que o oxigênio leva à piora do quadro, pois na titulação certa, ele é benéfico.

A letra B está incorreta. Incorreta B, a malformação adenomatosa cística é uma anormalidade que pode ser encontrada em neonatos que provoca insuficiência respiratória é afeta mais o lado direito.

A letra C está incorreta. Incorreta C, a insuficiência respiratória é mais comum em lactentes devido a fatores como:

- maior metabolismo e consumo de oxigênio
- língua relativamente grande que facilita a obstrução alta,
- presença de ventilação colateral que favorece a formação de atelectasia
- conformação do diafragma e caixa torácica
- musculatura respiratória menos desenvolvida e frequência respiratória proporcionalmente maior
- diâmetro reduzido das vias aéreas
- tórax em barril
- menor quantidade de elastina nas crianças pequenas, que leva à diminuição na complacência pulmonar;

A letra D está correta. Correta D, porque definiu a insuficiência respiratória.

A letra E está incorreta. Incorreta E, nem todas as crianças com insuficiência respiratória apresentam cianose, a maior parte apresenta taquipneia e sinais de desconforto respiratório.

Questão | | 2024 | 4000205782

Sobre a atuação do zinco nas diarreias agudas, assinale alternativa correta.

- A)** O zinco é um micronutriente essencial para o funcionamento adequado do sistema imunológico, porém não deve ser prescrito antes dos doze meses de idade.
- B)** Esse íon pode interferir na adesão, na invasão e na produção de toxinas por alguns agentes patogênicos causadores de diarreia.
- C)** Na diarreia aguda, o zinco pode aumentar a duração, a gravidade e a frequência das evacuações.
- D)** O mecanismo de ação do zinco na diarreia aguda não envolve a modulação da resposta inflamatória.
- E)** O zinco aumenta a secreção de água e eletrólitos pelo intestino e a redução da absorção de sódio e água pelas células epiteliais.

Solução

Gabarito: B) Esse íon pode interferir na adesão, na invasão e na produção de toxinas por alguns agentes patogênicos causadores de diarreia.

Olá, Estrategista.

O zinco é uma importante medicação na presença da diarreia aguda. Ela diminui o tempo de evolução da doença, reduz a gravidade do quadro e previne a recorrência nos próximos 3 meses.

A dose é de 10mg ao dia para menores de 6 meses e 20mg/dia para crianças de 6 meses a 5 anos. Deve ser prescrita por 10 a 14 dias.

A letra A está incorreta. Incorreto, o zinco é um micronutriente essencial para o funcionamento adequado do sistema imunológico, porém, não há idade mínima de prescrição.

A letra B está correta. Correto, esse é um dos motivos pelo qual o zinco interfere na gravidade e duração da doença.

A letra C está incorreta. Incorreto, como vimos acima, é ao contrário.

A letra D está incorreta. Incorreto, um dos efeitos do zinco e pelo qual ele melhora o quadro diarreico é agir como anti inflamatório.

A letra E está incorreta. Incorreto, pois o zinco não tem ação direta na secreção. E se aumentássemos a secreção de água e eletrólitos, pioraríamos a diarreia.

Questão | | 2024 | 4000205783

Paciente de onze anos que apresenta crises convulsivas, que iniciaram há seis meses, sem déficits até o momento. Existe história familiar de uma síndrome epiléptica generalizada, caracterizada por movimentos súbitos e involuntários de um grupo ou de um único músculo. Qual das seguintes alternativas apresenta o diagnóstico mais provável para esse paciente?

- A)** Síndrome de Dravet.
- B)** Síndrome de Lennox-Gastaut.
- C)** Síndrome do lobo temporal.
- D)** Síndrome de West.
- E)** Epilepsia mioclônica juvenil.

Solução

Gabarito: E) Epilepsia mioclônica juvenil.

A epilepsia é definida como uma condição em que um indivíduo tem suscetibilidade de apresentar crises epiléticas. Pois existem as chamadas síndromes epiléticas, que são condições em que os tipos de crise, os achados de eletroencefalograma, a abordagem e prognóstico são específicas. Esse tipo de situação ocorre, preferencialmente, na população pediátrica e dependem da idade de início. Essas síndromes podem ser causadas por causas genéticas, estruturais ou mesmo metabólicas, ou seja, quando falamos em síndromes epiléticas da infância estamos falando de um modo de apresentação específico e que pode ter mais de uma causa.

Quando falamos em lactentes, a síndrome epilética mais comum é a síndrome de West. Ela se caracteriza pela tríade de regressão do desenvolvimento neuropsicomotor (encefalopatia), crises de espasmos e um padrão de EEG conhecido como hipsarritmia. O tratamento costuma ser feito com vigabatrina, corticóide ou ACTH. O motivo pelo qual o corticóide e o ACTH funcionam é desconhecido, mas especula-se alguma base imunológica na gênese da síndrome.

A síndrome de Lennox-Gastaut ocorre em crianças um pouco mais velhas, entre 1 e 6 anos de idade, e se caracteriza por crises de múltiplas semiologias, frequentemente associadas a crises tônicas em que a criança apresenta várias quedas. Esse é um motivo de grande morbidade e algumas crianças, inclusive, precisam usar um capacete! Essas crianças também apresentam déficit cognitivo e em até 30% das vezes, apresentaram a síndrome de West previamente, que “evoluiu” com os anos para a síndrome de Lennox-Gastaut. O tratamento é feito com drogas antiepiléticas de “amplo espectro” como o ácido valpróico, destacando-se que o uso de carbamazepina é evitado, pois pode piorar as crises.

A síndrome de Dravet é uma condição associada a uma mutação no gene SCNA1 em até 80% dos casos. Trata-se de um gene relacionado à tradução de canais de sódio. Essa síndrome também se apresenta com múltiplas semiologias de crise, sendo as do tipo mioclônicas as mais comuns e, curiosamente, as crises podem se iniciar ou piorar muito em situações de febre. Outro ponto importante é que se deve evitar o uso de bloqueadores de canal de sódio

que podem piorar o quadro. Entre eles: carbamazepina, oxcarbazepina, lamotrigina e fenitoína.

Já nos adolescentes e adultos jovens, a principal causa é a epilepsia mioclônica juvenil. Caracteriza-se por crises mioclônicas e frequentemente tônico-clônico generalizadas. O tratamento de escolha é feito com ácido valproico em homens e levetiracetam em mulheres.

A letra A está incorreta. Conforme vimos acima, essa é uma síndrome epilética do bebê e da criança.

A letra B está incorreta. Outra síndrome epilética que ocorre mais cedo e que tem características distintas das apresentadas.

A letra C está incorreta. É a causa mais comum de epilepsia focal do adulto. Inicia-se, em geral, no adulto jovem e cursa com crises focais disceptivas em detrimento das mioclônicas ou generalizadas como descrito.

A letra D está incorreta. Essa é uma entidade do bebê, associada a uma apresentação estereotipada e muito diferente do descrito.

A letra E está correta. Exatamente! É a principal síndrome epilética generalizada dessa faixa etária.

Questão | | 2024 | 4000205784

Uma criança de sete anos, previamente saudável, é levada ao pronto-socorro com queixas de poliúria, polidipsia, perda de peso e vômitos. Ao exame físico, apresenta desidratação, taquipneia e hálito cetônico. Os exames laboratoriais revelam glicemia de 450 mg/dL, sódio e potássio de 140 mEq/L e 5,5 mEq/L, respectiva; pH arterial de 7,2, bicarbonato de 18 mEq/L. Qual deve ser a conduta inicial nesse caso?

- A)** Iniciar hidratação venosa com solução salina isotônica e, após hidratação, reavaliar a necessidade de insulina regular em infusão contínua.
- B)** Iniciar hidratação venosa com solução salina isotônica e bicarbonato em infusão contínua.
- C)** Iniciar hidratação venosa com solução glicosada hipotônica e tiamina em bolus.
- D)** Iniciar hidratação venosa com solução salina isotônica e glicose em infusão contínua.
- E)** Iniciar hidratação venosa com solução salina hipertônica e insulina NPH em bolus.

Solução

Gabarito: A) Iniciar hidratação venosa com solução salina isotônica e, após hidratação, reavaliar a necessidade de insulina regular em infusão contínua.

Gabarito: Letra A

A cetoacidose diabética é uma complicação aguda e grave do diabetes descompensado. Esta condição é mais comum em pacientes com diabetes mellitus do tipo 1, mas também pode ocorrer em diabéticos do tipo 2. O cerne da fisiopatologia da doença é a insulinopenia intensa. Lembre que a insulina, ao se ligar ao seu receptor, estimula a transferência da glicose do meio extracelular para o intracelular. Assim, quando há uma insulinopenia intensa, por mais que o meio extracelular esteja repleto de glicose, como esta não atinge o meio intracelular de forma adequada os diversos tecidos interpretam como houvesse "glicose em falta", o que desencadeia uma série de alterações metabólicas que lembram muito um estado de jejum intenso. Há ativação intensa dos hormônios contrarreguladores da insulina, como o glucagon, sistema adrenérgico, vias glicocorticoides e hormônio do crescimento. Estes hormônios por sua vez ativam as vias da glicogenólise (destruição do glicogênio a glicose), gliconeogênese (conversão de aminoácidos e glicerol em glicose), proteólise (destruição de proteínas, primordialmente para permitir a sua conversão a glicose) e lipólise (destruição de gordura, principalmente triglicérides, em ácidos graxos e glicerol).

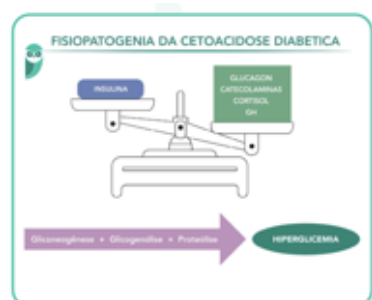


Figura 01: a insuficiência insulínica faz com que a secreção dos hormônios contrarreguladores fique desinibida, o que culminará nas reações de gliconeogênese, glicogenólise e proteólise. Esses eventos justificam a hiperglicemia característica da CAD e do DHH.



Figura 02: O aumento dos hormônios contrarreguladores também resultará em aumento da lipólise e da produção de AGLs. Concomitante a isso, ocorre aumento na oxidação dos AGLs e produção de cetocácidos. Esses eventos justificam a acidose metabólica característica da CAD.

A consequência é que há acentuação da hiperglicemia a níveis em que os túbulos renais não são mais capazes de reabsorver toda a glicose do filtrado glomerular (o que geralmente ocorre com níveis de glicemia acima de 250). O resultado é um fluido tubular repleto de glicose, que tem efeito osmótico, levando a formação de urina com maior quantidade de água livre e espoliação de eletrólitos. As manifestações clínicas nesta fase são aquelas mesmas da hiperglicemia sintomática: poliúria, desidratação (e suas consequências como astenia e hipotensão), polidipsia (pela desidratação), perda de peso (por proteólise, lipólise, glicogenólise e gliconeogênese) e polifagia (como tentativa de reverter a perda de peso).

Com o passar do tempo, o excesso de ácidos graxos leva ao clássico hálito cetônico e a uma acidose metabólica de ânion gap alto (afinal, ácidos graxos são, como o nome diz, ácidos!) , que pode se manifestar clinicamente com o sinal de Kussmaul. Lembrar também que a identificação dos cetoácidos (seja na urina ou no sangue) é essencial para o diagnóstico da cetoacidose diabética. É comum também que os pacientes com esta doença apresentem sinais e sintomas clínicos abdominais, como náuseas, vômitos e dor abdominal, que têm explicação multifatorial, como distúrbios hidroeletrólíticos e acidose afetando a motilidade gastrointestinal.

Vamos também revisar de forma mais detalhada os distúrbios hidroeletrólíticos. O sódio na cetoacidose diabética pode estar tanto elevado (pela desidratação e redução da quantidade de água livre corporal total pela diurese osmótica da hiperglicemia) quanto reduzido (pela hiperglicemia intensa, que exerce efeito osmótico no plasma, atraindo água livre e "diluindo"

o sódio). O potássio também pode estar reduzido (pela perda de potássio renal pela poliúria osmótica e ativação do sistema renina-angiotensina-aldosterona pela hipovolemia) ou aumentado (pela acidose que estimula o trocador H^+/K^+ na superfície das células, levando a internalização do H^+ às custas da transferência do potássio do meio intra para o extracelular). O fósforo e o magnésio costumam estar reduzidos (pela espoliação renal induzida por poliúria).

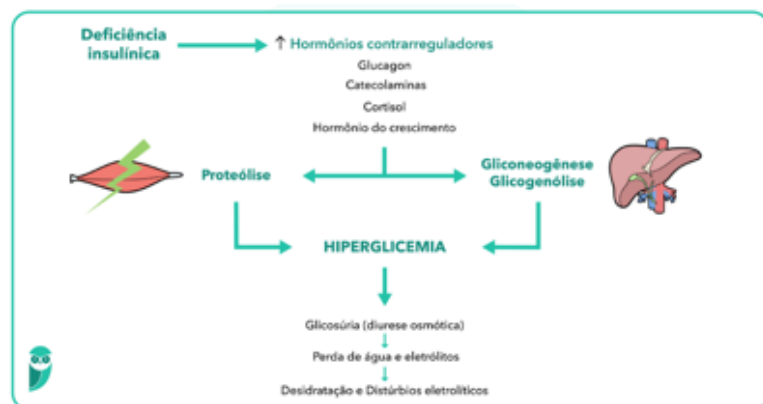


Figura 03: os processos de proteólise, gliconeogênese e glicogenólise resultam em hiperglicemia. Os níveis aumentados de glicose causam diurese osmótica, espoliação de água e eletrólitos, bem como desidratação.

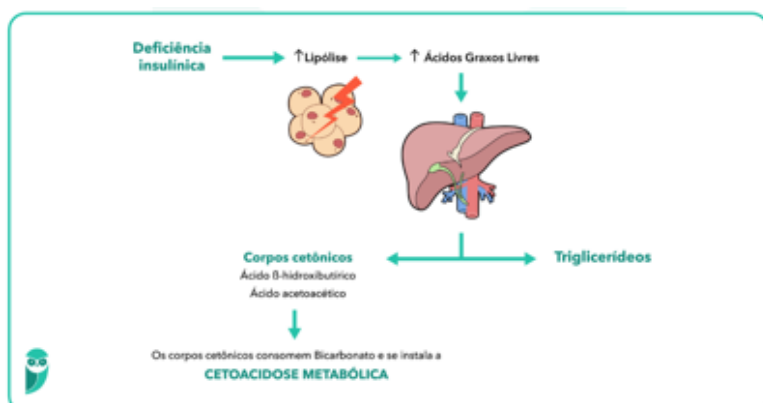


Figura 04: o aumento da lipólise e da oxidação hepática de ácidos graxos livres resultará na formação de cetócidos. Os cetócidos são tamponados pelo bicarbonato sérico, o que culminará em acidose metabólica com ânion gap aumentado.

Revise também abaixo, os critérios diagnósticos da cetoacidose diabética:

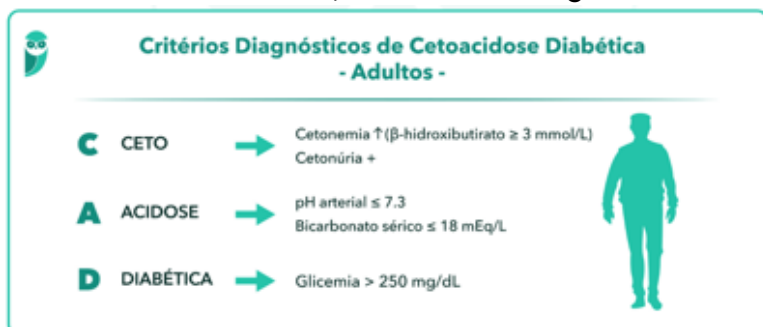


Figura 05: critérios diagnósticos de CAD para o paciente adulto - ADA, 2009.

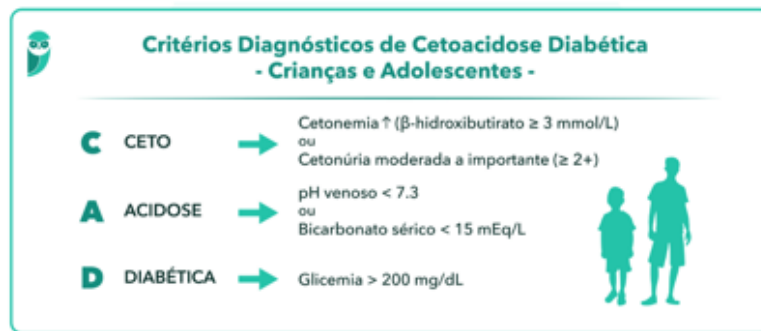


Figura 06: critérios diagnósticos de CAD na pediatria – ISPAD, 2018.

Quanto ao tratamento da cetoacidose diabética, consideramos que o tripé de medidas principais é: Hidratação, Correção de distúrbios hidroeletrólíticos e ácido-básicos (especialmente do potássio) e insulino terapia. A primeira medida a ser instituída deverá ser a hidratação venosa com coleta de exames laboratoriais. Dentre os exames, o nível sérico de potássio irá determinar:

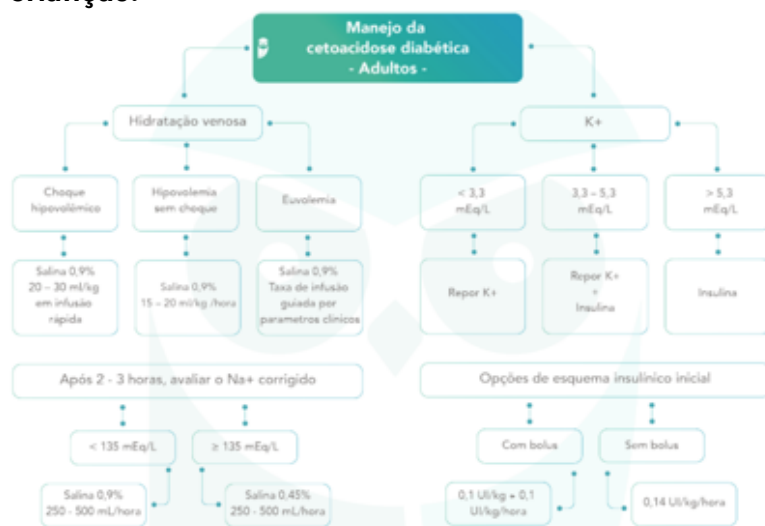
Se já podemos iniciar o tratamento com insulina (indicada somente se o potássio estiver $> 3,3$, pois lembre que a insulino terapia por si só pode diminuir os níveis séricos de potássio)

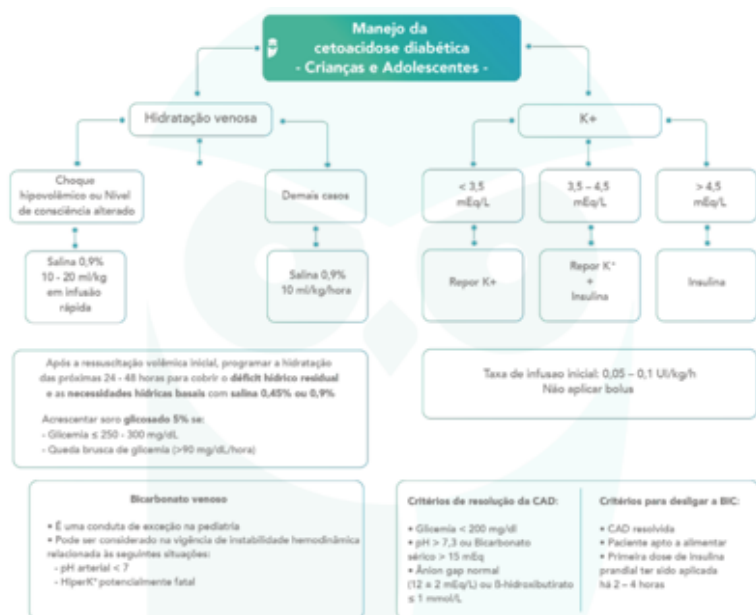
Se além do tratamento com insulina devemos instituir uma reposição de potássio (indicada se níveis séricos $< 5,3$ - $5,5$ em adultos ou $< 4,5$ em crianças e adolescentes).

A prescrição de bicarbonato de sódio 8,4% na dose de 100mEq está indicada para aqueles pacientes com pH $< 6,9$

Por fim, recorde que nos pacientes com glicemia capilar < 200 - 250 mg/dL, devemos reduzir a infusão de volume e associar ao cloreto de sódio um soro glicosado 5% na proporção 1:1, no intuito de permitir a manutenção da infusão de insulina EV até que tenhamos os critérios de resolução da cetoacidose.

Revise os esquemas abaixo que ilustram o tratamento da cetoacidose diabética em adultos e crianças.





A letra A está correta. Correta. Conforme a explicação acima, o tratamento usual da cetoacidose diabética inclui em primeiro lugar a hidratação venosa, seguida por avaliação quanto à indicação de reposição de potássio e insulina regular endovenosa de acordo com os níveis séricos de potássio. Em casos com potássio muito baixo, a insulina regular estará momentaneamente contraindicada, até que os níveis sejam elevados a um patamar satisfatório.

A letra B está incorreta. Incorreta. Sempre que possível evitamos a prescrição de bicarbonato de sódio no tratamento da cetoacidose diabética pediátrica, devido aos riscos aumentados de desenvolvimento de hipertensão intracraniana nesta faixa etária. Para adultos, podemos cogitar o uso do bicarbonato em pacientes com pH sérico $< 6,9$

A letra C está incorreta. Incorreta. Na cetoacidose diabética não realizamos a infusão de solução glicosada isoladamente para expansão volêmica, pelo impacto significativo na redução dos níveis séricos de sódio e dificuldade maior no controle da glicemia que este fluido pode ocasionar. A tiamina não precisa ser prescrita de rotina na CAD, podendo ser utilizada nos pacientes com indicações específicas para a sua reposição (por exemplo, pacientes etilistas, desnutridos e pós-bariátricos).

A letra D está incorreta. Incorreta. Devemos prescrever a associação de cristalóide e soro glicosado na proporção 1:1 apenas para os pacientes com CAD e glicemias menores que 250 (adultos) ou 200 (crianças).

A letra E está incorreta. Incorreta.

Na CAD, podemos utilizar como fluidos para a reposição volêmica: cloreto de sódio 0,9% (indicado para pacientes com sódio desconhecido ou < 135), cloreto de sódio 0,45% (também conhecido como soro meio, utilizado em pacientes com sódio > 135) e ringer lactato (evidências mais recentes indicam que a resolução da acidose pode até ser mais rápida com este cristalóide, mas para a maioria das questões de residência prefira responder cloreto de sódio, já que o uso de ringer neste contexto ainda é uma área de fronteira do conhecimento). A salina hipertônica

(cloreto de sódio 3%), que a alternativa E traz, deve ser evitada na CAD. A justificativa é que parte da hiponatremia que ocorre nessa doença é de fisiopatologia dilucional devido aos elevados níveis glicêmicos (a hiperglicemia causa hipertonicidade do plasma, que atrai líquidos por meio de osmose, diluindo o sódio). À medida que corrigimos a glicemia, o sódio nestes pacientes costuma rapidamente melhorar.

Além disso, não devemos realizar infusão de insulina NPH endovenosa (seja em bolus ou continuamente). Para o tratamento de cetoacidose diabética, quando indicadas, podemos utilizar tanto insulina regular quanto insulinas ultrarrápidas (lispro, aspart e glulisina) por via endovenosa.

Questão | | 2024 | 4000205785

Menina de três anos de idade foi levada ao pronto-socorro após ser picada por uma abelha. Ela apresentou sintomas de uma reação alérgica grave que pode ser fatal se não tratada rapidamente. Nesse caso, a conduta mais adequada é

- A)** usar injeção de adrenalina na coxa da criança, evitando complicações mais graves.
- B)** administrar um antialérgico oral e encaminhar a criança para o hospital mais próximo.
- C)** remover o ferrão da abelha com uma pinça e prescrever pomada anti-inflamatória no local.
- D)** aplicar uma compressa fria no local da picada e observar a evolução dos sintomas.
- E)** transferir para a UTI pediátrica e iniciar dobutamina.

Solução

Gabarito: A) usar injeção de adrenalina na coxa da criança, evitando complicações mais graves.

Olá Estrategista,

O diagnóstico de anafilaxia é baseado em um conjunto de sinais e sintomas clínicos. Há um risco maior de novos episódios no caso de pacientes que apresentam história clínica de dermatite atópica, urticária ou angioedema e teste cutâneo positivo para, pelo menos, um alérgeno alimentar.

Observe que alguns, ou todos estes sinais e sintomas a seguir, podem estar presentes:

- Urticária;
- Angioedema;
- Comprometimento respiratório;
- Gastrointestinal; e/ou; e
- Hipotensão arterial (comprometimento cardiovascular).

Vamos aprender os critérios diagnósticos:

1. Início agudo de uma doença (minutos a algumas horas) com envolvimento simultâneo da pele, do tecido mucoso ou de ambos (por exemplo, urticária generalizada, prurido ou rubor, inchaço dos lábios-língua-úvula) E pelo menos um dos seguintes:

- a. Comprometimento respiratório (por exemplo, dispneia, broncoespasmo, estridor, PFE reduzido, hipoxemia),
- b. PA reduzida ou sintomas associados de disfunção de órgão-alvo (por exemplo, hipotonia [colapso], síncope, incontinência)
- c. Sintomas gastrointestinais graves (por exemplo, cólicas abdominais intensas, vômitos repetitivos), especialmente após a exposição a alérgenos não alimentares

2. Início agudo de hipotensão ou broncoespasmo ou envolvimento laríngeo após exposição a um alérgeno conhecido ou altamente provável para aquele paciente (minutos a algumas horas), mesmo na ausência de envolvimento cutâneo típico.

As bases do gerenciamento inicial da anafilaxia são:

- Remoção da causa
 - Injeção intramuscular(IM) de Epinefrina assim que possível, pode ser repetida após 5 min; **(PRINCIPAL MEDIDA NA ANAFILAXIA)** A dose recomendada de adrenalina é de 0,01 mg/Kg (a dose máxima de criança é de 0,3 mg/dose), injetada na face anterolateral da coxa, intramuscular, na concentração de 1:1.000. Se os sintomas persistirem ou piorarem, a dose inicial pode ser repetida em até 2 a 3 vezes, com intervalos de 5 a 15 minutos. Em adultos e adolescentes a dose preconizada varia de 0,2-0,5mg.
 - Colocar paciente em decúbito dorsal com extremidades inferiores elevadas, se paciente não estiver vomitando ou presença de edema de glote
 - Monitorização de pressão arterial, saturação de oxigênio por oximetria de pulso, frequência cardíaca e respiratória
 - Reanimação volêmica com fluidos intravenosos
 - Oxigênio para manter saturação acima de 95%.
- Algumas medicações adjuvantes podem ser indicadas com beta 2 agonistas inalatórios e anti-histamínicos.**

A letra A está correta. Correta A, porque indicou a medida mais adequada para o tratamento da anafilaxia.

A letra B está incorreta. Incorreta B, o antialérgico é uma medicação adjuvante e não a principal.

A letra C está incorreta. Incorreta C, essas medidas não são as principais, o mais importante é a aplicação da adrenalina IM.

A letra D está incorreta. Incorreta D, porque não mencionou a adrenalina IM.

A letra E está incorreta. Incorreta E, não adianta transferir a UTI sem administrar a adrenalina, a dobutamina não é preconizada para esses casos.

Uma criança de dez anos de idade apresenta quadro de abdome agudo, após período de dois dias com febre, vômitos e importante distensão do abdome. Assinale a alternativa que apresenta uma das condutas corretas nesse caso.

- A) Devido à urgência, não comunicar a família e proceder à laparotomia exploradora.
- B) Explicar à criança a importância da tomografia abdominal e do raio x de tórax.
- C) Proceder à sondagem gástrica, explicando que não há risco de perfuração intestinal.
- D) Solicitar exames laboratoriais: hemograma, eletrólitos, glicemia, amilase, lipase, gasometria arterial, explicando previamente à família sua conduta.
- E) Avisar à farmácia hospitalar a respeito da indicação de reposição volêmica com solução salina hipertônica, explicando para família sua indicação.

Solução

Gabarito: D) Solicitar exames laboratoriais: hemograma, eletrólitos, glicemia, amilase, lipase, gasometria arterial, explicando previamente à família sua conduta.

Estamos diante de uma criança de 10 anos com quadro de febre, vômitos e distensão do abdominal. Só com esses dados, não é possível determinar a causa do abdome agudo. Dessa forma, o próximo passo será realizar exames complementares (laboratoriais e de imagem), para definir a causa e indicar o melhor tratamento, sempre informando aos pais ou responsáveis os procedimentos realizados

A letra A está incorreta. Não temos um diagnóstico definido, por isso, não há indicação de laparotomia. Além disso, mesmo que seja uma urgência cirúrgica, a família deve ser comunicada,

A letra B está incorreta. E explicação deve ser feita aos responsáveis, uma vez que a criança, menor de idade, não tem autonomia para autorizar a realização de exames.

A letra C está incorreta.

A letra D está correta. Esta é uma das condutas corretas a ser realizada.

A letra E está incorreta. Se indicada reposição volêmica nessa criança, ela deve ser feita com solução cristaloide, não com solução salina hipertônica.

Questão | | 2024 | 4000205787

Na consulta de rotina, o pediatra está em dúvida sobre um sopro cardíaco em uma criança de dois anos que não apresenta sinais de insuficiência cardíaca. Suspeita-se de Comunicação Interventricular (CIV). Para auscultar o sopro cardíaco nesse caso,

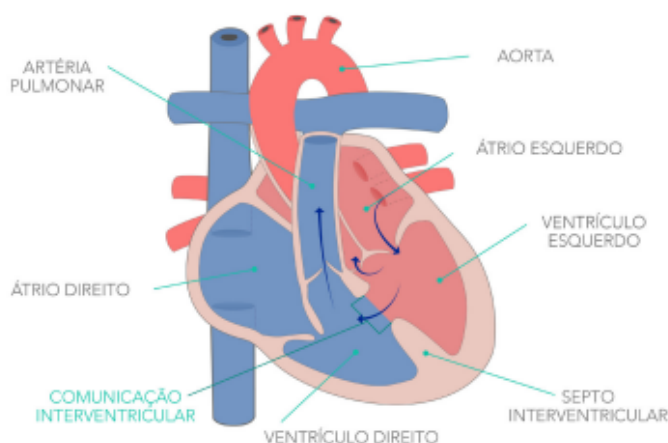
- A) o paciente deve estar, preferencialmente, em decúbito dorsal com o tórax elevado.
- B) o paciente deve estar em posição supina, com o braço esquerdo apoiado no peito, subclavicular.

- C)** o paciente deve estar em posição sentada com o tronco inclinado para frente, axilar direito.
- D)** o melhor local é o quarto espaço intercostal esquerdo.
- E)** o paciente deve estar em decúbito ventral, interescapular.

Solução

Gabarito: D) o melhor local é o quarto espaço intercostal esquerdo.

A comunicação interventricular (CIV) é uma descontinuidade do septo que divide os ventrículos direito e ventrículo esquerdo.



No período pós-natal, a pressão é maior do lado esquerdo do corpo, certo? Portanto, há passagem do sangue do lado esquerdo do coração para o direito (shunt esquerdo–direito) por meio da CIV. Com o aumento de volume do lado direito, temos então um hiperfluxo pulmonar. Na evolução de CIVs grandes, podemos ter uma insuficiência cardíaca direita com congestão venosa sistêmica.

Quanto ao exame físico na CIV temos um sopro holossistólico, mais evidente na borda esternal esquerda baixa, entre o terceiro e o quarto espaço intercostal.

O componente pulmonar da segunda bulha torna-se mais acentuado (hiperfonese de B2), em decorrência do hiperfluxo pulmonar.

A letra A está incorreta. Incorreto. Não encontramos na literatura o relato de melhora do sopro nesse posição.

A letra B está incorreta. Incorreto. Esse seria o sopro da persistência do canal arterial.

A letra C está incorreta. Incorreto. Essa localização em axila direita não se relaciona à CIV.

A letra D está correta. Correto. Como vimos, esse sopro é mais audível no 3-4 espaço intercostal.

A letra E está incorreta. Incorreto. O sopro interescapular pode ser da coarctação de aorta.

Questão | | 2024 | 4000205788

Um menino de cinco anos de idade comparece à consulta com sua mãe, a qual se queixa de que o filho não está crescendo como o irmão mais velho. Qual é o principal indicador para avaliar se existe baixa estatura?

- A) Prega cutânea tricipital no percentil 25.
- B) Circunferência cefálica abaixo do percentil 10 para a idade.
- C) Comprimento abaixo do percentil 3 para a idade.
- D) Perímetro torácico abaixo do percentil 10 para a idade.
- E) Peso abaixo do percentil 10 para a idade.

Solução

Gabarito: C) Comprimento abaixo do percentil 3 para a idade.

Olá Estrategista,

A baixa estatura é definida quando o escore Z para estatura se encontra abaixo do -2 ou percentil 3.

Observe a tabela abaixo:

VALORES CRÍTICOS		Diagnóstico Nutricional
< Percentil 0,1	< escore -3	Muito baixa estatura para a idade
≥ Percentil 0,1 e < Percentil 3	escore -2 -3 ou escore Z < -2	Baixa estatura para a idade
≥ Percentil 3	escore Z ≥ -2	Estatura adequada para a idade

Mas, outras situações também podem indicar algum problema de crescimento tais como:

- uma criança que se encontre desviada por mais de 2 desvios padrão em relação ao seu alvo genético
- crianças que apresentam queda no percentil de estatura, ou seja, baixa velocidade de crescimento.

A letra A está incorreta. Incorreta A, a prega cutânea avalia a adiposidade e não a baixa estatura.

A letra B está incorreta. Incorreta B, o perímetro cefálico é realizado em lactentes para a avaliação indireta do crescimento do cérebro e não indica baixa estatura.

A letra C está correta. Correta C (com ressalvas), pois o comprimento é o nome que se dá para a avaliação de menores de 2 anos. Acima dessa idade, denominamos estatura. Como essa criança tem 5 anos a terminologia correta seria estatura abaixo do percentil 3 para a idade.

A letra D está incorreta. Incorreta D, o perímetro torácico não é referência para o diagnóstico de baixa estatura.

A letra E está incorreta. Incorreta E, o peso abaixo do percentil 10 pode ser considerado normal e não define a baixa estatura.

Questão | | 2024 | 4000205789

A respeito de doenças hematológicas em crianças, assinale a alternativa correta.

- A)** A anemia falciforme é uma doença genética e adquirida que afeta os glóbulos vermelhos do sangue.
- B)** A Leucemia Linfocítica Aguda (LLA) se origina nas células linfóides, que são um tipo de glóbulo branco, e tem uma evolução rápida. A causa da maioria dos casos é desconhecida, mas envolve alterações no DNA das células da medula óssea.
- C)** Na anemia falciforme, os glóbulos vermelhos são ovalados e muito flexíveis, podendo causar obstrução dos vasos, dor, inflamação e lesão de órgãos.
- D)** Em crianças, as causas menos comuns de anemia macrocítica são a deficiência de vitamina B12 ou de ácido fólico.
- E)** A anemia falciforme pode ser tratada com medicamentos, e a cura ocorre antes dos dez anos de idade.

Solução

A Leucemia Linfocítica Aguda (LLA) se origina nas células linfóides, que são um **Gabarito: B)** tipo de glóbulo branco, e tem uma evolução rápida. A causa da maioria dos casos é desconhecida, mas envolve alterações no DNA das células da medula óssea.

Vamos julgar as alternativas, Estrategista?

A letra A está incorreta. Incorreto. A anemia falciforme é uma doença congênita e não adquirida. Decorre de uma mutação autossômica recessiva que troca o ácido glutâmico pela valina como sexto aminoácido na cadeia de beta globina, formando a hemoglobina anômala chamada HbS. Por ser capaz de formar fibras insolúveis no interior das hemácias, a HbS altera o formato habitual destas células, criando os drepanócitos ou hemácias em foice. Os drepanócitos, por sua vez, são menos deformáveis que as hemácias habituais, sofrendo hemólise e obstruindo a microcirculação de órgãos e tecidos, levando às famosas crises vaso-oclusivas.

A letra B está correta. Correto. A LLA é a leucemia mais comum da faixa etária pediátrica e se trata de uma neoplasia de células precursoras hematopoiéticas de origem da linhagem linfóide. A maioria dos casos é idiopático, mas apresenta mutações no DNA das células-tronco, levando à perda de seus mecanismos de apoptose normais e, conseqüentemente, à proliferação descontrolada dessas células doentes.

A letra C está incorreta. Incorreto. Como vimos acima, é justamente o contrário: as hemácias falcizadas são menos deformáveis que os eritrócitos normais, causando as vaso-oclusões que tanto marcam a vida do paciente falcêmico. As crises vaso-oclusivas mais comuns são as crises algicas, síndrome torácica aguda, AVE isquêmico, sequestro esplênico, dentre outras.

A letra D está incorreta. Incorreto. Anemias macrocíticas são aquelas em que vemos uma redução da quantidade de hemoglobina (anemia) acompanhada da presença de hemácias de tamanho aumentado (macroscíticas). Tanto em crianças quanto em adultos, a causa mais comum de anemia macroscítica é justamente a anemia megaloblástica, decorrente da deficiência e vitamina B12 e/ou ácido fólico.

A letra E está incorreta. Incorreto. A anemia falciforme é uma doença hereditária autossômica recessiva e, portanto, incurável. Pacientes falcêmicos possuem elevada morbi-mortalidade, com uma expectativa de vida em torno de 50 anos de idade.

Questão | | 2024 | 4000205790

Um menino de um ano e meio de idade apresenta febre há três dias, com poucos pródromos de infecção respiratória aguda, e apresenta erupção maculo-papular que cursa por dois dias. O que chamou a atenção da mãe foi que, “no dia em que apareceram as manchas na pele, a febre desapareceu”. Clinicamente a criança encontra-se bem. Qual é o diagnóstico provável nesse caso?

A) Eritema infeccioso.

- B) Mononucleose infecciosa.
- C) Varicela.
- D) Exantema súbito.
- E) Escarlatina.

Solução

Gabarito: D) Exantema súbito.

Olá, Estrategista, o ponto chave dessa questão é essa frase: “no dia em que apareceram as manchas na pele, a febre desapareceu”. Com ela, podemos chegar ao diagnóstico de exantema súbito.

O exantema súbito, também chamado de roséola infantil ou sexta doença é uma doença infecciosa viral característica de crianças entre 6 meses e 6 anos, predominando em menores de 2 anos. É causada pelo herpes vírus tipo 6 ou 7.

O quadro clínico é bem marcado por dois momentos:

- 1) No primeiro momento, a criança apresenta febre alta, sem toxemia e sem outras manifestações associadas, que nos levem a um diagnóstico. Essa criança pode apresentar crise convulsiva febril.
- 2) No segundo momento, a febre cessa. Ao cessar da febre, aparece o exantema maculopapular róseo, que inicia no tronco e dissemina para os membros, de curta duração e que some sem descamação.

O tratamento da doença é apenas orientações aos pais e sintomáticos.



A letra A está incorreta. No eritema infeccioso geralmente não há febre, temos rash malar, semelhante a uma "face esbofetada", seguido de exantema rendilhado difuso pelo corpo.

A letra B está incorreta. Na mononucleose podemos ter amigdalite, rash maculopapular, associado com linfadenomegalia e hepatomegalia.

A letra C está incorreta. A varicela traz um exantema polimórfico, com lesões em diferentes estágios de evolução.

A letra D está correta. Correto.

A letra E está incorreta. A escarlatina se manifesta por faringite associada aos sinais de pastia (hiperemia de dobras) e filatov (palidez perioral).

Questão | | 2024 | 4000205791

Um recém-nascido de 27 dias de vida, que recebe aleitamento exclusivo ao seio materno, é levado para consulta de puericultura. O peso e comprimento estão adequados para esse tempo de vida, comparado ao nascimento. Há relato de seis evacuações por dia, das quais duas ou três são semilíquidas e amareladas. Ao exame, o paciente está hidratado com bom estado geral. Qual é a conduta mais adequada diante do quadro?

- A) Manter o aleitamento materno exclusivo.
- B) Substituir o leite materno por dieta isenta de lactose.
- C) Iniciar leite de soja.
- D) Sugerir pausa alimentar por 24 horas.
- E) Recomendar leite de vaca a 50% com água.

Solução

Gabarito: A) Manter o aleitamento materno exclusivo.

Olá Estrategista,

Esse neonato recebe recebe aleitamento materno exclusivo , apresenta bom ganho de peso e comprimento além de seis evacuações por dia, das quais duas ou três são semilíquidas e amareladas.

Isso pode ser considerado normal, pois, como sabemos, o lactente apresenta um reflexo gastro-cólico exacerbado fazendo com que ele evacue a cada mamada. Além disso, as fezes amolecidas e amareladas são consideradas normais.

Outro dado positivo, paciente está hidratado e com bom estado geral. Assim, devemos manter o aleitamento materno, pois esses achados são totalmente normais.

A letra A está correta. Correta A, vamos manter o aleitamento materno para esse bebê.

A letra B está incorreta. Incorreta B, o fato de apresentar seis evacuações não indica uma intolerância à lactose, e sim o reflexo gastro-cólico exacerbado, que é normal para essa idade.

A letra C está incorreta. Incorreta C, não há indicação de leite de soja, nessa idade a única recomendação para leite de soja seria o RN com galactosemia.

A letra D está incorreta. Incorreta D, o neonato está bem, e hidratado, não há indicação de suspender o leite materno.

A letra E está incorreta. Incorreta E, não se recomenda o leite de vaca nessa idade. As manifestações apresentadas são consideradas normais.

Questão | | 2024 | 4000205792

Um lactente de seis meses apresenta sintomas que incluem tosse, chiado, dificuldade para respirar e taquipneia, sem cianose. Considerando que a bronquiolite é a principal causa de insuficiência respiratória aguda em crianças menores de 5 anos, especialmente nos meses de inverno, em que consiste o tratamento a ser prescrito nesse caso?

- A) Uso de antibióticos por via venosa.
- B) Oxigenoterapia, hidratação e medidas de suporte.
- C) Iniciar com antiviral via oral e aguardar a evolução.
- D) Intubação traqueal imediata.
- E) Aspiração de vias aéreas superiores e lavagem nasal.

Solução

Gabarito: B) Oxigenoterapia, hidratação e medidas de suporte.

Caro Estrategista,

A bronquiolite viral aguda (BVA) caracteriza-se pelo primeiro episódio de sibilância em um lactente que apresenta sinais clínicos de infecção viral do trato respiratório inferior e ausência de outra razão que explique a sibilância.

Trata-se da infecção do trato respiratório inferior mais comum em lactentes e sua sintomatologia é resultado da obstrução das pequenas vias aéreas devido à inflamação. O principal agente etiológico é o vírus sincicial respiratório.

A bronquiolite é classicamente uma doença que afeta lactentes e sua sintomatologia é mais exuberante quanto mais jovem for a criança. Os sintomas iniciais da bronquiolite são semelhantes a um resfriado comum, ou seja, os lactentes apresentam febre baixa nos primeiros 2 dias, associada à coriza hialina, à obstrução nasal, espirros, tosse seca e a algum grau de irritabilidade. Por volta do 3o ao 6o dia, esses pacientes evoluem com piora respiratória que se deve ao acometimento das vias aéreas inferiores. Nesse momento, encontramos sibilos na ausculta pulmonar devido à inflamação e à broncoconstrição, as quais impedem a passagem normal de ar, causando o turbilhonamento de ar.

O diagnóstico da BVA baseia-se em dados clínicos, sendo desnecessária a realização de exames laboratoriais ou radiológicos.

Crianças que estão estáveis, sem sinais de desconforto respiratório e sem hipoxemia, podem receber tratamento ambulatorial. São recomendados:

- Inalações com soro fisiológico para fluidificação de secreções;
- Lavagem nasal com soro fisiológico em casos de obstrução nasal; e
- Antitérmicos para a febre.

Lactentes com desconforto respiratório, que se manifesta com hipóxia, diminuição da aceitação alimentar, apneia e taquipneia intensa, necessitam de hospitalização.

O tratamento da BVA em crianças internadas baseia-se em três pilares: hidratação, nebulização com solução salina e oferta de oxigênio se a saturação de oxigênio for menor ou igual a 92%, preferencialmente por métodos não invasivos.

A letra A está incorreta. Incorreta A, a bronquiolite é um quadro viral e seu tratamento não requer o uso de antibióticos.

A letra B está correta. Correta B, o tratamento da bronquiolite é baseado em medidas de suporte como as descritas nesta alternativa. Além disso, não vemos um desconforto respiratório tão grave para indicar a intubação.

A letra C está incorreta. Incorreta B, o antiviral não é recomendado para o tratamento da bronquiolite.

A letra D está incorreta. Incorreta C, a oferta de oxigênio para crianças com bronquiolite é feita por métodos não invasivos como o catéter nasal de alto fluxo.

A letra E está incorreta. Incorreta E, na bronquiolite observamos um acometimento do trato respiratório inferior, assim, a aspiração das vias aéreas e lavagem nasal, isoladamente não são recomendadas.

Questão | | 2024 | 4000205793

Uma menina de cinco anos está em investigação por apresentar febre de origem não esclarecida há um mês, associada à perda de peso nas últimas semanas, sem outras queixas. Seu pai, que morava na mesma casa, teve uma doença de pulmão, tratada por longo período, segundo a pessoa que acompanha a menina. A radiografia de tórax apresenta imagens micronodulares disseminadas. Ao exame físico: eupneica, ausculta pulmonar rude, com queixa de tosse eventual. A principal hipótese diagnóstica e orientação nesse caso serão:

- A)** Histoplasmoze pulmonar aguda / Fazer desinfecção do ambiente.
- B)** Pneumonia atípica por vírus sincicial respiratório / Isolar por 15 dias.
- C)** Tuberculose miliar pulmonar / Iniciar esquema preconizado.
- D)** Pneumonia linfocítica intersticial / Broncoscopia.
- E)** Pneumonia por *Pneumocystis Carinii* / Descolonizar com antibiótico via oral.

Solução

Gabarito: C) Tuberculose miliar pulmonar / Iniciar esquema preconizado.

Nesse enunciado temos:

- Criança de 5 anos,
- Febre há 1 mês
- Emagrecimento

-Pai com doença pulmonar

-Radiografia com imagens micronodulares (sugestivo de tuberculose miliar)

O diagnóstico da tuberculose em crianças é muito desafiador, pois elas nem sempre apresentam sintomas típicos, os achados radiológicos são inespecíficos e, além disso, elas são paucibacilíferas.

Dessa forma, o isolamento do agente etiológico nas secreções respiratórias é difícil, assim frente a uma forte suspeita clínica, utilizamos o sistema de pontos ou escore, veja:

QUADRO CLÍNICO-RADIOLOGICO		CONTATO DE ADULTO COM TUBERCULOSE	PROVA TUBERCULINICA	ESTADO NUTRICIONAL
Febre ou sintomas como tosse, adinamia, expectoração, emagrecimento, sudorese por 2 semanas ou mais	Adenomegalia hilar ou padrão miliar e/ou Condensação ou infiltrado (com ou sem escavação) inalterado por 2 semanas ou mais e/ou Condensação ou infiltrado (com ou sem escavação) por 2 semanas ou mais, evoluindo com piora ou sem melhora com antibióticos para germes comuns	Próximo, nos últimos 2 anos	PT entre 5-9mm 5 pontos PT ≥10mm	Desnutrição grave (peso < percentil 10)
15 pontos	15 pontos	10 pontos	10 pontos	5 pontos
Assintomático ou com sintomas há menos de 2 semanas	Condensação ou infiltrado de qualquer tipo por menos de 2 semanas	Ocasional ou negativo	PT < 5 mm	Peso ≥ percentil 10
0 ponto	5 pontos			
Infecção respiratória com melhora após uso de antibióticos para germes comuns ou sem antibióticos	Radiografia normal			
- 10 pontos	- 5 pontos	0 ponto	0 ponto	0 ponto

Utilizando os dados do enunciado temos:

Sintomas: 15 pontos

Radiografia: 15 pontos

Contato: 10 pontos

Emagrecimento: 5 pontos

Total: 45 pontos

Observe a classificação e conduta :



Essa criança tem diagnóstico muito provável e necessita de tratamento específico com isoniazida, rifampicina e pirazinamida.

A letra A está incorreta. Incorreta A, nesse caso deveria haver algum antecedente epidemiológico de contato com fezes de pássaros, que não foi mencionado no enunciado da questão.

A letra B está incorreta. Incorreta B, a pneumonia atípica por vírus sincicial respiratório é um quadro agudo que não cursa com comprometimento de peso e as alterações radiológicas são a hiperinsuflação pulmonar e infiltrado intersticial.

A letra C está correta. Correta C, porque indicou a principal suspeita e recomendou o tratamento apropriado.

A letra D está incorreta. Incorreta D, essa condição é mais comum em adultos, pode ser relacionada a doenças como síndrome de Sjögren, doença auto-imune da tireóide, doença de Castleman e síndrome da imunodeficiência adquirida. Sua causa é desconhecida e se caracteriza por uma infiltração difusa do interstício por uma mistura polimórfica de linfócitos, histiócitos e células plasmáticas. O quadro clínico é insidioso, com tosse, e comprometimento progressivo da função pulmonar.

A letra E está incorreta. Incorreta E, a pneumonia por *Pneumocystis Carinii* é causada por um agente oportunista, sendo comumente encontrada em pacientes com síndrome da imunodeficiência adquirida (SIDA).

Questão | | 2024 | 4000205794

Uma criança de dois anos de idade teve, há 10 dias, um quadro diarreico. Foi internado há 48h, apresentando plaquetopenia, queda do hematócrito e insuficiência renal. Nesse caso, o diagnóstico é

- A)** síndrome hemolítica urêmica.
- B)** glomerulonefrite pós-estreptocócica.
- C)** refluxo vesicoureteral.
- D)** síndrome nefrótica.
- E)** pielonefrite aguda.

Solução

Gabarito: A) síndrome hemolítica urêmica.

Temos uma questão direta que traz um paciente pediátrico que, após um quadro diarreico, evolui com a tríade clássica da síndrome hemolítico-urêmica: anemia, plaquetopenia e injúria renal aguda.

Definida pela presença de anemia hemolítica microangiopática (com presença de esquizóticos em sangue periférico), disfunção renal e plaquetopenia (plaquetas $< 100.000 \text{ mm}^3$), a forma típica da doença é causada por toxinas de bactérias que causam gastroenterite (a bactéria tipicamente associada é *Escherichia coli* produtora de shiga-toxina, causa comum de colite hemorrágica), classicamente 2 a 5 dias após o episódio de diarreia, semelhante ao descrito na questão. O diagnóstico pode ser confirmado através da pesquisa da shiga-toxina. O tratamento da doença envolve terapia de suporte, inclusive terapia de substituição renal (diálise), quando houver indicação.

Vamos às alternativas:

A letra A está correta. Correta. Como vimos, é nossa principal hipótese diagnóstica.

A letra B está incorreta. Incorreta. A GNPE é uma causa clássica de síndrome nefrítica, isto é, edema, hematúria glomerular e hipertensão arterial. O paciente do enunciado não cursa com essas alterações.

A letra C está incorreta. Incorreta. O refluxo vesicoureteral é uma causa urológica de disfunção renal, diagnosticada a partir da suspeita de um exame de imagem alterado, demonstrando hidronefrose.

A letra D está incorreta. Incorreta. A síndrome nefrótica é caracterizada pela presença de edema, proteinúria nefrótica e hipoalbuminemia, condições não citadas no enunciado.

A letra E está incorreta. Incorreta. A pielonefrite aguda envolve a presença de febre, prostração e alterações urinárias, como leucocitúria, por exemplo.

Questão | | 2024 | 4000205795

Um recém-nascido está sendo examinado pelo pediatra ainda no alojamento conjunto e, quando é realizada a flexão da coxa sobre o quadril, depois abdução e extensão da coxa, existe uma alteração do movimento sentida pelo examinador. Esse procedimento descrito denomina-se

- A)** teste de Manchester.
- B)** manobra de Ortolani.
- C)** exame de Denver.
- D)** prova de Adams.
- E)** teste de Dick.

Solução

Gabarito: B) manobra de Ortolani.

GABARITO: ALTERNATIVA B

Discussão sobre a questão

O que o examinador quer saber com esta pergunta?

Questão direta sobre semiologia ortopédica na DDQ (Displasia do Desenvolvimento do Quadril).

O que você precisa saber para responder a esta pergunta:

Exame físico na DDQ:

O exame físico da DDQ muda conforme a faixa etária.

Até os três meses, os principais exames são os testes de Ortolani e Barlow.

A partir dos três meses, a restrição da abdução – sinal de Hart – pela contratura da musculatura adutora torna este o teste mais confiável.

A partir da idade de deambulação, a criança claudica pela diferença de comprimento das pernas – devido à luxação do quadril. O teste de Galeazzi, que avalia a diferença de comprimento das coxas, também auxilia no diagnóstico.

Manobra de Ortolani: manobra clássica, utilizada nos primeiros 3 meses de vida. É realizada com o paciente em decúbito dorsal, realizando-se a abdução dos quadris. Sente-se a redução do quadril afetado. Teste positivo indica tratamento.

Manobra de Barlow: “irmã” do Ortolani, também é utilizada nos primeiros 3 meses de vida. É realizada na mesma posição em que o teste de Ortolani, mas o quadril é posteriorizado, promovendo-se a luxação.

Teste de Galeazzi: o teste de Galeazzi é realizado com o paciente em decúbito dorsal e os quadris fletidos. A altura dos côndilos é comparada, e o côndilo do quadril afetado se encontra mais baixo.

Sinal de Hart: partindo-se da mesma posição do Ortolani, ao se realizar a abdução dos quadris, observa-se diferença, que pode ser entre um lado e outro, no caso de doença unilateral, ou em relação ao normal, em quadros bilaterais. Normalmente, a abdução dos quadris do recém-nascido é de 60° a 80° e valores diminuídos indicam teste positivo.

Sobre a questão:

Você pode não saber absolutamente nada de ortopedia e ainda assim conseguir responder a esta questão. É bastante direta: dentre os testes que se faz na maternidade, qual é o único que se associa ao quadril? E o que ele está sempre triando? Displasia do quadril.

A letra A está incorreta. Incorretas as alternativas A, C e E: nenhum destes testes existe em ortopedia.

A letra B está correta. Correta a alternativa B, sem ressalvas.

A letra C está incorreta. Incorretas as alternativas A, C e E: nenhum destes testes existe em ortopedia.

A letra D está incorreta. Incorreta a alternativa D. O teste de Adams (não prova) é feito para avaliação de escoliose e consiste em solicitar que o paciente se incline para frente, para se

buscar uma gibosidade na coluna, indicando o ponto de curva escoliótica.

A letra E está incorreta. Incorretas as alternativas A, C e E: nenhum destes testes existe em ortopedia.

Questão | | 2024 | 4000205796

Em relação à Doença Falciforme, assinale a alternativa INCORRETA

- A)** Não é indicado aconselhamento genético futuro, para evitar preocupações para a família.
- B)** As crises álgicas se iniciam antes de 12 meses em muitos casos.
- C)** A hidratação venosa está indicada no início do tratamento em caso de crises álgicas.
- D)** O alívio da dor não é alcançado com paracetamol nos casos com recidivas.
- E)** As complicações da perfusão são pouco importantes durante as crises álgicas

Solução

Gabarito: A) Não é indicado aconselhamento genético futuro, para evitar preocupações para a família.

A anemia falciforme é um dos temas mais comuns da Hematologia nas provas de residência, Estratégista. Isto porque se trata de uma doença hereditária com grande aumento de morbimortalidade na vida de seus portadores: a sobrevida de pacientes falcêmicos nos Estados Unidos, por exemplo, é de cerca de 50 anos de idade, ou seja, pelo menos 20 anos a menos que a população geral.

Além disso, a vida do paciente falciforme é marcada por quadros de muito impacto na sua qualidade de vida: as crises vaso-oclusivas, grande marco da doença, levam a muitos atendimentos hospitalares e necessidade de internação para estes indivíduos.

Com isso em mente, vamos julgar as alternativas:

A letra A está correta. Incorreto. Como vimos, a anemia falciforme é uma doença de grande impacto na vida de seus portadores. De herança autossômica recessiva, a condição pode acometer a prole do indivíduo falcêmico se seu parceiro for portador da mutação, seja em homozigose (anemia falciforme em si) ou em heterozigose (traço falcêmico). Assim, o aconselhamento genético é essencial.

A letra B está incorreta. Correto. A anemia falciforme é uma doença marcada pela presença da HbS, hemoglobina anômala gerada de uma mutação que altera a estrutura da HbA normal. Ao nascimento, a hemoglobina predominante é a HbF e, por isso, recém-nascidos falcêmicos costumam ser assintomáticos. Ao longo do primeiro ano de vida, especialmente após os 3 a 6 meses, a HbF declina como hemoglobina principal, sendo gradativamente substituída pela HbA,

ou pela HbS, no caso da população falcêmica. Assim, sim, as crises álgicas costumam surgir antes dos 12 meses de idade.

A letra C está incorreta. Correto. O manejo de crises álgicas é baseado em 3 medidas:

- 1 - hidratação vigorosa, visando a euvolemia;
- 2 - afastamento de fatores desencadeantes, como infecções;
- 3 - analgesia adequada à dor do paciente.

A letra D está incorreta. Correto. O manejo das crises álgicas devem ser feito com uma combinação de analgésicos comuns (paracetamol, dipirona), anti-inflamatórios não esteroidais, opioides fracos e fortes e adjuvantes (antidepressivos).

A letra E está incorreta. Alternativa questionável. Apesar da perfusão dos membros não ser afetada, isto é, manterem-se os pulsos e a chegada de sangue aos membros, a microcirculação é afetada por vaso-oclusões, causando as crises álgicas. Caberia recurso, mas a banca liberou a alternativa A como correta.

Questão | | 2024 | 4000205797

Um menino de dois anos tem uma pneumonia, com derrame pleural extenso, causada por estafilococo. Ele encontra-se acordado com sinais moderados de desconforto respiratório e com cateter nasal de oxigênio a 3L/min. Em decorrência do quadro, há necessidade de drenagem torácica e, ao preparar o material, o cirurgião passa orientações ao residente. Assinale a alternativa que apresenta a orientação correta repassada pelo cirurgião ao residente.

- A)** Não há necessidade de anestesia local, pois a ferida não permite ação do analgésico.
- B)** Quanto menor o calibre do dreno, melhor será a recuperação do paciente.
- C)** Em geral, a melhor conduta é apenas a punção de alívio.
- D)** As imagens de ultrassom podem guiar melhor a posição do dreno e, assim, alcançar áreas com abscessos fechados.
- E)** O paciente deve estar sob intubação mecânica para a drenagem.

Solução

Gabarito: D) As imagens de ultrassom podem guiar melhor a posição do dreno e, assim, alcançar áreas com abscessos fechados.

Estamos diante de uma criança com diagnóstico de pneumonia por estafilo, complicada com derrame pleural extenso, já com desconforto respiratório, indicações de drenagem torácica. vamos analisar as alternativas:

A letra A está incorreta. Em crianças, a drenagem torácica deve ser feita com anestesia local, geralmente associada a sedação.

A letra B está incorreta. Tubos torácicos menores (por exemplo, < 14F, incluindo cateteres pigtail) são agora geralmente recomendados em vez de tubos de grande diâmetro para minimizar o desconforto do paciente. No passado, tubos menores eram frequentemente evitados porque se pensava que eram mais propensos à obstrução por exsudato fibrinopurulento, mas os estudos clínicos não conseguiram fundamentar esta preocupação, especialmente quando fibrinolíticos são usados além da drenagem torácica.

Dessa forma, o uso de drenos de menor calibre não "melhora" a recuperação do paciente, mas oferece melhor conforto.

A letra C está incorreta. A presença de derrame pleural volumoso, associada à desconforto respiratório, são indicações de drenagem torácica.

A letra D está correta. A ultrassonografia pode ser usada para orientar a colocação do dreno torácico. O procedimento pode ser realizado simultaneamente à ultrassonografia ou a pele pode ser marcada para indicar o local ideal para inserção do dreno. Uma amostra de fluido deve ser enviada para culturas e coloração de Gram para ajudar a direcionar a terapia antibiótica.

A letra E está incorreta. Não há necessidade de intubação mecânica para a drenagem torácica.

Questão | | 2024 | 4000205798

A Intolerância à Lactose (IL) e a Alergia à Proteína do Leite de Vaca (APLV) possuem sinais e sintomas semelhantes, por isso a importância de avaliar a diferença em sua origem, sinais e sintomas. Sobre esse assunto, assinale a alternativa correta.

- A)** Na sua grande maioria, os casos de IL são associados a uma condição genética de pessoas de origem asiática.
- B)** Urticária, inchaço e vômito podem ser consequência da APLV.
- C)** A APLV é uma condição benigna que afeta apenas crianças e desaparece na adolescência.
- D)** Na IL, não são recomendados testes de tolerância à lactose e de hidrogênio no ar expirado, devido ao risco de insuficiência respiratória.
- E)** Na APLV, a conduta será prescrever medicamentos antialérgicos ou anti-inflamatórios.

Solução

Gabarito: B) Urticária, inchaço e vômito podem ser consequência da APLV.

Olá, Estrategista, apesar dos sintomas semelhantes, a IL e a APLV são patologias totalmente distintas!

A APLV é uma doença de lactentes jovens que apresentam manifestações de alergia alimentar, enquanto a intolerância à lactose é de crianças mais velhas, adolescentes e adultos que perdem a enzima lactase ao longo da vida e que apresentam sintomas após a ingestão de leite e de seus derivados.

Veja o quadro abaixo.

APLV	INTOLERÂNCIA À LACTOSE
Lactentes jovens	Crianças Adolescentes Adultos
Alergia alimentar IgE, não IgE mediada ou mista	Perda da enzima lactase com a idade
Sintomas gastrointestinais, associados ou não a sintomas sistêmicos	Sintomas apenas gastrointestinais, após ingestão de leite ou seus derivados
Dieta de exclusão de proteínas do leite de vaca	Dieta isenta de lactose

Vamos às alternativas.

A letra A está incorreta. Incorreto. Existe uma patologia chamada de intolerância congênita à lactose, que causa sintomas já no período neonatal e que está associada à pessoas de origem asiática, porém, ela é rara.

A letra B está correta. Correto, a APLV tem 3 tipos de manifestações:

- IgE mediadas
- Não IgE mediadas
- Mistas

Observe:

Mediadas por IgE	Não mediadas por IgE	Mistas
Urticária Angioedema	Dermatite de contato	Dermatite atópica
Rinoconjuntivite alérgica Broncoespasmo	Enterocolite Proctocolite Enteropatia	Asma
Anafilaxia		Esofagite eosinofílica Gastrite eosinofílica

Urticária, angioedema ("inchaço) e vômitos podem sim estar relacionados com alergia alimentar, inclusive como manifestação de anafilaxia.

A letra C está incorreta. Incorreto. Como vimos, é uma condição de lactentes jovens e ela tem um bom prognóstico, resolvendo-se por volta dos 2 a 3 anos de idade.

A letra D está incorreta. Existem quatro categorias de testes para diagnóstico de intolerância aos açúcares: o exame das fezes para avaliação do pH, os testes de tolerância, o teste do hidrogênio no ar expirado após a sobrecarga do açúcar e os testes genéticos. Eles são indicados para a confirmação diagnóstica da IL e não há risco de insuficiência respiratória.

A letra E está incorreta. A conduta na APLV é a retirada das proteínas do leite da dieta, seja por dieta de exclusão materna (quando amamentados ao seio) ou pela introdução de fórmulas especiais (proteínas extensamente hidrolisadas, de aminoácidos ou de soja).

Questão | | 2024 | 4000205799

Menina de 11 anos apresenta peso de 39 Kg, altura de 144 cm e seu índice de massa corporal é de 23 Kg/m². Ela passou por consulta com dois médicos que prescreveram medicamentos “para emagrecer”. Caso não haja outras complicações associadas, a conduta para esse caso deve ser

- A)** manter os medicamentos prescritos.
- B)** encaminhar para academia de ginástica e psicoterapia.
- C)** colher exames: hemograma, triglicerídeos, colesterol e iniciar ansiolítico.
- D)** indicar tomografia de crânio para avaliação da sela túrcica e investigar cariótipo.
- E)** controlar ingesta calórica e oferecer oportunidade de exercícios físicos regulares.

Solução

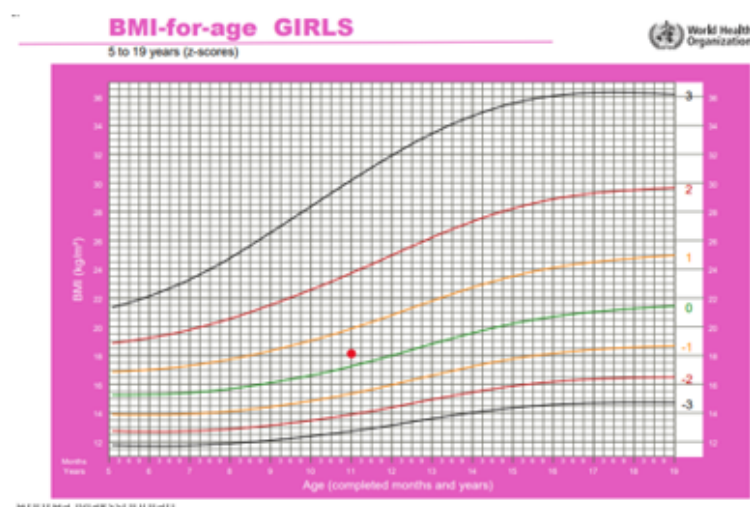
Gabarito: E) controlar ingesta calórica e oferecer oportunidade de exercícios físicos regulares.



Olá Estrategista,

Nesse enunciado temos uma adolescente com IMC de 23kg/m^2 mas, fique atento, se utilizarmos os dados de peso e estatura dessa menina, vemos que o cálculo do IMC revela $18,8\text{ kg/m}^2$. Assim, julgamos que caberia recurso a esta questão. Vamos lá:

O enunciado diz que foram prescritos medicamentos para emagrecer e solicita a conduta. Como o gráfico de IMC não foi fornecido, não conseguimos classificar o IMC da paciente, mas de acordo com o gráfico da OMS (não fornecido), temos o seguinte:



Observe ao quadro abaixo;

Percentil	Escore Z	Zero a 5 anos Incompletos	5 a 20 anos Incompletos
< Percentil 0,1	< Escore-z -3	Magreza acentuada	Magreza acentuada
≥ Percentil 0,1 e < Percentil 3	≥ Escore-z -3 e < Escore-z -2	Magreza	Magreza
≥ Percentil 3 e ≤ 85	≥ Escore-z -2 e ≤ +1	Eutrofia	Eutrofia
> Percentil 85 e ≤ 97	> Escore-z +1 e ≤ +2	Risco de sobrepeso	Sobrepeso
> Percentil 97 e ≤ 99,9	> Escore-z +2 e ≤ +3	Sobrepeso	Obesidade
> Percentil 99,9	> Escore-z +3	Obesidade	Obesidade grave

Concluimos que a adolescente está eutrófica, assim, não se justificam medidas comportamentais para controle do IMC, tampouco o uso de medicamentos para emagrecer. De qualquer forma, como o gráfico não foi fornecido, o candidato poderia inferir que há sobrepeso ou obesidade, assim, vamos julgar as alternativas:

A letra A está incorreta. Incorreta A, mesmo que a adolescente estivesse na faixa de sobrepeso ou obesidade, as primeiras medidas seriam as comportamentais, com ajuste na dieta e incentivo à prática de atividades esportivas.

A letra B está incorreta. Incorreta B, mesmo que a adolescente estivesse com IMC acima do escore Z+1 (o que não é o caso), deveríamos recomendar dieta e incentivo à prática de atividades físicas, a psicoterapia de apoio, pode também ser benéfica nesses casos.

A letra C está incorreta. Incorreta C, a coleta de exames seria recomendada se o IMC estivesse acima do normal, os ansiolíticos não são recomendados na maior parte dos casos.

A letra D está incorreta. Incorreta D, não há suspeita de doença genética cursando com obesidade pois o enunciado da questão não apresentou estigmas característicos de síndromes genéticas. Além disso, a tomografia seria recomendada se suspeitássemos de uma patologia do sistema nervoso central e faltam dados no enunciado que suportem essa suspeita.

A letra E está correta. Correta E (com ressalvas) pois, essa seria a conduta apropriada para a adolescente se o seu IMC estivesse acima do escore Z+1.

Questão | | 2024 | 4000205800

Assinale a alternativa correta sobre Diabetes na infância.

- A)** Diabetes na infância é uma condição muito rara abaixo dos 10 anos de idade.
- B)** Diabetes tipo I é a mais frequente na infância.
- C)** Diabetes do tipo gestacional é mais prevalente na pré-adolescência do que nas demais faixas etárias das mulheres.
- D)** Diabetes na infância acomete apenas meninos.
- E)** A resistência insulínica nos lactentes é de grande importância para a manutenção da glicemia.

Solução

Gabarito: B) Diabetes tipo I é a mais frequente na infância.

Olá Estrategista,

Esta questão aborda vários aspectos da epidemiologia do diabetes na infância.

O diabetes mellitus tipo 1 (DM tipo 1) corresponde a 5%-10% dos casos de DM e é caracterizado pela deficiência grave de insulina,

ocasionada pela destruição das células beta pancreáticas. É o tipo de diabetes mellitus mais comum na infância e adolescência, representando

cerca de 85% dos casos.

O seu pico de maior incidência é bimodal, ocorrendo entre 4-6 anos e no início da puberdade (10-14 anos).

O diabetes mellitus tipo 2 é uma doença mais frequente em adultos, geralmente > 45 anos, mas a sua prevalência tem aumentado na faixa etária pediátrica e em adultos jovens, correspondendo a quase 20% dos casos em crianças e adolescentes. Credita-se uma grande parte desses números à elevação simultânea da obesidade, condição relacionada com a piora da resistência à insulina.

Quanto ao diabetes gestacional, observe os fatores de risco associados à hiperglicemia durante a gravidez:

- Idade (aumento progressivo do risco com o avançar da idade).
- Sobrepeso/obesidade (índice de massa corporal – IMC ≥ 25 kg/m²).
- Antecedentes familiares de DM em parente de 1º grau.
- Antecedentes pessoais de alterações metabólicas:
 - Hemoglobina glicada (HbA1c) $\geq 5,7\%$.
 - Síndrome dos ovários policísticos.
 - Hipertrigliceridemia.
 - Hipertensão arterial sistêmica.
 - Acantose nigricans.
 - Doença cardiovascular aterosclerótica.
 - Uso de medicamentos hiperglicemiantes.
- Antecedentes obstétricos:
 - ≥ 2 perdas gestacionais.
 - DMG.
 - Polidrâmnio (maior bolsa ≥ 8 cm ou o índice de líquido amniótico – ILA ≥ 24 cm).
 - Macrosomia (recém-nascido com peso ≥ 4.000 g ou peso > 90º percentil para a idade gestacional).
 - Óbito fetal/neonatal sem causa determinada.
 - Malformação fetal.

A letra A está incorreta. Incorreta A, o primeiro pico de incidência do DM1 é entre 4 e 6 anos.

A letra B está correta. Correta B, esse é o tipo mais comum em crianças.

A letra C está incorreta. Incorreta C, o aumento do diabetes gestacional ocorre com o progredir da idade.

A letra D está incorreta. Incorreta D, o diabetes tipo 1 afeta ambos os sexos.

A letra E está incorreta. Incorreta E, a resistência insulínica é um evento raro em lactentes.

Questão | | 2024 | 4000205801

Um paciente de 72 anos foi submetido a uma laparotomia exploradora por diverticulite complicada de cólon sigmoide, tendo sido realizada uma cirurgia com ressecção do sigmoide, fechamento do coto retal e confecção de colostomia terminal no cólon descendente. Esse tipo de cirurgia denomina-se

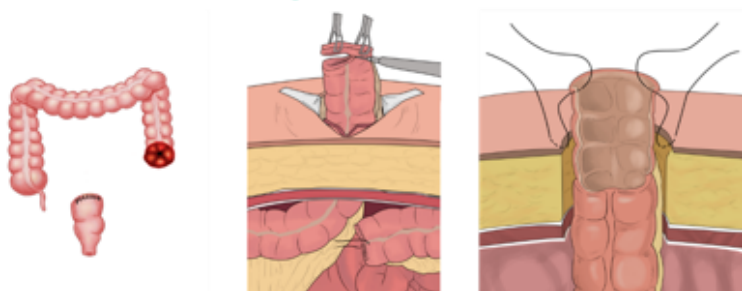
- A) cirurgia de Whipple.
- B) cirurgia de Hartmann.
- C) cirurgia de Murphy.
- D) cirurgia de Duhamel.
- E) cirurgia de Wilson.

Solução

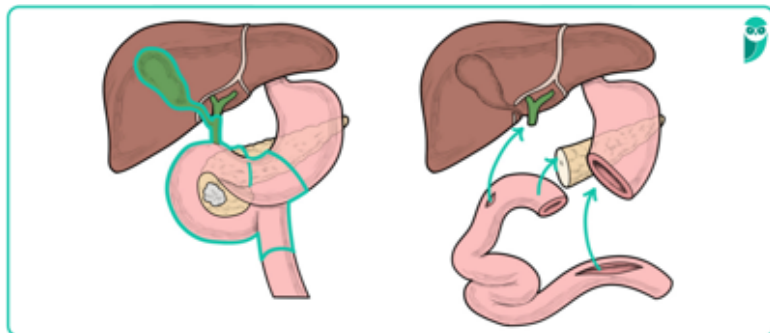
Gabarito: B) cirurgia de Hartmann.

No enunciado temos a descrição da Cirurgia de Hartmann, ou seja, sigmoidectomia, fechamento do coto retal e colostomia terminal no cólon descendente.

Cirurgia de Hartmann



A letra A está incorreta. A cirurgia de Whipple é realizada para neoplasias de cabeça de pâncreas e consiste em uma duodenopancreatectomia (ressecção da cabeça do pâncreas, duodeno, vias biliares e parte distal do estômago).



A letra B está correta. Como vimos, está descrita a cirurgia de Hartmann no enunciado.

A letra C está incorreta. Não existe cirurgia de Murphy, mas sinal de Murphy, presente dos quadros de colecistite aguda (parada abrupta da inspiração durante a palpação profunda do ponto cístico).

A letra D está incorreta. A cirurgia de Duhamel está indicada para casos de megacólon. É realizada retossigmoidectomia abdominoperineal com anastomose colorretal (latero-lateral) retrorretal.

A letra E está incorreta. Não existe cirurgia de Wilson descrita na literatura.

Questão | | 2024 | 4000205802

Um paciente de 65 anos apresenta dor, distensão abdominal e vômitos repetidos há 2 dias. Não evacua e não elimina flatos há 3 dias. Os exames de imagem mostram distensão de intestino delgado e fezes em reto. Assinale a alternativa que apresenta a melhor conduta inicial para tratamento desse paciente.

- A)** Coletar exames laboratoriais para detectar se há distúrbios hidroeletrólíticos e efetuar passagem de sonda nasogástrica para drenagem e hidratação.
 - B)** Indicar laparotomia exploradora para melhor diagnosticar e tratar o paciente, já que ele apresenta o quadro há mais de 2 dias.
 - C)** Coletar exames laboratoriais para detectar se há sinais de infecção associada; passar sonda nasoenteral para alimentação pós-pilórica e iniciar antibióticos de forma profilática.
 - D)** Conversar com os familiares e indicar laparotomia exploradora com ileostomia associada, pois, nesses casos de distensão grande do delgado, não é recomendada anastomose primária.
- Coletar exames laboratoriais; realizar tomografia para melhor avaliação e, a seguir,
- E)** encaminhar o paciente para cirurgia, pois a maior parte desses casos é solucionada por meio de cirurgia.

Solução

Gabarito: A) Coletar exames laboratoriais para detectar se há distúrbios hidroeletrólíticos e efetuar passagem de sonda nasogástrica para drenagem e hidratação.

Estamos diante de um paciente idoso com quadro clínico típico de obstrução intestinal, pois apresenta dor e distensão abdominal associada a vômitos e parada de eliminação de flatos há 3 dias. E o exame de imagem apresenta distensão de delgado.

Ainda não temos dados suficientes para indicar a causa da obstrução intestinal, mas a primeira conduta nesses casos é realizar as "medidas de suporte":

- Jejum
- SNG (descompressão do TGI)
- Hidratação endovenosa;
- Correção dos distúrbios hidroeletrólíticos e ácido-básico (o mais comum é a alcalose hipoclorêmica e hipocalêmica devido aos vômitos - coletar exames laboratoriais)
- Analgesia
- Definir o tratamento, cirúrgico ou conservador (a depender da causa da obstrução).

A letra A está correta. Essa é alternativa correta.

A letra B está incorreta. É bem provável que o paciente apresente um quadro de obstrução intestinal com indicação de tratamento cirúrgico. Mas antes, devemos tentar identificar a causa da obstrução (geralmente com TC de abdome) e fazer as "medidas de suporte" inicialmente.

A letra C está incorreta. O paciente não apresenta nenhum sinal de infecção. Além disso, ele apresenta sinais de obstrução intestinal e deve permanecer em jejum. A antibioticoprofilaxia só deverá ser realizada se houver indicação de tratamento cirúrgico.

A letra D está incorreta. Distensão "grande" do delgado não é contraindicação à anastomose.

A letra E está incorreta. Esta conduta está correta, mas TC de abdome e uma possível cirurgia devem ser feitas após as medidas iniciais.

Questão | | 2024 | 4000205803

Qual das seguintes alternativas apresenta a maior causa de obstrução do intestino delgado?

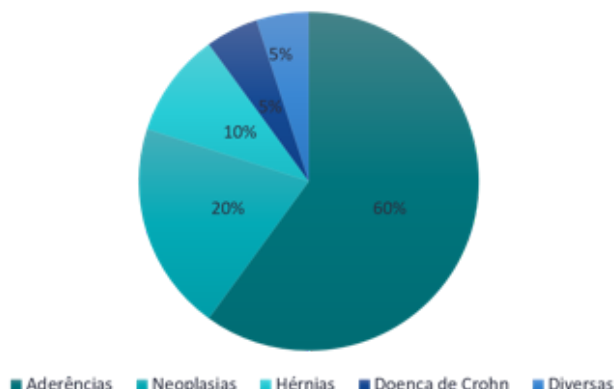
- A)** Hérnias.
- B)** Doença de Crohn.
- C)** Aderências.
- D)** Neoplasias.
- E)** Doenças neurológicas.

Solução

Gabarito: C) Aderências.

A principal causa de obstrução intestinal alta são as bridas, aderências intestinais pós-operatórias tardias (60%), seguida por neoplasias (20% e hérnias (10%).

OBSTRUÇÃO INTESTINAL ALTA



A letra A está incorreta. Obstrução intestinal alta por hérnias é a terceira causa

A letra B está incorreta. Doença de Crohn corresponde a 5% das obstruções altas.

A letra C está correta. Como vimos, aderências intestinais pós-operatórias são a principal causa de obstrução intestinal.

A letra D está incorreta. Neoplasias correspondem a segunda causa mais frequente de obstrução intestinal alta.

A letra E está incorreta. Doenças neurológicas, bem como algumas medicações para o seu tratamento, podem predispor a alguns casos de obstrução intestinal, como volvo de sigmoide, íleo paralítico, mas não são causas frequentes de obstrução intestinal.

Questão | | 2024 | 4000205804

Segundo a classificação de Caprini para pacientes cirúrgicos, assinale a alternativa correta quanto à classificação de risco para TEV (Tromboembolismo Venoso) de um paciente de 54 anos que foi submetido a uma cirurgia de câncer de cólon, aberta, que durou aproximadamente 2h.

- A) Risco muito baixo.
- B) Risco baixo.
- C) Risco moderado.
- D) Risco alto.
- E) Risco muito alto.

Solução

Gabarito: D) Risco alto.

O tromboembolismo venoso (TEV) é uma entidade que compreende a trombose venosa profunda e o tromboembolismo pulmonar. No contexto perioperatório, o TEV é considerado uma das principais causas de morte preveníveis. Desse modo, a profilaxia de tromboembolismo venoso é uma medida fundamental para que possamos evitar esses óbitos. Para escolhermos o tipo de profilaxia, os pacientes cirúrgicos devem ser classificados de acordo com o risco de tromboembolismo venoso. Isso é feito através da aplicação um escore chamado Caprini.

Esse escore estratifica os pacientes em 4 categorias, conforme uma pontuação, da seguinte forma:



ESCORE DE CAPRINI MODIFICADO	
1 ponto	- Idade entre 41 a 60 anos - Cirurgia de pequeno porte - IMC > 25kg/m² - Presença de veias varicosas - Gravidez ou pós-parto - História de abortamento inexplicado ou recorrente - Uso de anticoncepcional oral ou terapia de reposição hormonal - Sepse <1 mês - Pneumonia há 1 mês - Função pulmonar anormal - Infarto Agudo Miocárdio recente - Paciente acamado - Doença inflamatória intestinal
2 pontos	- Idade 61-74 anos - Artroscopia - Cirurgia abdominal de grande porte (>45 minutos) - Malignidade - Confinado ao leito > 72 horas - Imobilização por aparelho gessado - Acesso Venoso Central
3 pontos	- Idade > 75 anos - História de TEV: história familiar de TEV - Estados de hipercoagulabilidade: mutação ns fatores de coagulação ou doenças de autoimunidade
5 pontos	- AVE < 1 mês - Artroplastia de joelho/quadril - Fratura de quadril, pelve ou membros inferiores - Trauma raquimedular <1 mês

Aplicando o escore no nosso paciente, temos:

Idade: 54 anos: 1 ponto

Malignidade (câncer de cólon): 2 pontos

Cirurgia de grande porte (aproximadamente 2h): 2 pontos

Total: 5 pontos (alto risco para TEV)

Agora que já estamos familiarizados com o escore de Caprini, podemos indicar qual a melhor forma de profilaxia, baseados no risco de TEV identificado pelo Escore. Veja abaixo.

• **MUITO BAIXO RISCO:** Nesse grupo, o risco de TEV é menor que 0,5%. Dessa forma, a deambulação precoce é a única profilaxia recomendada para esses pacientes.

• **BAIXO RISCO:** Nesse grupo, o risco de TEV sem profilaxia é em torno de 1,5%. Portanto, além da deambulação precoce está indicado o uso de meias elásticas compressivas e de compressor pneumático intermitente.

• **RISCO MODERADO OU ALTO:** Nesse grupo, o risco de TEV sem profilaxia é em torno de 3,0%. Desse modo, a necessidade de profilaxia é inquestionável. O tipo de profilaxia pode ser farmacológico (anticoagulantes) ou mecânico e varia de acordo com o risco de sangramento, conforme veremos abaixo.

Risco de sangramento baixo e risco de TEV moderado: é preferida profilaxia farmacológica em relação à profilaxia mecânica

Risco de sangramento baixo e risco de TEV alto: é preferida associação de profilaxia farmacológica à profilaxia mecânica

Risco de sangramento alto e risco de TEV moderado ou alto: Nesses casos, está indicada a utilização de profilaxia mecânica, apenas. Afinal, a utilização de profilaxia farmacológica pode levar à hemorragia.

GABARITO: alternativa D

A letra A está incorreta.

A letra B está incorreta.

A letra C está incorreta.

A letra D está correta. Como vimos, nosso paciente apresenta alto risco para TEV, devendo realizar profilaxia farmacológica associada à profilaxia mecânica

A letra E está incorreta.

Questão | | 2024 | 4000205805

Um paciente será submetido a uma tireoidectomia total devido a um câncer de tireoide. Diante disso, as principais complicações que podem ocorrer após o procedimento e devem ser informadas ao paciente pelo médico são:

- A)** hipercalcemia e alteração da voz.
- B)** hipocalcemia e rouquidão.
- C)** hipocalcemia e paresia dos músculos da face.
- D)** hipercalcemia e dificuldade de deglutição.
- E)** hipocalcemia e alteração da voz.

Solução

Gabarito: E) hipocalcemia e alteração da voz.

As principais complicações decorrentes da tireoidectomia abordadas em provas anteriores são: as lesões nervosas, vasculares e das paratireoides.

Nas complicações pós-operatórias relacionadas às paratireoides, ocorre o desenvolvimento de hipocalcemia sintomática, com o surgimento de vários sinais ou sintomas que serão descritos no material da endocrinologia.

Em relação às complicações nervosas, o principal nervo lesado na tireoidectomia é o nervo laríngeo recorrente. Esse faz a inervação de quase toda a musculatura intrínseca da laringe ipsilateral e, nos casos em que houve lesão cirúrgica iatrogênica, o paciente pode apresentar disфония e/ou dispneia nas lesões unilaterais, causadas por uma paresia ou paralisia da prega vocal ipsilateral.

Em casos de lesões bilaterais, pode ocorrer uma paralisia mediana de ambas as pregas vocais, não permitindo a passagem do ar para a traqueia, levando ao desenvolvimento de dispneia intensa, cornagem e estridor após a remoção do tubo ao término da cirurgia. Nesses casos, é imperativa a reintubação (se possível), além da realização de traqueostomia.

A letra A está incorreta. Pode ocorrer hipocalcemia

A letra B está incorreta. Pode ocorrer hipocalcemia

A letra C está incorreta. Não ocorre paresia dos músculos da face. Esta seria uma das principais complicações da parotidectomia, por lesão do nervo facial.

A letra D está incorreta. Pode ocorrer hipocalcemia e não há alteração na deglutição após a tireoidectomia.

A letra E está correta. Como vimos, as principais complicações da tireoidectomia é a disfonia e hipocalcemia.

Questão | | 2024 | 4000205806

Em um paciente com doença coronariana, qual dos seguintes agentes NÃO seria indicado para indução anestésica, por ter como efeito colateral a hipertensão?

- A)** Tiopental.
- B)** Propofol.
- C)** Cetamina.
- D)** Etomidato.
- E)** Midazolam.

Solução

Gabarito: C) Cetamina.

Questão que aborda o uso de anestésicos endovenosos. Vamos analisar as alternativas:

A letra A está incorreta. O tiopental é uma droga da classe dos barbitúricos que tem como características serem muito lipossolúveis, o que gera acúmulo na gordura e pode fazer com que sua eliminação seja lenta, atrasando o despertar e causando efeitos adversos no pós-operatório, como náuseas e vômitos. O uso dessa droga é caracterizado por depressão da contratilidade miocárdica, vasodilatação, hipotensão arterial, liberação de histamina e diminuições na atividade, no metabolismo e no fluxo sanguíneo cerebrais

A letra B está incorreta. O PROPOFOL é uma droga muito utilizada em anestesia em função de sua curta latência e rápida distribuição tecidual, o que promove rápida reversão de seus efeitos. O propofol apresenta como vantagens a promoção de um despertar suave, sensação de bem-estar e diminuição da incidência de náuseas e vômitos.

O principal efeito adverso é induzir hipotensão devido a sua ação vasodilatadora e depressora da contratilidade miocárdica e seu uso para pacientes que apresentam instabilidade hemodinâmica deve ser cauteloso e, por vezes, contraindicado.

A letra C está correta. A CETAMINA possui rápido início de efeitos e, diferentemente dos outros hipnóticos, apresenta ação analgésica potente. Sua administração causa liberação de catecolaminas, produzindo **umentos da frequência cardíaca, da pressão arterial e da**

resistência vascular periférica. A ventilação é pouco afetada pela cetamina, que inclusive causa broncodilatação, tornando seu uso interessante em pacientes asmáticos.

A letra D está incorreta. O ETOMIDATO apresenta rápidos início e término de ação, sendo o agente hipnótico que oferece maior estabilidade hemodinâmica. Em função disso, é frequentemente escolhido como agente hipnótico em situações de urgência e na indução de pacientes com instabilidade hemodinâmica. Seu efeito adverso mais relevante é a supressão da produção de cortisol pela glândula adrenal. Pode induzir o aparecimento de mioclônias.

A letra E está incorreta. Os benzodiazepínicos podem causar depressão respiratória, especialmente se combinados com opioides. Seus efeitos cardiovasculares são menos pronunciados do que o propofol, mas ainda assim podem cursar com hipotensão quando doses mais altas são administradas.

Questão | | 2024 | 4000205807

Assinale a alternativa que apresenta 2 tipos de bactérias que estão entre as mais frequentemente encontradas/isoladas na apendicite aguda perforada.

- A)** *Acinetobacter baumannii* e *Klebsiella pneumoniae*.
- B)** *Pseudomonas aeruginosa* e *Bacteroides coprosuis*.
- C)** *Escherichia coli* e *Bacteroides fragilis*.
- D)** *Campylobacter jejuni* e *Burkholderia cepacia*.
- E)** *Acinetobacter baumannii* e *Escherichia coli*.

Solução

Gabarito: C) *Escherichia coli* e *Bacteroides fragilis*.

Uma vez que o apêndice cecal encontra-se obstruído, por exemplo por um fecalito, ocorre um supercrescimento bacteriano dentro do apêndice, principalmente por bactérias anaeróbias e Gram negativas (flora colônica).

Abaixo está uma tabela com as principais bactérias encontradas nos casos de apendicite aguda complicada:

Tipos de bactérias isoladas na apendicite perfurada	Pacientes (%)
ANAERÓBIOS	
<i>Bacteroides fragilis</i>	80
<i>Bacteroides thetaiotaomicron</i>	61
<i>Bilophila wadsworthia</i>	55
<i>Peptostreptococcus spp.</i>	45
AERÓBIOS	
<i>Escherichia coli</i>	77
<i>Streptococcus viridans</i>	43
<i>Streptococcus Group D</i>	27
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	18

Fonte: Sabiston, 20ª edição

Dessa forma, a alternativa que apresenta as bactérias mais frequentemente encontradas nos casos de apendicite aguda é a "alternativa C", ou seja, *Escherichia coli* e *Bacteroides fragilis*.

GABARITO: alternativa C

A letra A está incorreta.

A letra B está incorreta.

A letra C está correta. Das bactéria Gram negativas, a *E. coli* é a mais comumente encontrada e, dentre as anaeróbias, os *Bacteroides fragilis*.

A letra D está incorreta.

A letra E está incorreta.

Questão | | 2024 | 4000205808

Os tecidos tentam restaurar a sua função normal e a integridade estrutural após uma lesão, passando pelo processo de cicatrização. Quais são as 3 fases desse processo, em ordem cronológica, e suas respectivas características?

- A)** Fase reativa (proliferação e migração epitelial), fase de maturação (regeneração do tecido conjuntivo) e fase proliferativa (proliferação de colágeno e formação da cicatriz).
- B)** Fase inflamatória (hemostasia e quimiotaxia), fase proliferativa (regeneração do tecido conjuntivo) e fase de maturação (contração, formação e remodelamento da cicatriz).
Fase inflamatória (hemostasia e inflamação), fase regenerativa (formação e contração da
- C)** cicatriz) e fase de remodelagem (migração epitelial e proliferação/regeneração do tecido conjuntivo).
- D)** Fase de remodelagem (hemostasia e quimiotaxia), fase reativa (proliferação e migração epitelial) e fase maturacional (contração e formação da cicatriz).

- E)** Fase proliferativa (migração e proliferação epitelial), fase maturacional (contração e formação da cicatriz) e fase reativa (hemostasia e quimiotaxia).

Solução

Fase inflamatória (hemostasia e quimiotaxia), fase proliferativa (regeneração do **Gabarito: B)** tecido conjuntivo) e fase de maturação (contração, formação e remodelamento da cicatriz).

Vamos revisar as três fases da cicatrização de feridas: Inflamatória, proliferativa e maturação ou remodelação.

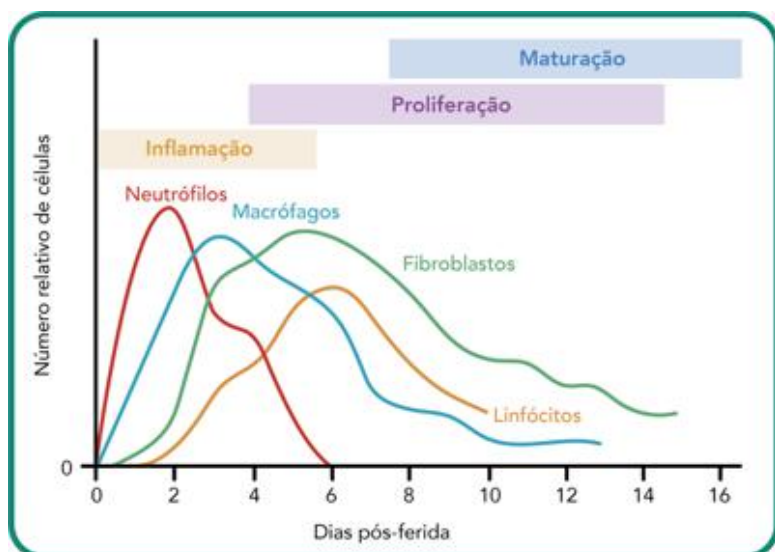
1ª - Inflamatória: Essa fase é dividida em duas etapas:

Vasoconstrição: ocorre a contração dos vasos lacerados e o subendotélio exposto promove a agregação plaquetária, responsável pela formação de um tampão hemostático inicial (coágulo ou trombo). As plaquetas liberam os agentes quimiotáticos que atraem as células de defesa e os fibroblastos.

Vasodilatação: as citocinas vasoativas promovem aumento da circulação local, e aumento da permeabilidade capilar. Tal fenômeno favorece o influxo inicial de leucócitos para a ferida. A fase inflamatória então é caracterizada por aumento da permeabilidade vascular, migração neutrófilos e macrófagos para a ferida por quimiotaxia, secreção de citocinas e fatores de crescimento para a ferida e ativação das células em migração. A primeira célula a entrar na ferida é o **NEUTRÓFILO** (responsável pela fagocitose de bactérias e debris inflamatórios). A segunda célula a entrar nas feridas é o **MACRÓFAGO**, considerados as células fundamentais na cicatrização das feridas; sendo as suas principais funções a **ATIVAÇÃO** e o **RECRUTAMENTO** de células via mediadores celulares.

2ª - Proliferativa: esta fase é caracterizada pela formação de tecido de granulação. Os macrófagos e mastócitos estimulam a ativação de fibroblastos e esses últimos passam a ser o tipo celular predominante em 3 a 5 dias. À medida que essas células povoam a ferida, há deposição de colágeno, especialmente do tipo I e do tipo III, fibronectina e ácido hialurônico. Dessa forma, os eventos característicos da fase proliferativa são: fibroplasia, granulação e epitelização.

3ª - Maturação ou remodelamento: nessa etapa, há um relativo equilíbrio entre a síntese e reabsorção de colágeno, há degradação da matriz extracelular do colágeno. Além disso, as moléculas de colágeno tornam-se estáveis, produzindo aumento da força tensil da cicatriz, ocorrendo a contração da ferida pelo movimento centrípeto de toda a espessura da pele circundante. A cicatriz atinge sua resistência máxima ao redor de um ano. As principais células envolvidas são os **MIOFIBROBLASTOS**



A letra A está incorreta. Não existe fase "reativa". Além disso, a fase de maturação é a última fase e na fase proliferativa não há formação de cicatriz (essa se forma na fase de maturação).

A letra B está correta. Como vimos, essa é a alternativa correta.

A letra C está incorreta. A segunda fase é a proliferativa e a formação e contração da cicatriz ocorre na última fase (maturação ou remodelamento).

A letra D está incorreta. A hemostasia e quimiotaxia ocorre na fase inflamatória (primeira fase)

A letra E está incorreta. A ordem está incorreta. A fase em que ocorre a hemostasia e quimiotaxia é denominada "fase inflamatória"

Questão | | 2024 | 4000205809

Um paciente de 82 anos, lúcido, realizará uma cirurgia eletiva para câncer de reto. Sabendo da grande chance de o paciente precisar de um estoma, os familiares solicitam ao médico que não revele ao paciente essa informação antes do procedimento, pois referem que ele não irá aceitar a cirurgia. Assinale a alternativa que apresenta a melhor conduta diante desse caso.

A) Não revelar ao paciente a possibilidade do estoma, pois essa informação pode prejudicar psicologicamente o paciente.

Informar o paciente sobre a cirurgia, porém não sobre o estoma, deixando a explicação

B) apenas para depois do procedimento, com a finalidade de que ele não deixe de fazer a cirurgia, já que esta é fundamental para seu tratamento.

C) Revelar ao paciente apenas as informações que os familiares julgarem necessárias.

D) Informar o paciente sobre a possibilidade do estoma apenas se ele questionar sobre tal assunto.

Informar o paciente sobre a possibilidade do estoma, independente da vontade dos familiares, já que o paciente é lúcido e é dever do médico informar os riscos do tratamento ao paciente.

Solução

Informar o paciente sobre a possibilidade do estoma, independente da vontade dos familiares, já que o paciente é lúcido e é dever do médico informar os riscos do tratamento ao paciente.

GABARITO: ALTERNATIVA E

Estrategista,

O Código de Ética Médica é claro quanto à comunicação de diagnósticos e prognósticos:

“É vedado ao médico

Art. 34. Deixar de informar ao paciente o diagnóstico, o prognóstico, os riscos e os objetivos do tratamento, salvo quando a comunicação direta possa lhe provocar dano, devendo, nesse caso, fazer a comunicação a seu representante legal”.

Observe que o enunciado faz questão de informar que o paciente é lúcido. Portanto, a menos que a comunicação direta ao paciente possa causar dano direto (o que não é dito pelo enunciado), o médico não deve aceitar a proposta dos familiares de ocultar o prognóstico dele.

Com esse conceito em mente, vamos avaliar as alternativas:

A letra A está incorreta. Incorreta a alternativa A. Não há nada no enunciado que informe que a comunicação do prognóstico da cirurgia possa causar dano direto ao paciente.

A letra B está incorreta. Incorreta a alternativa B. O paciente tem o direito de saber sobre todas as informações e não se deve proceder com a comunicação do prognóstico por etapas, principalmente se após a realização do procedimento. Toda a comunicação deve ser anterior à cirurgia para que o paciente possa dar o seu consentimento livre e esclarecido.

A letra C está incorreta. Incorreta a alternativa C. O médico não deve ter a sua conduta baseada na opinião dos familiares.

A letra D está incorreta. Incorreta a alternativa D. O médico não deve comunicar o prognóstico apenas se o paciente perguntar, uma vez que é possível que ele nem saiba quais as consequências da cirurgia por ser leigo. Logo, não teria nem conhecimento para elaborar perguntas nesse sentido.

A letra E está correta. Correta a alternativa E, sem ressalvas.

Questão | | 2024 | 4000205810

Um paciente, que mora sozinho, está, no momento, acompanhado de um familiar que reside em uma cidade distante e permite que o médico lhe forneça o resultado de uma biópsia realizada de algumas lesões da pele. O diagnóstico é sarcoma de Kaposi. Esse familiar questiona o médico, junto ao paciente, sobre a doença e se sente surpreso, dizendo que o paciente sempre foi saudável e não possuía nenhuma doença prévia. Diante dessa situação, assinale a alternativa correta.

- Deve-se informar ao familiar, junto ao paciente, que o Kaposi é frequentemente observado
- A)** em pacientes com Imunodeficiência Adquirida (AIDS) e, portanto, deve ser investigada a presença da doença imediatamente.
- Deve-se informar ao familiar que o Kaposi é uma neoplasia maligna de tecidos moles de baixo grau, porém não se deve fornecer mais informações sem o consentimento do paciente,
- B)** pois ele pode ter o diagnóstico de AIDS em sigilo, já que o Kaposi é frequentemente associado à Imunodeficiência Adquirida.
- Já que o paciente permitiu fornecer o resultado da biópsia, é possível inferir que o familiar é
- C)** próximo e deve-se orientar os dois sobre a possibilidade de o paciente também ter AIDS, já que o Kaposi é frequentemente associado a essa patologia.
- Deve-se informar ao paciente e ao familiar que o Kaposi é uma neoplasia maligna associada à
- D)** AIDS, já que, nesse momento, o familiar é representante legal do paciente e não é preciso manter sigilo profissional em relação a esse familiar.
- Deve-se informar ao paciente e ao familiar sobre o Kaposi, sobre a possível associação da doença com a AIDS e que o paciente pode estar infectado com o vírus, já que, nessa ocasião
- E)** de risco a um terceiro (possibilidade de transmissão da doença por contato entre eles), o acompanhante também deve ter acesso a essas informações.

Solução

Gabarito: B) Deve-se informar ao familiar que o Kaposi é uma neoplasia maligna de tecidos moles de baixo grau, porém não se deve fornecer mais informações sem o consentimento do paciente, pois ele pode ter o diagnóstico de AIDS em sigilo, já que o Kaposi é frequentemente associado à Imunodeficiência Adquirida.

GABARITO: ALTERNATIVA B

Estrategista,

Observe quantas questões de Ética Médica o ENARE trouxe na edição de 2024! Portanto, o meu conselho aqui é que você priorize esse assunto se você for realizar essa prova!

O enunciado menciona um paciente que recebeu o diagnóstico de sarcoma de Kaposi. Justamente por isso, é necessário investigar se existe uma possível infecção pelo vírus HIV, já que essa neoplasia está frequentemente associada à essa infecção. Além disso, o paciente

está acompanhado de um familiar e autorizou que o médico fornecesse o resultado da biópsia de pele para esse familiar.

A partir disso, o examinador questiona a alternativa correta. Bom, observe que o paciente autorizou a comunicação do resultado da biópsia de pele, ou seja, do sarcoma de Kaposi. No entanto, nada foi acordado sobre a comunicação dos possíveis desdobramentos a partir dessa biópsia, tampouco sobre a possibilidade de uma infecção pelo vírus HIV. (aliás, o paciente nem sabe sobre essa possibilidade. Primeiro, deve-se conversar sobre isso com o paciente para que então ele decida se quer participar o familiar, ou não).

Portanto, o médico deve **APENAS** comunicar o diagnóstico do sarcoma, conforme combinado com o paciente.

Com essas informações iniciais, vamos analisar as alternativas:

A letra A está incorreta. Incorreta a alternativa A. Essa assertiva fala sobre o médico mencionar para o familiar a possibilidade de infecção pelo vírus HIV, mas conforme mencionado acima, nada foi acordado sobre esse assunto com o paciente.

A letra B está correta. Correta a alternativa B. Essa é a alternativa mais adequada dentre todas as propostas.

A letra C está incorreta. Incorreta a alternativa C. Não se deve inferir que o familiar é próximo. Deve-se cumprir aquilo que foi combinado com o paciente, que é a comunicação apenas da biópsia de pele.

A letra D está incorreta. Incorreta a alternativa D. O sigilo médico deve ser mantido independentemente da gravidade da situação.

A letra E está incorreta. Incorreta a alternativa E. Mais uma vez, a comunicação sobre um possível diagnóstico de infecção pelo vírus HIV não deve ser feita ao familiar.

Questão | | 2024 | 4000205811

Um paciente de 37 anos, com pele e olhos claros e história familiar de melanoma, possui uma lesão pigmentada em região da mão esquerda de, aproximadamente, 1 cm. Nesse caso, a melhor conduta a ser seguida para esse paciente é realizar

- A)** biópsia incisional da lesão e sutura em pontos simples com fio absorvível.
- B)** tratamento precoce, com ressecção da lesão com margens amplas devido ao histórico familiar, com sutura contínua após ressecção.
- C)** biópsia excisional da lesão e sutura em pontos simples com fio inabsorvível.
- D)** ressecção da lesão com margem de 1 cm devido à alta suspeita de melanoma e sutura contínua com fio inabsorvível.

E) biópsia com 5 mm de margem e enxerto em mão com sutura contínua.

Solução

Gabarito: C) biópsia excisional da lesão e sutura em pontos simples com fio inabsorvível.

Estrategista, diante de toda lesão pigmentada devemos aplicar a regra do ABCDE para sabermos se podemos estar diante de um melanoma. Vamos lembrar?

A – assimetria. Lesão assimétrica indica suspeita de malignidade

B – bordas irregulares. Bordas irregulares indica suspeita de malignidade

C – cores. Lesões pigmentadas com múltiplas cores (preto, marrom escuro, marrom claro...) indicam suspeita de malignidade

D – diâmetro. Lesões pigmentadas com diâmetro maior que 5mm indicam suspeita de malignidade

E - evolução. Lesões que estão mudando de aspecto indicam malignidade.

Essa lesão é pigmentada e apresenta um tamanho de 1cm, portanto, é suspeita de ser melanoma. Também é importante levar em conta que a paciente apresenta importantes fatores de risco para o surgimento desse câncer que é o fototipo baixo (pele e olhos claros) e ainda história familiar.

Diante da suspeita de melanoma, a conduta adequada é realizar biópsia excisional (remoção completa da lesão) com margens de 1 a 3mm. Vamos analisar agora as alternativas.

A letra A está incorreta. Alternativa A) Incorreta. A biópsia incisional (remoção de apenas um fragmento da lesão) não é a melhor abordagem diante da suspeita de melanoma. Para esse diagnóstico, o patologista necessita analisar toda a amostra.

A letra B está incorreta. Alternativa B) Incorreta. Evitamos nesse momento realizar uma biópsia ampla pois podemos comprometer a drenagem linfática peritumoral caso necessitemos realizar a pesquisa de linfonodo sentinela. Por isso, no primeiro momento realizamos biópsia com margens exíguas e, caso seja confirmado o melanoma, realizamos a ampliação das margens posteriormente.

A letra C está correta. Alternativa C) Correta. Alternativa perfeita. Essa é a conduta e realizamos realmente sutura da pele com fio inabsorvível (geralmente nylon).

A letra D está incorreta. Alternativa D) Incorreta. Pelo mesmo motivo que falamos na alternativa B.

A letra E está incorreta. Alternativa E) Incorreta. A margem deve ter no máximo 3mm e é realizado fechamento primário do defeito cirúrgico.

Questão | | 2024 | 4000205812

Um médico está realizando uma live (transmissão ao vivo) para alunos de medicina dentro do centro cirúrgico e, sem avisar, adentra a sala de um segundo médico (cirurgião) durante a realização de uma gastroduodenopancreatectomia, solicitando que o colega descreva e

demonstre os passos dessa cirurgia. Assinale a melhor conduta e a justificativa do segundo cirurgião diante dessa situação.

- A)** Tendo em vista o aprendizado que os expectadores terão sobre uma cirurgia não tão comum, o cirurgião deve aceitar a proposta e demonstrar a cirurgia durante a live.
- B)** O cirurgião deve aceitar a proposta e, posteriormente, informar ao paciente que foi realizada a live com o intuito de contribuir para o avanço da medicina.
- C)** O cirurgião não deve aceitar a proposta devido à proibição do Conselho Federal de Medicina quanto à realização de lives realizadas por médicos.
- D)** O cirurgião deve aceitar a proposta desde que, posteriormente, o paciente seja compensado monetariamente pelo uso de sua imagem.
- E)** O cirurgião não deve aceitar a proposta, pois a imagem do paciente não deve ser exposta na mídia, especialmente sem sua prévia autorização.

Solução

Gabarito: E) O cirurgião não deve aceitar a proposta, pois a imagem do paciente não deve ser exposta na mídia, especialmente sem sua prévia autorização.

GABARITO: ALTERNATIVA E

Estrategista,

Como dito nas questões anteriores, essa banca do ENARE vem mostrando predileção pelas questões de Ética Médica. Por isso, priorize esse tema para a sua prova!

Observe que o médico realizou uma live para alunos de medicina dentro do centro cirúrgico e, sem qualquer combinação prévia, adentrou a sala de um outro cirurgião e pediu que ele descrevesse o passo a passo de uma gastroduodenopancreatectomia.

No entanto, a transmissão do caso do paciente, ainda que exclusivamente para alunos de Medicina, deve ter autorização expressa dele. Logo, se nada foi combinado previamente, o médico cirurgião NÃO deve aceitar que o colega realize a transmissão ao vivo. Portanto: A letra A está incorreta. Incorreta a alternativa A. O cirurgião não deve aceitar a proposta, uma vez que nada foi acordado previamente com o paciente.

A letra B está incorreta. Incorreta a alternativa B pelo mesmo motivo descrito em A.

A letra C está incorreta. Incorreta a alternativa C. A realização de lives não é proibida pelo Conselho Federal de Medicina. O que é proibido é a exposição do caso sem a devida autorização do paciente.

A letra D está incorreta. Incorreta a alternativa D. A assertiva propõe a utilização da imagem do paciente sem o seu consentimento e ainda oferecer recompensa monetária por isso, o que seria completamente antiético.

A letra E está correta. Correta a alternativa E, sem ressalvas.

Questão | | 2024 | 4000205813

Assinale a alternativa que apresenta alguns dos principais genes mutados que contribuem para o surgimento do câncer colorretal hereditário e um dos fatores que pode contribuir para a prevenção do câncer colorretal esporádico.

- A)** BRCA 1 e BRCA 2 / Consumo diário de grandes quantidades de proteína.
- B)** VHL e KRAS / Ingestão diária de ômega 3.
- C)** BRAF e MEN1 / Dieta restrita em carnes vermelhas e gorduras.
- D)** APC e MSH2 / Atividade física regular.
- E)** BRCA 2 e p53 / Alimentação rica em frutas e vegetais.

Solução

Gabarito: D) APC e MSH2 / Atividade física regular.

O câncer colorretal pode ser categorizado em hereditário e esporádico, com diferenças significativas em suas etiologias. O câncer colorretal hereditário está frequentemente associado a mutações genéticas específicas, enquanto o esporádico é mais influenciado por fatores ambientais e de estilo de vida. A compreensão desses aspectos é crucial para a prevenção e o tratamento eficazes.

Vamos analisar cada alternativa:

A letra A está incorreta. INCORRETA. BRCA1 e BRCA2 são genes mais comumente associados ao câncer de mama e de ovário. Embora possam ter um papel em outros tipos de câncer, não são os principais genes associados ao câncer colorretal hereditário. Além disso, o consumo diário de grandes quantidades de proteína não é reconhecido como um fator de prevenção para o câncer colorretal esporádico.

A letra B está incorreta. INCORRETA: VHL e KRAS são genes associados a diferentes tipos de câncer. O gene VHL está mais relacionado ao carcinoma de células renais, enquanto mutações no KRAS são comuns em vários tipos de câncer, incluindo colorretal, mas não são os principais genes associados ao câncer colorretal hereditário. A ingestão diária de ômega 3 pode ter benefícios para a saúde, mas sua relação direta com a prevenção do câncer colorretal esporádico não é claramente estabelecida.

A letra C está incorreta. INCORRETA: BRAF e MEN1 são genes associados ao câncer, mas não são os principais genes relacionados ao câncer colorretal hereditário. Uma dieta restrita em carnes vermelhas e gorduras pode contribuir para a prevenção do câncer colorretal esporádico, mas a associação genética apresentada nesta opção é imprecisa.

A letra D está correta. CORRETA: APC e MSH2 são genes frequentemente mutados no câncer colorretal hereditário, particularmente na polipose adenomatosa familiar e na síndrome de Lynch, respectivamente. MSH2, assim como MSH1, são genes que fazem parte do complexo MMR (Mismatch Repair), um conjunto de genes que codificam proteínas para o reparo do DNA. Mutação nesses genes leva à chamada "instabilidade microssatélite", o principal mecanismo gerador da Síndrome de Lynch. A atividade física regular é reconhecida como um fator que pode contribuir para a prevenção do câncer colorretal esporádico, reduzindo o risco através de vários mecanismos biológicos, especialmente no controle do peso corporal.

A letra E está incorreta. INCORRETA. BRCA2 é mais conhecido por sua associação com o câncer de mama e ovário, embora possa ter um papel em outros tipos de câncer, incluindo o colorretal. O gene p53 é um importante gene supressor de tumor e está envolvido em muitos tipos de câncer, mas não é um dos principais genes associados especificamente ao câncer colorretal hereditário. Quanto à alimentação rica em frutas e vegetais, esta é, de fato, recomendada para a prevenção do câncer colorretal esporádico, pois fornece fibras, vitaminas e antioxidantes que podem ajudar a reduzir o risco. No entanto, a combinação de genes mencionada nesta alternativa não é a mais representativa para o câncer colorretal hereditário.

Questão | | 2024 | 4000205814

No caso de um paciente que realizou gastrectomia parcial e tem apresentado, 20 minutos após a ingesta alimentar, sintomas como náuseas, vômitos, sensação de plenitude gástrica, diarreia explosiva, palpitações e taquicardia, qual é o provável diagnóstico e a orientação que o médico deve fornecer para a melhora dos sintomas?

- A)** Dumping tardio / Orientar a evitar hipoglicemia, ingerindo maiores quantidades de alimentos com açúcar em um menor intervalo de tempo.
 - B)** Síndrome da alça aferente / Orientar o paciente a provocar vômitos quando tiver os sintomas de plenitude gástrica, pois geralmente gera um alívio imediato dos sintomas.
 - C)** Gastrite alcalina de refluxo / Orientar o paciente a utilizar inibidor de bomba de prótons a cada 12 horas e evitar a ingestão de alimentos ácidos.
 - D)** Atonia gástrica / Utilizar pró-cinéticos como a metoclopramida e fazer a ingestão de várias refeições com menores quantidades de alimentos.
- Dumping precoce / Orientar a evitar alimentos que contenham grande quantidade de açúcar,
- E)** realizar pequenas refeições com proteínas e gorduras em menor intervalo de tempo e separar os líquidos dos sólidos durante as refeições.

Solução

Dumping precoce / Orientar a evitar alimentos que contenham grande quantidade

Gabarito: E) de açúcar, realizar pequenas refeições com proteínas e gorduras em menor

intervalo de tempo e separar os líquidos dos sólidos durante as refeições.

A síndrome de dumping precoce pode ocorrer em até 50% dos pacientes submetidos ao bypass gástrico. Ela corresponde ao surgimento de sintomas gastrointestinais e vasomotores em 15 a 20 minutos após as refeições. Os sintomas gastrointestinais incluem náuseas e vômitos, sensação de plenitude gástrica, cólicas abdominais e, frequentemente, diarreia explosiva. Com menor frequência, ocorrem sintomas vasomotores, como palpitações, diaforese, tonturas e rubor. O dumping precoce é resultado do rápido esvaziamento de alimentos hiperosmolares no intestino delgado devido à interrupção do mecanismo pilórico, que, associada à pequena bolsa gástrica criada no BGYR, impede o estômago de preparar seu conteúdo e liberá-lo para o intestino proximal sob a forma de pequenas partículas em solução isotônica. O bolo alimentar hipertônico passa para o lúmen intestinal e induz à rápida passagem de líquido extracelular para o lúmen intestinal, a fim de obter a isotonicidade. Esse deslocamento de líquido extracelular promove distensão intestinal que, por sua vez, gera as respostas autonômicas responsáveis pelos sintomas descritos. Os pacientes devem ser orientados a evitar alimentos ricos em açúcar e a substituí-los por uma dieta composta por alimentos ricos em fibras, em carboidratos complexos, em gorduras e em proteínas, além de fazer refeições pequenas e frequentes.

Já a síndrome de dumping tardio, atualmente referida como hipoglicemia hiperinsulinêmica pós-prandial, é uma complicação mais rara. Os sintomas do dumping tardio geralmente ocorrem de uma a três horas após a ingestão de carboidratos e, geralmente, meses a anos

após a cirurgia. Estão associados à hipoglicemia documentada. A fisiopatologia não é totalmente compreendida. A liberação acelerada de carboidratos no lúmen intestinal e sua rápida absorção resulta em hiperglicemia, processo que desencadeia a liberação de grandes quantidades de insulina. Isso pode resultar em uma resposta excessiva e evoluir para uma hipoglicemia profunda em resposta a esse excesso de insulina. A glândula adrenal é excitada a liberar catecolaminas e o paciente desenvolve sintomas adrenérgicos, como diaforese, tremores, tonturas e taquicardia.

A letra A está incorreta. Incorreta. A ocorrência de sintomas gastrointestinais e vasomotores em 15-30min após a ingesta alimentar nos faz pensar em dumping precoce, e não tardio.

A letra B está incorreta. A síndrome da alça aferente (SAA) é uma obstrução mecânica da passagem da bile pela alça aferente com uma incidência de 0,2-13%. Geralmente, apresenta-se como uma complicação de gastrectomia subtotal com reconstrução à Billroth II, hepato-jejunostomia em Y de Roux ou duodenopancreatectomia. A obstrução ocorre por torção da alça, hérnias internas ou por aderência. Os sintomas mais frequentes são dor epigástrica que irradia para região interescapular e vômitos biliosos, devido à dilatação da alça aferente. O tratamento deve ser cirúrgico ou endoscópico.

A letra C está incorreta. Incorreta. A gastrite alcalina de refluxo é caracterizada por sintomas dispépticos de intensidades variáveis e regurgitação biliar pós-prandiais. Não ocorrem sintomas vasomotores (palpitação, taquicardia, sensação de desmaio)

A letra D está incorreta.

A atonia gástrica (ou gastoparesia) leva a um retardo no esvaziamento gástrico, causando sintomas como plenitude gástrica, estufamento abdominal, regurgitação, pirose. Não causa sintomas vasomotores como os descritos no enunciado.

A letra E está correta. Correta. As orientações nutricionais para o dumping precoce são: fracionamento das refeições, diminuir o índice glicêmico da refeição (adicionando fibras, gorduras e proteínas ao invés da ingesta de carboidratos simples isolados) e não ingerir líquidos durante as refeições.

Questão | | 2024 | 4000205815

Uma paciente gestante de 25 semanas apresenta dor em região de flanco direito há 1 dia, associada a náuseas e vômitos. No hemograma, apresenta uma leucocitose de 11.500 (VR = 10.000). Quanto a esse caso, é correto afirmar que

- A)** se deve fazer uma ultrassonografia abdominal devido à suspeita de apendicite aguda e, caso necessário, uma tomografia para melhor visualização do apêndice.
- há suspeita de apendicite aguda, devido à localização da dor (apêndice deslocado
- B)** cefalicamente). Uma ultrassonografia de abdome pode visualizar o apêndice e ajudar a esclarecer o diagnóstico.
- pode se tratar apenas de uma intercorrência da gestação, como dor do ligamento redondo.
- C)** Para melhor esclarecimento do caso, deve-se solicitar uma ressonância de abdome, já que a ultrassonografia não é recomendada nessa idade gestacional.
- há grandes chances de ser uma apendicite aguda, já que a paciente tem dor em flanco
- D)** direito (apêndice deslocado cefalicamente) e tem leucocitose, sinal de que há um processo inflamatório agudo vigente.
- E)** se trata de uma provável colecistite, devido à topografia da dor associada à leucocitose, que favorece processo inflamatório agudo.

Solução

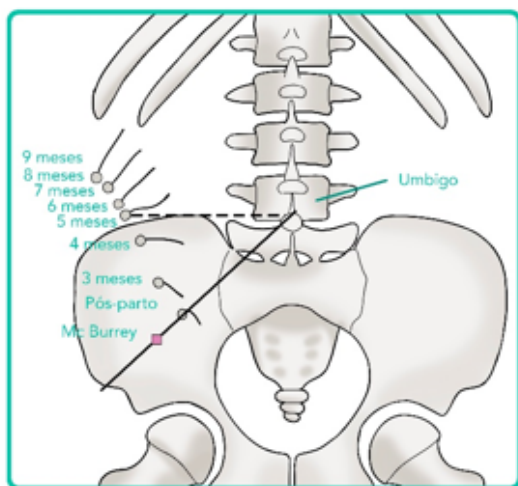
há suspeita de apendicite aguda, devido à localização da dor (apêndice deslocado

Gabarito: B) cefalicamente). Uma ultrassonografia de abdome pode visualizar o apêndice e ajudar a esclarecer o diagnóstico.

A apendicite aguda é a emergência cirúrgica, não obstétrica, mais comum durante a gravidez. É mais comum nos dois primeiros trimestres, com incidência de 32%, 42% e 26% no primeiro, segundo e terceiro trimestres, respectivamente.

A apresentação clássica da apendicite está presente em 50 a 60% dos casos. O sintoma mais comum de apendicite, a dor no quadrante inferior direito, ocorre próximo ao ponto de McBurney na maioria das mulheres grávidas; no entanto, a localização do apêndice migra

alguns centímetros cefálicos com o útero aumentado; portanto, no terceiro trimestre, a dor pode se localizar no meio ou mesmo no lado superior direito do abdome. O útero gravídico também pode impedir o contato entre o omento e o apêndice, e dessa forma, favorecer uma peritonite difusa, já que a perfuração não será bloqueada pelo omento. Como a apresentação da apendicite na paciente gestante muitas vezes não é clássica, que geralmente acontece no final da gravidez, o exame de imagem está indicado. O primeiro exame indicado é a ultrassonografia e se ainda persistir dúvida, uma ressonância nuclear magnética sem contraste. Feito o diagnóstico, o tratamento é cirúrgico, ou seja, apendicectomia, que pode ser feita por via aberta convencional ou por laparoscopia.



A letra A está incorreta. Realmente o primeiro exame indicado é a ultrassonografia, mas se ainda persistir dúvida, o melhor exame a ser realizado é a ressonância nuclear magnética sem contraste.

A letra B está correta. Como vimos, esta é a alternativa correta.

A letra C está incorreta. A ultrassonografia é o primeiro exame de imagem a ser solicitado na suspeita de apendicite na gestante, independente da idade gestacional.

A dor do ligamento redondo geralmente se localiza no abdome inferior.

A letra D está incorreta. Lembre-se que na gestação pode ocorrer uma "leucocitose fisiológica", e não necessariamente processo inflamatório agudo vigente.

A suspeita de apendicite neste caso apresentado é com base no quadro clínico, não na "leucocitose".

A letra E está incorreta. A principal causa de abdome agudo não obstétrico na gestante é a apendicite aguda e a segunda causa, colecistite aguda.

A dor no flanco é justificada pelo deslocamento cranial do apêndice cecal.

Além disso, a colecistite apresenta dor no hipocôndrio direito, mais comumente.

Questão | | 2024 | 4000205816

Um paciente de 45 anos teve uma pancreatite aguda e, após 6 semanas, passou a notar dor abdominal persistente, saciedade precoce, náusea e perda de peso. Ao procurar o serviço médico, foram verificados níveis elevados das enzimas pancreáticas e uma lesão cística de aproximadamente 8 cm em cauda do pâncreas, em contato com a parede gástrica. Qual é o provável diagnóstico e a conduta mais adequada nesse caso?

- A)** Trata-se provavelmente de necrose pancreática que deve ser tratada com antibióticos de amplo espectro como o meropenem.
- B)** Trata-se provavelmente de um pseudocisto pancreático que deve ser tratado com antibióticos de amplo espectro como o meropenem.
- C)** Trata-se provavelmente de pseudocisto pancreático e pode-se tentar uma drenagem endoscópica transgástrica.
- D)** Trata-se provavelmente de necrose pancreática que deve ser tratada de maneira expectante, com indicação de intervenção cirúrgica se o paciente apresentar febre.
- E)** Trata-se provavelmente de pseudocisto pancreático que deve ser tratado com abordagem cirúrgica por laparotomia.

Solução

Gabarito: C) Trata-se provavelmente de pseudocisto pancreático e pode-se tentar uma drenagem endoscópica transgástrica.

Estrategista, estamos avaliando um paciente com um histórico de pancreatite aguda que desenvolveu uma lesão cística no pâncreas após seis semanas. Os sintomas e achados clínicos e radiológicos são cruciais para determinar o diagnóstico e a conduta apropriada. Vamos analisar cada alternativa:

A letra A está incorreta. A) INCORRETA: A descrição de uma lesão cística de 8 cm na cauda do pâncreas após um episódio de pancreatite aguda sugere um pseudocisto, não necrose pancreática. A necrose pancreática geralmente apresenta um conteúdo mais heterogêneo nas imagens radiológicas. Além disso, o uso de antibióticos de amplo espectro como o meropenem é indicado na presença de infecção, não como tratamento padrão para necrose pancreática.

A letra B está incorreta. B) INCORRETA: Embora a descrição seja consistente com um pseudocisto pancreático, o uso de antibióticos de amplo espectro não é a conduta padrão para pseudocistos, a menos que haja evidência de infecção secundária.

A letra C está correta. C) CORRETA: Esta alternativa é consistente com o diagnóstico provável de pseudocisto pancreático. A drenagem endoscópica transgástrica é uma opção de tratamento minimamente invasiva para esse tipo de lesão, especialmente aqueles em contato com a parede gástrica, como descrito no caso.

A letra D está incorreta. INCORRETA: Como já foi dito, a descrição da lesão como cística não é compatível com necrose pancreática. Além disso, a abordagem expectante com indicação de intervenção cirúrgica em caso de febre não é a conduta padrão para necrose pancreática, que pode requerer intervenção mais ativa dependendo da extensão da necrose e da presença de complicações.

A letra E está incorreta. INCORRETA: Embora a cirurgia possa ser uma opção para o tratamento de pseudocistos pancreáticos, a abordagem cirúrgica por laparotomia geralmente é reservada para casos complicados ou refratários a outras modalidades de tratamento. A drenagem endoscópica, como mencionado na alternativa C, é frequentemente preferida devido à sua natureza menos invasiva.

Questão | | 2024 | 4000205817

O médico de um paciente cirrótico está verificando a possibilidade de uma cirurgia hepática para esse paciente, porém, para isso, quer primeiro verificar qual seu escore Child-Pugh, já que este possui correlação com a sobrevida do paciente. Nesse sentido, o paciente apresenta os seguintes exames: bilirrubina de 2,5 mg/dL; albumina de 2,6 g/dL; tempo de protrombina de 2 segundos; nenhuma ascite ou encefalopatia. Diante desses resultados, qual é a classificação de Child-Pugh desse paciente e sua chance de sobrevida?

- A) Child-Pugh A / Sobrevida alta.
- B) Child-Pugh B / Sobrevida intermediária.
- C) Child-Pugh C / Sobrevida baixa.
- D) Child-Pugh D / Sobrevida alta.
- E) Child-Pugh C / Sobrevida intermediária.

Solução

Gabarito: B) Child-Pugh B / Sobrevida intermediária.

Estamos diante de um paciente cirrótico cujo médico está considerando uma cirurgia hepática. Antes de prosseguir, é crucial avaliar a gravidade da doença hepática do paciente usando a classificação de Child-Pugh, que é um indicador prognóstico importante em cirrose. Esta classificação leva em conta cinco parâmetros: bilirrubinas séricas, albumina sérica, tempo de protrombina, presença e grau de ascite, e grau de encefalopatia hepática. Cada um desses critérios é pontuado de acordo com a severidade, e a soma dos pontos determina a classificação de Child-Pugh (A, B ou C), que correlaciona com a sobrevida e o risco cirúrgico. Veja a tabela com os parâmetros e a pontuação correspondente do Child abaixo:

Child-Turcot-Pugh			
	1 PONTO	2 PONTOS	3 PONTOS
BILIRRUBINA (mg/dL)	< 2,0	2 - 3	> 3,0
ALBUMINA (g/dL)	> 3,5	3,5 - 3,0	< 3,0
TEMPO DE PROTROMBINA (s) ou INR	0-3 / < 1,7	4 - 6 / 1,7 - 2,3	> 6 / > 2,3
ASCITE	Ausente	Leve ou facilmente controlada	Moderada a grave ou mal controlada
ENCEFALOPATIA	Ausente	Grau 1 ou 2	Grau 3 ou 4
5 a 6 pontos – Child A 7 a 9 pontos – Child B 10 a 15 pontos – Child C			

No caso deste paciente, os parâmetros são: bilirrubina de 2,5 mg/dL (2 pontos), albumina de 2,6 g/dL (3 pontos), tempo de protrombina em 2 segundos (1 ponto), sem ascite (1 ponto) ou encefalopatia (1 ponto). Estes resultados sugerem uma doença hepática de gravidade moderada.

Vamos analisar as opções de resposta:

A letra A está incorreta. INCORRETA. O paciente soma mais de 6 pontos, portanto, não tem como ser um Child A.

A letra B está correta. CORRETA: Com base nos dados fornecidos, o paciente soma 8 pontos na classificação de Child-Pugh, o que corresponde à categoria B (7 a 9 pontos). Esta categoria indica uma doença hepática de gravidade moderada, com sobrevida intermediária e risco cirúrgico aumentado em comparação com a categoria A, mas menor que na categoria C. A pontuação é determinada da seguinte forma: 2 pontos para bilirrubinas, 3 pontos para albumina,

1 ponto para tempo de protrombina, 1 ponto para a ausência de ascite e 1 ponto para a ausência de encefalopatia.

A letra C está incorreta. INCORRETA. Para ser Child C, ele teria que somar mais de 9 pontos, o que não ocorre.

A letra D está incorreta. INCORRETA. Não existe a categoria D na classificação de Child.

A letra E está incorreta. INCORRETA. Além da pontuação não corresponder à categoria C, essa representaria uma sobrevida curta, não intermediária.

Questão | | 2024 | 4000205818

Sobre doença de Crohn e colite ulcerativa, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma a seguir e assinale a alternativa com a sequência correta.

- () O tabagismo parece conferir um efeito protetor na colite ulcerativa.
- () A lesão mais característica da colite ulcerativa é o abscesso das criptas de Lieberkühn.
- () Uma característica histológica importante da doença de Crohn é o granuloma não caseoso, um agregado de histiócitos epitelioides circundados por neutrófilos e células gigantes.
- () O paciente com doença de Crohn pode desenvolver fístulas entre o intestino e qualquer outro órgão intra abdominal, a maioria delas envolve o intestino delgado.

- A) V – V – F – V.
- B) F – V – F – V.
- C) V – V – V – V.
- D) V – V – F – F.
- E) F – V – V – F.

Solução

Gabarito: C) V – V – V – V.

"Doenças inflamatórias intestinais" (DIIs) é termo usado para agrupar afecções caracterizadas por inflamação crônica do intestino, entre as quais estão incluídas a Doença de Crohn (DC) e a Retocolite Ulcerativa (RCU). A respeito das mesmas, vamos classificar as assertivas.

(V) O tabagismo é fator protetor para retocolite ulcerativa e fator de risco para doença de Crohn.

(V) A retocolite ulcerativa cursa com envolvimento CONTÍNUO do reto e sigmóide, compatível com um padrão ASCENDENTE. A presença de enantema e úlceras rasas falam a

favor da acometimento da MUCOSA, camada mais superficial da parede intestinal. Além disso, os achados anatomopatológico revelam inflamação do reto com MICROABSCESSOS DE CRIPTAS, típicos e sugestivos de RETOCOLITE ULCERATIVA.

(V) O granuloma epitelióide não caseoso é achado esperado em doentes portadores de DC, embora não seja obrigatório. O granuloma epitelióide não ocorre na RCU.

(V) A DC pode comprometer toda a parede intestinal, propiciando o desenvolvimento de fístulas. Tais fístulas podem comunicar um segmento a outro do TGI, dificultando o seu pleno funcionamento. Assim, ocorrem fístulas enterogástricas, enterocolônicas, colônicas, coloduodenal e cologástrica. Comunicações entre trato genitourinário e gastrointestinal também são possíveis.

GABARITO: VVVV

A letra A está incorreta.

A letra B está incorreta.

A letra C está correta. CORRETA.

A letra D está incorreta.

A letra E está incorreta.

Questão | | 2024 | 4000205819

Um paciente com obstrução e infecção das vias biliares apresenta a chamada tríade de Charcot, a qual é caracterizada por:

- A)** icterícia, hipotensão e confusão mental.
- B)** dor em hipocôndrio direito, icterícia e hipotensão.
- C)** febre, hipotensão e icterícia.
- D)** icterícia, dor em hipocôndrio direito e febre.
- E)** febre, icterícia e confusão mental.

Solução

Gabarito: D) icterícia, dor em hipocôndrio direito e febre.

A tríade de Charcot, presente nos quadros de colangite guda é composta por: dor abdominal, febre e icterícia.

Já a pêntade de Reynold's, da colangite aguda grave consiste na tríade de Charcot associada à hipotensão arterial e alteração do nível de consciência (por exemplo, sonolência, confusão mental)

A letra A está incorreta. Hipotensão e confusão mental fazem parte da Pêntade de Reynolds

A letra B está incorreta. Hipotensão não faz parte da tríade de Charcot.

A letra C está incorreta. Hipotensão não faz parte da tríade de Charcot.

A letra D está correta. Esses sintomas definem a tríade de Charcot.

A letra E está incorreta. Confusão mental não faz parte da tríade de Charcot.

Questão | | 2024 | 4000205820

Um paciente encontra-se internado devido a uma infecção de partes moles associada à lesão vegetante, friável e ulcerativa em perna, com crescimento há 2 meses, sem melhora. É solicitada uma avaliação médica para biópsia. A enfermeira do setor do paciente liga para o médico, que se encontra em outro setor do hospital atendendo a um segundo paciente, e questiona se ela pode ir realizando a biópsia enquanto ele não chega. Quanto a essa situação, assinale a alternativa correta.

- O médico deve permitir que a enfermeira realize a biópsia, tendo em vista que será de fácil
- A)** execução e que poderá agilizar o diagnóstico, já que provavelmente é compatível com um câncer de pele.
- B)** O médico deve permitir que a enfermeira realize a biópsia, porém deve orientá-la sobre a execução do procedimento, passo a passo, antes de iniciá-lo.
- C)** O médico deve solicitar à enfermeira que aguarde a sua chegada para iniciar a realização da biópsia, permitindo que ela a realize para ampliar seu conhecimento prático.
- O médico deve pedir à enfermeira que não realize a biópsia nesse momento, porque,
- D)** primeiro, deve ser avaliada a existência de outras lesões que necessitam de biópsia a fim de que ela realize todas em um mesmo tempo.
- E)** O médico deve pedir à enfermeira que não realize a biópsia, pois esse tipo de procedimento é considerado um ato privativo do médico.

Solução

Gabarito: E) O médico deve pedir à enfermeira que não realize a biópsia, pois esse tipo de procedimento é considerado um ato privativo do médico.

GABARITO: ALTERNATIVA E

Estrategista,

O ENARE 2024 vem mostrando predileção pela Ética Médica, cobrando esse tema em uma frequência maior do que aquela observada em outras provas de residência médica. Por isso, fique atento!

No caso dessa questão, temos um paciente internado por uma infecção de partes moles. Há ainda uma lesão vegetante, friável e ulcerativa, que como vem crescendo há 2 meses sem melhora, necessita ser biopsiada. Porém, o médico assistente está em outro setor do hospital atendendo outro paciente.

O ponto de conflito da questão é justamente o fato de a enfermeira ter ligado para o médico e perguntado se ela pode iniciar a biópsia enquanto ele não chega.

Ora, já existe consenso, inclusive para o COFEN (Conselho Federal de Enfermagem) que a biópsia de qualquer lesão é um ato exclusivamente médico.

Além disso, o nosso Código de Ética Médica proíbe que o médico ensine a realização de procedimentos exclusivamente médicos para profissionais de outras categorias:

Portanto:

A letra A está incorreta. Incorreta a alternativa A. O médico não deve permitir que a enfermeira realize a biópsia.

A letra B está incorreta. Incorreta a alternativa B porque, como vimos, a biópsia é um ato exclusivamente médico e o profissional não deve permitir que a enfermeira realize esse procedimento.

A letra C está incorreta. Incorreta a alternativa C. Como vimos, o médico não deve ensinar a profissionais de outras categorias procedimentos que sejam considerados um ato médico.

A letra D está incorreta. Incorreta a alternativa D. Como dito nas alternativas anteriores, a enfermeira não deve realizar a biópsia.

A letra E está correta. Correta a alternativa E, sem ressalvas.

Questão | | 2024 | 4000205821

Durante atendimento de um paciente portador de artrite reumatoide, ele demonstra bastante resistência para realizar o tratamento com medicações injetáveis. Diante desse cenário, qual atitude é a mais adequada?

- A) Ameaçar abandonar o acompanhamento, caso o paciente não aceite a medicação indicada.
- B) Respeitar o direito do paciente de decidir livremente sobre seu tratamento, salvo em risco iminente de morte.
- C) Prescrever o que há de melhor para o paciente, independentemente das preferências individuais dele.
- D) Oferecer apenas o tipo de tratamento que julgar melhor, não sendo necessário utilizar todos os meios disponíveis de promoção de saúde e de tratamento.
- E) Exagerar a gravidade do diagnóstico ou do prognóstico e complicar a terapêutica, para que o paciente entenda que a medicação injetável é extremamente necessária.

Solução

Gabarito: B) Respeitar o direito do paciente de decidir livremente sobre seu tratamento, salvo em risco iminente de morte.

GABARITO: ALTERNATIVA B

Estrategista,

O enunciado aborda um paciente que tem artrite reumatoide e que está bastante resistente ao início do tratamento com medicamentos injetáveis, ou seja, o paciente **NÃO** quer passar utilizar esse tipo de medicação. Portanto, trata-se de uma questão sobre **recusa terapêutica**.

Mas que recusa é essa?

Segundo a Resolução nº 2.232/2019 do Conselho Federal de Medicina, trata-se do direito que o paciente tem de negar a oferta de um determinado tratamento, já que a autonomia é um princípio bioético que deve ser respeitado. Diante de um paciente que não deseja aderir ao tratamento, o médico deve informar as consequências (isto é, os prejuízos à saúde) que essa recusa pode trazer. Se mesmo assim o paciente mantiver sua decisão, o médico deve respeitar a recusa, propondo outro tratamento.

No entanto, para que a recusa terapêutica do paciente seja aceita pelo médico, o paciente deve estar lúcido, orientado e ser plenamente capaz no momento da decisão.

Veja o que diz os artigos 1º e 2º da resolução supracitada:

“Art. 1º. A recusa terapêutica é, nos termos da legislação vigente e na forma desta Resolução, um direito do paciente a ser respeitado pelo médico, desde que esse o informe dos riscos e das consequências previsíveis de sua decisão.

Art. 2º. É assegurado ao paciente maior de idade, capaz, lúcido, orientado e consciente, no momento da decisão, o direito de recusa à terapêutica proposta em tratamento eletivo, de acordo com a legislação vigente.

Parágrafo único. O médico, diante da recusa terapêutica do paciente, pode propor outro tratamento quando disponível”.

Porém, em caso de urgências, emergências e risco iminente de morte, o médico pode agir levando o tratamento a diante, mesmo se o paciente se recusar.

Por exemplo, um paciente em consulta eletiva de Oncologia que se nega a passar por quimioterapia pode ter a sua recusa terapêutica respeitada porque o tratamento ainda é eletivo. O mesmo não pode acontecer com um paciente que professa uma religião que não permite transfusões sanguíneas, mas que sofre um acidente com hemorragia intensa e passa a necessitar de transfusão. Nesse caso, a transfusão deve ser considerada devido à gravidade da situação. Veja a seguir o que a Resolução 2.232/2019 fala sobre a não aceitação da recusa terapêutica por parte do médico:

“Art. 3º - Em situações de risco relevante à saúde, o médico não deve aceitar a recusa terapêutica de paciente menor de idade ou de adulto que não esteja no pleno uso de suas faculdades mentais, independentemente de estarem representados ou assistidos por terceiros.

(...)

“Art. 11. Em situações de urgência e emergência que caracterizarem iminente perigo de morte, o médico deve adotar todas as medidas necessárias e reconhecidas para preservar a vida do paciente, independentemente da recusa terapêutica”.

- Certo, mas e se o paciente recusar um determinado tratamento e propor outro que o médico não concorde?

Nesse caso, o médico pode lançar mão do que chamamos de **“objeção de consciência”**. Segundo a resolução supracitada, a objeção de consciência é o direito do médico de se abster do atendimento ao paciente justamente pela não concordância em relação ao tratamento. Mas atenção: o médico só pode proceder com a objeção de consciência caso isso não coloque o paciente em risco. Caso contrário, nada feito.

“Art. 8º. Objeção de consciência é o direito do médico de se abster do atendimento diante da recusa terapêutica do paciente, não realizando atos médicos que, embora permitidos por lei, sejam contrários aos ditames de sua consciência.

(...)

Art. 10. Na ausência de outro médico, em casos de urgência e emergência e quando a recusa terapêutica trazer danos previsíveis à saúde do paciente, a relação com ele não pode ser interrompida por objeção de consciência, devendo o médico adotar o tratamento indicado, independentemente da recusa terapêutica do paciente”.

Com essas informações, vamos analisar as alternativas:

A letra A está incorreta. Incorreta a alternativa A. Embora seja um tratamento eletivo e o médico possa exercer o seu direito de objeção de consciência, não se deve ameaçar o paciente com possibilidade de ruptura da relação médico-paciente. Ademais, caso não haja concordância entre o médico e o paciente, o médico deve seguir os seguintes procedimentos para interromper o vínculo com o paciente:

“Art. 9º. A interrupção da relação do médico com o paciente por objeção de consciência impõe ao médico o dever de comunicar o fato ao diretor técnico do estabelecimento de saúde, visando garantir a continuidade da assistência por outro médico, dentro de suas competências.

Parágrafo único. Em caso de assistência prestada em consultório, fora de estabelecimento de saúde, o médico deve registrar no prontuário a interrupção da relação com o paciente por objeção de consciência, dando ciência a ele, por escrito, e podendo, a seu critério, comunicar o fato ao Conselho Regional de Medicina”.

Observe, portanto, que não é simplesmente “cortar” o vínculo. A objeção de consciência é um ato de extrema responsabilidade, para que o paciente não fique desassistido.

A letra B está correta. Correta a alternativa B. Essa é a alternativa mais adequada dentre as que foram propostas.

A letra C está incorreta. Incorreta a alternativa C, uma vez que autonomia do paciente deve ser respeitada. Portanto, a tomada de decisão deve levar em consideração as preferências do paciente.

A letra D está incorreta. Incorreta a alternativa D. O erro da alternativa está em desconsiderar a promoção da saúde, bem como a oferta de outros tratamentos.

A letra E está incorreta. Incorreta a alternativa E. Assim como não se deve ameaçar o paciente com uma possível ruptura na relação médico-paciente, também não se deve exagerar a gravidade do diagnóstico ou prognóstico apenas para que o paciente aceite aquilo que o médico quer.

Questão | | 2024 | 4000205822

Assinale a alternativa correta que apresenta uma medicação osteoformadora indicada no tratamento da osteoporose de alto e muito alto risco de fraturas.

- A)** Alendronato.
- B)** Denosumabe.
- C)** Ácido Zoledrônico.

D) Teriparatida.

E) Raloxifeno.

Solução

Gabarito: D) Teriparatida.

Diagnóstico da Osteoporose:

A Osteoporose é diagnosticada de duas formas: clinicamente por meio de uma fratura por fragilidade (fêmur proximal, rádio distal, úmero proximal ou coluna), contanto que com história compatível (trauma de baixa energia; uma fratura de fêmur proximal em jovem por acidente automobilístico não é considerada fratura de fragilidade; ou da coluna vertebral após queda de altura), ou por meio de uma DMO.

A DMO avalia dois sítios primariamente: o colo do fêmur e a coluna lombar. Seus valores podem ser ajustados para uma população jovem (T-Score) ou para uma população da mesma faixa etária (Z-Score). Para o diagnóstico de osteoporose primária, é sempre usado o T-Score (pois deve-se comparar com o valor “normal” do osso, que naturalmente diminui sua densidade com a idade. O uso do Z-Score poderia gerar falsos negativos).

Ele é dividido em categorias:

Classificação	T-score
Normal	Até -1
Osteopenia	-1 a -2,5
Osteoporose	Igual ou abaixo de -2,5
Osteoporose estabelecida	Igual ou abaixo de -2,5 + fratura de fragilidade

Tratamento da Osteopenia e Osteoporose:

Todos os pacientes com osteopenia ou osteoporose merecem receber o tratamento não farmacológico. Esse tratamento inclui a modificação de hábitos de vida (como sedentarismo, modificar ingestão de cálcio e vitamina D, exposição solar, evitar tabagismo, etilismo, cafeína excessiva) e a introdução de suplementação de cálcio e vitamina D, se a obtenção por outras fontes (dieta e sol) for insuficiente.

Esses mesmos métodos servem para a osteopenia, que seria como uma “fase de transição” do osso normal para o osso osteoporótico. É uma janela de oportunidade para “frear” a osteoporose. Sendo assim, não são necessários medicamentos, mas apenas esses cuidados preventivos. As exceções nesse caso são pacientes que já tenham tido fraturas por fragilidade, ainda que osteopênicos, ou que tenham alto risco de fratura calculado pelo FRAX: >20% de fraturas maiores e/ou >3% para fratura de quadril.

Em suma, em quem devemos considerar tratamento farmacológico?

- T Score < -2,5 (OP densitométrica)
- Antecedente pessoal de fratura de fragilidade
- T Score entre -1 e -2,5 (osteopenia) com FRAX (probabilidade de fratura em 10 anos) > 20% fratura maior, > 3% fratura de quadril

As medicações disponíveis para o tratamento da osteoporose são divididas em 2 classes, conforme mostra a tabela abaixo:

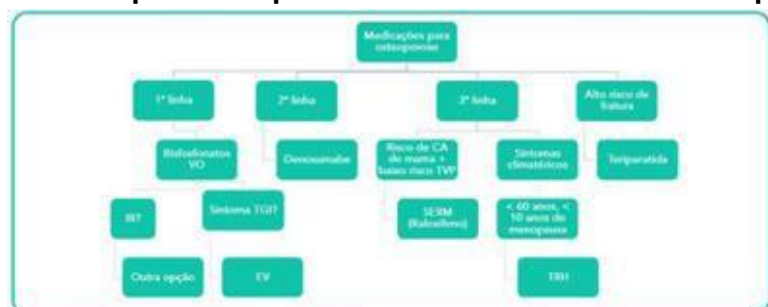
Antirreabsortivos	Anabólicos
• Bisfosfonatos • Denosumabe • SERMs • Terapia hormonal da menopausa	• Teriparatida ou abaloparatida • Romosozumabe

Os bisfosfonatos são a 1ª escolha de tratamento para a grande maioria dos pacientes. Porém, em caso de muito alto risco de fratura, devemos considerar iniciar o tratamento com medicações anabólicas (Teraparite, abaloparatide, Romosozumabe), que atuam estimulando a formação óssea.

E quem são esses indivíduos de muito alto risco?

- Fraturas nos últimos 12 meses
- Múltiplas fraturas
- Fraturas durante tratamento de OP ou uso de drogas que reduzem massa óssea (ex: corticoides)
- T-scores muito baixos (< -3.0)
- Alto risco de quedas ou histórico de quedas
- FRAX > 30% para fratura osteoporótica maior e > 4,5% para fratura de quadril.

Vamos aproveitar para rever o tratamento da osteoporose, que foi citado nas alternativas



A letra A está incorreta. O alendronato faz parte da classe dos bisfosfonatos, que são medicações antirreabsortivas. Os bisfosfonatos ligam-se aos cristais de hidroxiapatita e impregnam os ossos. Quando o osteoclasto reabsorve esse osso “envenenado” com bisfosfonatos, ele não consegue formar a borda em escova para aderir à superfície óssea e

concluir o processo de reabsorção óssea. Além disso, promovem a apoptose dos osteoclastos e inibem o recrutamento dos seus progenitores.

A letra B está incorreta. O denosumabe é um anticorpo monoclonal com afinidade pelo RANKL, portanto impede a ligação RANKL- RANK, essencial ao processo de osteoclastogênese. Também atua como uma medicação antirreabsortiva. Ao contrário dos bisfosfonatos, que exercem efeito antirreabsortivo mesmo após a suspensão do tratamento, a suspensão do denosumabe resulta em uma queda vertiginosa da DMO. Portanto, o tratamento é contínuo e, caso haja a necessidade de suspensão da droga, devemos prescrever outra classe medicamentosa para dar continuidade ao tratamento.

A letra C está incorreta. O ácido zoledrônico faz parte da classe dos bisfosfonatos, que são medicações antirreabsortivas. Diferencia-se do alendronato por ser de aplicação endovenosa e anual.

A letra D está correta. Resposta correta. A teriparatida é uma forma recombinante de PTH e a abaloparatida (ainda não disponível no Brasil) é um análogo sintético do PTHrP (proteína relacionada ao hormônio da paratireoide). A exposição crônica ao PTH ou PTHrP (como observamos no hiperparatireoidismo ou na hipercalcemia maligna, respectivamente) resulta em aumento da reabsorção óssea. Entretanto, a administração intermitente de PTH recombinante ou PTHrP sintético faz com que a formação óssea prepondere sobre a reabsorção óssea. São, portanto, drogas anabólicas.

A letra E está incorreta. O Raloxifeno é um modulador seletivo do receptor de estrógeno (SERM). Os SERMs possuem estrutura molecular semelhante à dos estrógenos e, dependendo do órgão-alvo, terão ações agonistas ou antagonistas sobre os receptores estrogênicos. Os SERMs exercem efeitos benéficos nos ossos e no perfil lipídico, sem causar efeitos deletérios sobre mamas e endométrio. São também consideradas medicações antirreabsortivas.

Questão | | 2024 | 4000205823

Em relação à reação de Jarisch-Herxheimer, assinale a alternativa correta.

- A)** Ocorre no final do tratamento da sífilis, no qual o paciente pode apresentar exacerbação das lesões cutâneas, com eritema, dor ou prurido.
- B)** Cursa com febre, dor de cabeça, sudorese, calafrios e tremores, sendo necessária a suspensão imediata do tratamento devido ao alto risco de reação anafilática.
- C)** É uma reação alérgica grave à penicilina com alto risco de reação anafilática e necessidade de administração de adrenalina intramuscular profilática.
- D)** Ocorre no início do tratamento de sífilis em resposta ao derrame de proteínas e de outras estruturas dos treponemas mortos pela penicilina na corrente sanguínea.

E) Também é conhecida como síndrome de Stevens-Johnson.

Solução

Ocorre no início do tratamento de sífilis em resposta ao derrame de proteínas e
Gabarito: D) de outras estruturas dos treponemas mortos pela penicilina na corrente sanguínea.

Gabarito: alternativa D.

A reação de Jarisch-Herxheimer é uma complicação benigna e autolimitada caracterizada por exacerbação dos sintomas de doenças causadas por espiroquetas (em especial a sífilis) que ocorre algumas horas após o início do tratamento antimicrobiano. Não é indicada a suspensão do tratamento para sífilis.

A letra A está incorreta. Incorreta a alternativa A. A reação ocorre no início do tratamento, e não no final.

A letra B está incorreta. Incorreta a alternativa B. Não é necessária a suspensão do tratamento.

A letra C está incorreta. Incorreta a alternativa C. Não é uma reação alérgica.

A letra D está correta. Correta a alternativa D. A reação de Jarisch-Herxheimer pode ocorrer no início do tratamento da sífilis, e consiste em uma reação inflamatória resultante da morte dos treponemas.

A letra E está incorreta. Incorreta a alternativa E. Não há relação com a síndrome de Stevens-Johnson. A síndrome de Stevens-Johnson é uma rara, mas grave, condição de pele e mucosas, frequentemente desencadeada por reações medicamentosas, caracterizada por erupções cutâneas, bolhas e envolvimento mucoso.

Questão | | 2024 | 4000205824

É considerada uma manifestação clínica comum da Doença de Parkinson a

- A)** estabilidade postural.
- B)** hipercinesia.
- C)** fasciculação.
- D)** hipermobilidade.
- E)** rigidez em roda dentada.

Solução

Gabarito: E) rigidez em roda dentada.

O termo parkinsonismo, segundo os critérios da Movement Disorders Society (MDS) descreve a associação de bradicinesia e pelo menos mais um dos seguintes sintomas:

1- Rigidez.

2- Tremor de repouso

Existe um critério mais antigo, conhecido como o critério do banco de cérebro de Londres, que admite, além dos dois sintomas acima, a possibilidade de instabilidade postural.

A doença de Parkinson é apenas uma das causas de parkinsonismo. As causas Outras causas relevantes são: síndromes Parkinson-Plus (Paralisia Supra Nuclear Progressiva, Atrofia de Múltiplos Sistemas, Degeneração Corticobasal e Demência com corpúsculos de Lewy) e efeito colateral de medicações como neurolépticos e antivertiginosos por exemplo.

A doença de Parkinson propriamente dita é neurodegenerativa e está associada à diminuição da disponibilidade de dopamina em locais estratégicos do sistema nervoso central. O principal deles é a substância nigra no mesencéfalo. Chamam a atenção nessa doença, a apresentação assimétrica dos sintomas, a resposta acentuada, inicialmente, ao uso de levodopa e a ausência de sinais de alerta como alteração da motricidade ocular, disfunção do trato corticoespinal lateral, disfunção cognitiva precoce, queixas sensitivas, disautonomia precoce entre outros. A combinação desses sinais de alerta aos sintomas clássicos de parkinsonismo, ajuda no diagnóstico das chamadas síndromes Parkinson plus.

Vamos às alternativas:

A letra A está incorreta. A instabilidade postural, não a estabilidade, que é um sintoma possível na doença de Parkinson.

A letra B está incorreta. A doença de Parkinson é o protótipo das doenças hipocinéticas, não hipercinéticas.

A letra C está incorreta. A fasciculação ocorre no acometimento do corno anterior da medula. Em nada se relacionada com a doença de Parkinson

A letra D está incorreta. A hipomobilidade, pela rigidez, que ocorre na doença de Parkinson

A letra E está correta. Exatamente! A rigidez é um dos sintomas típicos do parkinsonismo como vimos acima.

Questão | | 2024 | 4000205825

Mulher de 68 anos, acompanhada da filha, foi encaminhada para nefrologia pela unidade básica de saúde (UBS) devido à alteração no exame de creatinina. Trouxe exames laboratoriais que evidenciavam: Hb 8,7g/L; Creatinina 2,8 mg/dL; Ureia 92 mg/dL; Gasometria arterial: pH 7,3, Bicarbonato 18 mmol/L, Na 140 mmol/L, K 5.2 mmol/L. Um exame realizado há 4 anos já evidenciava creatinina sérica basal de 2,3 mg/dL. O peso da paciente é de 56 Kg. Conforme o caso apresentado, assinale a alternativa correta.

- A)** Está contraindicada vacina contra hepatite B para essa paciente.
- B)** O clearance de creatinina pela equação de Cockcroft-Gault é de 20 ml/min. A paciente está em estágio 3 de doença renal crônica.
- C)** Essa paciente não deveria ter sido encaminhada para a nefrologia, devendo ser acompanhada somente em UBS.
- D)** O tratamento para essa paciente deve ser classificado como conservador, pois ela está entre os estágios 1 e 3 de doença renal crônica.
- E)** O clearance de creatinina pela equação de Cockcroft-Gault é de 17 ml/min. A paciente está em estágio 4 de doença renal crônica.

Solução

Gabarito: E) O clearance de creatinina pela equação de Cockcroft-Gault é de 17 ml/min. A paciente está em estágio 4 de doença renal crônica.

Olá, Estrategista!

Temos uma questão importante do ENARE, que trata sobre uma mulher idosa com alteração da função renal, detectada pela elevação da creatinina. Sempre devemos tentar diferenciar, nesses casos, uma injúria renal aguda de uma possível doença renal crônica.

O principal parâmetro utilizado nessa diferenciação é a creatinina basal da paciente em questão. Veja que 4 anos antes da consulta atual, a paciente já apresentava uma importante elevação da creatinina.

Nesses casos, não nos resta dúvida: trata-se de uma doença renal crônica (DRC)!

A avaliação inicial de um paciente com suspeita de DRC envolve a estimativa da taxa de filtração glomerular (TFG). Como o enunciado nos dá o peso da paciente, é de bom tom usarmos a fórmula de Cockcroft-Gault.

$TFG \text{ estimada} = (140 - \text{idade}) \times \text{peso} / \text{Creatinina} \times 72.$

Vale lembrar que, em se tratando do sexo feminino, o resultado deve ser multiplicado por 0,85.

$TFG \text{ estimada} = (140 - 68) \times 56 / 2,8 \times 72 = 20 \times 0,85 \text{ (sexo feminino)} = 17 \text{ mL/min.}$

Vamos às alternativas:

A letra A está incorreta. Incorreta. A vacinação para hepatite B deve ocorrer no paciente renal crônico, em dose dobrada e 04 aplicações.

A letra B está incorreta. Incorreta. Como vimos, a taxa de filtração é de 17, não 20.

A letra C está incorreta. Incorreta. Pacientes a partir do estágio IV da doença renal crônica, isto é, $TFG \text{ estimada} < 30 \text{ mL/min}$, devem ser referenciados ao nefrologista para seguimento.

A letra D está incorreta. Incorreta. O tratamento é conservador, mas a paciente encontra-se no estágio IV da doença renal crônica.

A letra E está correta. Correta. O estágio IV vai de 29 a 15 mL/min e a paciente apresenta 17 mL/min.

Dentre as alternativas a seguir, qual apresenta o agente infeccioso bacteriano mais comum na pneumonia adquirida na comunidade?

- A) *Streptococcus pneumoniae*.
- B) *Mycoplasma pneumoniae*.
- C) *Streptococcus aureus*.
- D) *Chlamydia pneumoniae*.
- E) *Pseudomonas aeruginosa*

Solução

Gabarito: A) *Streptococcus pneumoniae*.

Gabarito: alternativa A

Estrategista, lembre-se sempre disso: *Streptococcus pneumoniae* é o agente bacteriano mais frequentemente associado à pneumonia adquirida na comunidade!

A letra A está correta. Correta a alternativa A. O *Streptococcus pneumoniae*, também conhecido como pneumococo, é o agente bacteriano mais comum associado à pneumonia adquirida na comunidade.

A letra B está incorreta. Incorreta a alternativa B. O *Mycoplasma pneumoniae* é uma causa comum de pneumonia atípica, mas não é o agente bacteriano mais prevalente na pneumonia adquirida na comunidade.

A letra C está incorreta. Incorreta a alternativa C. Embora o *Staphylococcus aureus* possa causar pneumonia, é mais comum em contextos específicos, como pneumonia associada à ventilação mecânica ou em pacientes com endocardite infecciosa por esse patógeno.

A letra D está incorreta. Incorreta a alternativa D. A *Chlamydia pneumoniae* é um agente atípico que pode causar pneumonia, mas não é o mais comum na pneumonia adquirida na comunidade.

A letra E está incorreta. Incorreta a alternativa E. A *Pseudomonas aeruginosa* não é comumente associada à pneumonia adquirida na comunidade, sendo mais prevalente em infecções relacionadas à assistência à saúde.

Questão | | 2024 | 4000205827

Sobre delirium tremens, assinale a alternativa correta

- Contenção mecânica imediata e administração de haloperidol intramuscular fazem parte do
- A) manejo. O uso de benzodiazepínicos é contraindicado devido ao risco de piora aguda do delirium tremens.

- B)** O uso de fenitoína parenteral, a “hidantalização”, deve ser feito de rotina, sendo eficaz no controle de crises convulsivas.
- Monitorar, corrigir possíveis distúrbios hidroeletrólíticos, realizar hidratação vigorosa, iniciar
- C)** benzodiazepínico e profilaxia para encefalopatia de Wernicke-Korsakoff podem ser ações necessárias para o manejo adequado.
- D)** A administração de clorpromazina e outros neurolépticos sedativos de baixa potência para controle de agitação são a primeira escolha em relação ao uso de haloperidol.
- E)** As manifestações geralmente ocorrem antes das primeiras vinte e quatro horas após a última ingesta de bebida alcoólica.

Solução

Monitorar, corrigir possíveis distúrbios hidroeletrólíticos, realizar hidratação

Gabarito: C) vigorosa, iniciar benzodiazepínico e profilaxia para encefalopatia de Wernicke-Korsakoff podem ser ações necessárias para o manejo adequado.

Estrategista, o quadro da Síndrome de Abstinência Alcoólica (SAA) pode se iniciar entre 6 e 24 horas depois do último consumo de álcool ou redução da quantidade de álcool ingerida. A SAA é representada por sintomas como tremores, que são geralmente as primeiras manifestações clínicas, ansiedade, irritabilidade, alterações de atenção, náuseas, febre, taquipneia, sudorese, piloereção, taquicardia e alterações de pressão arterial. Em casos graves pode evoluir para Delirium Tremens, normalmente após 48h do início dos sintomas, ocorrendo psicose, tremores intensos e alteração do nível de consciência.

O tratamento é baseado no uso de benzodiazepínicos (para tratamento da SAA-DT) e reposição de tiamina (profilaxia da encefalopatia de Wernicke-Korsakoff). Haloperidol, um antipsicótico típico de alta potência, pode ser utilizado se houver sintomas psicóticos ou agitação intensa.

Vamos às alternativas!

A letra A está incorreta. Incorreta. O manejo é justamente o contrário. As drogas de escolha são os benzodiazepínicos. O haloperidol IM é medida instituída apenas nos casos refratários.

A letra B está incorreta. Incorreta. A fenitoína está contraindicada neste manejo. Quando ocorrem convulsões, tendem a ser únicas e benignas, não exigindo, normalmente, medidas adicionais.

A letra C está correta. Correta e autoexplicativa.

A letra D está incorreta. Incorreta. Nos casos selecionados, o antipsicótico a ser empregado é o haloperidol, justamente por rebaixar menos o limiar de convulsões e por sua segurança cardiovascular.

A letra E está incorreta. Incorreta. As manifestações da SAA é que ocorrem, normalmente, nas primeiras 24 horas. O DT surge, frequentemente, após 48 horas de curso.

Questão | | 2024 | 4000205828

Homem, 46 anos, hipertenso e etilista, comparece à emergência médica após hematêmese e confusão mental aguda. Apresenta-se, ao exame físico, icterico, confuso, desorientado, sarcopênico e hipotenso. Após estabilização clínica inicial, foi submetido a exames laboratoriais que evidenciaram: INR 3.2; Albumina 1.8 g/dL; Bilirrubinas totais 9.5 mg/dL e Creatinina de 4.2 mg/dL.

Assinale a alternativa que **NÃO** contribui, dentro do caso apresentado, para a classificação de Child-Pugh do paciente.

- A)** INR.
- B)** Albumina.
- C)** Bilirrubinas.
- D)** Creatinina.
- E)** Grau de Encefalopatia.

Solução

Gabarito: D) Creatinina.

A apresentação clínica do paciente sugere uma descompensação aguda de uma doença hepática crônica, possivelmente relacionada ao seu histórico de alcoolismo. Os sintomas de icterícia, confusão mental, sarcopenia e hipotensão são indicativos de uma doença hepática avançada. A hematêmese pode ser um sinal de varizes esofágicas sangrantes, uma complicação comum da hipertensão portal em pacientes com cirrose.

Os exames laboratoriais revelam um INR elevado, albumina baixa, bilirrubinas totais elevadas e creatinina elevada. Estes resultados são consistentes com insuficiência hepática significativa e disfunção renal. O INR elevado indica uma coagulopatia, enquanto a albumina baixa e as bilirrubinas elevadas refletem a função hepática comprometida. A creatinina elevada sugere uma possível insuficiência renal, que pode ser secundária à doença hepática (síndrome hepatorenal) ou a outros fatores.

A classificação de Child-Pugh é utilizada para avaliar a gravidade da doença hepática e inclui cinco parâmetros: bilirrubinas séricas, albumina sérica, INR, presença de ascite e grau de encefalopatia. Cada um desses parâmetros é pontuado com base em critérios específicos, e a soma total determina a classificação de Child-Pugh (A, B ou C), que é usada para prever o prognóstico em pacientes com cirrose.

Vamos escolher a alternativa que **NÃO** constitui um parâmetro da classificação de Child:

A letra A está incorreta. CORRETA. Contribui para a classificação de Child-Pugh. O INR é um dos parâmetros utilizados para avaliar a função hepática e a coagulopatia associada à cirrose. É

um dos primeiros parâmetros que se altera diante de uma disfunção hepática importante, sendo também usado como critério diagnóstico na insuficiência hepática aguda.

A letra B está incorreta. CORRETA. Contribui para a classificação de Child-Pugh. A albumina sérica é um indicador da função sintética do fígado e é usada na avaliação da gravidade da doença hepática. Toda albumina circulante é produzida pelo fígado, com meia-vida de cerca de 30 dias. A queda da albumina sinaliza hepatopatia crônica avançada.

A letra C está incorreta. CORRETA. Também contribuem para a classificação de Child-Pugh. As bilirrubinas séricas são um marcador de função hepática e são incluídas na avaliação da gravidade da cirrose, elevando-se tanto na insuficiência hepática aguda quanto crônica.

A letra D está correta. **INCORRETA**. A creatinina NÃO contribui diretamente para a classificação de Child-Pugh. Embora a creatinina elevada seja um sinal importante de disfunção renal e possa indicar síndrome hepatorenal, ela não é um dos parâmetros utilizados na classificação de Child-Pugh. Lembre-se de que a creatinina entra no escore de MELD (Bilirrubina - INR - Creatinina), uma escala usada para listar os pacientes na fila de transplante.

A letra E está incorreta. CORRETA. Parâmetro clínico que contribui para a classificação de Child-Pugh. O grau de encefalopatia hepática é um dos critérios utilizados para avaliar a gravidade da doença hepática, além de ser o mais importante critério diagnóstico para insuficiência hepática aguda e fulminante.

Questão | | 2024 | 4000205829

Em relação ao uso de trombolíticos em paciente com infarto agudo do miocárdio com supra de ST no eletrocardiograma, é considerado(a) contraindicação absoluta

- A)** uso crônico de AAS 100 mg diário.
- B)** trauma cranioencefálico importante nos últimos 3 meses.
- C)** histórico de úlcera péptica mesmo sem evidência de sangramento ativo.
- D)** acidente vascular encefálico isquêmico há 1 ano.
- E)** gestação.

Solução

Gabarito: B) trauma cranioencefálico importante nos últimos 3 meses.

Gabarito: B.

Estamos diante de uma questão direta sobre as contraindicações absolutas à realização da trombólise no IAM com supra. Sendo assim, vamos revisá-las a partir da Diretriz Brasileira:

Quadro 10 – Contraindicações aos fibrinolíticos

Contraindicações absolutas	Contraindicações relativas
Qualquer sangramento intracraniano prévio	História de AVC isquêmico > 3 meses ou doenças intracranianas não listadas nas contraindicações absolutas
AVC isquêmico nos últimos 3 meses	Gravidez
Dano ou neoplasia no sistema nervoso central	Uso atual de antagonistas da vitamina K: quanto maior o INR maior o risco de sangramento
Trauma significativo na cabeça ou rosto nos últimos 3 meses	Sangramento interno recente < 2-4 semanas
Sangramento ativo ou distúrbio hemorrágico (exceto menstruação)	Reanimação cardiopulmonar traumática e prolongada ou cirurgia de grande porte < 3 semanas
Qualquer lesão vascular cerebral conhecida (malformação arteriovenosa)	Hipertensão arterial não controlada (pressão arterial sistólica > 180 mmHg ou diastólica > 110 mmHg)
Dissecção aguda de aorta	Punções não compressíveis
Discrepância sanguínea	História de hipertensão arterial crônica importante e não controlada
	Úlcera péptica ativa
	Exposição prévia à estreptocinase (somente para estreptocinase)

AVC: acidente vascular cerebral; INR: International Normalized Ratio

A letra A está incorreta. Incorreta. O uso de AAS não é uma contraindicação sequer relativa. Aliás, muitos dos pacientes que apresentam quadro de IAM são usuários dessa medicação.

A letra B está correta. Correto. Como vemos na tabela, essa é uma contraindicação absoluta à trombólise química.

A letra C está incorreta. Incorreta. A úlcera péptica ativa é uma contraindicação relativa. A úlcera inativa não consta como contraindicação.

A letra D está incorreta. Incorreto. O AVC isquêmico é contraindicação absoluta quando ocorreu há menos de três meses.

A letra E está incorreta. Incorreto. Gestação é uma contraindicação relativa.

Questão | | 2024 | 4000205830

Diante de um atendimento a um paciente em parada cardiorrespiratória, o líder precisa conduzir a equipe que está realizando a Reanimação Cardiopulmonar (RCP). Qual é a maneira de comunicação mais apropriada entre o líder e a equipe nessa situação?

- A)** Apenas o líder da equipe possui a competência necessária para verbalizar informações, devendo o restante da equipe permanecer em silêncio durante todo o atendimento.
- B)** O líder deve transmitir mensagens simultâneas a cada membro da equipe para que sejam evitados atos de procrastinação e a situação possa ser revertida o mais rápido possível.
- O líder deve transmitir uma mensagem, ordem ou atribuição a um membro da equipe; solicitar uma resposta clara e contato visual do membro da equipe para garantir que tenha entendido a mensagem; confirmar que o membro da equipe concluiu a tarefa, antes de lhe atribuir outra tarefa.
- C)**
- D)** O líder deve elevar o tom de voz ao perceber que um dos membros da equipe não compreendeu a ordem dada, a fim de que tal atitude não se repita.
- É necessário que o líder reconheça sua equipe com elogios, como forma de incentivá-la
- E)** quando o atendimento é bem sucedido, bem como repreender em alto tom de voz ao perceber quaisquer falhas durante o atendimento.

Solução

Gabarito: C)

O líder deve transmitir uma mensagem, ordem ou atribuição a um membro da equipe; solicitar uma resposta clara e contato visual do membro da equipe para garantir que tenha entendido a mensagem; confirmar que o membro da equipe concluiu a tarefa, antes de lhe atribuir outra tarefa.

Gabarito: alternativa C.

Estrategista, estamos diante de uma questão de resolução simples que aborda o papel do líder frente à comunicação no cenário de PCR. Sendo assim, devemos nos recordar que a comunicação deve ser em alça fechada, ou seja, as orientações devem ser claras, sucintas e sucedidas por uma comunicação verbal de quem recebeu a ordem que manifeste entendimento e execução.

Vamos observar as alternativas e perceba que apenas por bom senso, seria possível descartar as opções erradas:

A letra A está incorreta. Incorreta. Veja como essa informação não pode ser prática. Como a equipe fica em silêncio o tempo todo? Obviamente, quando a equipe recebe uma ordem, deve manifestar entendimento e sinalizar quando a ordem for executada para que as novas etapas de atendimento prossigam.

A letra B está incorreta. Incorreta. Em um cenário tenso como o da PCR, ordens simultâneas serão esquecidas rapidamente. Sendo assim, as ordens devem ser dadas uma de cada vez e com clareza.

A letra C está correta. Correto. Veja como essa alternativa preenche o critério do bom senso. Ordens claras, com sinalização de entendimento, uma de cada vez...

A letra D está incorreta. Incorreta. Essa alternativa é um tanto quanto exagerada. Essa liderança geraria um clima de tensão excessivo, que reproduziria erros na condução do caso.

A letra E está incorreta. Incorreto. O atendimento da PCR deve ser sistemático e objetivo. Não é momento de elogios ou repreensões, apenas orientações técnicas.

Questão | | 2024 | 4000205831

Paciente do sexo masculino, 73 anos, apresentou desconforto respiratório progressivo na última semana e foi avaliado no pronto-socorro. Ao exame físico, apresentava, na ausculta pulmonar, murmúrio vesicular abolido em 2/3 inferiores, tendo sido confirmado derrame pleural moderado por radiografia de tórax.

Após ser avaliado pela cirurgia torácica, optou-se por toracocentese de alívio e diagnóstica. Os exames séricos do paciente eram: Proteína total 3,8/dl, DHL 154 U/L.

A rotina laboratorial de líquido pleural: Proteína total 1,7 g/dl, DHL 60 U/L.

Observação: Desidrogenase láctica (DHL) – valores séricos normais de referência 120 a 246 U/L.

Após análise dos resultados dos exames séricos e da rotina do líquido pleural do paciente, são aplicados os critérios de Light.

Assinale a alternativa correta em relação a esse caso.

- A)** Os resultados da análise indicam características de transudato, e insuficiência cardíaca poderia ser uma das hipóteses diagnósticas.
- B)** A relação entre LDH do líquido pleural/nível sérico preenche um dos critérios de Light, característico de exsudato.
- C)** Os resultados da análise indicam características de exsudato pelos critérios de Light, e pneumonia bacteriana é uma das hipóteses diagnósticas.
- D)** Para transudato, é necessário preencher pelo menos dois dos critérios de Light.
- E)** Um dos critérios de Light é que o DHL do líquido pleural seja $> 1/3$ do valor do limite superior sérico.

Solução

Gabarito: A) Os resultados da análise indicam características de transudato, e insuficiência cardíaca poderia ser uma das hipóteses diagnósticas.

Gabarito: A.

Estamos diante de uma questão clássica de provas de residência, mas que nunca havia caído no enare ainda. Toda análise de toracocentese começa pela diferenciação entre exsudatos e transudatos, que é feita pelos critérios de Light:

	Transudato	Exsudato
Relação proteína no líquido pleural/proteína no soro	$\leq 0,5$	$> 0,5$
Relação LDH no líquido pleural/LDH no soro	$\leq 0,6$	$> 0,6$
LDH líquido pleural $> 2/3$ limite superior da normalidade sérica	Não	Sim

Na questão, vemos: proteína no LP/proteína sérica = $1,7 / 3,8$; portanto $< 0,5$; LDH no LP/ LDH sérico = $60/154$, portanto $< 0,6$ e DHL no LP de 60 quando o limite sérico é 246, portanto $< 2/3$. sendo assim, podemos afirmar que se trata de um transudato.

As causas de transudato são descritas na tabela abaixo:

Diagnóstico Diferencial - Líquido Pleural	
Transudato	Exsudato
ICC	Infecciosas
Cirrose hepática	Neoplásico
Sd. Nefrótica	Induzido por drogas
Hipoalbuminemia	Hemotórax
Diálise peritoneal	Quilotórax
Mixedema	Colagenoses
Obstrução Veia Cava Sup.	Embolia pulmonar(80%)
Embolia pulmonar(20%)	Pancreatite
Atelectasia (aguda)	Pós IAM

A letra A está correta. Correta. Como vimos, o líquido é um transudato e IC é a principal causa de transudato.

A letra B está incorreta. Incorreto. para preencher critério como exsudato a relação de proteína LP/ proteína sérica deveria ser $> 0,5$.

A letra C está incorreta. Incorreto. Como descrito anteriormente é um transudato.

A letra D está incorreta. Incorreto. Para ser transudato não pode preencher nenhum dos critérios de Light para exsudato.

A letra E está incorreta. Incorreto. O valor é 2/3 acima do limite da normalidade sérica de LDH.

Questão | | 2024 | 4000205832

De acordo com o tema “publicidade médica”, é correto afirmar que

- A)** é vedado divulgar fora do meio científico processo de tratamento ou descoberta cujo valor ainda não esteja expressamente reconhecido cientificamente por órgão competente.
- é permitida a participação e divulgação de assuntos médicos, em qualquer meio de
- B)** comunicação de massa, mesmo que não tenha caráter exclusivo de esclarecimento e educação da sociedade.
- C)** é autorizado participar de anúncios de empresas comerciais, qualquer que seja sua natureza, valendo-se de sua profissão.
- há dispensa da apresentação do número no Conselho Regional de Medicina e do Registro de
- D)** Qualificação de Especialista (RQE) quando anunciar a especialidade em anúncios profissionais.

- E)** é liberado o anúncio de títulos científicos mesmo que não possa comprovar a especialidade ou área de atuação com registro no Conselho Regional de Medicina.

Solução

é vedado divulgar fora do meio científico processo de tratamento ou descoberta
Gabarito: A) cujo valor ainda não esteja expressamente reconhecido cientificamente por órgão competente.

GABARITO: ALTERNATIVA A

Essa questão foi cobrada em outubro de 2023 (processo seletivo ENARE 2024), portanto, quando a nova resolução de publicidade médica ainda não estava em vigor (Resolução 2.336, de 12 de setembro de 2023).

- Mas Bárbara, a nova resolução é de 12 de setembro! Ou seja, anterior a prova!

Sim, mas ela só entra em vigência a partir de fevereiro de 2024. Nesse sentido, era necessário que o candidato respondesse a questão a partir dos conceitos da resolução antiga (Resolução 1.974, de 2011).

A letra A está correta. • **Correta a alternativa A.** Essa alternativa não está nem na resolução antiga, nem na nova, e sim no próprio Código de Ética Médica (CEM).

“É vedado ao médico:

Art. 113. Divulgar, fora do meio científico, processo de tratamento ou descoberta cujo valor ainda não esteja expressamente reconhecido cientificamente por órgão competente”.
(Código de Ética Médica, 2018).

A letra B está incorreta. • **Incorreta a alternativa B.** Veja o que diz o CEM em seu artigo 111:

“É vedado ao médico:

Art. 111. Permitir que sua participação na divulgação de assuntos médicos, em qualquer meio de comunicação de massa, deixe de ter caráter exclusivamente de esclarecimento e educação da sociedade”.
(Código de Ética Médica, 2018).

A letra C está incorreta. • **Incorreta a alternativa C.** À luz da resolução antiga (1.914/11), tal prática é proibida. Veja o que diz o manual da CODAME (Comissão Nacional de Divulgação de Assuntos Médicos), que faz parte do CFM, sobre essa resolução:

“27. Posso participar de anúncios que deem aval ao uso de determinados produtos?

Não. O médico não deve participar de ações publicitárias de empresas ou produtos ligados à medicina. Esta proibição se estende a entidades sindicais e associativas médicas”

O CEM também traz tal proibição em seu artigo 115:

“É vedado ao médico:

Art. 115. Participar de anúncios de empresas comerciais, qualquer que seja sua natureza, valendo-se de sua profissão”.

A nova resolução de publicidade médica (2.336/23) também sugere a proibição da participação do médico em anúncios de empresas comerciais, bem como citar nomes de produtos, embora isso ainda não esteja totalmente claro (por isso, será necessário esperar a publicação do novo manual da CODAME, que é o documento que geralmente explica a resolução).

Por exemplo, veja o que diz os artigos 9º e 11º:

“Art. 9. É permitido ao médico:

XVIII – anunciar a aplicação de órteses e próteses, fármacos, insumos e afins, quando da execução de procedimentos nos termos do inciso III deste artigo, desde que:

Descreve características e propriedades de insumos, órteses e próteses, de acordo com a Resolução 2.318/2022;

Quando criador ou desenvolvedor da órtese ou insumo, aprovados pela ANVISA e pelo CFM, nos termos do inciso III, ao fazer divulgação e aplicar nos ambientes previstos nessa resolução, esclareça seus conflitos de interesse.

Não anuncie marcas comerciais e fabricantes”.

Veja que o item “c” fala justamente em não citar nomes. Dessa forma, como poderia o médico participar de anúncios de empresas?

Agora veja o artigo 11º:

“Art.11 É vedado ao médico:

(...)

V – Participar de propaganda/publicidade de medicamento, insumo médico, equipamento, alimento e quaisquer outros produtos, induzindo a garantia de resultados”.

Portanto, ao que tudo indica, de fato o médico não poderá participar de anúncios de empresas comerciais pela nova resolução.

A letra D está incorreta. • **Incorreta a alternativa D.** É necessário ter o RQE para apresentar alguma especialidade médica, conforme afirma o artigo 114 do CEM:

“É vedado ao médico:

Art. 114. Anunciar títulos científicos que não possa comprovar e especialidade ou área de atuação para a qual não esteja qualificado e registrado no Conselho Regional de Medicina”.

A resolução antiga (1.914/11) corrobora o CEM ao proibir o anúncio de especialidades médicas caso o médico não tenha o RQE. Além disso, o anúncio de títulos de pós-graduações lato sensu só podem ocorrer se tais cursos estão vinculados à área que o médico tem o RQE.

Já a nova resolução (2.336/23) é mais permissiva. O médico até pode anunciar pós-graduações que não estejam relacionadas diretamente à área em que tem o RQE, mas ao lado deve vir a frase “não especialista”. Por exemplo: “Dr. João, pós-graduação em dermatologia (não especialista)”.

A letra E está incorreta. • **Incorreta a alternativa E** pelos mesmos motivos já explicados em “D”.

Questão | | 2024 | 4000205833

Uma mulher de 58 anos apresentou-se à sala de emergência com palpitações intensas, dor torácica e dispneia. Ela relatou que as palpitações começaram repentinamente enquanto estava em repouso em casa. Não havia histórico prévio de arritmias. A seguir está o eletrocardiograma realizado:



Sinais vitais: frequência cardíaca estimada em cerca de 150 bpm; pressão arterial: 80/50 mmHg. Assinale a alternativa que apresenta o diagnóstico e a conduta adequada para esse caso.

- A) Taquicardia supraventricular / Sedação leve e cardioversão química.
- B) Fibrilação atrial / Sedação leve e cardioversão elétrica.
- C) Flutter atrial / Desfibrilação.
- D) Taquicardia sinusal / Conduta expectante.
- E) Fibrilação atrial / Sedação leve e cardioversão química.

Solução

Gabarito: B) Fibrilação atrial / Sedação leve e cardioversão elétrica.

Gabarito: B.

Estrategista, estamos diante de uma questão de taquiarritmias e conduta. Sendo assim, o primeiro passo sempre deve ser definir se há instabilidade hemodinâmica através dos 4 D's: Dispneia, Dor torácica, Diminuição de consciência e diminuição da pressão (abaixo de 90/60 mmHg).

Nosso paciente tem dor torácica, dispneia e diminuição da pressão. Em toda taquiarritmia instável, o tratamento é choque! Geralmente uma cardioversão elétrica sincronizada, com exceção da taquicardia ventricular polimórfica, cujo tratamento é desfibrilação.

Mas além disso, é necessário que observemos nessa questão o diagnóstico eletrocardiográfico. Trata-se de uma taquicardia de QRS estreito e sem onda P. Duas hipóteses se sobressaem: TPSV ou fibrilação atrial. A diferença das duas basicamente é que a primeira tem ritmo regular enquanto a segunda, irregular. Observe o DII longo abaixo:



O ritmo é irregular! Portanto, fibrilação atrial!

Muitos alunos tiveram dúvida nesse ECG já que em alguns momentos dá a impressão de ser um ritmo regular. Toda taquiarritmia com resposta muito alta dará essa impressão, mas tente sempre observar o DII longo para ter certeza de que o ritmo é ou não é regular.

A letra A está incorreta. Incorreta. Como vimos é uma fibrilação atrial e cardioversão química não é uma opção para taquiarritmia instável.

A letra B está correta. Correta. Como vimos é uma FA instável, portanto tratamento é cardioversão elétrica!!!

A letra C está incorreta. Incorreta. No Flutter esperaríamos a presença das ondas F em serrate e a desfibrilação só está indicada na taquicardia ventricular polimórfica instável ou na PCR em FV/TV.

A letra D está incorreta. Incorreta. Não vemos onda P para ser taquicardia sinusal.

A letra E está incorreta. Incorreta. A cardioversão química só é uma opção em pacientes estáveis.

Paciente do sexo feminino, 56 anos, em pós-operatório de tireoidectomia radical, deu entrada no pronto atendimento com queixa de formigamento em membros superiores e tremores, associados a sudorese. No exame físico, são encontrados sinais de Trousseau e Chvostek positivos.

Considerando o antecedente da paciente, qual eletrólito pode estar em níveis alterados e que poderia explicar a clínica e os achados no exame físico?

- A) Cálcio.
- B) Sódio.
- C) Potássio.
- D) Magnésio.
- E) Cloro.

Solução

Gabarito: A) Cálcio.

Diante de paciente em pós-operatório de tireoidectomia total e com sintomas de irritabilidade neuromuscular (parestesias, câimbras, espasmos e, até mesmo, tetania e convulsão), devemos pensar em **hipocalcemia por lesão inadvertida de paratireoides durante o procedimento**.

O cálcio sérico é rigidamente controlado pelos receptores sensores de cálcio (CaSR), presentes nas paratireoides. Qualquer queda ou aumento na calcemia faz com que se aumente ou reduza a secreção de paratormônio (PTH), respectivamente.

O PTH é o principal determinante dos níveis de cálcio e esse hormônio eleva a calcemia através dos seguintes efeitos:

- Estímulo à reabsorção óssea;
- Aumento da reabsorção renal de cálcio;
- Estímulo à hidroxilação do calcidiol, o que gera calcitriol (forma ativa de vitamina D) e, em última análise, resulta no estímulo à absorção intestinal de cálcio.

A seguir, resumimos as principais manifestações clínicas de um quadro de hipocalcemia:

Manifestações agudas

● Hiperexcitabilidade neuromuscular:

- Tetanias e parestesias
- Sinais de Trousseau e Chvostek
- Convulsões
- Laringoespasma e broncoespasmo

● Manifestações cardiovasculares:

- Prolongamento do intervalo QT

- Hipotensão
- Insuficiência cardíaca
- Arritmias
- Papiledema

Manifestações crônicas

- Calcificação dos gânglios da base
- Sintomas extrapiramidais
- Parkinsonismo
- Demência
- Catarata subcapsular
- Anormalidades na dentição
- Pele seca

Também temos que lembrar que há dois sinais clínicos típicos de hipocalcemia:

- **Sinal de Chvostek:** ao se percutir a região do músculo masseter (correspondente ao nervo facial), observaremos contratura muscular da face ipsilateral ao estímulo
- **Sinal de Trousseau:** ao se insuflar o manguito durante 3 minutos na artéria braquial acima de 20 mmHg da pressão sistólica, observaremos adução do polegar, contração das articulações metacarpofalangeanas, extensão das interfalangeanas e flexão do punho.



Figura 03: Sinal de Chvostek é a contração dos músculos faciais ipsilaterais provocada pela percussão do nervo facial, anteriormente ao pavilhão auditivo.



Figura 04: Sinal de Trousseau é a indução de espasmo carpal pela inflação de um esfigmomanômetro 20 mmHg acima da pressão arterial sistólica por (no máximo) três minutos. O espasmo carpal consiste nos seguintes eventos: adução do polegar, flexão das articulações metacarpofalangeanas, extensão das articulações interfalangeanas e flexão do punho.

Quase 80% dos casos de hipoparatiroidismo são decorrentes de manipulações cirúrgicas. O hipoparatiroidismo cirúrgico pode ocorrer após cirurgia da tireoide, paratireoide ou outras cirurgias cervicais mais radicais. Pode ser transitório (recuperação em dias, semanas ou meses), permanente ou intermitente. O hipoparatiroidismo transitório ocorre em até 20% dos pacientes após a cirurgia para câncer de tireoide e o hipoparatiroidismo permanente ocorre em 0,8 a 3,0% dos pacientes após a tireoidectomia total.

Questão | | 2024 | 4000205835

Um médico, trabalhando em uma unidade de pronto atendimento, atende um paciente de 70 anos com queixa de febre de início há 4 dias, acompanhada de tosse produtiva e astenia. O paciente é diabético e hipertenso, encontra-se consciente e orientado, porém, no momento, está com a visão prejudicada, devido à cirurgia recente de correção de catarata. Ele não tem tomado as medicações de uso contínuo por não estar conseguindo identificá-las. Seu filho, que mora há 450 Km de distância, chegará em 2 dias para poder acompanhá-lo. Ao exame físico, apresenta frequência respiratória de 24 irpm, pressão arterial de 100x64 mmHg, exame laboratorial: ureia 45 mg/dl e creatinina 0,6 mg/dL.

Diante do exposto, qual seria a conduta adequada?

- A)** Internar o paciente para início do tratamento, por possuir 4 pontos no escore de prognóstico "CURB-65."
- B)** O paciente pode realizar o tratamento ambulatorial por possuir apenas 1 ponto no escore de prognóstico "CURB-65".
- Apesar de o paciente ter somente 1 ponto no escore de prognóstico "CURB-65", devido às
- C)** comorbidades e ao seu contexto social, a conduta mais adequada é interná-lo para o tratamento.
- D)** O paciente pode realizar o tratamento ambulatorial por possuir apenas 2 pontos no escore de prognóstico "CURB-65".
- E)** Internar o paciente para início do tratamento, por possuir 3 pontos no escore de prognóstico "CURB-65."

Solução

Apesar de o paciente ter somente 1 ponto no escore de prognóstico "CURB-65",

Gabarito: C) devido às comorbidades e ao seu contexto social, a conduta mais adequada é interná-lo para o tratamento.

Gabarito: alternativa C.

Preste atenção aos comentários dessa questão, pois não basta saber os critérios do CURB-65, como será necessário avaliar o contexto social do paciente.

Para definição do melhor local para tratamento, podemos utilizar o escore do CURB-65 (relembrando: Confusão mental; Ureia > 50mg/dL; frequência Respiratória > 30 ciclos/min; Blood pressure - pressão arterial sistólica - < 90 mmHg ou diastólica < 60 mmHg; e idade ≥ 65 anos). O paciente possui apenas um ponto na escala (idade), o que indicaria o tratamento ambulatorial (0 a 1 pontos - tratamento ambulatorial; 2 - considerar tratamento hospitalar; 3 ou mais - hospitalização, sendo 4 a 5 indicação de considerar tratamento em UTI). No entanto, o paciente está com a visão prejudicada, e não consegue sequer tomar seus medicamentos de uso contínuo. Como não haverá ninguém para auxiliá-lo no tratamento

durante dois dias, é indicada a internação hospitalar, já que o paciente não é capaz de realizar o tratamento sozinho.

A letra A está incorreta. Incorreta a alternativa A. O paciente não possui 4 pontos no escore de CURB-65.

A letra B está incorreta. Incorreta a alternativa B. Apesar de ter apenas 1 ponto, não é recomendado que realize o tratamento ambulatorial sem auxílio.

A letra C está correta. Correta a alternativa C. O contexto social é o principal motivo para a internação do paciente.

A letra D está incorreta. Incorreta a alternativa D. O paciente não tem 2 pontos no escore de CURB-65.

A letra E está incorreta. Incorreta a alternativa E. O paciente não tem 3 pontos no escore de CURB-65.

Questão | | 2024 | 4000205836

Assinale a alternativa que apresenta corretamente as principais manifestações extra-articulares da artrite psoriática.

- A)** Pneumopatia intersticial padrão não específico; esclerodactilia; microstomia, fenômeno de Raynaud.
- B)** Entesite; pneumopatia intersticial usual; hipertensão pulmonar; mãos de mecânico.
- C)** Sinal do Coldre; heliótropo; dactilite; ganglionopatia.
- D)** Doença inflamatória intestinal; pneumopatia intersticial usual; xeroftalmia; fenômeno de Raynaud.
- E)** Doença inflamatória intestinal; uveíte; dactilite; entesite.

Solução

Gabarito: E) Doença inflamatória intestinal; uveíte; dactilite; entesite.

GABARITO: ALTERNATIVA E.

Estrategista, a artrite psoriásica ocorre em cerca de 1/3 dos pacientes com psoríase e é classificada dentro do grupo das espondiloartrites.

Na maioria dos casos, as manifestações articulares surgem após o diagnóstico da psoríase cutâneo e/ou ungueal; no entanto, em cerca de 15% dos casos ocorrem concomitantemente e, nos 15% restantes, o quadro articular precede o cutâneo.

Nesta espondiloartrite, temos acometimento predominante do esqueleto periférico e, inicialmente, costumamos encontrar uma oligoartrite assimétrica. No entanto, com a progressão da doença, o padrão mais encontrado é o de uma poliartrite simétrica ou assimétrica. Sacroilite e espondilite também podem ser encontradas de forma isolada ou em associação ao acometimento periférico.

Quando pensamos em espondiloartrites, lembre-se que a artrite não é a única manifestação articular. Destacam-se a **entesite** – especialmente a entesite do tendão de Aquiles – e a **dactilite**, mais conhecida como “dedos em salsicha”. Na artrite psoriásica, ela está presente em cerca de 40% dos pacientes, mais do que em qualquer outra espondiloartrite.

Falando agora sobre manifestações extra-articulares, aqui não temos uma profusão, como visto na artrite reumatoide, por exemplo.

Além das alterações cutâneas e ungueais clássicas da psoríase, devemos lembrar do acometimento ocular (conjuntivite, uveíte anterior), úlceras orais, uretrite, colite e insuficiência aórtica.

Dito isso, vamos às alternativas:

A letra A está incorreta. Incorreta a alternativa A: este conjunto de manifestações clínicas deve remeter imediatamente à esclerose sistêmica e não tem qualquer relação com a artrite psoriásica.

A letra B está incorreta. Incorreta a alternativa B: diferentemente das demais doenças autoimunes do tecido conjuntivo, na qual predominam a pneumopatia intersticial não específica, na artrite reumatoide o padrão mais encontrado é da pneumopatia intersticial usual. Hipertensão pulmonar é descrita em várias condições, principalmente esclerose sistêmica e doença mista do tecido conjuntivo. Por fim, as mãos de mecânico estão classicamente associadas às miopatias autoimunes sistêmicas, especialmente a síndrome antissintetase.

A letra C está incorreta. Incorreta a alternativa C: o heliótropo é patognomônico da dermatomiosite e o sinal do coldre é uma das diversas manifestações cutâneas descritas nessa condição e recebe esse nome por tratar-se de um exantema macular, eritemato-violáceo, presente na face lateral das coxas e do quadril. A ganglionopatia é uma das manifestações neurológicas da síndrome de Sjögren.

A letra D está incorreta. Incorreta a alternativa D: além do que já discutimos sobre essas manifestações, ao pensarmos na xeroftalmia, devemos lembrar da síndrome de Sjögren primária e secundária. Não há correlação com a artrite psoriásica.

A letra E está correta. Correta a alternativa E: conforme discutimos acima. Note que todas as manifestações descritas são características do grupo das espondiloartrites e não apenas da artrite psoriásica.

Homem, 24 anos, sem comorbidades conhecidas, sob estresse emocional intenso relacionado ao preparo para uma prova de um concurso público, procurou o pronto atendimento com queixa principal de que o lado direito do rosto não se mexia havia 1 dia. Ao exame físico, apresentava paralisia em hemiface superior e inferior à direita, paralisia da pálpebra superior direita que levava à dificuldade de fechar o olho e piscar, além de desvio da rima labial para o lado esquerdo. As pupilas estavam isocóricas e fotorreagentes, e a força estava preservada (grau V) em membros superiores e inferiores bilaterais.

De acordo com o caso clínico apresentado, qual é a principal hipótese diagnóstica?

- A) Paralisia de Todd.
- B) Acidente vascular encefálico.
- C) Síndrome de Claude Bernard-Horner.
- D) Paralisia de Bell.
- E) Hemorragia subaracnoidea.

Solução

Gabarito: D) Paralisia de Bell.

Estrategista, a questão cobra conhecimentos sobre a principal causa de paralisia facial periférica, a paralisia de Bell. A primeira definição importante é o aspecto anatômico da entidade, em que ocorre o acometimento do andar superior e inferior da face! Já na paralisia facial central, apenas o andar inferior da face estará acometido.

A paralisia de Bell é idiopática, contudo, se especula uma etiologia viral. O principal fator de risco associado à síndrome é a gravidez, com aumento de incidência de cerca de 3 vezes, especialmente no terceiro trimestre e período puerperal.

Nessa condição, o início é agudo, ao longo de um ou dois dias, o curso é progressivo, atingindo a máxima piora em até 3 semanas. Além da paralisia facial, o paciente pode apresentar alteração lacrimal ou salivar, sensação de olho seco, disgeusia (alteração do paladar) e hiperacusia.

Não há necessidade de exame de neuroimagem em casos típicos, sendo considerada em casos em que há piora além de 3 semanas, ausência de qualquer melhora após cerca de 4 meses, ou se os sintomas são atípicos, por exemplo, com a associação de disfunção de outros nervos cranianos.

Para todos os pacientes, está indicado o uso de corticóide, em geral, 60 a 80 mg de prednisona ao dia por 1 semana. Cabe ressaltar que os estudos com essa medicação foram feitos com quadros iniciados em até 72 horas. O uso de antiviral (aciclovir ou valaciclovir) é debatido, exceto quando há sinais de infecção viral subjacente, por exemplo, lesões vesicobolhosas em pavilhão auditivo, a medicação está indicada. Em linhas gerais, a adição de antivirais é mais aceita nos casos graves.

É fundamental orientar o paciente sobre cuidados com úlcera de córnea, que pode ocorrer como consequência da má oclusão palpebral (lagofthalmo). É recomendável o uso de lágrima artificial e nos quadros mais graves pode ser necessária a oclusão do olho com colírio lubrificante noturno.

Vamos às alternativas

A letra A está incorreta. A paralisia de Todd é um quadro de fraqueza transitório e que ocorre logo após uma crise epiléptica com manifestação motora.

A letra B está incorreta. No AVC, a paralisia facial, classicamente, é de padrão central, ou seja, há o acometimento apenas do andar inferior da face!

A letra C está incorreta. Essa síndrome caracteriza-se pela associação de miose e ptose e decorre do acometimento simpático.

A letra D está correta. Exatamente! É a principal hipótese diagnóstica.

A letra E está incorreta. A HSA cursa com cefaleia de padrão thunderclap. O déficit neurológico é incomum e na ausência de cefaleia, não é uma hipótese diagnóstica para o caso descrito.

Questão | | 2024 | 4000205838

Um médico assistente é o responsável por comunicar ao paciente que os resultados dos exames mostraram o diagnóstico de câncer metastático. Assinale a alternativa que aborda de forma adequada a comunicação de más notícias como nesse caso.

- A)** O paciente precisa ser informado a qualquer custo naquele momento, mesmo que ele deixe claro que não deseja saber.
- B)** Deve-se deixar claro que não há mais nada a ser feito pelo paciente.
- C)** A comunicação deve ser rápida e objetiva, sem espaço para dúvidas.
- D)** Deve-se utilizar termos técnicos independente da compreensão do paciente, garantindo a passagem de informações corretas.
- E)** Deve-se usar palavras adequadas ao vocabulário do paciente, formular frases curtas e perguntar, com certa frequência, como o paciente está e o que está entendendo.

Solução

Deve-se usar palavras adequadas ao vocabulário do paciente, formular frases

Gabarito: E) curtas e perguntar, com certa frequência, como o paciente está e o que está entendendo.

GABARITO: ALTERNATIVA E

Estrategista,

Observe que a banca do ENARE mencionou o termo “comunicação de más notícias”. A forma mais adequada de comunicarmos uma notícia ruim para o paciente é utilizando o protocolo **SPIKES**.

A palavra “SPIKES” nada mais é do que um acrônimo, onde cada letra representa um dos passos a serem seguidos nessa comunicação. Vamos lá:

S – Setting Up the interview (ou preparando a entrevista ou encontro).

Como o médico já sabe que precisará comunicar uma má notícia, o primeiro passo é adequar o ambiente para esse momento. Logo, o médico deve organizar a sala de atendimento, com copo d’água, lenços e tudo aquilo que possa servir de suporte para o paciente. Além disso, o médico também deve comunicar à equipe que realizará um atendimento importante e que não gostaria de ser interrompido.

Portanto, segundo o artigo original de Baile WF et al (2000), esse é o roteiro a ser seguido nesse passo:

- Certifique-se de que haverá privacidade. O ideal é realizar o encontro em uma sala fechada, mas se isso não for possível porque o paciente está hospitalizado, então feche as cortinas ao redor do leito do paciente.
- Tenha lenços prontos caso o paciente fique chateado.
- Envolver as pessoas importantes para o paciente. No entanto, isso é uma escolha do paciente, por isso, vale a pena perguntar se ele quer a companhia de alguém naquele encontro.
- Mantenha contato visual durante a comunicação.
- Silencie o seu pager ou celular.
- O artigo original ainda fala que o médico pode pegar no braço do paciente ou na mão dele para demonstrar proximidade, desde que o paciente se sinta confortável com isso.

P – Perception (ou avaliando o que o paciente sabe).

Esse é o passo em que o médico avalia o que o paciente já sabe sobre o problema a ser comunicado. Por isso, o ideal é que sejam utilizadas “perguntas abertas”, para que assim o médico consiga perceber como o paciente percebe aquela situação. Por exemplo, “o que já conversaram com o senhor sobre a sua situação médica?”, “o senhor sabe por qual motivo realizamos aquela ressonância magnética?”.

Esse passo é importante para que o médico corrija eventuais informações incorretas e saiba quais pontos deve priorizar ao proceder com a comunicação da má notícia.

I – Invitation (ou convidando para saber mais).

Nesse passo, o médico pergunta ao paciente se ele gostaria de saber mais sobre a sua condição médica. Essa pergunta é muito importante, uma vez que existem pacientes que não desejam saber por terem dificuldade de lidar com aquilo que vem acontecendo (e nesse ponto, alguns preferem que a notícia seja comunicada a um familiar ou amigo próximo).

Além disso, o nosso Código de Ética Médica, apesar de afirmar que não se deve esconder informações do paciente, também afirma que caso percebamos que aquela comunicação vai causar dano ao paciente, então a mesma deve ser feita a um representante legal.

K – Knowledge (comunicando a notícia)

Nesse passo, o médico comunica a notícia diretamente, com linguagem clara e assertiva.

E – Emotions (emoções)

Nesse passo, o médico respeita as emoções do paciente, fazendo as pausas necessárias para que ele absorva melhor a notícia, assim como oferecendo lenços e água.

S – Strategy and Summary.

Aqui, o médico faz um resumo e pactua com o paciente os próximos passos a serem seguidos.

Com essas informações, vamos analisar as alternativas:

A letra A está incorreta. Incorreta a alternativa A. Como vimos anteriormente, precisamos questionar se o paciente deseja saber mais sobre o assunto (I – Invitation). Caso ele não deseje saber, precisamos respeitar e verificar se o paciente deseja que realizemos a comunicação para outra pessoa próxima.

A letra B está incorreta. Incorreta a alternativa B. Vamos combinar que essa alternativa é de uma crueldade sem fim, né? Além disso, existe uma frase muito famosa que diz o seguinte: “se o médico não é capaz de curar, é capaz de aliviar o sofrimento”. Portanto, sempre há algo a ser feito pelo paciente.

A letra C está incorreta. Incorreta a alternativa C. A comunicação deve ser feita de forma clara e assertiva, e evidentemente deve-se permitir que o paciente tire as suas dúvidas.

A letra D está incorreta. Incorreta a alternativa D. A comunicação deve ser feita de forma clara, isto é, de forma compreensível. Dessa forma, utilizar termos técnicos, especialmente se o paciente não for profissional de saúde, não atingirá o objetivo de comunicação clara e assertiva.

A letra E está correta. Correta a alternativa E, sem ressalvas.

Questão | | 2024 | 4000205839

Qual é a coloração utilizada na baciloscopia para investigação de hanseníase?

- A)** Tinta da China.
- B)** Ziehl-Neelsen.
- C)** Vermelho congo.
- D)** Azul da Prússia.
- E)** Grocott.

Solução

Gabarito: B) Ziehl-Neelsen.

A hanseníase é uma doença infectocontagiosa crônica, cujo agente etiológico é o *Mycobacterium leprae* (*M. leprae*). A doença acomete principalmente o sistema nervoso periférico e a pele, mas também pode afetar outros órgãos.

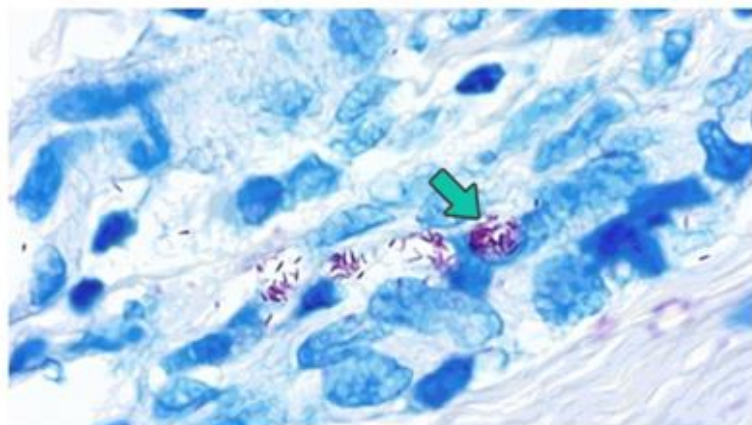
Você tem que conhecer o *M. leprae* e essa pergunta especificamente sobre ele. Vamos lembrar alguns conceitos

- a) O *Mycobacterium leprae* é um bacilo álcool-ácido resistente (BAAR), fracamente gram-positivo. É parasita intracelular obrigatório predominante em macrófagos e na célula de Schwann. As colorações para identificar BAAR são a da Ziehl-Neelsen e a de Fite- Faraco.
- b) O tempo de incubação do agente é longo
- c) Até hoje não é possível realizar cultivo “in vitro” do *M. leprae*.

Vamos discutir um pouco sobre a baciloscopia da hanseníase.

A baciloscopia é o exame complementar mais útil para o diagnóstico da hanseníase.

Apresenta uma especificidade de 100%, ou seja, quando é positiva o paciente realmente tem hanseníase! Porém, uma baciloscopia negativa não exclui o diagnóstico da doença. A baciloscopia não é obrigatória, mas deve ser realizada quando disponível. Veja uma imagem de uma baciloscopia da hanseníase.



Os bacilos álcool-ácido resistentes, quando corados pelo Ziehl-Neelsen ficam da cor lilás.

A letra A está incorreta. Alternativa A) Incorreta. A tinta da China é uma coloração para identificar criptococose.

A letra B está correta. Alternativa B) Correta. Alternativa correta.

A letra C está incorreta. Alternativa C) Incorreta. Vermelho congo é uma coloração para identificar amiloidose.

A letra D está incorreta. Alternativa D) Incorreta. O azul da prússia cora em azul o que contiver ferro, como hemoglobina.

A letra E está incorreta. Alternativa E) Incorreta. O grocott é uma coloração para identificação de fungos.

Questão | | 2024 | 4000205840

Em relação ao tema manifestações paraneoplásicas relacionadas ao câncer de pulmão, assinale a alternativa INCORRETA.

- A)** A neuropatia periférica aguda é mais prevalente como síndrome paraneoplásica pulmonar no subtipo não pequenas células.
- B)** Síndrome de Lambert-Eaton está associada ao quadro de síndrome miastênica, frequentemente associado ao carcinoma indiferenciado de pequenas células.
- C)** A síndrome de Cushing foi descrita como secreção ectópica do ACTH pelo tumor do pulmão, sendo frequente no carcinoma de pequenas células.
- D)** A SIADH (Síndrome da Secreção Inadequada do Hormônio Antidiurético) está correlacionada ao carcinoma indiferenciado de pequenas células.
- E)** A osteoartropatia pulmonar hipertrófica pode preceder os sintomas pulmonares do câncer de pulmão em meses.

Solução

Gabarito: A) A neuropatia periférica aguda é mais prevalente como síndrome paraneoplásica pulmonar no subtipo não pequenas células.

Gabarito: A.

Estrategista, estamos diante de uma questão muito difícil, já que envolve apenas conceitos decorados. As síndromes paraneoplásicas são extremamente raras nas neoplasias de pulmão. O subtipo histológico mais relacionado a elas é o câncer de pulmão pequena células, no entanto, há exceções. Veja na tabela abaixo:

Classificação	Síndrome	Tipo histológico
Endocrinológico	Síndrome de Cushing	Pequenas células
	SIADH	Pequenas células
	Hipercalcemia	CEC
	Ginecomastia	Grandes células
Ósseo/tecido conectivo	Osteoartropatia hipertrófica pulmonar	Adenocarcinoma
Neuromuscular	Neuropatia periférica sensitiva e motora	Pequenas células
	Degeneração cerebelar, encefalite limbica	Pequenas células
	Síndrome miastênica de Eaton-Lambert	Pequenas células
	Dermatomiosite	Todos os subtipos
Cardiovascular	Tromboflebite (síndrome de Trousseau)	Adenocarcinoma
Cutâneo	Acantose nigricans	Todos os subtipos
	Eritema gyratum	Todos os subtipos

Vamos continuar comentando nas alternativas:

A letra A está correta. Incorreto. Como vemos na tabela as neuropatias periféricas são mais comuns no subtipo pequenas células.

A letra B está incorreta. Correta. A síndrome de Eaton-Lambert é uma desordem neuromuscular autoimune caracterizada pela presença de anticorpos contra os canais de cálcio nas terminações nervosas motoras periféricas. Esses anticorpos interferem na liberação de acetilcolina, neurotransmissor essencial na transmissão neuromuscular. A condição resulta em uma redução na liberação de acetilcolina nas junções neuromusculares, levando a uma fraqueza muscular proximal, fadiga e outros sintomas neuromusculares.

Esta síndrome está frequentemente associada ao câncer de pulmão de pequenas células, embora também possa ocorrer de forma idiopática.

A letra C está incorreta. Correta. A Síndrome de Cushing é uma condição médica causada pelo excesso de exposição ou produção prolongada de cortisol. Como síndrome paraneoplásica se relaciona de fato ao pequenas células.

A letra D está incorreta. Correta. O Síndrome de Secreção Inadequada de Hormônio Antidiurético (SIADH) é uma condição caracterizada pelo aumento da secreção do hormônio antidiurético (ADH ou vasopressina). Este distúrbio resulta em hiponatremia e pode estar associado a várias condições, incluindo o câncer de pulmão.

A relação entre o SIADH e o câncer de pulmão muitas vezes ocorre devido à produção ectópica de ADH por certos tumores, principalmente os de pequenas células do pulmão.

A letra E está incorreta. Correta. A osteoartropatia pulmonar hipertrófica ou baqueteamento digital pode ser um achado precoce do câncer de pulmão.